ЛОР-справочник

Разборы клинических рекомендаций

20 рекомендаций Минздрава РФ · сборка от 22.10.2026 · каждый пункт сверен с текстом КР

Оглавление

Абсцесс, фурункул и карбункул носа 6
J34.0

1. Основные положения 7
2. Клиническая картина и классификация 7
3. Диагностика 9
4. Лечение 10
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 15
6. Источник и актуальность 16

Аллергический ринит 17
J30.1, J30.2, J30.3, J30.4

1. Основные положения 18
2. Клиническая картина и классификация 18
3. Диагностика 19
4. Лечение 21
5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации 24
6. Контроль лечения 25
7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 26
8. Источник и актуальность 26

Болезнь Меньера 27
H81.0

1. Основные положения 28
2. Клиническая картина и классификация 28
3. Диагностика 30
4. Лечение 32
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 34
6. Источник и актуальность 34

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин 36
J31.1, J35.1, J35.2, J35.3, J35.8

1. Основные положения 37
2. Клиническая картина и классификация 37
3. Диагностика 39
4. Лечение 40
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 43
6. Источник и актуальность 44

Мастоидит 45
H70

1. Основные положения 46
2. Клиническая картина и классификация 46
3. Диагностика 49
4. Лечение 50
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 54
6. Источник и актуальность 54

Наружные отиты **55**
H60.0, H60.1, H60.2, H60.3, H60.4, H60.5, H60.8, H60.9, H61.0, H61.8, H61.9, H62.0, H62.1, H62.3, H62.4, H62.8

1. Основные положения 56
2. Клиническая картина и классификация 56
3. Диагностика 57
4. Лечение 57
5. Профилактика. Показания к госпитализации 59
6. Источник и актуальность 59

Нейросенсорная тугоухость у взрослых **60**
H90.3, H90.4, H90.5, H91.1, H91.2, H91.8

1. Основные положения 61
2. Клиническая картина и классификация 61
3. Диагностика 63
4. Лечение и реабилитация 66
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 70
6. Источник и актуальность 71

Носовое кровотечение **72**
R04.0

1. Основные положения 73
2. Клиническая картина и классификация 73
3. Диагностика 74
4. Лечение 75
5. Профилактика. Показания к госпитализации 77
6. Источник и актуальность 78

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых **79**
B34.0, B34.2, B34.9, B97.0, B97.4, J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J20, J21, J22

1. Основные положения 80
2. Клиническая картина и классификация 80
3. Диагностика 82
4. Лечение 86
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 90
6. Источник и актуальность 92

Острый ларингит **94**
J04.0, J04.2

1. Основные положения 95
2. Клиническая картина и классификация 95

3. Диагностика 96
4. Лечение 98
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 102
6. Источник и актуальность 103

Острый синусит **105**
J01
1. Основные положения 106
2. Клиническая картина и классификация 106
3. Диагностика 108
4. Лечение 111
5. Показания к госпитализации. Осложнения 115
6. Источник и актуальность 115

Острый тонзиллит и фарингит **117**
J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9
1. Основные положения 118
2. Клиническая картина и классификация 118
3. Диагностика 119
4. Лечение 121
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения 124
6. Источник и актуальность 124

Отит средний острый **126**
H65.0, H65.1, H66.0
1. Основные положения 127
2. Клиническая картина и классификация 127
3. Диагностика 128
4. Лечение 129
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 132
6. Источник и актуальность 133

Отосклероз **134**
H80
1. Основные положения 135
2. Клиническая картина и классификация 135
3. Диагностика 136
4. Лечение 140
5. Медицинская реабилитация. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 143
6. Источник и актуальность 143

Паратонзиллярный абсцесс **145**
J36, J39.0, J39.1
1. Основные положения 146
2. Клиническая картина и классификация 146
3. Диагностика 147

4. Лечение 148
5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения 150
6. Источник и актуальность 150

Полипозный риносинусит 151
J33.0, J33.1, J33.8, J33.9

1. Основные положения 152
2. Клиническая картина и классификация 152
3. Диагностика 154
4. Лечение 155
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 157
6. Источник и актуальность 158

Травма носа 160
S00.3, S01.2, S02.2

1. Основные положения 161
2. Клиническая картина и классификация 161
3. Диагностика 163
4. Лечение 164
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 169
6. Источник и актуальность 170

Хронический синусит 171
J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J34.1

1. Основные положения 172
2. Клиническая картина и классификация 172
3. Диагностика 175
4. Лечение 176
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 180
6. Источник и актуальность 181

Хронический средний отит 183
H65.2, H65.3, H65.4, H66.1, H66.2, H66.3, H72.0, H90.0, H90.1, H90.2, H90.6, H90.7, H90.8

1. Основные положения 184
2. Клиническая картина и классификация 184
3. Диагностика 185
4. Лечение 189
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 192
6. Источник и актуальность 193

Хронический тонзиллит 195
J31.2, J35.0, J35.8, J35.9

1. Основные положения 196
2. Клиническая картина и классификация 196
3. Диагностика 197
4. Лечение 198
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 200

6. Источник и актуальность 201

Клинические рекомендации

Абсцесс, фурункул и карбункул носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.0** — Абсцесс, фурункул и карбункул носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/956_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- В стадии инфильтрации лечение фурункула консервативное; при абсцедировании и при карбункуле гнойник вскрывают и дренируют, не прекращая консервативной терапии.
- При фурункуле, карбункуле и абсцессе носа во всех случаях необходима системная антибактериальная терапия, направленная на санацию очага инфекции и профилактику осложнений.
- При каждом осмотре необходимо исключить признаки внутричерепных осложнений: синдром системной воспалительной реакции, неврологическую и офтальмологическую симптоматику, тромбоз угловой вены и кавернозного синуса.
- Лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и поражение III, IV, V и VI пар черепных нервов свидетельствуют о возможном тромбозе кавернозного синуса; в этом случае требуется компьютерная томография (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.
- Дети с данным диагнозом во всех случаях подлежат госпитализации в круглосуточный оториноларингологический стационар; взрослые в стадии инфильтрации могут получать лечение амбулаторно.
- Массаж области носа и выдавливание содержимого фурункула противопоказаны.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Фурункул носа представляет собой острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и сальной железы, локализующееся на кончике или крыльях носа, в преддверии носа или в области дна носа у верхней губы. Карбункул носа характеризуется гнойно-некротическим воспалением нескольких волосяных фолликулов и сальных желёз с распространением процесса вглубь тканей и по поверхности, с обширными некрозами кожи и подкожной клетчатки. Абсцесс носа (абсцедирующий фурункул) представляет собой скопление гноя, возникающее при острой инфекции и приводящее к деструкции тканей в очаге, часто с перифокальным отёком.

2.2 Этиология

Ведущим возбудителем является золотистый стафилококк; резервуаром инфекции служат бессимптомные носители. Возбудителями пиодермии и фурункула носа могут быть также стрептококки, прежде всего бета-гемолитический стрептококк группы А. Инфицированию волосяного фолликула способствуют микротравмы кожи носа и его преддверия, загрязнение кожи техническими маслами и пылью при несоблюдении гигиены, а также переохлаждение, перегревание, стресс и нарушение секреторной функции кожи. У детей фурункул носа в большинстве случаев возникает вследствие привычки ковырять в носу и чрезмерного сморкания.

Фурункул носа нередко является проявлением фурункулёза, то есть образования множественных фурункулов на фоне вторичного иммунодефицита при эндокринных заболеваниях, прежде всего при сахарном диабете, а также при гиповитаминозе, нарушениях питания и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

2.3 Патогенез

Отток венозной крови от средней зоны лица (так называемого опасного треугольника, ограниченного линиями, соединяющими назион с углами рта) осуществляется по угловым венам, венам орбиты и крыловидному сплетению в кавернозный синус. Вены этой системы лишены клапанов, поэтому инфекция с кожи лица, носа и околоносовых пазух может распространяться гематогенным путём в глазницу, далее в кавернозный синус и на головной мозг. В кавернозном синусе проходят внутренняя сонная артерия, III, IV и VI пары черепных нервов, первая и вторая ветви тройничного нерва; к нему прилежат гипофиз и клиновидная пазуха. Этими анатомическими особенностями обусловлена тяжесть внутричерепных осложнений.

При снижении сопротивляемости организма и высокой вирулентности возбудителя возможна генерализация процесса: стафилококки распространяются в окружающие ткани или проникают в кровоток с развитием сепсиса. В зоне инфильтрата развивается тромбоз мелких вен, и увеличение воспалительного очага повышает угрозу распространения тромбоза.

2.4 Классификация

По стадии воспалительного процесса выделяют I стадию (инфильтрации) и II стадию (абсцедирования).

2.5 Клиническая картина

Пациенты с фурункулом носа предъявляют жалобы на боль в области носа, головную боль, слабость, снижение работоспособности, повышение температуры тела до субфебрильных значений. В общем анализе крови возможны сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Фурункул может локализоваться на кончике носа, в преддверии носа, вблизи перегородки носа или в области дна носа.

> В разделе 1.6 указана локализация фурункула «в области дна носа у нижней губы», тогда как в определениях (раздел 1.1 и «Термины и определения») указано «у верхней губы». Поскольку дно носа граничит с верхней губой, в разделе 1.6, по-видимому, допущена опечатка.

В стадии инфильтрации отмечаются постепенно нарастающая гиперемия кожи над фурункулом, локальная боль, усиливающаяся при мимических движениях и жевании, нарастающая инфильтрация мягких тканей. Вокруг первичного очага образуется некротическая ткань, формируется стержень фурункула. На внутренней поверхности входа в нос определяется болезненный конусовидный инфильтрат.

При благополучном течении происходит отторжение некротического стержня с выделением небольшого количества гноя, инфильтрат уменьшается, болевой синдром регрессирует, температура тела нормализуется, общее состояние улучшается.

В стадии абсцедирования при прогрессировании процесса зона некроза увеличивается, кожа над инфильтратом истончается, появляется флюктуация, формируется абсцесс.

Для карбункула и абсцесса носа характерны тяжёлое общее состояние, фебрильная лихорадка, ощущение распирания и выраженная пульсирующая боль. В области носа появляются несколько плотных инфильтратов, которые сливаются в единый увеличивающийся очаг. В области карбункула формируется обширная полость с гнойно-некротическим содержимым, на коже образуется несколько отверстий, из которых выделяются гной и некротизированные кровянистые массы.

У детей заболевание протекает тяжелее вследствие выраженного интоксикационного синдрома (головная боль, слабость, вялость, лихорадка). Местные изменения могут развиваться стремительнее, а обширный отёк и гиперемия верхней губы или щёчной области могут маскировать фурункул под заболевание челюстно-лицевой области.

2.6 Анамнез

В анамнезе возможны указания на переохлаждение и косметические процедуры в области наружного носа и его преддверия.

3. Диагностика

Диагноз фурункула носа устанавливается на основании трёх критериев: жалоб, данных осмотра и передней риноскопии. Пациенты предъявляют жалобы на выраженную боль в области очага, усиливающуюся при прикосновении, головную боль, недомогание, повышение температуры тела. При осмотре определяются гиперемия, отёк и инфильтрация мягких тканей наружного носа, преддверия носа и носо-лицевой области, резкая болезненность при пальпации. При передней риноскопии в преддверии носа у волосяного фолликула выявляются гиперемия кожи, инфильтрат и гнойный стержень в центре.

3.1 Физикальное обследование

Каждый пациент с подозрением на фурункул носа для установления и уточнения диагноза подлежит первичному осмотру врачом-оториноларингологом, врачом общей практики или педиатром.

При передней риноскопии на начальном этапе может определяться остиофолликулит преддверия носа: гиперемия и уплотнение в устье волосяного фолликула. В течение 1–2 суток развиваются отёк, инфильтрация и гиперемия кожи входа в нос (стадия инфильтрации), затем кожа истончается, происходит гнойно-некротическое расплавление тканей в очаге с образованием детрита. При наружном осмотре определяются гиперемия, отёк и болезненность в области преддверия и кончика носа; прикосновение к носу и риноскопия болезненны. Кожа преддверия носа может быть покрыта толстыми жёлтыми корками. При выраженном воспалении отёк распространяется на щёчную область и верхнюю губу.

Основным методом инструментальной диагностики является передняя риноскопия; её выполняют у всех пациентов, чтобы осмотреть полость носа и уточнить локализацию фурункула.

3.2 Признаки внутричерепных осложнений

При каждом осмотре необходимо оценивать наличие симптомов внутричерепных осложнений, которые объединяются в три синдрома: инфекционный, неврологический и офтальмологический.

Инфекционный синдром представляет собой синдром системной воспалительной реакции: температура тела 38 °C и выше или 36 °C и ниже, частота сердечных сокращений 90 в минуту и более, частота дыхания более 20 в минуту, количество лейкоцитов более 12 × 10^9/л или менее 4 × 10^9/л либо незрелых форм более 10%, уровень прокальцитонина в плазме 0,5 нг/мл и выше.

Неврологический синдром включает интенсивную головную боль, тошноту и рвоту, не связанные с приёмом пищи, несистемное головокружение. О развитии менингеального синдрома свидетельствуют светобоязнь, звукобоязнь, гиперестезия кожи, ригидность затылочных мышц; могут определяться симптомы Кернига и Брудзинского, скуловой симптом Бехтерева, симптом Менделя. При прогрессировании возможны оглушение, психомоторное возбуждение, судорожный синдром.

Офтальмологический синдром включает отёк век, хемоз и экзофтальм на стороне поражения; при пальпации век могут определяться болезненные тромбированные вены. При офтальмоскопии возможно выявление признаков внутричерепной гипертензии.

Для тромбоза угловой вены характерны резкая болезненность при пальпации, интенсивная головная боль, отёк лица на стороне поражения; угловая вена пальпируется в виде плотного болезненного тяжа.

Для тромбоза кавернозного синуса, особенно на начальном этапе, характерен выраженный цианоз слизистой оболочки губ, кожи лба и носа. В дальнейшем нарастает отёк верхней губы и щеки на стороне поражения с распространением на височную и лобную области, веки и противоположную половину лица. Развивается нарушение функции глазодвигательного, блокового, отводящего и тройничного нервов вплоть до полного её выпадения.

Подозрение на тромбоз кавернозного синуса служит показанием к компьютерной томографии (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.

О возможном тромбозе кавернозного синуса свидетельствуют фебрильная лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и признаки поражения III, IV, V и VI пар черепных нервов.

При осложнённом течении необходимы первичные консультации офтальмолога и невролога для дифференциальной диагностики и выбора тактики лечения.

При распространении воспалительного процесса на область лица целесообразна консультация челюстно-лицевого хирурга.

Алгоритм ведения пациента (приложение Б) при внутричерепных осложнениях предусматривает консультации нейрохирурга, офтальмолога и челюстно-лицевого хирурга.

> Состав консультантов при осложнениях в разных разделах рекомендации не совпадает: в разделе 2.5 и в критериях качества указаны невролог и офтальмолог, в алгоритме (приложение Б) указаны нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

3.3 Лабораторные исследования

Развёрнутый общий анализ крови обязателен для всех пациентов на любой стадии заболевания: он позволяет оценить общее состояние и выраженность воспалительного процесса.

Биохимический анализ крови выполняют для выявления сахарного диабета, нарушений углеводного обмена и других состояний, способствующих развитию фурункула и утяжеляющих его течение.

Сахарный диабет неблагоприятно влияет на частоту развития, течение и прогноз фурункула. При повышенном уровне глюкозы пациента направляют к эндокринологу для коррекции гликемии, выявления сахарного диабета и назначения лечебного питания. Изменения уровня билирубина, креатинина, мочевины, активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) свидетельствуют о нарушении функции печени и почек.

У всех пациентов с осложнённым течением фурункула носа и с сопутствующими заболеваниями оценивают коагулограмму.

При абсцедирующем фурункуле, карбункуле и абсцессе носа гнойное отделяемое направляется на посев на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам для обоснованного выбора антибактериального препарата.

Материал забирают из раны после вскрытия, без контакта с окружающими тканями, до начала антибактериальной терапии.

---

4. Лечение

Метод лечения определяется стадией фурункула и характером проявлений, в том числе наличием карбункула или абсцесса. При неосложнённом течении лечение преимущественно консервативное, местное и парентеральное. Лечение носит комплексный характер и направлено на элиминацию возбудителя, купирование интоксикации, восстановление обмена веществ и повышение защитных сил организма.

По алгоритму ведения пациента (приложение Б) в стадии инфильтрации лечение консервативное, в стадии абсцедирования хирургическое в сочетании с консервативным. В стадии разрешения предусмотрена консультация физиотерапевта, при рецидиве консультации эндокринолога и аллерголога-иммунолога.

4.1 Местное лечение

Для подавления инфекции и воспаления у всех пациентов с фурункулом носа местно применяют антисептики.

В первые часы после появления инфильтрата эффективно повторное смазывание пустулы 5% спиртовым раствором йода. Выраженным действием обладают четвертичные аммониевые соединения (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний), препараты йода (повидон-йод разрешён детям старше 28 дней) и хлоргексидин; эти средства допустимо использовать у взрослых и детей. Кратность обработки раны зависит от выраженности воспаления; рану обрабатывают до разрешения инфекционного процесса. В стадии инфильтрации кожа вокруг очага бережно обрабатывается 70% этанолом.

При фурункуле и карбункуле носа для санации очага местно используют мази с антибиотиками широкого спектра действия.

Мупироцин в форме мази наносится взрослым 2–3 раза в день в течение 5–7 дней, детям с рождения 2–3 раза в день не более 10 дней. Фузидовая кислота в форме мази или крема наносится взрослым на кожу над фурункулом до 3–4 раз в день в течение 7–14 дней, детям с рождения в форме крема 3–4 раза в день в течение 7–14 дней. Мазь диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол обладает противомикробным и противовоспалительным действием; взрослым и детям с одного года она наносится один раз в день до очищения раны от гнойно-некротических масс.

4.2 Анальгетическая и противовоспалительная терапия

Для купирования воспаления и болевого синдрома при отсутствии противопоказаний рекомендуется противовоспалительная и обезболивающая терапия.

Используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и другие анальгетики-антипиретики в монотерапии или в комбинации. Выраженный лечебный эффект оказывает сочетание НПВП с парацетамолом, а для купирования болевого синдрома у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде, применяется метамизол натрия. Из НПВП у детей допускается применение ибупрофена с 3 месяцев, кетопрофена с 15 лет, кетопрофена в форме гранул для приготовления раствора для приёма внутрь с 6 лет.
В амбулаторной практике от назначения метамизола натрия детям следует воздержаться; в стационаре препарат применяется только при отсутствии других анальгетиков, разрешённых к применению у детей, в связи с риском серьёзных нежелательных явлений.

4.3 Анальгетическая терапия у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	0,5–1 г внутривенно, инфузия в течение 15 минут	6 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 «мл» внутримышечно (так в таблице рекомендации; по смыслу 75 мг)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно или внутримышечно	8 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Декскетопрофен	50 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

Разовая доза диклофенака в таблице 1 указана как «75 мл в/м»; исходя из смысла и суточного максимума 150 мг, речь идёт о 75 мг.

4.4 Анальгетическая терапия у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия в течение 15 минут: менее 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; более 50 кг — 1000 мг	4 ч	Менее 10 кг — менее 30 мг/кг; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; более 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	С 12 лет — 0,5–1 г; 6–12 лет — 240–480 мг; 1–6 лет — 120–240 мг; от 3 месяцев до года — 72–120 мг	6 ч	С 12 лет — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг	С 12 лет — 3 суток, до 12 лет — 5–7 суток
Парацетамол в ректальных суппозиториях	10–14 лет — 500 мг; 5–9 лет — 250 мг; 1–4 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50–100 мг	4–6 ч	Менее 60 мг/кг	До 5 суток
Ибупрофен внутрь	Старше 6 лет — 200–400 мг; 4–6 лет — 150 мг; 1–3 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50 мг	8 ч	12–17 лет — 1 г; 6–12 лет — 800 мг; 4–6 лет — 450 мг; 1–3 года — 300 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 3–6 месяцев — 150 мг	4 суток
Ибупрофен в ректальных суппозиториях	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	8 ч (3–9 месяцев), 6 ч (9–24 месяца)	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	Не более 3 суток
Кетопрофен	С 15 лет — 100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	Не более 2 суток
Кетопрофен в гранулах для раствора внутрь	Старше 6 лет — 40 мг	8 ч	120 мг	Не более 2 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Метамизол натрия внутримышечно	13–14 лет — 0,8–1,8 мл (400–900 мг); 10–12 лет — 0,5–1,0 мл (250–500 мг); 7–9 лет — 0,4–1,0 мл (200–500 мг); 4–6 лет — 0,3–0,8 мл (150–400 мг); 1–3 года — 0,2–0,5 мл; 3–11 месяцев — 0,1–0,2 мл (50–100 мг)	8–12 ч	С 15 лет — 2 г; 8–14 лет — 900 мг; 4–7 лет — 600 мг; 2–3 года — 300 мг	1–5 суток

> В строке метамизола натрия таблицы 2 для детей 1–3 лет указано «0,2–0,5 мл (100–2500 мг)». При концентрации 500 мг в 1 мл, как и в соседних строках, 0,5 мл соответствуют 250 мг, следовательно, значение «2500» является опечаткой. Возраст «79 лет» в той же строке следует читать как 7–9 лет.

4.5 Системная антибактериальная терапия

Всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа для санации очага инфекции и предупреждения осложнений проводят системную антибактериальную терапию.

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет или с массой тела более 40 кг применяют амоксициллин с клавулановой кислотой по 1000 мг (875/125) 2 раза в сутки в течение 7 дней. Для детей от 3 месяцев до 12 лет с массой тела менее 40 кг предусмотрена форма суспензии (400 мг амоксициллина + 57 мг клавулановой кислоты в 5 мл) из расчёта 20 мг/кг в сутки, новорождённым и детям до 3 месяцев — 30 мг/кг (по амоксициллину) 2 раза в день, 7–14 дней. С 12 лет возможно применение цефдиторена по 200 мг каждые 12 часов в течение 10 дней.

При тяжёлом или рецидивирующем течении фурункула и при непереносимости бета-лактамных антибиотиков пациентам с 18 лет могут быть назначены левофлоксацин по 750 мг один раз в сутки в течение 7–14 дней или моксифлоксацин по 400 мг один раз в сутки в течение 7 дней.

Препаратом первой линии для парентерального введения является цефазолин: взрослым по 0,5 г внутривенно или внутримышечно 2 раза в день, детям от месяца до 18 лет — 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в течение 7–10 дней. Цефтриаксон вводится взрослым и детям старше 12 лет или с массой тела более 50 кг по 1–2 г один раз в сутки; новорождённым до 14 дней — 20–50 мг/кг один раз в сутки, не более 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг один раз в сутки, в течение 7–10 дней.

Ампициллин с сульбактамом вводится внутримышечно или внутривенно (капельно со скоростью 60–80 капель в минуту или струйно медленно в течение 3–5 минут): взрослым 3–12 г в сутки в 3–4 введения в зависимости от тяжести инфекции, детям 150 мг/кг в сутки в 3–4 введения, недоношенным и детям первой недели жизни — 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в течение 5–14 дней. Амоксициллин с клавулановой кислотой внутривенно вводится взрослым и детям старше 12 лет по 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки; детям до 3 месяцев и с массой тела менее 4 кг — 25/5 мг/кг каждые 8 часов, только медленной инфузией в течение 30–40 минут; от 3 месяцев до 12 лет — 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов в зависимости от тяжести инфекции, в течение 5–14 дней.

При аллергии на бета-лактамные антибиотики применяют клиндамицин: взрослым парентерально 0,6–2,7 г в сутки в несколько введений, детям 3–18 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 3–4 равных приёма, в течение 7–10 дней. Детям младше 3 лет препарат противопоказан.

4.6 Парентеральные антибактериальные препараты

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Цефазолин	Взрослым 0,5 г; детям старше месяца 10–20 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям старше месяца 100 мг/кг	7–10 дней
Цефтриаксон	Взрослым 1–2 г; новорождённым до 14 дней 20–50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	1 раз в сутки	Взрослым 4 г, детям 2 г	7–10 дней
Ампициллин + сульбактам	Взрослым 1–2 г; детям старше месяца 50 мг/кг; новорождённым до 14 дней 75 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	Взрослым и детям старше месяца 3 раза, новорождённым 2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям 150 мг/кг	5–14 дней внутримышечно (или 5–7 дней внутривенно, затем внутримышечно до 14 дней)
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослым и детям старше 12 лет 1 г внутривенно; до 12 лет 25 мг/кг внутривенно	Взрослым и детям старше 3 месяцев 3 раза, детям до 3 месяцев 2–3 раза в сутки	Взрослым и детям старше 12 лет 6 г, до 12 лет 50–75 мг/кг	5–14 дней
Клиндамицин	Взрослым «0,2–0,9 мг» (так в таблице; внутримышечно не более 0,6 г, внутривенно не более 1,2 г на одно введение); детям 3–18 лет 5–10 мг/кг внутримышечно или внутривенно	3–4 раза в сутки	Взрослым 4,8 г, детям 40 мг/кг	7–10 дней

> Данные раздела 3.1 и таблицы 3 не совпадают. Цефазолин детям: в тексте 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в таблице 10–20 мг/кг 2 раза в сутки. Ампициллин с сульбактамом: в тексте взрослым до 12 г в сутки, в таблице максимальная доза 6 г; новорождённым в тексте 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в таблице 75 мг/кг на введение 2 раза в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 25 мг/кг каждые 6–8 часов (до 100 мг/кг в сутки), в таблице максимальная доза 50–75 мг/кг в сутки. Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице указана в миллиграммах («0,2–0,9 мг»), хотя, исходя из смысла и текста (0,6–2,7 г в сутки), речь идёт о граммах.

4.7 Антикоагулянтная терапия

Осложнённое течение фурункула, карбункула или абсцесса носа во всех случаях требует профилактики тромбозов антикоагулянтами прямого или непрямого действия.

Доза подбирается под контролем показателей свёртывающей системы крови.

4.8 Хирургическое лечение

Хирургическое лечение фурункула носа показано только в стадии абсцедирования, а также при карбункуле носа.

При осложнённом течении абсцесс или карбункул носа вскрывают, чтобы эвакуировать гной и обеспечить дренирование.

Вмешательство возможно как под местной анестезией, так и под общим обезболиванием. Забор материала из раны для бактериологического исследования обязателен.

В стадии разрешения для ускорения выздоровления показана консультация физиотерапевта.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Рецидивирующее течение

При рецидивирующих фурункулах носа рекомендована консультация эндокринолога (у детей детского эндокринолога) для выявления причины рецидивов.

В ряде случаев целесообразна также консультация аллерголога-иммунолога.

Для профилактики рецидивов при рецидивирующем течении фурункула носа применяют бактериофаги.

Местное применение бактериофагов в комплексном лечении оправдано при устойчивости выделенных штаммов к антибиотикам, при наличии в анамнезе более двух курсов антибактериальной терапии, при непереносимости антибиотиков и при рецидивирующем течении.

5.2 Профилактика

Основой профилактики фурункула и его осложнений является соблюдение личной гигиены: мытьё рук до и после еды, после посещения туалета, поездок в транспорте и посещения общественных мест. Важное значение имеет также гигиена труда, в том числе использование средств защиты при работе в условиях запылённости и загрязнения. Не допускаются прикосновения к коже лица, особенно носа, грязными руками, массаж болезненных участков, выдавливание фурункула и самолечение. При сахарном диабете и других сопутствующих заболеваниях необходимы соблюдение диеты и своевременный приём лекарственных препаратов. Гигиеническим навыкам обучают в семье, детском саду и школе.

Пациенту разъясняется необходимость осторожного отношения к косметическому уходу за лицом, включая чистку лица и бритьё; при появлении гнойничка на коже носа или верхней губы массаж и выдавливание его категорически противопоказаны. Родителям следует контролировать чистоту рук ребёнка, обучать его правильному туалету носа и не допускать ковыряния в носу. При появлении отёка или гиперемии в области фурункула пациенту рекомендуется обращаться в оториноларингологический стационар.

5.3 Показания к госпитализации

У детей установленный диагноз абсцесса, фурункула или карбункула носа является показанием к госпитализации в круглосуточный оториноларингологический стационар. Взрослые в стадии инфильтрации могут получать лечение у оториноларинголога амбулаторно. Пациенты с фурункулом в стадии инфильтрации и сопутствующими заболеваниями, а также пациенты с рецидивирующими фурункулами упоминаются в рекомендации отдельно, однако тактика их ведения не указана. В большинстве случаев пациентов ведёт оториноларинголог в условиях хирургического стационара.

> В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена и тактика их ведения не указана; по контексту, по-видимому, подразумевается госпитализация. Кроме того, в информации для пациента (приложение В) при отёке или гиперемии в области фурункула всем пациентам рекомендуется обращаться в оториноларингологический стационар, хотя гиперемия и отёк отмечаются уже в стадии инфильтрации, при которой взрослые, согласно разделу 6, могут получать лечение амбулаторно.

Пациента выписывают при положительной динамике и отсутствии осложнений: после разрешения абсцесса, фурункула или карбункула, при удовлетворительном общем состоянии и нормализации температуры тела.

При неосложнённом течении прогноз благоприятный. У пациентов с первичным или вторичным иммунодефицитом и с сахарным диабетом следует ожидать более тяжёлого течения и высокого риска осложнений.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Абсцесс. Фурункул носа. Карбункул носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	956_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 1.6 фурункул локализуется «в области дна носа у нижней губы», тогда как в определениях указано «у верхней губы».
- В таблице 1 разовая доза диклофенака указана как «75 мл».
- В таблице 2 для метамизола натрия у детей 1–3 лет указано «100–2500 мг» (объёму 0,2–0,5 мл соответствуют 100–250 мг), а возраст «79 лет» означает 7–9 лет.
- Дозы антибактериальных препаратов в тексте раздела 3.1 и в таблице 3 не совпадают: доза цефазолина у детей, максимальная доза ампициллина с сульбактамом у взрослых и его доза у новорождённых, суточная доза амоксициллина с клавулановой кислотой у детей.
- Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице 3 указана как «0,2–0,9 мг» вместо граммов; в тексте фраза «противопоказан детям в возрасте старше до 3-х лет» искажена (по контексту имеется в виду возраст младше 3 лет).
- Цефдиторену присвоен код АТХ N07AX02, левофлоксацину приведён неполный код J01MA.
- Состав консультантов при внутричерепных осложнениях в разделе 2.5 и в критериях качества (невролог, офтальмолог) не совпадает с алгоритмом в приложении Б (нейрохирург, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург).
- В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена; рекомендация из приложения В обращаться в стационар при любом отёке или гиперемии расходится с возможностью амбулаторного лечения взрослых в стадии инфильтрации.
- Показания к хирургическому лечению сформулированы по-разному: в разделе 3.2 указаны абсцедирование и карбункул, в тезисе-рекомендации указано осложнённое течение, в критериях качества указана стадия абсцедирования.
- Раздел «Иное лечение» пронумерован как 4 вместо 3.3, вследствие чего номер 4 повторяется дважды.
- В комментарии о бактериофагах упомянута «комплексная терапия ОС»; сокращение в рекомендации не расшифровано и к фурункулу носа, по-видимому, не относится.

Клинические рекомендации

Аллергический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.1** — Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений **J30.2** — Другие сезонные аллергические риниты **J30.3** — Другие аллергические риниты **J30.4** — Аллергический ринит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 11.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается при наличии не менее двух из четырёх симптомов (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу), беспокоящих ежедневно не менее часа, связи симптомов с аллергеном и положительных результатах аллергологического обследования.
- Лечение строится по ступенчатому принципу. На первой ступени применяют один препарат: антигистаминный внутрь или интраназально, кромоглициевая кислота или монтелукаст. На второй ступени предпочтителен интраназальный глюкокортикостероид. На третьей ступени к нему добавляются один или два препарата первой ступени. Четвёртая ступень предусматривает назначение омализумаба, решение о котором принимает только специалист.
- Интраназальные глюкокортикостероиды превосходят по эффективности антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту, особенно при выраженной заложенности носа.
- Сосудосуживающие препараты допустимы только при обострении с выраженной заложенностью носа и только коротким курсом, 3–7 дней.
- Контроль симптомов оценивается по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и через 2–4 недели лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Аллергический ринит является IgE-опосредованным воспалительным заболеванием слизистой оболочки носа, развивающимся под действием аллергенов. Заболевание характеризуется наличием не менее двух симптомов (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в полости носа), проявляющихся ежедневно в течение часа и более.

2.2 Классификация

По этиологическому фактору выделяют сезонный, круглогодичный (бытовой) и профессиональный ринит. По течению различают интермиттирующий ринит, при котором симптомы беспокоят менее 4 дней в неделю или менее 4 недель в году, и персистирующий, при котором симптомы сохраняются более 4 дней в неделю и более 4 недель в году.

При лёгком течении симптомы не нарушают сон и повседневную активность. При среднетяжёлом течении симптомы препятствуют работе, учёбе, занятиям спортом и нарушают сон. При тяжёлом течении без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать. Кроме того, выделяют периоды обострения и ремиссии.

В формулировке диагноза указываются аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельной формой является локальный аллергический ринит. Для него характерны типичные симптомы с чёткой связью с аллергеном при отрицательных результатах кожных проб и исследования специфических IgE в крови. Определение специфических IgE в носовом секрете в России не проводится, назальные провокационные тесты положительны.

2.3 Жалобы и анамнез

Пациенты предъявляют жалобы на заложенность носа с дыханием через рот, сопением, храпом и изменением голоса; водянистые выделения из носа; чихание, нередко приступообразное, чаще в утренние часы; зуд, реже жжение в носу, в ряде случаев зуд нёба и глотки. Характерен «аллергический салют» (потирание кончика носа ладонью), вследствие которого формируется поперечная носовая складка. На поздних стадиях отмечается снижение обоняния.

У каждого пациента с подозрением на аллергический ринит подробно собирают жалобы и анамнез. При круглогодичной форме ведущим симптомом является заложенность носа со слизистыми выделениями, при сезонной форме преобладают приступы чихания, зуд и ринорея. Следует уточнить связь симптомов с аллергеном и наличие аллергических заболеваний у пациента и его кровных родственников.

Обильные выделения и нарушение проходимости слуховых труб могут сопровождаться раздражением и отёком кожи над верхней губой и в области крыльев носа, носовыми кровотечениями после сморкания, болью в горле и покашливанием, болью и треском в ушах при глотании, снижением слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром, представляющий собой перекрёстную непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Его проявления варьируют от зуда в полости рта до анафилаксии.

2.4 Физикальное обследование

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей, общий осмотр и аускультацию для выявления бронхиальной астмы, конъюнктивита и атопического дерматита. Характерны затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот, тёмные круги под глазами, мацерация кожи над верхней губой, отёчность лица.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании характерных жалоб (не менее двух симптомов из четырёх, ежедневно не менее часа), данных анамнеза, указывающих на связь с аллергеном или на наличие других аллергических заболеваний, и положительных результатов аллергологического обследования.

Ведение пациента осуществляется совместно оториноларингологом и аллергологом-иммунологом. В задачи оториноларинголога входят риноскопия и эндоскопическое исследование, дифференциальная диагностика, выявление осложнений и анатомических нарушений, определение показаний к хирургическому лечению. Аллерголог-иммунолог проводит кожные и провокационные тесты и оценивает их результаты, исключает бронхиальную астму и решает вопрос о проведении аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

3.1 Осмотр ЛОР-органов

Переднюю риноскопию выполняют всем пациентам. Как правило, определяются отёк носовых раковин и обильный водянистый секрет. Слизистая оболочка ярко-красная в период обострения сезонного ринита, цианотичная или серая при круглогодичном рините, в ряде случаев пятнистая («мраморная», симптом Воячека); могут выявляться полипы.

Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки и околоносовых пазух необходимо при неэффективности стандартной терапии или осложнённом течении ринита. Проба с сосудосуживающим средством позволяет оценить обратимость назальной обструкции.

Контроль симптомов оценивается по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и через 2–4 недели лечения. Методика оценки приведена в разделе «Контроль лечения».

3.2 Аллергологическое обследование

При отсутствии противопоказаний выполняют кожные пробы (prick-тесты или скарификационные пробы) для подтверждения аллергической природы ринита, выявления причинно-значимых аллергенов и решения вопроса об АСИТ.

Пробы проводятся в аллергологическом кабинете. На результат влияют возраст младше 5 и старше 60 лет, приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов, дермографизм (ложноположительный результат) и недавно перенесённая острая аллергическая реакция (ложноотрицательный результат).

К определению специфических IgE в сыворотке крови прибегают, если кожные пробы противопоказаны или невозможны, их результат сомнителен или расходится с данными анамнеза.

При использовании метода ImmunoCAP результат считается положительным при значении более 0,70 kU/l.

Исследование общего IgE для диагностики аллергического ринита нецелесообразно, поскольку не несёт необходимой диагностической информации.

3.3 Лабораторные исследования

Развёрнутый общий анализ крови необходим при выраженных симптомах в период обострения или перед проведением АСИТ. Оценивается содержание эозинофилов; лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево является поводом для поиска инфекции, прежде всего острого риносинусита.

При выраженных симптомах в период обострения возможно цитологическое исследование смывов из полости носа. Для аллергического ринита характерна эозинофилия носового секрета, составляющая 10% и более.

Общий IgE исследуют только перед назначением омализумаба (с 12 лет, при тяжёлом течении), поскольку по его уровню рассчитывается доза препарата.

3.4 Инструментальные исследования

Рентгенографию околоносовых пазух выполняют при симптомах риносинусита (гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, повышение температуры тела) или при лейкоцитозе со сдвигом лейкоцитарной формулы влево.

Компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух показана при неэффективности лечения, выраженной и длительной назальной обструкции, стойкой аносмии или отрицательных результатах аллергологического обследования, прежде всего при подозрении на полипозный риносинусит.

Спирометрию с бронхолитиком выполняют при кашле, свистящем дыхании и одышке, а также перед АСИТ для выявления скрытого бронхоспазма.

Перед проведением инъекционной АСИТ регистрируют электрокардиограмму (ЭКГ).

3.5 Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит дифференцируют с инфекционным ринитом, аномалиями внутриносовых структур, аденоидами у детей и полипозным риносинуситом, а также с неаллергическими ринитами: эозинофильным, лекарственным (на фоне приёма нестероидных противовоспалительных препаратов, альфа- и бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, резерпина, длительного применения деконгестантов), гормональным (беременность, пубертатный период, менструальный цикл, приём контрацептивов, акромегалия, гипотиреоз), профессиональным, атрофическим ринитом пожилых, пищевым и алкогольным, идиопатическим. Кроме того, следует исключить первичную цилиарную дискинезию и муковисцидоз.

4. Лечение

Целью лечения является полный контроль симптомов. При продолжающемся контакте с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями достижимо лишь уменьшение выраженности симптомов.

4.1 Ступенчатая терапия

На любой ступени показаны исключение контакта с аллергеном, хирургическое лечение сопутствующей патологии при наличии показаний и рассмотрение вопроса об АСИТ.

Ступень	Назначения
1-я ступень	Один препарат: антигистаминный препарат без седативного эффекта внутрь, антигистаминный препарат интраназально, кромоглициевая кислота интраназально или монтелукаст.
2-я ступень	Один препарат, предпочтительно интраназальный глюкокортикостероид; возможно назначение антигистаминного препарата внутрь или интраназально либо монтелукаста.
3-я ступень	Интраназальный глюкокортикостероид в сочетании с одним или несколькими препаратами: антигистаминным препаратом внутрь или интраназально, монтелукастом.
4-я ступень	Омализумаб при тяжёлом течении, с 12 лет. Назначается только специалистом.
Препараты скорой помощи	Сосудосуживающие препараты коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Перед переходом на ступень выше следует повторно оценить правильность диагноза, приверженность лечению, наличие сопутствующих заболеваний и анатомических аномалий.

4.2 Системные антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты без седативного эффекта рекомендованы всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность носа. Цетиризин в высоких дозах чаще других препаратов вызывает сонливость.

Назначение седативных антигистаминных препаратов первого поколения не рекомендуется, поскольку они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к развитию апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	Взрослым и детям с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 2,5 мг, детям 1–5 лет — 1,25 мг, детям 6–12 месяцев — 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–12 лет при массе тела до 30 кг — 5 мг, более 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки, детям 1–2 лет — 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз в сутки.

Препарат	Доза
Эбастин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10–20 мг 1 раз в сутки. Имеется лекарственная форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	Взрослым и детям старше 12 лет — 20 мг 1 раз в сутки.

4.3 Интраназальные глюкокортикостероиды

Интраназальные глюкокортикостероиды показаны при среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно при выраженной заложенности носа. По эффективности они превосходят антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту и уменьшают также глазные симптомы. Возможны сухость слизистой оболочки, носовые кровотечения, редко перфорация носовой перегородки, поэтому пациента следует обучить правильной технике введения спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза; при необходимости до 4 доз. Детям 2–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза. Детям 2–12 лет — 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза. Детям 4–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, для поддерживающей терапии — 200 мкг в сутки. Не более 3 месяцев.
Беклометазон	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки (максимальная доза); для поддерживающей терапии — 1 доза 2 раза в сутки.

4.4 Интраназальные антигистаминные и комбинированные препараты

Интраназальные антигистаминные препараты быстро, в течение 30 минут, уменьшают выраженность симптомов. Их применяют в монотерапии или в сочетании с другими препаратами; возможна сухость слизистой оболочки носа.

При необходимости одновременного интраназального применения антигистаминного препарата и глюкокортикостероида целесообразно назначение одного комбинированного спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки, с 12 лет при необходимости 2 дозы. Не более 6 месяцев.
Левокабастин	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза. При отсутствии эффекта в течение 3 дней препарат отменяется.
Азеластин и флутиказон	Взрослым и детям старше 12 лет — 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	Взрослым с 18 лет — 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки, курс 2 недели.
Мометазон и олопатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина). Детям 6–11 лет только при сезонном рините — 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

4.5 Монелукаст и кромоглициевая кислота

Монелукаст может назначаться при любой степени тяжести, в монотерапии или в сочетании с другими препаратами, однако по эффективности он уступает интраназальным глюкокортикостероидам.

При сопутствующей бронхиальной астме монелукаст позволяет контролировать оба заболевания. Курс лечения составляет от 1 до 3 месяцев и более; согласно инструкции, ограничений по длительности применения нет.

При необходимости назначения и антигистаминного препарата внутрь, и монелукаста возможно применение комбинированной таблетки левоцетиризина с монелукастом.

Кромоглициевую кислоту интраназально используют при лёгком течении. Препарат безопасен, однако по эффективности уступает антигистаминным препаратам, монелукасту и интраназальным глюкокортикостероидам.

Препарат	Доза
Монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 10 мг 1 раз в сутки, детям 6–15 лет — 5 мг, детям 2–6 лет — 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	Взрослым и детям старше 5 лет — 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз. После достижения эффекта возможно применение только при контакте с аллергеном. Курс 4 недели.

4.6 Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью носа сосудосуживающие препараты применяют коротким курсом, 3–7 дней.

Длительное применение не рекомендуется: после 10 дней развиваются привыкание, отёк слизистой оболочки и медикаментозный ринит.

При необходимости интраназального применения и антигистаминного, и сосудосуживающего препарата возможно назначение комбинации диметиндена с фенилэфрином, не более 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки. Детям 1–6 лет — 1–2 капли 0,025%, детям от 5 недель до года — 1–2 капли 0,01%, до 4 недель — 1 капля 0,01% 2–3 раза в сутки. Курс 3–4 дня.
Ксилометазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки, детям 2–6 лет — 1 доза 0,05% 1–2 раза в сутки. Не более 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки. Детям 1–6 лет — только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

4.7 Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или неэффективности третьей ступени возможно назначение короткого курса глюкокортикоидов внутрь.

Системные глюкокортикоиды являются терапией четвёртой линии или средством лечения тяжёлого обострения. Введение растворов и депо-форм глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо, поскольку сопряжено с риском тяжёлых осложнений вплоть до слепоты. Доза преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирается индивидуально; преднизолон в таблетках противопоказан детям до 3 лет.

Назначение депо-форм глюкокортикоидов не рекомендуется в связи с быстрым развитием побочных эффектов, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Назначение омализумаба рассматривается с 12 лет при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении в случае неэффективности третьей ступени.

Препарат вводится подкожно каждые 2 или 4 недели в дозе от 75 до 600 мг в соответствии с таблицей дозирования. При сезонном рините введение начинается не менее чем за неделю до начала пыления и продолжается до его окончания.

4.8 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам рекомендуется по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение контакта облегчает течение заболевания и снижает потребность в лекарственных препаратах.

Рекомендуется применение изотонических солевых растворов для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением интраназального глюкокортикостероида полость носа целесообразно промыть: это улучшает контакт препарата со слизистой оболочкой и снижает частоту сухости и носовых кровотечений.

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия

Проведение АСИТ рассматривается у всех пациентов в период ремиссии, в том числе медикаментозной. Метод уменьшает выраженность симптомов и потребность в лекарственных препаратах, предупреждает развитие бронхиальной астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяются аллергологом-иммунологом, которым и назначается АСИТ.

4.10 Хирургическое лечение

К хирургическому лечению прибегают только при сопутствующей патологии; показания определяются оториноларингологом по данным эндоскопического и рентгенологического исследования. Плановые операции в сезон пыления причинно-значимых аллергенов не выполняют.

4.11 Нетрадиционные методы

Гомеопатия, фитотерапия, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапия не рекомендуются в связи с отсутствием доказательств их эффективности.

Иглоукалывание может рассматриваться в составе комплексной терапии.

---

5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации

5.1 Возрастные ограничения

Мометазон и флутиказона фуроат разрешены к применению с 2 лет, флутиказона пропионат с 4 лет, беклометазон и будесонид с 6 лет.

Цетиризин и дезлоратадин разрешены с 6 месяцев, лоратадин с 2 лет. Антигистаминные препараты первого поколения (хлоропирамин, диметинден) разрешены с 1 месяца, однако по достижении ребёнком соответствующего возраста предпочтение отдаётся препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст в дозе 4 мг разрешён с 2 лет, в дозе 5 мг с 6 лет.

Согласно инструкциям к препаратам, АСИТ возможна с 5 лет.

Детям интраназальные глюкокортикостероиды применяют в минимальной эффективной дозе; при длительном применении необходим контроль роста.

Предпочтительно ограничить применение препаратов с высокой биодоступностью: будесонида (30–40%) и беклометазона (40–50%). Биодоступность дексаметазона превышает 80%, что следует учитывать, поскольку он входит в состав многих комбинированных капель.

5.2 Беременность и лактация

У беременных необходимо учитывать возможность ринита беременных, который характеризуется заложенностью носа без признаков инфекции и аллергии и полностью регрессирует в течение 2 недель после родов. Выявленная сенсибилизация свидетельствует в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и лактации не выполняют; для аллергологического обследования исследуется уровень специфических IgE в сыворотке крови.

Предпочтение отдаётся элиминационным мероприятиям и промыванию полости носа. К лекарственной терапии переходят при их недостаточной эффективности с учётом рисков для матери и ребёнка.

Для лоратадина, цетиризина и будесонида доказательства риска для человека отсутствуют (категория B по классификации Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, FDA).

В первом триместре назначения лекарственных препаратов по возможности следует избегать, за исключением случаев жизненной необходимости.

В период лактации предпочтительно ограничиться местными средствами с минимальной биодоступностью, поскольку все системные препараты проникают в грудное молоко.

6. Контроль лечения

Визуальная аналоговая шкала представляет собой линию длиной 10 см, на которой пациент отмечает выраженность беспокоящих его симптомов. При отметке от 0 до 50 мм ринит считается контролируемым, при отметке 50 мм и более неконтролируемым.

У подростков и взрослых при отметке 5 см и более лечение начинается с антигистаминных препаратов на 2–4 недели. При достижении контроля лечение продолжается по потребности и рассматривается вопрос об АСИТ. При отсутствии контроля добавляется интраназальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё на 2–4 недели. Если контроль не достигнут и в этом случае, следует пересмотреть диагноз, провести поиск сопутствующей патологии, рассмотреть АСИТ и хирургическое лечение.

Ринит считается контролируемым, если за последние 4 недели симптомы отсутствовали, не нарушались сон и дневная активность, а результат теста «дыхание с закрытым ртом» нормальный. Любое отклонение, в том числе учащение потребности в препаратах скорой помощи, свидетельствует о потере контроля; в этом случае возможен переход на ступень выше.

Для проведения теста пациенту предлагается закрыть рот и в течение 30 секунд дышать только носом.

При ведении дневника симптомов (шкала TNSS, суммарная оценка назальных симптомов) пациент ежедневно оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов; суммарный балл составляет от 0 до 12. Врач рассчитывает среднее значение за 7 дней. Дневник ведётся в период обострения и для оценки эффективности АСИТ.

Отдельно оценивается медикаментозная нагрузка: приём только антигистаминных препаратов соответствует 1 баллу, интраназальных глюкокортикостероидов 2 баллам, системных глюкокортикоидов 3 баллам.

7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Каждому пациенту или его представителям следует разъяснить суть заболевания, составить индивидуальный план лечения и обучить навыкам самостоятельного контроля заболевания.

Пациенты подлежат диспансерному наблюдению у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые не реже одного раза в год, дети не реже двух раз в год. Наблюдение осуществляется пожизненно или до достижения стойкой ремиссии длительностью 3 года и более.

АСИТ применяется и для вторичной профилактики: она позволяет предупредить развитие бронхиальной астмы, утяжеление течения ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации рекомендуется ограничить употребление перекрёстно реагирующих продуктов и растительных лекарственных средств.

Лечение, как правило, амбулаторное. Показаниями к госпитализации являются крайне тяжёлое или осложнённое течение, у детей тяжёлое обострение с выраженной заложенностью носа, а также плановое проведение ускоренного курса АСИТ. Выписка осуществляется при достижении контроля над симптомами или после завершения курса АСИТ.

8. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года
Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

8.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная как «22.4 мкг»; эти значения следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», тогда как в оригинальном названии указано «untreated patients», то есть пациенты, не получавшие лечения.
- В тексте доз мометазона и флутиказона фуроата повторяются фрагменты фраз; на значения доз это не влияет.

Клинические рекомендации

Болезнь Меньера

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H81.0** — Болезнь Меньера
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/18_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз достоверной болезни Меньера устанавливается при наличии не менее двух спонтанных приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов, сенсоневральной тугоухости на низких и средних частотах, подтверждённой аудиометрией во время или после приступа, флюктуирующих слуховых симптомов (слух, шум, ощущение полноты в ухе) и при отсутствии других причин.
- Обследование всех пациентов включает тональную пороговую аудиометрию для оценки степени тугоухости и импедансометрию (тимпанометрию и акустическую рефлексометрию) для исключения патологии среднего уха.
- Для купирования приступа применяются атропин или платифиллин подкожно, антигистаминные препараты (дименгидринат, дифенгидрамин) или бензодиазепины (лоразепам, диазепам) на срок не более 3 суток; ввиду тошноты и рвоты предпочтительно парентеральное введение препаратов.
- После перенесённого приступа, а также при повторении приступов чаще одного раза в 3 месяца применяют бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев и более.
- Если консервативное лечение в течение 6–12 месяцев неэффективно, переходят к хирургическому лечению: начинают со слухосохраняющих вмешательств, а деструктивные оставляют для второго этапа или для случаев социально незначимого слуха.
- Компьютерная томография (КТ) височных костей и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов необходимы для исключения новообразований, прежде всего акустической шванномы при односторонней сенсоневральной тугоухости.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Болезнь Меньера (БМ) является заболеванием внутреннего уха, которое характеризуется повторяющимися приступами системного головокружения, а также шумом в ушах и сенсоневральной тугоухостью.

2.2 Классификация

Согласно классификации Американской академии оториноларингологии и хирургии головы и шеи (AAO-HNS), выделяются четыре формы заболевания: несомненная, достоверная, вероятная и возможная.

Начало заболевания может быть различным. При кохлеарной форме вначале возникают слуховые расстройства, а затем вестибулярные. При классическом варианте слуховые и вестибулярные нарушения появляются одновременно: уже первый приступ головокружения сопровождается снижением слуха и шумом в ухе. Реже встречается вестибулярная форма, при которой заболевание начинается с приступов головокружения, а слуховые расстройства присоединяются позднее.

По данным ряда авторов, флюктуация слуха в сочетании с головокружением наблюдается у 82,7% пациентов, без головокружения у 17,3%; по другим данным, заболевание начинается с изолированной кохлеарной симптоматики у 54,4% пациентов, с классической картины у 45,6%.

2.3 Клиническая картина

Заболевание характеризуется триадой симптомов: приступами системного головокружения, шумом в ухе и тугоухостью. Приступ развивается внезапно, в любое время суток и года, на фоне полного здоровья и ничем не провоцируется. В ряде случаев ему предшествует аура в виде появления или усиления заложенности и шума в поражённом ухе. Приступ всегда сопровождается вегетативными проявлениями, прежде всего тошнотой и рвотой, длится несколько часов (чаще 4–6) и купируется самостоятельно, без применения лекарственных препаратов. Шум в ухе односторонний, чаще низко- или среднечастотный, усиливается перед приступом и во время него.

Тугоухость, как правило, односторонняя и носит флюктуирующий характер. При аудиологическом исследовании определяется так называемая скалярная, или ложная сенсоневральная, тугоухость: горизонтальный или восходящий тип аудиометрической кривой с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах. Пороги восприятия ультразвука в пределах нормы, отмечается латерализация ультразвука в сторону хуже слышащего уха.

2.4 Стадии заболевания

Первая стадия (начальная). Приступы возникают редко, 1–2 раза в год или даже один раз в 2–3 года, продолжаются в среднем 1–3 часа и сопровождаются тошнотой и рвотой. Шум, заложенность или ощущение распирания в ухе возникают до или во время приступа, но постоянными симптомами не являются. Для этой стадии характерна флюктуация слуха: его ухудшение, как правило, перед приступом и последующее улучшение. Некоторые пациенты отмечают значительное улучшение слуха сразу после приступа и его снижение до прежнего уровня в течение последующих суток.

Вторая стадия (разгар заболевания). Приступы приобретают типичный характер, с интенсивным системным головокружением и выраженными вегетативными проявлениями, и повторяются от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю или ежедневно. Шум в ухе беспокоит постоянно и усиливается во время приступа, ощущение заложенности и дискомфорта в поражённом ухе отмечается ежедневно, снижение слуха прогрессирует от приступа к приступу.

Третья стадия (затухающая). Типичные приступы урежаются или прекращаются, однако пациента постоянно беспокоит ощущение шаткости и неустойчивости. Отмечается выраженное снижение слуха на поражённое ухо, часто в процесс вовлекается второе ухо. Возможно развитие отолитовых кризов Тумаркина, то есть приступов внезапного падения вследствие резкого смещения отолитовых рецепторов и внезапной активации вестибулярных рефлексов; они могут приводить к серьёзным травмам.

> Длительность приступа в тексте рекомендации указана неодинаково: в общем описании клинической картины она составляет несколько часов (чаще 4–6), для первой стадии в среднем 1–3 часа, в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.

2.5 Степень тяжести

С учётом частоты и длительности приступов и сохранности трудоспособности выделяются три степени тяжести. При тяжёлой степени приступы ежедневные или еженедельные, продолжительностью несколько часов, со всем комплексом статокинетических и вегетативных расстройств; трудоспособность утрачена. При средней степени приступы еженедельные или ежемесячные, также продолжительностью несколько часов, статокинетические расстройства умеренные, вегетативные выражены; трудоспособность утрачивается во время приступа и в течение нескольких часов после него. При лёгкой степени приступы непродолжительные, ремиссии длятся месяцы или годы.

2.6 Жалобы

Пациенты предъявляют жалобы на приступы нарастающей глухоты, шум в ушах, периодическую потерю равновесия, головокружение, тошноту вплоть до рвоты.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается по критериям AAO-HNS (редакции 1972, 1985 и 1995 годов) и по критериям 2015 года, согласованным Обществом Барани, Европейской академией отологии и нейроотологии (EAONO), комитетом по равновесию AAO-HNS и Корейским обществом равновесия.

3.1 Диагностические критерии

Форма	Критерии
Несомненная	Гистологически подтверждённый эндолимфатический гидропс; не менее двух приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов; сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; флюктуирующие слуховые симптомы (слух, шум, ощущение полноты в ухе).
Достоверная	Не менее двух спонтанных приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов; сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; флюктуирующие слуховые симптомы; отсутствие других причин.
Вероятная	Не менее одного приступа головокружения; сенсоневральная тугоухость, подтверждённая по крайней мере однократной аудиометрией; шум или ощущение заложенности в поражённом ухе; отсутствие других причин, объясняющих симптомы.
Возможная	Приступы головокружения без подтверждённого снижения слуха либо стойкая или непостоянная сенсоневральная тугоухость с нарушением равновесия, но без явных приступов головокружения; отсутствие других причин, объясняющих симптомы.

3.2 Физикальное обследование

Необходимо комплексное общеклиническое обследование с участием терапевта и невролога. В его объём входят акуметрия (исследование слуха шёпотной и разговорной речью, камертональные пробы Вебера, Ринне и Федериче), оценка спонтанного нистагма, тест импульсного (быстрого) поворота головы (тест Хальмаги–Кертойза), статокоординаторные и статокинетические пробы (поза Ромберга, проба Фишера–Барре, ходьба по прямой и фланговая походка, проба на диадохокинез), позиционные пробы (проба Дикса–Холлпайка, roll-тест Пагнини–Макклюра).

3.3 Лабораторные исследования

Для дифференциальной диагностики выполняют общий (клинический) и биохимический общетерапевтический анализы крови.

3.4 Аудиометрия и импедансометрия

Степень тугоухости определяют по данным тональной пороговой аудиометрии; исследование выполняется всем пациентам.

Импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия) также необходима каждому пациенту: она позволяет исключить патологию среднего уха.

При клинических признаках вероятной болезни Меньера, а также при неэффективности консервативной терапии гидропс лабиринта подтверждают с помощью определения порогов чувствительности к ультразвуку и его латерализации, электрокохлеографии (ЭКоГ) или дегидратационного теста, по отдельности или в сочетании.

К исследованию вызванной отоакустической эмиссии и регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) прибегают при противопоказаниях к МРТ головного мозга (например, при наличии металлических конструкций в теле), а также при сомнительных результатах тональной аудиометрии (подозрение на аггравацию или симуляцию).

При болезни Меньера на аудиограмме определяется скалярная, или ложная сенсоневральная, тугоухость: горизонтальный или восходящий тип кривой с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах. Пороги восприятия ультразвука в пределах нормы, отмечается латерализация ультразвука в сторону хуже слышащего уха. Возможно снижение амплитуды пиков спонтанной отоакустической эмиссии.

При ретрокохлеарном уровне поражения отмечается повышение порогов акустического рефлекса относительно нормальных порогов слышимости.

Критериями ретрокохлеарной дисфункции по данным КСВП являются отсутствие всех пиков с I по V, которое трудно объяснить потерей слуха; отсутствие всех пиков, следующих за I или III; удлинение межпикового интервала I–V более 4,4 мс; снижение отношения амплитуд V/I менее 0,5, особенно в сочетании с другими изменениями. Диагностическое значение имеет также патологически большая межауральная разница параметров, особенно межпиковых интервалов, если её трудно объяснить односторонней или асимметричной тугоухостью периферического уровня.

Универсального метода выявления гидропса лабиринта не существует. Для подтверждения диагноза необходим широкий спектр исследований с оценкой результатов в динамике, при этом результаты в значительной степени зависят от стадии заболевания.

3.5 Вестибулярные исследования

Вестибулометрия необходима для дифференциальной диагностики в тех случаях, когда диагноз невозможно установить на основании клинических данных, а также при планировании хирургического лечения.

В межприступном периоде спонтанная вестибулярная симптоматика отсутствует, статическое и динамическое равновесие в пределах нормы, в том числе по данным постурографии (стабилографии). Во время приступа развивается периферический вестибулярный синдром: системное головокружение, тошнота, рвота, нарушение равновесия, горизонтальный вестибулярный нистагм. При вестибулометрии в межприступном периоде выявляется угнетение вестибулярной функции, более выраженное на стороне поражения.

По тем же показаниям (дифференциальная диагностика и планирование хирургического лечения) выполняют видеонистагмографию (ВНГ) с записью калорической или вращательной пробы, видеоимпульсного и других тестов.

3.6 Лучевые методы исследования

Из лучевых методов используют компьютерную томографию височных костей и магнитно-резонансную томографию головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов, в том числе с контрастированием.

Эти исследования позволяют исключить новообразования (при односторонней сенсоневральной тугоухости прежде всего акустическую шванному), демиелинизирующий процесс, нейроваскулярный конфликт, приобретённые и врождённые структурные изменения височных костей.

3.7 Дифференциальная диагностика

Диагноз	Отличительные признаки
Болезнь Меньера	Приступы системного головокружения, сопровождающиеся снижением слуха, ощущением распирания и шумом в ухе, тошнотой и рвотой
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)	Кратковременные приступы системного головокружения, возникающие при изменении положения тела
Вестибулярный нейронит	Резко выраженное вращательное головокружение, расстройство равновесия, тошнота и рвота на фоне вирусной инфекции
Перилимфатическая фистула	Головокружение различной степени выраженности и нарушения слуха вплоть до глухоты после травмы уха или на фоне хронического отита; симптомы провоцируются изменением давления или громкими звуками
Инфаркт лабиринта	Острое системное головокружение, часто в сочетании с острой односторонней глухотой и шумом в ухе
Аутоиммунные заболевания внутреннего уха	Прогрессирующее головокружение преимущественно вестибулярного характера с двусторонним снижением слуха и другими признаками аутоиммунного заболевания
Вестибулярная мигрень	Мигренозная головная боль при части приступов головокружения

4. Лечение

Лечение включает три направления: медикаментозное купирование приступа головокружения, медикаментозную профилактику в межприступном периоде и хирургическое лечение.

4.1 Купирование приступа

Для купирования острого приступа вестибулярного головокружения подкожно вводится #атропин или #платифиллин, которые блокируют афферентную импульсацию от раздражённого лабиринта. Знак # обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

Для купирования приступа применяются также дименгидринат или дифенгидрамин.

Препараты относятся к Н1-антигистаминным средствам, проникают через гематоэнцефалический барьер и действуют как вестибулярные блокаторы центрального действия. Их используют в первые сутки приступа, максимально до 3 суток.

В первые сутки острого головокружения, максимально до 3 суток, для купирования приступа допускается применение #лоразепама или #диазепама.

Ввиду тошноты и рвоты во время приступа предпочтительно парентеральное введение препаратов; по мере купирования симптомов возможен переход на таблетированные формы.

Препарат	Доза
#Атропин	1 мл 0,1% раствора подкожно
#Платифиллин	2 мл 0,2% раствора подкожно
Дименгидринат	50–100 мг 2–3 раза в сутки
Дифенгидрамин	25–50 мг внутрь 3–4 раза в сутки; внутримышечно — #дифенгидрамин 10–50 мг
#Лоразепам	1 мг, возможно сублингвальное применение

Препарат	Доза
#Диазепам	10 мг внутримышечно

4.2 Терапия в межприступном периоде

Бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки (суточная доза 48 мг) рекомендован после перенесённого приступа головокружения, а также при межприступном периоде менее 3 месяцев; курс составляет 2–3 месяца и более.

Бетагистин улучшает кровообращение в сосудистой полоске внутреннего уха, снижает возбудимость нейронов вестибулярных ядер и ускоряет восстановление вестибулярной функции, в том числе за счёт активации центральной вестибулярной компенсации.

Курсами назначаются диуретики (калийсберегающие, тиазидные и др.) или ингибиторы карбоангидразы, оптимально ацетазоламид. В рекомендации приведён пример схемы: в 1–3-й день по 1 таблетке 2 раза в день (утром и днём), в 7–9-й и 13–15-й дни по 1 таблетке утром. Курс подбирается индивидуально.

Петлевые диуретики не применяются ввиду возможного ототоксического действия. При длительном приёме ацетазоламида следует контролировать уровень электролитов крови и при необходимости восполнять их.

Всем пациентам рекомендуется диетотерапия: ограничение поваренной соли до 2 г в сутки, исключение глутамата натрия, сбалансированное питание, направленное на нормализацию обменных процессов, прежде всего водно-солевого обмена.

Потребление соли и готовых продуктов следует максимально ограничить, алкоголь, кофеин и никотин исключить, жидкость потреблять умеренно.

Плановую инфузионную дегидратационную терапию в первые 2 года заболевания повторяют с интервалом 6–12 месяцев, в последующем с интервалом 2–3 года. Конкретные препараты в рекомендации не указаны.

4.3 Хирургическое лечение

Показанием к хирургическому лечению является неэффективность консервативной терапии в течение 6–12 месяцев.

При первой и второй стадиях заболевания хирургическое лечение начинают со слухосохраняющих вмешательств: хордоплексустомии, интратимпанального введения глюкокортикоидов, обнажения (дренирования) эндолимфатического мешка или селективной лазеродеструкции ампулярного рецептора горизонтального полукружного канала.

К деструктивным вмешательствам (интратимпанальное введение гентамицина, лазеродеструкция лабиринта, вестибулярная нейроэктомия) переходят вторым этапом при неэффективности слухосохраняющей операции или при социально незначимом слухе.

4.4 Медицинская реабилитация

При нарушении равновесия в межприступном периоде на третьей стадии заболевания вестибулярную функцию корригируют средствами лечебной физкультуры. Двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость со средними порогами слуха в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе выше 31 дБ является показанием к слухопротезированию.

При развитии соматоформных расстройств на фоне хронической вестибулярной дисфункции показана психолого-социальная реабилитация.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с болезнью Меньера подлежат диспансерному наблюдению с ежегодным профилактическим осмотром для оценки эффективности терапии, контроля слуховой и вестибулярной функции.

К мерам профилактики рекомендация относит формирование здорового образа жизни, раннее выявление воспалительных заболеваний ЛОР-органов, особенно у детей, и предупреждение рецидивов хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов посредством диспансерного наблюдения.

Пациенту рекомендуется избегать резких перепадов давления в среднем ухе (подводное плавание, резкое сморкание, авиаперелёты). В рационе ограничиваются углеводы, солёные, острые и жирные мясные продукты; ежедневно следует употреблять продукты, богатые калием (печёный картофель, творог, курага). Исключаются алкоголь, курение, кофеин и продукты с консервантами, особенно с глутаматом натрия. Следует избегать переутомления, работы на высоте и с движущимися предметами.

5.1 Организация медицинской помощи

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-оториноларингологом в амбулаторных условиях.

При тяжёлом состоянии пациента показана госпитализация в оториноларингологическое отделение; при тяжёлом течении пациент госпитализируется бригадой скорой медицинской помощи непосредственно в специализированное оториноларингологическое отделение, минуя амбулаторное звено.

Критериями выписки являются прекращение или урежение приступов головокружения либо улучшение или стабилизация порогов слуха.

На течение и исход заболевания влияют его длительность и тяжесть, сопутствующая патология, возраст пациента, наличие и характер осложнений.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Болезнь Меньера»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «пересмотр не позднее 2026 года»; в приложении А2 — обновление каждые 3 года
Код в рубрикаторе	18_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность приступа указана неодинаково: в описании клинической картины «чаще 4-6 ч.», для первой стадии «в среднем от 1 до 3 часов», в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.
- Срок пересмотра не согласован: на титульном листе указано «пересмотр не позднее 2026», то есть через 2 года после утверждения, в приложении А2 указано обновление «каждые 3 года».
- В критериях качества для обследований указан УДД 4, тогда как для тех же рекомендаций в разделе 2 указан УДД 5.
- Схема применения ацетазоламида приведена в таблетках, без указания дозы в миллиграммах.
- Для плановой инфузионной дегидратационной терапии (раздел 6) не названы препараты и не указаны УУР и УДД; уровни не указаны также для рекомендаций по хирургическому лечению и диспансерному наблюдению.

- Профилактика сформулирована через воспалительные заболевания ЛОР-органов «особенно в педиатрической практике», хотя рекомендация адресована взрослым, а воспаление среди причин заболевания не названо.
- Опечатки: «импендансометрии» вместо «импедансометрии», «Н3-гистаминовых» вместо «Н3-гистаминовых».

Клинические рекомендации

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.1** — Хронический назофарингит **J35.1** — Гипертрофия миндалин **J35.2** — Гипертрофия аденоидов **J35.3** — Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/662_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин само по себе не является патологией. Показанием к обследованию служат жалобы, клинические проявления или сопутствующее заболевание, на течение которого могут влиять аденоиды и нёбные миндалины.
- Гипертрофия нёбных миндалин диагностируется на основании жалоб, анамнеза и данных фарингоскопии с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин; диагноз гипертрофии аденоидов требует инструментального подтверждения (эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография).
- Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей не проводится.
- При наличии показаний аденоиды и нёбные миндалины оперируют в плановом порядке; при отсутствии показаний или наличии абсолютных противопоказаний необходимо динамическое наблюдение оториноларинголога.
- Консервативное лечение детям с гипертрофией аденоидов назначают только при признаках аденоидита. У детей младше 7–9 лет при отсутствии осложнений и значимого влияния на качество жизни аденоидит не рассматривается как патология, и тактика ограничивается наблюдением.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Гипертрофия аденоидов характеризуется увеличением глоточной миндалины со стойким затруднением носового дыхания и (или) другими осложнениями: обструктивными нарушениями сна, экссудативным средним отитом, деформацией лицевого скелета. Гипертрофия нёбных миндалин представляет собой увеличение одной или обеих нёбных миндалин; она может протекать бессимптомно или проявляться храпом, остановками дыхания во сне, нарушениями глотания и артикуляции, деформацией лицевого скелета.

Аденоидит представляет собой реактивные воспалительные изменения глоточной миндалины как органа местного иммунитета слизистых оболочек в ответ на антигены, попадающие на слизистую оболочку носа и глотки. У детей младше 7–9 лет при отсутствии значимого влияния на качество жизни и осложнений (например, средних отитов) аденоидит не рассматривается как патология.

Острый синусит считается рецидивирующим при 4 и более эпизодах за последний год. Острый средний отит считается рецидивирующим при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

2.2 Этиология

Наиболее вероятными причинами считаются вирусная инфекция, генетическая предрасположенность и влияние факторов окружающей среды. Роль бактериальной инфекции, гастроэзофагеального рефлюкса и аллергии остаётся дискутабельной. Как правило, действует одновременно несколько факторов, и выделить ведущий не удаётся.

Особое внимание уделяется вирусу герпеса IV типа: герпетическая инфекция является одной из частых причин выраженной гипертрофии глоточной миндалины со стойкой обструкцией носоглотки.

2.3 Классификация

Для оценки степени гипертрофии аденоидов в России наиболее широко применяется классификация А. Г. Лихачёва, основанная на том, какую часть сошника прикрывает ткань глоточной миндалины. При I степени ткань миндалины прикрывает не более верхней трети сошника, при II степени от 1/3 до 2/3, при III степени более 2/3.

Для нёбных миндалин наиболее широко применяется классификация Б. С. Преображенского. Расстояние между вертикалью, проведённой через середину язычка, и линией по краю передней (нёбно-язычной) дужки делится на три части. При I степени миндалина занимает треть этого расстояния, при II степени две трети, при III степени миндалины достигают язычка и соприкасаются друг с другом.

2.4 Клиническая картина

Жалобы и симптомы чаще всего отмечаются при гипертрофии III степени. При I и II степени пациенты, как правило, хотя и не всегда, жалоб не предъявляют.

При гипертрофии нёбных миндалин родители, как правило, предъявляют жалобы только на храп. В отличие от храпа при воспалении, он носит постоянный характер и часто не зависит от положения тела во сне. В ряде случаев родители отмечают и классические признаки синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): дневную сонливость и снижение успеваемости. Значительно реже наблюдаются изменения прикуса и лёгкая дисфония.

При гипертрофии аденоидов, в том числе в сочетании с увеличением нёбных миндалин, жалобы более разнообразны. Помимо нарушений дыхания во сне, беспокоят стойкое затруднение носового дыхания и его последствия: постоянно открытый рот, гипоназальность (закрытая гнусавость), сухость во рту. Нередко отмечается снижение слуха вследствие экссудативного среднего отита или указание на повторные острые средние отиты в анамнезе. Даже при II степени ринологические симптомы (заложенность носа, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель) после перенесённого простудного заболевания могут сохраняться до нескольких недель. У школьников с аденоидами часто встречаются острые синуситы, в том числе рецидивирующие.

Основной жалобой при аденоидите является кашель, как правило продуктивный, ночной и утренний; он является проявлением постназального синдрома, то есть стекания отделяемого по задней стенке глотки. Аденоидит может развиваться и при небольших размерах глоточной миндалины. При аденоидите на фоне гипертрофии аденоидов II–III степени пациенты, как правило, одновременно предъявляют жалобы на заложенность носа и кашель.

Реактивные изменения глоточной миндалины после перенесённого простудного заболевания или на фоне аллергического ринита у детей младше 7–9 лет носят физиологический характер. Патологией они не считаются при отсутствии осложнений (средних отитов, острого синусита) и если симптомы (кашель или затруднение носового дыхания) не нарушают сон и дневную активность ребёнка.

Симптомы гипертрофии аденоидов и аденоидита не являются патогномоничными. Гипертрофию аденоидов и нёбных миндалин дифференцируют с острым и хроническим риносинуситом, аллергическим, вазомоторным и гипертрофическим ринитом, искривлением перегородки носа, инородными телами и новообразованиями полости носа и носоглотки. Гипертрофия аденоидов часто сопутствует острому и хроническому синуситу и аллергическому риниту.

Клиническая картина у взрослых не отличается от таковой у детей.

2.5 Жалобы и анамнез

Необходимо уточнить длительность заболевания, с чем пациент связывает его начало, динамику жалоб и их влияние на сон и повседневную активность ребёнка, проводившееся лечение, его эффективность и нежелательные явления. Важно выяснить, сохраняются ли симптомы вне эпизодов острых респираторных инфекций и насколько они выражены в настоящее время по сравнению с прошлым. Из анамнеза жизни выясняются сопутствующие заболевания, прежде всего аллергические: наблюдается ли по ним ребёнок у специалиста, какое лечение получает, планируются ли операции. Большое значение имеют перенесённые операции и манипуляции в полости носа, включая назотрахеальную интубацию и установку любых назальных зондов.

3. Диагностика

Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин не является патологией. Обследование оправдано при наличии жалоб, клинических проявлений или сопутствующего заболевания, на течение которого могут влиять аденоидит, гипертрофия аденоидов или нёбных миндалин.

Гипертрофия нёбных миндалин диагностируется на основании жалоб, анамнеза и физикального обследования, включающего фарингоскопию с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин. Для диагноза гипертрофии аденоидов, кроме того, необходимо инструментальное исследование: эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография (КТ).

3.1 Физикальное обследование

Каждого пациента осматривает оториноларинголог для оценки общего состояния, выраженности симптомов и сопутствующей патологии как в амбулаторных условиях, так и при госпитализации в ЛОР-отделение.

Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей в амбулаторной практике не проводится: его результаты крайне субъективны, процедура неприятна для ребёнка и может приводить к травме структур глотки.

Лабораторные исследования для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин не применяют; их используют лишь для диагностики сопутствующих заболеваний.

3.2 Инструментальные исследования

При симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, выполняют эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки.

Наиболее предпочтительна эндоскопия гибким эндоскопом с возможностью сохранения изображения в виде фото или видео. Эндоскопия носоглотки является методом первого выбора для дифференциальной диагностики и для оценки состояния носоглотки после операции, в том числе в отдалённые сроки. Осмотр ригидным эндоскопом дети, особенно дошкольного возраста, переносят хуже, а осмотр без сохранения изображения значительно менее объективен при последующих консультациях.

Рентгенографию носоглотки в боковой проекции применяют при симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, для оценки размеров глоточной миндалины.

Метод является недорогим, доступным и безболезненным. К недостаткам относятся небольшая лучевая нагрузка, необходимость правильной укладки с открытым ртом и невозможность дифференцировать аденоиды от других объёмных образований носоглотки; результат не всегда соответствует выраженности симптомов. После аденотомии рентгенография малоинформативна, поскольку не позволяет отличить аденоиды от компенсаторной гипертрофии трубных валиков и оценить рубцовые изменения.

КТ верхних дыхательных путей и шеи проводят не всем пациентам, а по специальным показаниям: в сложных случаях, когда необходимо дифференцировать гипертрофию аденоидов от другой патологии носа со сходными симптомами или диагностировать их одновременно.

При гипертрофии аденоидов состояние среднего уха объективно оценивают с помощью тимпанометрии.

3.3 Иные исследования

Исследование мазков из глотки на микрофлору для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин у детей не показано. Условно-патогенные бактерии часто выявляются в глотке и у здоровых лиц, поэтому при отсутствии признаков бактериальной инфекции ни наличие, ни отсутствие роста не позволяют оценить риск и прогноз.

3.4 Консультации специалистов

По специальным показаниям пациент направляется к аллергологу-иммунологу для подтверждения или исключения сопутствующей аллергической патологии и согласования лечения. Плановая консультация необходима при клинических и анамнестических признаках аллергического ринита, атопической бронхиальной астмы или атопического дерматита.

Консультация показана в первую очередь при глазных симптомах или повторяющемся чихании и зуде в носу; при ринологических симптомах, которые пациент связывает с цветением растений, животными или другими определёнными ситуациями; при повторных приступах кашля, свистящего или затруднённого дыхания и стеснения в груди, особенно ночью и рано утром; при кожных проявлениях атопического дерматита, крапивницы и других аллергических заболеваний кожи; при рецидивирующих острых средних отитах или риносинуситах.

При признаках повторяющихся обструктивных нарушений сна пациент по возможности направляется в плановом порядке к специалисту по расстройствам сна для объективной диагностики и согласования лечения.

При врождённых или приобретённых изменениях челюстно-лицевой области показана плановая консультация ортодонта.

По специальным показаниям пациент направляется к инфекционисту для диагностики персистирующих вирусных инфекций, прежде всего герпесвирусной.

Показанием является наличие хотя бы одного из следующих признаков, сохраняющегося 3 месяца и более: увеличение лимфатических узлов в 3 группах и более (не менее 3 узлов в каждой); увеличение печени и (или) селезёнки; снижение абсолютного числа нейтрофилов в анализе крови ниже возрастной нормы и (или) общего числа нейтрофилов ниже 5×10^9/л. Оториноларинголог только оценивает симптомы, решение о лабораторном поиске вирусов принимает инфекционист.

4. Лечение

При наличии показаний гипертрофию аденоидов и нёбных миндалин устраняют хирургически в плановом порядке. При отсутствии показаний или наличии абсолютных противопоказаний показано динамическое наблюдение оториноларинголога. При хронической или врождённой сопутствующей патологии оперируют только по согласованию с профильным специалистом.

Абсолютными противопоказаниями к операции являются шок, острая стадия инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения, поздние стадии тяжёлых инфекционных и онкологических заболеваний, тяжёлое, крайне тяжёлое или терминальное состояние, обусловленное сопутствующими заболеваниями. К относительным противопоказаниям относятся неконтролируемое или плохо контролируемое течение сопутствующей соматической патологии и аномалии строения носа, резко повышающие риск серьёзных интраоперационных осложнений.

Консервативное лечение оправдано только при клинических и анамнестических признаках воспаления глоточной миндалины (аденоидита) или нёбных миндалин (тонзиллита) при наличии соответствующих жалоб или осложнений.

4.1 Хирургическое лечение

Аденотомия при гипертрофии аденоидов выполняется по специальным показаниям для восстановления проходимости носоглотки и только при отсутствии противопоказаний.

Показаниями у детей являются: частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, в ряде случаев с дневной сонливостью и вялостью); экссудативный средний отит, сохраняющийся 3 месяца, резистентный к консервативному лечению и подтверждённый тимпанометрией; рецидивирующие острые средние отиты или острые синуситы (3 эпизода и более за 6 месяцев или 4 и более за 12 месяцев) после исключения других причин, прежде всего иммунодефицита, и при неэффективности медикаментозной профилактики; хронический синусит с выраженными симптомами или частыми обострениями при неэффективности 1–2 курсов консервативного лечения; стойкое затруднение носового дыхания при отсутствии других причин, ухудшающее качество жизни или приводящее к деформации лицевого скелета по данным цефалометрии и заключению ортодонта или челюстно-лицевого хирурга; заключение других специалистов о необходимости аденотомии как этапа лечения сопутствующего заболевания, например перед кардиохирургическим вмешательством.
При возможности объективной оценки обструктивных нарушений сна ориентиром служит индекс апноэ-гипопноэ: значения от 5 до 15 соответствуют среднетяжёлой форме, более 15 тяжёлой форме.
Детям аденотомию предпочтительно выполнять под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Тонзиллотомию детям с гипертрофией нёбных миндалин выполняют по специальным показаниям для уменьшения размеров миндалин. Основным показанием являются частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, в ряде случаев с дневной сонливостью и вялостью); при возможности ориентиром служит индекс апноэ-гипопноэ, как и при аденотомии.

При одновременном наличии у ребёнка показаний и к тонзиллотомии, и к тонзиллэктомии предпочтение отдаётся тонзиллэктомии. Тонзиллотомию предпочтительно проводить под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

При сочетанной гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин аденотомию сочетают с тонзиллотомией по тем же показаниям, что и аденотомия.

Такое вмешательство проводится только под общим обезболиванием с обязательным визуальным контролем операционного поля; в раннем послеоперационном периоде пациент находится под наблюдением в ЛОР-отделении стационара.

Взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и синдромом обструктивного апноэ сна при отсутствии противопоказаний показана тонзиллэктомия для уменьшения симптомов апноэ.

> Для рекомендации о тонзиллэктомии у взрослых не указаны ни уровень убедительности рекомендаций, ни уровень достоверности доказательств. Кроме того, в разделах о госпитализации, послеоперационном обезболивании и реабилитации речь идёт только об аденотомии и тонзиллотомии, тонзиллэктомия у взрослых не упоминается.

4.2 Консервативное лечение аденоидита

Консервативное лечение детей с гипертрофией аденоидов оправдано только при признаках аденоидита: продуктивном кашле вследствие постназального затёка, выделениях из носа, периодическом затруднении носового дыхания. У детей младше 7–9 лет при отсутствии значимого влияния на сон, приём пищи и повседневную активность и при отсутствии осложнений (например, средних отитов) такое состояние не рассматривается как патология, и тактика ограничивается наблюдением.

Всем пациентам с аденоидитом рекомендована ирригационно-элиминационная терапия (промывание полости носа).

Орошение полости носа проводится 1–2 раза в день изотоническими или гипертоническими (1,5–3%) солевыми растворами на основе морской воды; это облегчает туалет полости носа, уменьшает выраженность симптомов и улучшает условия для последующего применения местных лекарственных средств. Детям дошкольного возраста промывание полости носа большими объёмами раствора не рекомендуется из-за высокого риска средних отитов.

По специальным показаниям при аденоидите применяют местные антибактериальные препараты для подавления условно-патогенной микрофлоры носоглотки.

Применяются назальный спрей фрамицетина, у детей старше 2,5 года комбинированный препарат дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин или раствор для ингаляций тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат. Курс короткий, до 7 дней. Показанием служат признаки бактериальной инфекции: слизисто-гнойные выделения из носа и по задней стенке глотки в течение всего дня или отсутствие улучшения в течение 7–10 дней противовоспалительной терапии.
Введение в полость носа растворов антибиотиков, предназначенных для парентерального, внутриконъюнктивального или ушного применения, не рекомендуется: они не предназначены для полости носа и могут нарушать мукоцилиарный транспорт.

Пациентам старше 2 лет с аденоидитом рекомендованы отхаркивающие муколитические препараты для уменьшения постназального затёка. Применяются только препараты с преимущественно мукорегулирующим действием; оптимальным в рекомендации назван карбоцистеин.

Карбоцистеин в форме сиропа, в том числе в виде карбоцистеина лизина моногидрата, назначается курсом от 1 до 3 месяцев. Препарат уменьшает постназальный затёк и повышает вероятность разрешения сопутствующего экссудативного среднего отита. При монотерапии отличие от выжидательной тактики становится заметным лишь к 2–3-й неделе. Одновременное назначение других муколитиков, в том числе местных, не рекомендуется во избежание усиления затёка.

Детям старше 2 лет с аденоидитом и сопутствующим аллергическим ринитом применяют топические глюкокортикостероиды: #мометазон в виде назального спрея по 1 дозе (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки (100 мкг в сутки) курсом от 1 до 3 месяцев.

Ни гипертрофия аденоидов, ни аденоидит, ни назофарингит не зарегистрированы в России в качестве показания ни для одного топического глюкокортикостероида; знак # обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

Масла, в первую очередь масло туи, при гипертрофии аденоидов и аденоидите не применяются: их эффективность не доказана, а в полости носа они угнетают функцию ресничек мерцательного эпителия, нарушают эвакуацию секрета и повышают риск бактериальной инфекции.

Ежедневное промывание полости носа растворами антисептиков не рекомендуется: эффективность не доказана, нарушается мукоцилиарный транспорт, возможны местные дисбиотические изменения.

4.3 Послеоперационное обезболивание

При болевом синдроме после аденотомии и (или) тонзиллотомии применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол. Обезболивание необходимо при жалобах на боль или других её проявлениях: отказе от еды и питья, повторной рвоте и тошноте.

Препарат	Доза у детей
Ибупрофен	8–10 мг/кг на приём, не более 30 мг/кг в сутки, внутрь в лекарственной форме, соответствующей возрасту (таблетки, покрытые оболочкой, — с 6 лет); детям младшего возраста — ректальные суппозитории.
Кетопрофен	С 6 лет — гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь (кетопрофена лизиновая соль), 40 мг на приём до 3 раз в день.

Препарат	Доза у детей
Парацетамол	10–15 мг/кг на приём, не более 60 мг/кг в сутки, в любой лекарственной форме, соответствующей возрасту. При невозможности приёма внутрь и отсутствии суппозиториев — парентерально 15 мг/кг на введение.

4.4 Послеоперационное ведение

После аденотомии и (или) тонзиллотомии показан осмотр оториноларинголога перед выпиской и амбулаторно через 7–14 дней после выписки для оценки состояния и исключения поздних послеоперационных осложнений.

В течение 5–7 дней после операции необходимо соблюдение охранительного режима.

Охранительный режим включает ограничение контактов (исключение посещения детского коллектива и людных мест), ограничение физической нагрузки и исключение перегревания, особенно области головы и шеи, в том числе отказ от горячей пищи и питья.

При сохранении дисфонии более месяца после операции пациент направляется к логопеду-дефектологу.

При сохранении симптомов обструктивных нарушений сна более 6–8 недель после операции пациент направляется к специалисту по расстройствам сна.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Специфическая профилактика гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин отсутствует. Поскольку важную роль играют респираторные вирусы, следует соблюдать общие правила профилактики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Ряд лекарственных препаратов может применяться для плановой и экстренной профилактики аденоидита у детей.

Детям старше 1 года из групп риска по респираторным инфекциям рекомендованы стандартизированные растительные препараты для приёма внутрь из группы прочих антисептиков для профилактики эпизодов ОРВИ, а также для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующих эпизодов аденоидита.

К ним относятся препараты, содержащие корень алтея, цветки ромашки, хвощ, листья грецкого ореха, тысячелистник, кору дуба и одуванчик лекарственный. Они назначаются также для лечения аденоидита при появлении симптомов ОРВИ в качестве монотерапии или в комплексе.

Детям старше 3 лет при появлении симптомов острого назофарингита применяют комбинированный препарат лизоцим + пиридоксин для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующего аденоидита.

Детям из групп риска по респираторным инфекциям рекомендованы лизаты бактерий (другие иммуностимуляторы) для сокращения длительности и уменьшения тяжести эпизодов аденоидита и его осложнений.

Как правило, проводится плановая профилактика курсами в соответствии с инструкцией 2–3 раза в год; применяются как пероральные, так и местные формы.

Для профилактики аденоидитов и их осложнений у детей может рассматриваться применение местных пробиотиков на основе бактерий нормальной микрофлоры глотки.

В информации для пациента указано, что следует обратиться к врачу, если после перенесённого простудного заболевания у ребёнка появились и в течение 2 недель сохраняются заложенность носа, храп, снижение слуха или кашель (при исключённой патологии нижних дыхательных путей).

5.2 Показания к госпитализации и выписке

Показанием к госпитализации является плановая аденотомия и (или) тонзиллотомия при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. Лечение аденоидита амбулаторное или в консультативно-диагностическом отделении. После операции пациент выписывается при удовлетворительном общем состоянии и отсутствии осложнений.

5.3 Факторы, влияющие на исход лечения

При хронических соматических заболеваниях после аденотомии и (или) тонзиллотомии возможно их обострение в раннем послеоперационном периоде. Аллергический ринит повышает вероятность неполного регресса назальных симптомов (передней и задней ринореи, в меньшей степени заложенности носа). Ожирение повышает вероятность сохранения обструктивных нарушений сна после операции. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь повышает вероятность сохранения назальных симптомов и риск инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде.

При гипертрофии нёбных миндалин медикаментозное лечение аденоидита крайне малоэффективно в отношении обструктивных нарушений сна.

При наличии у ребёнка сопутствующего заболевания, способного повлиять на результат операции, врач должен проинформировать об этом пациента или родителей до операции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	662_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Рекомендация о тонзиллэктомии взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и СОАС дана без уровня убедительности рекомендаций и уровня достоверности доказательств, а в разделах о госпитализации, обезболивании и реабилитации упоминаются только аденотомия и тонзиллотомия.
- Для хронического аденоидита в разделе 1.4 предложены два кода: J31.1 («как возможный вариант кодирования») и J35.8 («например, аденоидит»).
- Растительные препараты рекомендованы в разделе профилактики, однако в комментарии к ним указано, что они назначаются также для лечения аденоидита при симптомах ОРВИ.
- В комментарии к ибупрофену фраза о суппозиториях оборвана («ректальные суппозитории (у детей младше) 2 лет»), поэтому возрастная граница неоднозначна.
- В рекомендации об осмотре после операции пропущено слово («через 7-14 после выписки»); по смыслу речь идёт о днях.
- Сведения о незарегистрированных показаниях для мометазона приведены «на конец 2020 года», хотя рекомендации утверждены в 2024 году.
- В разделе профилактики приведена ссылка «см. КР 25» без пояснения, о каких рекомендациях идёт речь.

Клинические рекомендации

Мастоидит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H70** — Мастоидит и родственные состояния
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.09.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/311_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Мастоидит представляет собой деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной основы ячеистой структуры сосцевидного отростка. При остром мастоидите изменения существуют **не более 1 месяца**, при хроническом (латентном) **более 1 месяца**.
- Критерии диагноза:
  1. боль в ухе и заушной области, головная боль, недомогание, лихорадка;
  2. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости в анамнезе;
  3. оттопыренность ушной раковины, гиперемия и пастозность заушной области, болезненность при пальпации и перкуссии сосцевидного отростка;
  4. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода при отоскопии;
  5. нарушение пневматизации среднего уха и костная деструкция по данным компьютерной томографии (КТ) височной кости.
- Каждый пациент с мастоидитом, независимо от этиологии и стадии процесса, подлежит **экстренной госпитализации** в оториноларингологический стационар.
- Антибактериальную терапию начинают сразу после постановки диагноза, не дожидаясь результатов посева, препараты вводят **парентерально**:
  1. амоксициллин + клавулановая кислота;
  2. цефотаксим;
  3. цефтриаксон.
- Хирургическое лечение выполняют в экстренном порядке:
  1. первый этап при целой барабанной перепонке: парацентез или шунтирование и дренирование барабанной полости;
  2. второй этап при отсутствии положительной динамики **в течение 48–72 часов**: антромастоидотомия.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Мастоидит представляет собой деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной основы ячеистой структуры сосцевидного отростка. Первичный мастоидит развивается без предшествующего среднего отита, вторичный является осложнением среднего отита.

Антритом (отоантритом) называют деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной ткани пещеры сосцевидного отростка, осложняющее острый средний отит у новорождённых и детей грудного возраста.

2.2 Классификация

Мастоидит классифицируют по преимущественной локализации воспалительного процесса в отростке и по клиническому течению.

1. Острый мастоидит: воспалительно-деструктивные изменения в ячеистой структуре сосцевидного отростка существуют **не более 1 месяца**.
2. Хронический (латентный) мастоидит: изменения сохраняются **более 1 месяца** и чаще связаны с хроническим гнойным средним отитом или затянувшимся острым средним отитом.

2.3 Клиническая картина

Общие симптомы

1. ухудшение общего состояния;
2. повышение температуры тела;
3. у детей вялость, сонливость, капризность, снижение аппетита.

Местные симптомы

1. нарастающая боль в ухе с иррадиацией в висок и затылок;
2. усиление гноетечения из уха (при блоке входа в пещеру может отсутствовать);
3. болезненность при надавливании на сосцевидный отросток;
4. оттопыренность ушной раковины;
5. гиперемия и пастозность заушной области;
6. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода;
7. снижение слуха.

Лабораторные изменения

1. лейкоцитоз;
2. выраженное повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ);
3. нарастание С-реактивного белка (СРБ).

Лабораторные изменения неспецифичны для мастоидита, но дополняют клиническую картину.

2.4 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. повышение температуры тела, ухудшение общего состояния;
2. снижение слуха;
3. головная боль;
4. боль в ухе и заушной области;
5. оттопыренность ушной раковины, припухлость и покраснение кожи за ухом;
6. у детей вялость, сонливость, капризность, снижение аппетита.

Анамнез

1. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости.

При хроническом мастоидите общее состояние может не страдать: беспокоят интермиттирующие спонтанные боли, особенно ночью, возможно снижение слуха.

2.5 Физикальное обследование

Отоскопия

1. сужение наружного слухового прохода за счёт нависания задневерхней стенки, гиперемия кожи нависающей части;
2. гиперемия, инфильтрация и выбухание барабанной перепонки;
3. при перфорации профузное гноетечение и пульсирующий рефлекс; при блоке входа в пещеру гноетечения может не быть.

Заушная область

1. пастозность мягких тканей и гиперемия кожи над сосцевидным отростком;
2. сглаженность складки у места прикрепления ушной раковины;
3. оттопыренность ушной раковины.

Следует оценить симметричность лица и функцию мимических мышц: при остром мастоидите возможен парез лицевого нерва.

2.6 Атипичные формы

Зигоматицит: отёк мягких тканей в проекции скулового отростка с распространением на щёку и веко.

Петрозит проявляется триадой Градениго:

1. ретроорбитальная боль (раздражение первой ветви тройничного нерва);
2. диплопия вследствие пареза отводящего нерва на стороне поражения;
3. симптомы воспаления среднего уха.

Мастоидит Бецольда проявляется кривошеей в больную сторону, отёком кожи и болезненностью по ходу грудино-ключично-сосцевидной, двубрюшной, ремённой мышц и длиннейшей мышцы головы.

При мастоидите Орлеанского вокруг места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы формируется инфильтрат: гной прорывается на наружную поверхность верхушки отростка без образования абсцесса. Повороты головы болезненны, но кривошеи нет, а надавливание на инфильтрат не усиливает гноетечение из уха.

Мастоидит Чителли представляет собой поражение угловых ячеек сосцевидного отростка с тромбозом сигмовидного синуса. Повороты головы болезненны, пальпация заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы вызывает боль, верхушка отростка при пальпации свободна.

При мастоидите Муре гной с верхушки сосцевидного отростка прорывается в ткани шеи и парафарингеальное пространство. Характерны дисфония, ощущение инородного тела в глотке, припухлость в переднем отделе боковой поверхности шеи, резкая болезненность при надавливании на грудино-ключично-сосцевидную мышцу под верхушкой отростка; при фарингоскопии выявляется инфильтрат или выбухание боковой и задней стенок глотки.

2.7 Этиология

При вторичном мастоидите инфекция проникает в ячейки сосцевидного отростка преимущественно отогенным путём при остром или хроническом гнойном среднем отите. Возбудители, как правило, те же, что и при остром гнойном среднем отите: преобладают Streptococcus pneumoniae и Streptococcus pyogenes, обнаруживают также Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus aureus и другие.

Факторы риска вторичного мастоидита

1. возраст до двух лет;
2. рецидивирующий острый средний отит;
3. неполная пневматизация сосцевидного отростка;
4. сопутствующие заболевания, снижающие иммунитет.

Первичный мастоидит имеет травматическое (удары, ушибы, переломы и трещины костей черепа, огнестрельные ранения) или гематогенное происхождение (септикопиемия, переход гнойного процесса из лимфатических узлов области сосцевидного отростка). Изолированное поражение сосцевидного отростка возможно при специфических инфекциях: туберкулёзе, инфекционных гранулёмах.

Ведущее звено патогенеза вторичного мастоидита заключается в недостаточном дренировании гнойного очага в среднем ухе. Ему способствуют запоздалое дренирование барабанной полости при задержке спонтанной перфорации или парацентеза при остром среднем отите, высокое расположение и малый размер перфорации при хроническом гнойном среднем отите, а также разобщение ячеек, антрума и барабанной полости отёчной утолщённой слизистой оболочкой.

Чаще всего костная деструкция формируется в проекции площадки сосцевидного отростка, и в заушной области образуется субпериостальный абсцесс, реже в области задней костной стенки наружного слухового прохода с отслойкой кожи и образованием свища. Деструкция чешуи височной кости приводит к сквамиту, вовлечение пирамиды к петрозиту. Распространение процесса к средней или задней черепной ямке ведёт к тяжёлым внутричерепным осложнениям: менингиту, абсцессам мозга и мозжечка, синустромбозу, сепсису.

2.8 Стадии

Экссудативная стадия продолжается первые 7–10 дней заболевания. Отёк слизистой оболочки разобщает ячейки с пещерой и пещеру с барабанной полостью, ячейки заполняются серозно-гнойным или гнойным экссудатом, образуя множество замкнутых эмпием. На КТ перегородки между завуалированными ячейками ещё различимы.

Пролиферативно-альтеративная стадия (истинный мастоидит) формируется обычно на 7–10-й день заболевания, у детей раньше. Грануляции и расплавление кости разрушают перегородки между ячейками, и образуются полости различной величины, заполненные гноем и грануляциями, или одна большая полость.

У детей плохой аэрации среднего уха и затруднению оттока способствуют частое нарушение носового дыхания, широкие короткие прямые слуховые трубы, эмбриональная миксоидная ткань в барабанной полости и высокое расположение сосцевидной пещеры, поэтому антрит возникает уже на ранней стадии острого среднего отита, особенно у новорождённых. Решающее значение имеют реактивность организма, инфекционные заболевания, недоношенность, перинатальная патология, гипо- и паратрофия, эндокринные заболевания.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на боль в ухе и заушной области, головную боль, недомогание, повышение температуры тела;
2. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости в анамнезе;
3. оттопыренность ушной раковины, гиперемия и пастозность заушной области, болезненность при пальпации и перкуссии сосцевидного отростка;
4. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода при отоскопии;
5. нарушение пневматизации структур среднего уха и костная деструкция по данным КТ височной кости.

3.2 Осмотр оториноларинголога

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: первичный осмотр для постановки диагноза и определения тактики лечения.

3.3 Компьютерная томография височной кости

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита.

Диагностические признаки

1. нарушение пневматизации структур среднего уха;
2. костно-деструктивные изменения.

При отсутствии технической возможности КТ допустима рентгенография височной кости в проекциях Майера и Шюллера.

Уровни приведены для детей; для взрослых УУР С, УДД 4.

Показания к КТ с внутривенным болюсным контрастированием

1. подозрение на внутричерепные осложнения.

3.4 Общий (клинический) анализ крови и С-реактивный белок

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: оценка общего состояния и выраженности воспаления.

Диагностические признаки

1. нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево;
2. повышение СОЭ;
3. умеренная анемия;
4. повышение СРБ.

3.5 Микробиологическое исследование отделяемого из уха

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: выбор антибактериальной терапии.

3.6 Исследование слуха

Камертональное исследование и (или) речевая аудиометрия.

Показания

1. пациенты **старше 7 лет** с подозрением на мастоидит: диагностика нарушения слуха.

3.7 Консультация невролога

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: исключение осложнений.

---

4. Лечение

Консервативное лечение начинают **незамедлительно** после постановки диагноза. Цели лечения:

1. эрадикация возбудителя;
2. ограничение воспаления пределами височной кости;
3. уменьшение субъективных и объективных симптомов;
4. предупреждение стойкого снижения слуха.

4.1 Системная антибактериальная терапия

Всем пациентам назначают один из препаратов, не дожидаясь результатов посева; у взрослых и детей препараты вводят **парентерально**:

1. амоксициллин + клавулановая кислота;
2. цефотаксим;
3. цефтриаксон.

Препараты резерва

1. ванкомицин: при выделении метициллинорезистентного золотистого стафилококка (MRSA), стрептококков, резистентных к пенициллинам, при непереносимости бета-лактамных антибиотиков или отсутствии ответа на другие препараты;
2. #меропенем (детям): при выделении синегнойной палочки или штаммов, устойчивых к пенициллинам и другим бета-лактамам.

Знак # обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

4.2 Режим дозирования антибактериальных препаратов

Препарат	Пациенты	Доза, путь и кратность введения
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослые и дети старше 12 лет или с массой тела 40 кг и более	1 г (по амоксициллину) внутривенно 3 раза в сутки
Амоксициллин + клавулановая кислота	Дети от 3 месяцев до 12 лет с массой тела менее 40 кг	25 мг/кг (по амоксициллину) внутривенно 3–4 раза в сутки, 5–14 дней
Цефотаксим	Взрослые и дети старше 12 лет с массой тела 50 кг и более	1–2 г внутривенно или внутримышечно каждые 12 часов; доза зависит от тяжести инфекции, чувствительности возбудителя и состояния пациента
Цефотаксим	Дети до 12 лет с массой тела до 50 кг	100–150 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно в 2–4 введения, 7–10 дней
Цефотаксим	Новорождённые	50 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно в 2–4 введения
Цефтриаксон	Взрослые и дети старше 12 лет с массой тела более 50 кг	1–2 г каждые 24 часа
Цефтриаксон	Дети до 12 лет с массой тела менее 50 кг	20–80 мг/кг/сут 1 раз в сутки
Цефтриаксон	Новорождённые (до 14 дней)	20–50 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно, 7–14 дней
Ванкомицин	Взрослые и дети старше 12 лет	2 г/сут внутривенно капельно: по 0,5 г каждые 6 часов или по 1 г каждые 12 часов. Скорость введения не более 10 мг/мин, продолжительность инфузии не менее 60 минут; максимальная разовая доза 1 г, суточная 2 г
Ванкомицин	Дети от 1 месяца до 12 лет	10 мг/кг внутривенно каждые 6 часов, инфузия не менее 60 минут; суточная доза 40 мг/кг
#Меропенем	Дети	60 мг/кг/сут внутривенно в 3 введения каждые 8 часов

> Длительность курса в рекомендации указана только для части групп: амоксициллин + клавулановая кислота 5–14 дней, цефотаксим у детей до 12 лет 7–10 дней, цефтриаксон 7–14 дней (указано после дозы для новорождённых). Для остальных групп срок в тексте не приведён.

4.3 Местная терапия

Показания к ушным каплям с противомикробными препаратами

1. перфорация барабанной перепонки;
2. послеоперационный период: введение через парацентезное отверстие или тимпаностомический шунт.

Препараты

1. офлоксацин взрослым и детям **старше 15 лет**: по 5 капель 2 раза в сутки, 10 дней;
2. рифамицин детям: по 3 капли 3 раза в сутки, 7 дней.

Для офлоксацина у взрослых УДД 4.

Для восстановления функции слуховой трубы всем пациентам назначают назальные деконгестанты (оксиметазолин, ксилометазолин) **не дольше 7 дней**. У детей их применяют с особой осторожностью.

Уровни приведены для детей; для взрослых УДД 4.

Препарат	Возраст	Доза и кратность
Оксиметазолин 0,01%	до 4 недель	по 1 капле в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,01%	с 5-й недели до 1 года	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,025%	от 1 года до 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,05%	взрослые и дети старше 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Ксилометазолин 0,05%	от 2 до 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–3 раза в сутки
Ксилометазолин 0,1%	взрослые и дети старше 6 лет	по 2–3 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки

4.4 Симптоматическая терапия

При боли и (или) лихорадке, в том числе после операции, в формах и дозах согласно инструкциям применяют:

1. парацетамол;
2. нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, диклофенак, кеторолак, кетопрофен, лорноксикам, декскетопрофен.

Для лорноксикама и диклофенака у взрослых УУР В, УДД 2.

4.5 Хирургическое лечение

Мастоидит и антрит требуют **экстренного** хирургического лечения, цель которого состоит в скорейшем обеспечении оттока экссудата из полостей среднего уха и предотвращении распространения процесса за пределы сосцевидного отростка.

4.6 Первый этап: парацентез или шунтирование барабанной полости

Показания

1. мастоидит при целой барабанной перепонке;
2. спонтанная перфорация недостаточного размера.

Это первый этап лечения неосложнённого острого мастоидита и антрита.

Предпочтительно установить тимпаностомический шунт, если для этого есть условия: перфорация не закрывается быстро, облегчаются введение ушных капель и отток отделяемого. При отсутствии положительной динамики **в течение 48–72 часов** переходят ко второму этапу.

4.7 Второй этап: антромастоидотомия или антродренаж (антротомия)

Показания

1. отсутствие эффекта от консервативного лечения и парацентеза или шунтирования **в течение 48–72 часов**;
2. субпериостальный абсцесс или абсцесс шеи;
3. признаки перехода инфекции на мозговые оболочки и другие внутричерепные осложнения;
4. отогенный сепсис;
5. вялотекущий процесс в сосцевидном отростке **более месяца** с рентгенологической картиной разрушения его тканей и жалобами пациента.

Операцию выполняют под комбинированным эндотрахеальным наркозом, желательно под контролем операционного микроскопа. У детей раннего возраста вскрытие сосцевидного отростка ограничивается антральной клеткой, детям **старше года** и взрослым обязательна ревизия всей клеточной системы отростка. После вскрытия антрума и окружающих клеток проверяют проходимость входа в пещеру.

Разрез мягких тканей ведут сверху вниз до верхушки сосцевидного отростка, отступив 5 мм от линии прикрепления ушной раковины; послойное рассечение позволяет выполнять гемостаз по ходу операции. Трепанацию проводят в пределах треугольника Шипо, антрум находят в глубине и кпереди, в проекции треугольника Траутмана. Ограничиваться вскрытием антрума не следует: при любой форме мастоидита необходима ревизия клеточной системы отростка с удалением всех патологически изменённых тканей и костных осколков, после чего полость промывают.

4.8 Послеоперационное ведение

1. При субпериостальном абсцессе или ожидаемом продолжении воспаления заушную рану полностью не ушивают: накладывают один-два шва в верхнем и нижнем углах и ведут рану открытым способом.
2. В остальных случаях в антрум устанавливают силиконовую дренажную трубку и рану ушивают полностью.
3. Перевязки выполняют ежедневно.
4. Дренажную трубку удаляют **на 5–7-е сутки**.
5. Открытую рану ушивают после полного очищения послеоперационной полости.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Все пациенты с мастоидитом, независимо от этиологии и стадии процесса, подлежат **экстренной госпитализации** в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профилю «оториноларингология».

Критерии выписки

1. нормализация общего состояния: отсутствие лихорадки и признаков интоксикации;
2. нормализация показателей общего и биохимического анализов крови;
3. отсутствие выделений из уха.

5.2 Медицинская реабилитация

Контрольное исследование слуха **через 1 месяц** после выздоровления всем перенёсшим мастоидит:

1. тональная аудиометрия пациентам старше 7 лет;
2. игровая аудиометрия детям от 3 до 7 лет;
3. регистрация вызванной отоакустической эмиссии детям младше 3 лет.

При снижении слуха пациента направляют к сурдологу-оториноларингологу.

5.3 Профилактика

1. профилактика острого среднего отита, заболеваний носа, околоносовых пазух и лимфоглоточного кольца;
2. квалифицированное лечение хронического среднего отита;
3. своевременное хирургическое лечение на среднем ухе, в полости носа, околоносовых пазухах, носоглотке и глотке.

Диспансерное наблюдение после мастоидита не требуется.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мастоидит»
Версия	2-я, год утверждения 2026, опубликована в рубрикаторе 04.09.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2029 года
Код в рубрикаторе	311_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность антибактериальной терапии приведена не для всех групп пациентов: для амоксициллина + клавулановой кислоты и цефтриаксона срок указан один раз в конце фразы, для цефотаксима только у детей до 12 лет.
- Границы массы тела для цефтриаксона заданы как «более 50 кг» и «менее 50 кг»; пациенты с массой ровно 50 кг формально не охвачены.
- Меропенем в тексте рекомендации назван с опечаткой («Меропеием»).
- PDF представляет собой скан с распознанным текстом: латинские названия возбудителей и коды АТХ распознаны с ошибками и сверены по изображениям страниц.

Клинические рекомендации

Наружные отиты

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.4** — Холестеатома наружного уха **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 13.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/663_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Наружный отит является воспалительным поражением ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
- При неосложнённом наружном отите применяют местно ушные капли; при бактериальном отите препаратами первого выбора являются фторхинолоны. Обязательны туалет наружного слухового прохода и обезболивание.
- При неосложнённом отите системная антибактериальная терапия не показана. Системные антибиотики применяют при постлучевом отите, сахарном диабете, иммуносупрессии и хондроперихондрите.
- Эффективность терапии оценивается через 48–72 часа. При отсутствии эффекта следует уточнить диагноз и исключить атопический или контактный дерматит, псориаз, экзему.
- Злокачественный наружный отит характеризуется выраженным болевым синдромом, грануляциями, выделением синегнойной палочки при посеве и отсутствием эффекта от лечения более недели; заболевание чаще встречается у пациентов пожилого возраста с сахарным диабетом. Необходимы определение уровня глюкозы крови, компьютерная томография (КТ), госпитализация и системная антибактериальная терапия продолжительностью не менее 6 недель.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Наружный отит характеризуется воспалительными изменениями ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.

Выделяют острую и хроническую (продолжительностью более 6–12 недель) формы наружного отита. К диффузному наружному отиту относятся экзема, дерматит, рожистое воспаление, герпес, перихондрит, хондроперихондрит и злокачественный наружный отит; ограниченный наружный отит представлен фурункулом и абсцессом.

Развитию воспаления предшествует нарушение целостности кожного покрова вследствие травмы, длительного пребывания во влажной среде, сахарного диабета, дерматита или экземы. Предрасполагающими факторами являются узкий наружный слуховой проход, экзостозы, ношение слухового аппарата, попадание воды в уши, нарушение образования ушной серы и лучевое воздействие.

2.2 Жалобы

Пациенты предъявляют жалобы на дискомфорт и боль в ухе, нередко усиливающуюся при надавливании и жевании; боль может иррадиировать в глаз, зубы, глотку. Снижение слуха отмечается при полной обтурации слухового прохода. В ряде случаев беспокоят зуд и выделения из уха. Температура тела, как правило, субфебрильная.

2.3 Физикальное обследование

Определяются гиперемия, отёк, инфильтрация и лихенификация кожи наружного слухового прохода, в ряде случаев ушной раковины и поверхностного слоя барабанной перепонки, патологическое отделяемое. При ограниченной форме выявляются абсцессы и инфильтраты, возможен регионарный лимфаденит.

2.4 Особенности клинических форм

При фурункуле наружного слухового прохода в стадии инфильтрации ведущей жалобой является дискомфорт, усиливающийся при манипуляциях в ухе, в стадии абсцедирования на первый план выходит боль. При диффузном отите беспокоят боль, выделения из уха, возможно снижение слуха.

При экзематозном отите определяются желтовато-розовые очаги с шелушением, беспокоит зуд, в ряде случаев интенсивный и предшествующий высыпаниям. В дальнейшем образуются микровезикулы, эрозии, участки мокнутия, причём элементы разных стадий наблюдаются одновременно.

При герпетическом поражении за 1–2 суток до высыпаний возникают жжение, зуд и покалывание, затем появляются эритема, пузырьки и корочки. Как правило, процесс разрешается за 10–14 дней, а при присоединении вторичной инфекции в течение 3–4 недель.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании характерных жалоб и клинической картины; при необходимости он подтверждается данными лабораторных и других методов исследования.

Выполняют бактериологическое исследование отделяемого, микроскопическое и культуральное исследование на грибы, цитологическое исследование; при подозрении на новообразование выполняют биопсию.

Материал забирается до начала противомикробной терапии, под контролем отоскопии, тампоном диаметром до 0,3 см из просвета или со стенок наружного слухового прохода, без контакта с его наружными отделами.

При жалобах на снижение слуха после купирования воспаления показана аудиометрия для исключения острой нейросенсорной тугоухости. При неосложнённом наружном отите возможна кондуктивная тугоухость.

КТ и магнитно-резонансную томографию (МРТ) применяют при осложнённой форме (формирование костных секвестров, абсцессов) для уточнения распространённости процесса. При неосложнённом отите необходимости в лучевой диагностике нет.

При поражении наружного уха на фоне системного, в том числе инфекционного, заболевания необходимы консультация профильного специалиста и дообследование.

3.1 Злокачественный наружный отит

При злокачественной форме определяют уровень глюкозы крови для выявления сахарного диабета, поскольку в 90–100% случаев злокачественный наружный отит сочетается с ним.

Основными признаками злокачественного наружного отита являются боль в ухе и головная боль на стороне поражения, отёк стенок и выделения из слухового прохода, грануляции в нём, микроабсцессы в области уха и основания черепа, очаг воспаления по данным сцинтиграфии, отсутствие эффекта от лечения более недели, выделение синегнойной палочки при посеве.

Дополнительными признаками являются сахарный диабет, поражение черепных нервов, истощение и пожилой возраст. При невозможности выполнения сцинтиграфии назначается местное лечение на 1–3 недели; отсутствие улучшения свидетельствует в пользу злокачественного отита.

4. Лечение

Основу лечения составляют устранение предрасполагающих факторов, адекватное обезболивание и регулярный туалет наружного слухового прохода.

4.1 Местное лечение

Для местного лечения неосложнённого наружного отита используют препараты, активные в отношении золотистого стафилококка и синегнойной палочки. Эффективность терапии оценивается через 48–72 часа. Сохранение симптомов требует уточнения диагноза и исключения атопического или контактного дерматита, псориаза, экземы.

При бактериальном наружном отите препаратами первого выбора являются ушные капли с фторхинолонами.

Ушные капли рекомендованы всем пациентам с бактериальным наружным отитом; перечень препаратов приведён в таблице ниже.

При всех формах применяются антисептики (бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид; йод с калия йодидом и поливиниловым спиртом) и противомикробные средства: фторхинолоны, аминогликозиды, противогрибковые препараты. На фоне местного лечения выздоровление на 7–10-е сутки наступает у 65–95% пациентов.

При экзематозной форме применяют кортикостероиды в сочетании с противомикробными средствами.

4.2 Ушные капли

Препарат	Состав	Возраст
Офлоксацин	офлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (в КР под названием «Комбинил»)	ципрофлоксацин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	с 18 лет
Норфлоксацин	норфлоксацин	с 15 лет
Рифамицин	рифамицин	без ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин B	неомицин + полимиксин B (антибактериальный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 1 года
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол	хлорамфеникол (антибактериальный компонент), клотримазол (противогрибковый компонент), беклометазон (противовоспалительный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 6 лет
Дексаметазон + неомицин + полимиксин B	неомицин + полимиксин B (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон	фрамицетин + грамицидин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений

> В данной рекомендации капли с норфлоксацином разрешены с 15 лет, тогда как в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года. Возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.

4.3 Системная антибактериальная терапия

При неосложнённом наружном отите системная антибактериальная терапия не показана, поскольку её добавление к местному лечению не улучшает результатов.

К системной антибактериальной терапии прибегают при постлучевом наружном отите, сахарном диабете и иммуносупрессии.

При злокачественном наружном отите необходима системная антибактериальная терапия продолжительностью не менее 6 недель препаратами, обладающими антисинегнойной и антистафилококковой активностью.

При хондроперихондрите ушной раковины применяют системные антибиотики и противовоспалительные средства для купирования болевого синдрома и отёка.

4.4 Хирургическое и дополнительное лечение

При ограниченном отите абсцессы наружного слухового прохода вскрывают и дренируют. При злокачественном отите удаляют грануляции, костные и хрящевые секвестры и холестеатому в пределах зоны поражения.

Для повышения эффективности лечения применяется физиотерапия.

Микробиологическое исследование повторяется до подтверждения элиминации возбудителя.

При сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе необходим контроль уровня глюкозы крови.

5. Профилактика. Показания к госпитализации

Для профилактики рекомендуется ограничить использование ватных палочек, избегать избыточного туалета наружного слухового прохода, соблюдать гигиену при использовании берушей, слуховых аппаратов и наушников.

Лечение, как правило, амбулаторное; при некротическом (злокачественном) наружном отите показана госпитализация. Пациент выписывается при стихании воспалительных явлений в наружном слуховом проходе и отсутствии гнойно-септических осложнений.

Медицинская реабилитация не рекомендована.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружные отиты»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее ноября 2027
Код в рубрикаторе	663_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые. Для детей — отдельная КР «Наружный отит» (21_3)

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены с 15 лет, в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года.
- В таблице 1 антибактериальный компонент препарата фрамицетин + грамицидин + дексаметазон назван «Грамидин»; по названию препарата речь идёт о грамицидине.
- Одна строка таблицы 1 приведена под торговым названием «Комбинил» (ципрофлоксацин + дексаметазон).
- Сокращение «зО» в разделе 2.5 по смыслу обозначает злокачественный наружный отит.

Клинические рекомендации

Нейросенсорная тугоухость у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя **H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная **H91.1** — Пресбиакузис **H91.2** — Внезапная идиопатическая потеря слуха **H91.8** — Другие уточненные потери слуха
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/518_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании жалоб, нормальной отоскопической картины и аудиологических данных: тимпанограмма типа «А», средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц составляет 26 дБ и выше, костно-воздушный интервал не превышает 10 дБ.
- Степень тугоухости определяется по среднему порогу воздушного звукопроведения на тех же четырёх частотах: I степень соответствует 26–40 дБ, II степень 41–55 дБ, III степень 56–70 дБ, IV степень 71–90 дБ, глухота 91 дБ и более.
- При внезапной и острой идиопатической потере слуха тональную аудиометрию выполняют не позднее суток от момента первого обращения и повторяют перед выпиской для оценки эффективности лечения.
- Пациенты с острой сенсоневральной тугоухостью подлежат экстренной госпитализации в оториноларингологическое (или неврологическое) отделение; назначаются глюкокортикоиды по убывающей схеме.
- Слуховой аппарат подбирают при среднем пороге слышимости в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе 31 дБ и выше; при двусторонней тугоухости IV степени или глухоте показана кохлеарная имплантация.
- При хронической тугоухости пациент находится под наблюдением сурдолога-оториноларинголога; тональная и речевая аудиометрия повторяются 1–2 раза в год.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость (СНТ) характеризуется снижением слуха вплоть до его утраты вследствие поражения какого-либо участка звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

2.2 Этиология и патогенез

Основным условием развития тугоухости является повреждение чувствительных структур улитки. Начальным звеном служит дистрофия волосковых клеток, которая при своевременно оказанной помощи может быть обратимой.

Причинами внезапной и острой СНТ являются инфекционные заболевания (грипп, эпидемический паротит, корь, клещевой энцефалит, менингококковый менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис), острые интоксикации и ототоксические препараты (аминогликозиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные препараты и другие), заболевания сердца и сосудов, в том числе нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне и нарушения реологических свойств крови, дегенеративные заболевания позвоночника с синдромом позвоночной артерии, а также моногенная наследственная патология и генетическая предрасположенность.

2.3 Степени тугоухости

Степень тугоухости определяется по усреднённому порогу слышимости воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Степень	Средний порог воздушного звукопроведения
I степень	26–40 дБ

Степень	Средний порог воздушного звукопроведения
II степень	41–55 дБ
III степень	56–70 дБ
IV степень	71–90 дБ
Глухота	91 дБ и более

2.4 Другие классификации

По темпу развития различают внезапную тугоухость (снижение слуха в срок до 12 часов), острую (снижение развивается в течение 1–3 суток и сохраняется до месяца), подострую (снижение сохраняется 1–3 месяца) и хроническую, или стойкую (снижение сохраняется более 3 месяцев).

По времени возникновения тугоухость подразделяется на врождённую и приобретённую; по течению на стабильную, прогрессирующую, флюктуирующую и обратимую; по стороне поражения на одностороннюю и двустороннюю, симметричную или асимметричную; по этиологии на генетическую (наследственную), мультифакториальную (с наследственной предрасположенностью) и приобретённую.

2.5 Клиническая картина

Основными проявлениями сенсоневральной тугоухости у взрослых являются снижение слуха, ухудшение разборчивости речи, шум в ушах и ощущение заложенности ушей.

Ведущей жалобой является снижение слуха в сочетании с шумом в ухе, чаще постоянным, преимущественно смешанной тональности.

Для острой сенсоневральной тугоухости характерно внезапное одно- или двустороннее снижение слуха вплоть до глухоты. В ряде случаев (при острой травме, нарушении кровотока в лабиринтной артерии, токсическом поражении лабиринта) оно сопровождается шумом в ухе, а также острой вестибулярной и вегетативной дисфункцией: атаксией, головокружением, тошнотой, потливостью, тахикардией, колебаниями артериального давления, спонтанным нистагмом.

2.6 Жалобы и анамнез

Уточняются время возникновения и темп нарастания снижения слуха, различие слуха на правое и левое ухо, выраженность затруднений при общении. Активно выясняется наличие шума в ушах, его интенсивность и тональность, наличие вестибулярных нарушений и неврологической симптоматики.

При сборе анамнеза особое внимание уделяется состоянию слуха у ближайших родственников, характеру профессиональной деятельности, перенесённым инфекционным и соматическим заболеваниям, наблюдению у других специалистов.

Выявляются факторы риска: тугоухость у родственников (особенно при совпадении степени, формы и условий возникновения), работа в условиях производственного шума, приём ототоксических препаратов, перенесённые инфекционные заболевания (менингит, эпидемический паротит, корь, грипп и другие) и соматическая патология.

При острой тугоухости сбор анамнеза проводится по следующему плану: общее самочувствие и температура тела; на какое ухо снижен слух, когда и при каких обстоятельствах произошло снижение, изменялся ли слух в динамике, с чем пациент связывает его снижение, отмечалось ли снижение слуха ранее; наличие шума в ушах; наличие и характер головокружения (с определённым направлением или хаотичное), наличие тошноты, рвоты, диареи, потливости, уменьшение головокружения и шума после рвоты; приступы системного головокружения в анамнезе и установленный ранее диагноз болезни Меньера; отиты в анамнезе, принимаемые лекарственные препараты, уровень артериального давления.

Уточняется также наличие гипертонической, ишемической или цереброваскулярной болезни; травмы головы или шейного отдела позвоночника, интенсивного звукового воздействия, плавания или приёма ванны перед снижением слуха; слабости в конечностях, асимметрии лица, нарушений чувствительности, движений и зрения; недавнего стоматологического лечения или протезирования зубов.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании жалоб на снижение слуха, шум в ушах и ухудшение разборчивости речи, нормальной отоскопической картины и аудиологических данных. При тимпанометрии регистрируется тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха регистрируются или отсутствуют. При тональной пороговой аудиометрии средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц составляет 26 дБ и более, костно-воздушный интервал не превышает 10 дБ. Результаты речевой аудиометрии соответствуют данным тональной аудиометрии.

3.1 Физикальное обследование

Необходимо убедиться в отсутствии изменений наружного и среднего уха. При сенсоневральной тугоухости отоскопическая картина без патологии: наружный слуховой проход свободный, барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая, опознавательные знаки чёткие.

Острая сенсоневральная тугоухость может развиться и у пациента с перенесённой или текущей патологией среднего уха, поэтому отоскопия необходима, однако для постановки диагноза и выбора тактики её недостаточно.

Осматривают также другие ЛОР-органы для исключения заболеваний уха, носа и глотки, нарушающих воздушное звукопроведение.

3.2 Лабораторные исследования

Всем пациентам для оценки общего состояния выполняют общий (клинический) анализ крови.

При наличии соответствующей сопутствующей патологии исследуются липидный спектр (холестерин, липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП)), биохимический общетерапевтический анализ крови (глюкоза, общий и прямой билирубин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевина), коагулограмма (активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), протромбиновое время, фибриноген) и уровень тиреотропного гормона.

3.3 Акуметрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ составляется слуховой паспорт: исследование слуха шёпотной и разговорной речью и камертональные пробы.

Акуметрия носит ориентировочный характер, однако на приёме оториноларинголога её достаточно для направления пациента к сурдологу-оториноларингологу.

3.4 Тональная пороговая аудиометрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ определяются пороги слышимости методом тональной аудиометрии: по воздушному звукопроведению на частотах 125–8000 Гц, по костному звукопроведению на частотах 250–6000 Гц. При нормальных порогах и наличии жалоб на снижение слуха или шум в ушах исследуется расширенный диапазон частот (125–20 000 Гц). Тональная аудиометрия является базовым методом как первичной диагностики, так и динамического наблюдения.

При внезапной и острой идиопатической потере слуха аудиометрию выполняют не позднее суток от момента первого обращения. В ходе лечения, перед выпиской, исследование повторяется для регистрации восстановления порогов до нормы, их частичного восстановления или стабилизации (отсутствия дальнейшего прогрессирования) и определения дальнейшей тактики.

При хронической двусторонней тугоухости по данным аудиограммы определяются показания к слухопротезированию, традиционному или имплантационному, включая кохлеарную имплантацию, а при необходимости к направлению на медико-социальную экспертизу и составлению индивидуальной программы реабилитации. У пользователей слуховых аппаратов, аппаратов костной проводимости или кохлеарных имплантов оценивают эффективность слухопротезирования и при необходимости корректируют его.

При асимметричном снижении слуха маскируют лучше слышащее (неисследуемое) ухо.

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводятся надпороговые тесты (определение порогов дискомфорта, тест SISI, тест Люшера) для выявления нарушения функции громкости (рекрутмент).

Исследование может быть дополнено сопоставлением порогов слышимости с порогами акустического рефлекса на частотах 500–4000 Гц.

3.5 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводится импедансометрия: тимпанометрия и регистрация акустического рефлекса ипси- и контралатерально. Исследование необходимо для исключения патологии среднего уха, дифференциальной диагностики сенсоневральной и кондуктивной тугоухости, выявления поражения слухового и лицевого нервов, центральных слуховых путей и ядер VII и VIII пар черепных нервов на уровне продолговатого мозга и моста.

Регистрация рефлекса в широком временном окне (до 10 секунд) позволяет выявить его распад, который является признаком ретрокохлеарного поражения.

Других типов тимпанограмм рекомендация не описывает: в критериях диагноза сенсоневральной тугоухости указана тимпанограмма типа «А», акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха могут регистрироваться или отсутствовать.

3.6 Речевая аудиометрия и объективные методы

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводится речевая аудиометрия в тишине и на фоне маскирующего шума.

Исследование позволяет определить пороги восприятия и разборчивость речи; речетональная диссоциация (несоответствие речевой и тональной аудиограмм) может указывать на центральные нарушения.

Для раннего выявления признаков эндолимфатического гидропса всем пациентам с подозрением на СНТ проводится электрокохлеография.

В амбулаторных условиях применяют экстратимпанальную электрокохлеографию с внутриушным электродом с регистрацией ответов на стимулы со сгущением и разрежением в начальной фазе.

Для дифференциальной и топической диагностики всем пациентам с подозрением на СНТ проводится исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП), вызванной отоакустической эмиссии и отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения.

При асимметричной тугоухости целесообразны предъявление стимулов низкой частоты и сравнение межпиковых интервалов I–V с обеих сторон.

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) представляет собой слабые звуковые колебания, генерируемые наружными волосковыми клетками улитки и регистрируемые зондом в наружном слуховом проходе. ОАЭ не регистрируется при порогах слышимости выше 25–30 дБ на частотах 1–4 кГц, охватывающих большую часть речевого диапазона.

КСВП отражают электрическую активность слухового пути в ответ на звуковой стимул и регистрируются с поверхности головы. Ответ представляет собой комплекс положительных пиков I–VII, наиболее стабильным из которых является V пик.

3.7 Интерпретация аудиограммы

Для периферического (кохлеарного) поражения характерна нисходящая аудиограмма без костно-воздушного разрыва с признаками феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНТ). При центральных (корковых и подкорковых) формах аудиограмма также чаще нисходящая, без костно-воздушного разрыва, однако ФУНТ отсутствует; при этом значительно нарушаются разборчивость речи в шуме и локализация звука.

3.8 Вестибулометрия и лучевые методы исследования

Пациентам с подозрением на СНТ необходима вестибулометрия для оценки состояния преддверия и полукружных каналов, выявления дисфункции лабиринта и дифференциальной диагностики.

Для оценки анатомических структур всем пациентам с подозрением на СНТ необходимы магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, в том числе с внутривенным контрастированием (внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка), и компьютерная томография (КТ) височных костей высокого разрешения, в том числе с болюсным контрастированием. Особое значение эти методы имеют при односторонней и асимметричной тугоухости, однако они важны при любой степени и симметрии снижения слуха.

Отдельной рекомендацией предусмотрены рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и МРТ головного мозга, а при односторонней тугоухости МРТ с контрастным усилением для подтверждения или исключения невриномы слухового нерва.

МРТ позволяет уточнить дифференциальный и топический диагноз, уровень поражения слухового анализатора и анатомические особенности уха.

При наличии соответствующей сопутствующей патологии дополнительно назначают дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстра- и интракраниальных отделов) с цветным допплеровским картированием и триплексное сканирование вен.

3.9 Консультации и дифференциальная диагностика

При любом виде СНТ независимо от длительности заболевания показаны консультации терапевта, невролога и эндокринолога. При аутоиммунных заболеваниях и иммунодефицитных состояниях исследуется иммунный статус.

Выявление нарушений липидного и углеводного обмена позволяет обосновать патогенетическое лечение.

Сенсоневральную тугоухость дифференцируют с другими причинами снижения слуха: лабиринтопатиями после хронического гнойного отита, радикальной операции на ухе или перенесённого лабиринтита, поражением внутреннего уха при инфекциях и интоксикациях, невриномой VIII нерва, нарушением кровообращения в вертебро-базилярном бассейне, рассеянным склерозом, объёмными образованиями головного мозга, черепно-мозговой и спинальной травмой, серной пробкой, сахарным диабетом, гипотиреозом, хронической почечной недостаточностью и другими состояниями.

На догоспитальном этапе диагноз острой сенсоневральной тугоухости является предположительным. Однако и предположительный диагноз требует экстренной защиты сенсорных структур внутреннего уха и срочной медицинской эвакуации в многопрофильный стационар с ЛОР-отделением для дифференциальной диагностики и лечения.

При подозрении на невриному слухового нерва или другое объёмное образование по данным МРТ или КТ необходима консультация нейрохирурга.

---

4. Лечение и реабилитация

4.1 Внезапная и острая тугоухость

Пациент с диагнозом «острая сенсоневральная тугоухость» направляется на лечение в стационар или дневной стационар.

Показана экстренная госпитализация в оториноларингологическое или неврологическое отделение.

> В одном разделе рекомендации допускается лечение острой тугоухости в дневном стационаре, тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию в оториноларингологическое или неврологическое отделение.

Назначается охранительный слуховой режим.

Проводится внутривенная инфузионная терапия глюкокортикоидами по убывающей схеме с учётом сопутствующей патологии, противопоказаний и возможных побочных эффектов.

Глюкокортикоиды могут вводиться системно (внутрь или инфузионно) и местно (транстимпанально и транстубарно), возможно сочетание этих путей введения. В остром периоде сочетанное применение позволяет снизить системную дозу без потери эффективности.

При предположительно ишемическом генезе острой тугоухости на фоне сердечно-сосудистых нарушений внутривенно вводятся препараты для лечения заболеваний нервной системы, например #этилметилгидроксипиридина сукцинат.

Препарат	Доза
#Дексаметазон	Внутривенно на 100 мл натрия хлорида: в 1-й и 2-й дни — 24 мг, в 3-й и 4-й — 16 мг, в 5-й — 8 мг, в 6-й — 4 мг, в 7-й день препарат не вводится, в 8-й — 4 мг.
#Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Раствор 5% — 4 мл на 16 мл натрия хлорида внутривенно, 8–10 дней.

4.2 Хроническая тугоухость

По индивидуальным показаниям с учётом соматической патологии назначают поддерживающие курсы лечения.

Назначается охранительный слуховой режим.

Проводится лечение фоновой соматической патологии; 1–2 раза в год назначаются курсы поддерживающей терапии таблетированными препаратами, улучшающими мозговой и лабиринтный кровоток и тканевой обмен.

При некоторых формах хронической тугоухости (наследственной, постменингитной, ототоксической) лечение в отдалённом периоде неэффективно.

Если при острой тугоухости восстановление слуха на фоне лечения ещё возможно, то при хронической вероятность медикаментозного улучшения порогов крайне мала. Корректнее говорить о лечении сопутствующих сердечно-сосудистых, неврологических, эндокринных и иммунных нарушений, которое одновременно является профилактикой прогрессирования тугоухости. При вестибулярных нарушениях и ушном шуме применяют патогенетическое и симптоматическое лечение.

4.3 Слухопротезирование

Пациентам с хронической тугоухостью показаны подбор и настройка слуховых аппаратов при среднем пороге слышимости на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) на лучше слышащем ухе 31 дБ и более.

В алгоритме рекомендации уточнено, что пороги должны быть стабильными, а при выборе аппарата учитываются возраст, профессия, образовательные потребности и социальная активность пациента.

При невозможности использования слуховых аппаратов рассматривают установку импланта среднего уха при условии, что пороги костного звукопроведения на частоте 500 Гц не превышают 55 дБ, на высоких частотах 75 дБ.

У пациентов со сниженным зрением и другими инвалидизирующими заболеваниями показания к слухопротезированию расширяются, а требования к техническим средствам реабилитации возрастают.

4.4 Кохлеарная имплантация

При двусторонней тугоухости IV степени или глухоте проводится слухоречевая реабилитация методом кохлеарной имплантации (КИ).

В настоящее время кохлеарная имплантация является единственным эффективным методом реабилитации при тугоухости высокой степени и глухоте и включает комплекс аудиологических, сурдопедагогических, психологических и хирургических мероприятий.

4.5 Показания к кохлеарной имплантации

№	Показание
1	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени с порогами слуха 80 дБ и более по данным КСВП
2	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени со средними порогами на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц 80 дБ и более по данным тональной пороговой аудиометрии
3	Пороги в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами (бинаурально) выше 55 дБ на частотах 2–4 кГц
4	Отсутствие выраженного улучшения восприятия речи с оптимально подобранными слуховыми аппаратами при среднем пороге выше 95 дБ после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)
5	Разборчивость речи в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами менее 40% после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)

> Пороговые значения для кохлеарной имплантации в КР не согласованы с классификацией той же рекомендации. По разделу 1.5 IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как показания 1 и 2 касаются «IV степени с порогами 80 дБ и более», то есть охватывают и глухоту, но не всю IV степень. Показание 4 предусматривает средний порог выше 95 дБ, что соответствует глухоте, хотя речь в нём идёт о «высокой степени тугоухости».

Абсолютными противопоказаниями являются полная аплазия внутреннего уха (аномалия Мишеля), полная облитерация улитки, тяжёлые соматические, неврологические и психические заболевания, недостаточность интеллекта и отсутствие коммуникативных возможностей (исключения возможны для слабовидящих и слепых пациентов).

Относительными противопоказаниями являются отсутствие мотивации и возможностей для длительной реабилитации, частичная облитерация улитки, выраженные аномалии улитки и слухового нерва, обострение острых или хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов и ретрокохлеарная патология. При облитерации, аномалиях и ретрокохлеарной патологии решение принимает врачебная комиссия центра, выполняющего операцию.

Двусторонняя (бинауральная) имплантация выполняется одномоментно или последовательно. Она обеспечивает стимуляцию слуховых путей с обеих сторон, локализацию звука, лучшую разборчивость речи в шуме и при разговоре нескольких собеседников, более естественное и менее утомительное восприятие, а также сохранение слуха при поломке одного импланта.

Одномоментная бинауральная имплантация показана при хронической двусторонней тугоухости IV степени и глухоте после перенесённого менингита (при наличии выписки из стационара) по решению врачебной комиссии.

Последовательная бинауральная имплантация показана при оссификации или облитерации улитки после перелома височных костей и при отосклерозе, при аномалиях развития внутреннего уха, а также при хорошей динамике слуха и речи после односторонней имплантации и высокой мотивации; во всех случаях решение принимает врачебная комиссия центра. Объём последовательных имплантаций не должен превышать 10% годового объёма данного вида помощи в учреждении.

Противопоказания аналогичны противопоказаниям к кохлеарной имплантации; дополнительным противопоказанием является интервал между операциями, при котором система КИ используется с одной стороны более 5 лет.

Объём кохлеарной имплантации взрослым пациентам в учреждении не должен превышать 20% государственного задания по данному виду высокотехнологичной медицинской помощи. Гарантийный срок на имплант составляет не менее 10 лет, на речевой процессор не менее 5 лет.

4.6 Повторная имплантация

Причина	Тактика ведения
Техническая неисправность импланта	Реимплантация
Гнойное воспаление среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)	Санация полостей среднего уха, тимпанопластика. При невозможности сохранения импланта показаны эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Экструзия корпуса импланта	Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Миграция корпуса импланта, исключающая использование речевого процессора, или экстракохлеарное положение электродной решётки	В таблице КР не заполнено

Реимплантация выполняется системой того же производителя; установка системы другого производителя возможна только за счёт внебюджетных средств, что отражается в информированном согласии.

При выходе импланта из строя в течение гарантийного срока производитель по заявлению медицинской организации в течение 10 суток предоставляет первичное заключение и в течение 30 суток после него предоставляет новый имплант. Неисправность окончательно устанавливается по результатам технической экспертизы извлечённого импланта, продолжительность которой не превышает трёх месяцев.

4.7 Физиотерапевтическое лечение и другие методы реабилитации

Пациентам с тугоухостью и шумом в ушах проводится электростимуляция.

Применяются постоянный импульсный ток прямоугольной формы и флюктуирующие токи силой 0,5–2 мА; частота подбирается в соответствии с частотой шума. Продолжительность процедуры 10–15 минут, курс 10–15 процедур. Метод противопоказан пользователям кохлеарного, стволомозгового импланта и импланта среднего уха.

Проводится курс гипербарической оксигенации: 10–20 процедур при давлении 1,5–2,5 атм продолжительностью 1–2 часа.

Лечение предпочтительно начинать в течение первого месяца от начала заболевания; результаты лучше при сочетании с глюкокортикоидами.

В курс лечения включается рефлексотерапия.

Метод эффективен в качестве дополнительного лечения, в том числе на поздней стадии; электропунктура эффективнее классической иглорефлексотерапии. Используются импульсы длительностью 1 мс переменной полярности частотой 61 Гц, амплитуда до ощущения лёгкого покалывания, по 10 минут на пару точек; курс 10–15 процедур ежедневно или через день.

Проводится электронейростимуляция головного мозга.

Наибольшая эффективность отмечается при начальной и лёгкой степени тугоухости, в том числе при аудиоселективной транскраниальной электростимуляции: сила тока до 1,0 мА, продолжительность 20 минут, 15 процедур через день. Метод противопоказан пользователям имплантов.

В курс лечения включаются дозированные физические нагрузки.

Используются баланстерапия и дыхательная гимнастика курсами по 3 месяца, 3 раза в неделю по 40 минут, а также ежедневный терренкур продолжительностью не менее 20 минут.

Проводится транскраниальная магнитная стимуляция, в том числе при шуме в ушах на фоне тугоухости.

Выполняют ритмическую стимуляцию височно-теменных, лобных и префронтальных областей коры. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Применяются лекарственный ультрафонофорез и внутриушной электрофорез лекарственных препаратов.

В наружный слуховой проход вводится 1,5–2,0 мл лекарственного препарата, нагретого до 36–37 °C. Продолжительность процедуры 5–15 минут при частоте 880 кГц, мощности до 0,2 Вт/см² и гальваническом токе до 0,3 мА; курс 10–12 процедур. Метод противопоказан пользователям имплантов.

В курс лечения включается медицинский массаж.

Назначают лечебный массаж шеи и воротниковой зоны (классический, точечный или вакуумный) ежедневно, курсом до 10 процедур.

В комплексной терапии применяется лазеротерапия.

Внутривенное лазерное облучение крови сочетается с введением трентала: длина волны 630 нм, мощность 1,0–2,0 мВт, продолжительность 25–30 минут, 5–7 процедур ежедневно. При эндауральной методике длина волны составляет 808–810 нм, плотность потока 8–15 мВт/см², продолжительность 8–10 минут, 12–14 процедур ежедневно.

В курс лечения включается слуховой тренинг в виртуальной реальности.

Метод показан в качестве дополнительного при хронической тугоухости лёгкой степени и скрытой потере слуха: ежедневно в течение 7 дней по 15 минут с одной паузой продолжительностью 2 минуты.

Проводятся вестибулярные тренировки, в том числе в виртуальной реальности.

Тренировки равновесия назначают ежедневно или через день по 30 минут, курс 20 процедур.

Для улучшения слуха, в том числе после кохлеарной имплантации, используются мобильные приложения с шумоподавлением в режиме реального времени.

Методы, перечисленные в пунктах 4–15 раздела реабилитации, как правило, применяются в ходе санаторно-курортного лечения после консультации врача.

4.8 Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение рекомендуется в хронической стадии тугоухости, врождённой или приобретённой; в таблице КР перечислены все степени, от I до глухоты.

Код	Заболевание
H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя
H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточнённая

Показаны бальнеологические курорты с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми и йодобромными водами, климатические (приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные) и грязевые курорты.

При неэффективности как слуховых аппаратов, так и кохлеарных имплантов необходим альтернативный способ коммуникации: обучение дактилю и жестовому языку, сурдоперевод.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с хронической тугоухостью подлежат диспансерному наблюдению у сурдолога-оториноларинголога в сурдологическом кабинете или центре по месту жительства с оценкой эффективности лечения и состояния пациента.

Эффективность слуховых аппаратов оценивается по данным речевой аудиометрии в свободном звуковом поле в тишине и в шуме и анкетирования о качестве жизни. Тональная аудиометрия, речевая аудиометрия в тишине и в шуме и коррекция настроек слухового аппарата по их результатам необходимы 1–2 раза в год.

При остром ухудшении или быстром прогрессировании тугоухости исследование повторяется незамедлительно для своевременного проведения лечения и восстановления порогов.

После кохлеарной имплантации речевую аудиометрию в свободном звуковом поле в тишине и в шуме выполняют после подключения речевого процессора и на каждой настроечной сессии, 2–4 раза в год, в сочетании с анкетированием. Тональная и речевая аудиометрия повторяются 1–2 раза в год, речевой процессор настраивают 2–4 раза в год.

Для оценки эффективности слуховых аппаратов в рекомендации приведён опросник «Международная оценка использования слуховых аппаратов» из 7 вопросов. Если во всех вопросах выбраны ответы 1 и 2, необходимы коррекция настроек, повторное обследование слуха и направление пациента на слухоречевую реабилитацию; если во всех вопросах выбран вариант 3, требуется коррекция настроек; при вариантах 4 и 5 изменение настроек не требуется.

При односторонней тугоухости необходима дополнительная дифференциальная диагностика, при вестибулярных нарушениях и ушном шуме требуются дополнительные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия.

По показаниям пациент направляется на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о стойкой нетрудоспособности. Одновременно с установлением группы инвалидности составляется индивидуальная программа реабилитации с указанием выбранного способа коррекции слуха: традиционного или имплантационного слухопротезирования либо кохлеарной имплантации.

5.1 Показания к госпитализации

Показаниями к госпитализации являются острая сенсоневральная тугоухость и замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации (в круглосуточном или дневном стационаре).

Выписка осуществляется при выздоровлении или улучшении состояния.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у взрослых»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 22.03.2023 (год утверждения в PDF не заполнен: «20__»)
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года; следующая версия ожидалась не позднее марта 2026 года, но на 22.10.2026 в рубрикаторе действует эта
Код в рубрикаторе	518_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Пороги для кохлеарной имплантации не согласованы с классификацией: IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как в показаниях указаны «IV степень с порогами 80 дБ и более» и средний порог «более 95 дБ» (по классификации это соответствует глухоте).
- В разделе 3.1 пациент с острой тугоухостью направляется «в стационар или дневной стационар», тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию.
- В рекомендации о слуховых аппаратах речевые частоты указаны как «500, 1000, 2000 и 4000 кГц», тогда как должно быть «Гц».
- В таблице реимплантации у строки «Миграция корпуса внутренней части кохлеарного импланта…» не заполнена графа «Методы лечения».
- Одна и та же рекомендация об охранительном слуховом режиме при острой тугоухости имеет УДД 5, при хронической УДД 4.
- МРТ головного мозга рекомендована дважды, отдельными рекомендациями с разным объёмом (во второй вместе с рентгенографией шейного отдела позвоночника).
- В схеме #дексаметазона на 7-й день препарат не вводится, а на 8-й день вновь вводится 4 мг; так указано в тексте КР.
- Год утверждения на титульном листе не заполнен («20__»); PDF представляет собой скан с распознанным текстом и содержит много ошибок распознавания (например, «8181» вместо SISI, «1рз1 и соШга» вместо ipsi и contra).

Клинические рекомендации

Носовое кровотечение

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.0** — Носовое кровотечение
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/977_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Первым мероприятием при кровотечении из передних отделов полости носа является плотное прижатие крыльев носа к носовой перегородке на 5 минут и более.
- Если кровотечение не угрожает жизни, начинают с местной остановки кровотечения (прижатие крыльев носа, сосудосуживающие средства, коагуляция или тампонада); к коррекции гемостаза или отмене антикоагулянтов переходят лишь после этого.
- При продолжающемся кровотечении, источник которого визуализировать не удаётся, необходима передняя тампонада полости носа.
- Артериальное давление измеряют у каждого пациента, что позволяет выявить артериальную гипертензию и оценить объём кровопотери.
- Показаниями к госпитализации являются неэффективность первичных мероприятий, значительная кровопотеря или интенсивное кровотечение, признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология, высокий риск рецидива; госпитализация обязательна во всех случаях переливания крови, задней тампонады, перевязки сосудов и эмболизации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Под носовым кровотечением понимается кровотечение из повреждённых сосудов полости носа, околоносовых пазух или носоглотки, а также из сосудов полости черепа при повреждении верхней стенки полости носа.

2.2 Этиология

Различают посттравматические, в том числе послеоперационные, и спонтанные носовые кровотечения. Спонтанное кровотечение является симптомом местного или общего заболевания.

Поражение сосудов слизистой оболочки полости носа наблюдается при её атрофии, специфическом воспалении (туберкулёз, сифилис), опухолях полости носа и околоносовых пазух, сосудистых мальформациях, гранулематозе с полиангиитом.

У детей кровотечение в большинстве случаев обусловлено повреждением слизистой оболочки (инородное тело, травма, в том числе ятрогенная), острыми инфекциями верхних дыхательных путей и опухолями.

У детей до двух лет носовое кровотечение встречается очень редко, приблизительно в одном случае из 10 000. При возникновении кровотечения в этом возрасте необходимо исключить заболевания крови и врождённую патологию, в частности гемангиому полости носа и носоглотки.

2.3 Классификация

По механизму развития выделяют кровотечения, обусловленные изменениями сосудов полости носа, нарушениями свёртывания крови или сочетанием этих причин. По источнику различают кровотечения из передних и задних отделов полости носа, из околоносовых пазух, носоглотки и внутричерепных сосудов.

2.4 Клиническая картина

При переднем кровотечении кровь вытекает преимущественно наружу, при заднем стекает в носоглотку.

Пациенты предъявляют жалобы на кровянистые выделения из носа, часто на стекание крови по задней стенке глотки, недомогание. При заглатывании крови отмечаются дискомфорт в животе, тошнота, стул чёрного цвета.

2.5 Общие симптомы и объём кровопотери

Шок	Признаки	Кровопотеря
Отсутствует	Признаки отсутствуют	до 10% объёма циркулирующей крови (до 500 мл)
Лёгкий	Пульс до 100, систолическое артериальное давление выше 100 мм рт. ст., конечности холодные, диурез не нарушен	15–20% (750–1250 мл)
Средний	Пульс до 120, систолическое артериальное давление 90–100 мм рт. ст., пульсовое давление снижено, беспокойство, потливость, бледность кожных покровов, диурез менее 50 мл в час	25–35% (1250–1750 мл)
Тяжёлый	Пульс более 120, систолическое артериальное давление ниже 60 мм рт. ст. или не определяется, ступор, резкая бледность кожных покровов, конечности холодные, сухость языка и кожи, анурия	более 35% (более 1750 мл)

2.6 Анамнез

При сборе анамнеза уточняются время начала, длительность и частота кровотечений, сторона предшествующих кровотечений, случаи госпитализации и переливания крови в связи с ними. Выясняется приём антиагрегантов, антикоагулянтов и других препаратов, наличие артериальной гипертензии, коагулопатий, анемии, кровотечений у родственников, травм и операций на полости носа и околоносовых пазухах.

Носовое кровотечение, особенно рецидивирующее, может быть первым проявлением коагулопатии, наследственной геморрагической телеангиэктазии, опухоли полости носа или носоглотки, заболеваний печени или почек. Беспричинное появление синяков и петехий, кровотечения из внутренних органов в анамнезе свидетельствуют в пользу системного нарушения свёртывания крови.

Кровотечение на фоне приёма антикоагулянтов (варфарин, гепарин, дабигатран, апиксабан и другие) или антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел) может потребовать их отмены или снижения дозы. У таких пациентов чаще отмечаются рецидивы и кровопотеря более 250 мл, требующая переливания крови. Риск кровотечения повышают также многие назальные спреи, в том числе сосудосуживающие и глюкокортикостероидные, и некоторые наркотические вещества.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается при подтверждении кровянистых выделений из носа данными риноскопии и фарингоскопии.

3.1 Физикальное обследование

Всем пациентам с носовым кровотечением требуется осмотр врача-оториноларинголога с оценкой общего состояния, поиском источника кровотечения и определением тактики лечения.

При необходимости госпитализации следует выбирать стационар, в котором имеется дежурный оториноларинголог. Если во время кровотечения пациент не был осмотрен оториноларингологом, в том числе в связи с самопроизвольной остановкой кровотечения, необходима плановая консультация оториноларинголога.

Для исключения гиповолемии оцениваются пульс, уровень сознания, состояние кожных покровов и слизистых оболочек. Обморок, тахикардия, тахипноэ, бледность кожных покровов свидетельствуют о гемодинамических нарушениях вследствие кровопотери. Кровоизлияния на коже и слизистых оболочках при отсутствии травмы могут указывать на системное нарушение свёртывания крови.

При повторных кровотечениях из обеих половин носа, а также при наличии носовых кровотечений у родственников следует искать телеангиэктазии на слизистой оболочке полости носа и рта, чтобы исключить наследственную геморрагическую телеангиэктазию (болезни Рандю—Ослера—Вебера).

У всех пациентов определяют артериальное давление, что позволяет выявить артериальную гипертензию и оценить гиповолемию; артериальная гипотензия может свидетельствовать о значительной кровопотере.

Если источник кровотечения не визуализируется при передней риноскопии, следует выполнить эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки.

Повторяющееся одностороннее кровотечение может быть первым признаком опухоли, не визуализируемой при передней риноскопии, а у детей также инородного тела.

3.2 Лабораторные исследования

Общий анализ крови позволяет оценить постгеморрагическую анемию и уровень тромбоцитов; о кровопотере судят по уровню гемоглобина и гематокриту.

3.3 Степень кровопотери у взрослых

Степень	Объём кровопотери	Гемоглобин, г/л	Гематокрит, %
I	до 500 мл	более 120	более 40
II	500–1000 мл	100–120	30–40
III	1000–1500 мл	80–100	20–30
IV	более 1500 мл	менее 80	менее 20

При рецидивирующих кровотечениях и при кровотечении, требующем госпитализации, исследуют систему гемостаза: определяют международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и протромбиновое время. Определение МНО имеет особое значение у пациентов, получающих варфарин: значение выше 4,5 является прогностически неблагоприятным.

На фоне приёма прямых пероральных антикоагулянтов (дабигатран, ривароксабан и др.) эти показатели могут не отражать степень гипокоагуляции.

3.4 Консультации специалистов

Артериальная гипертензия, анемия, коагулопатия или другие сопутствующие заболевания, влияющие на течение кровотечения, требуют консультации терапевта или педиатра.

Пациентов с рецидивирующими кровотечениями и лабораторными признаками тромбоцитопатии или коагулопатии направляют на консультацию к гематологу.

---

4. Лечение

Целью лечения является остановка кровотечения, устранение факторов риска и коррекция последствий кровопотери, в том числе гиповолемии и анемии.

Если кровотечение не угрожает жизни, его в первую очередь останавливают местными методами: прижатием крыльев носа, применением сосудосуживающего средства, коагуляцией или тампонадой. Корригировать гемостаз или отменять антикоагулянты и антиагреганты следует лишь после этого, поскольку системная коррекция сопряжена с риском осложнений, прежде всего тромбоэмболических.

4.1 Остановка кровотечения

При кровотечении из передних отделов полости носа прежде всего плотно прижимают крылья носа к носовой перегородке на 5 минут и более, как правило на 5–15 минут. Предварительно пациент сморкается для удаления сгустков и находится в положении сидя или стоя с небольшим наклоном головы вперёд. Манипуляция может быть выполнена самим пациентом. Если кровь продолжает стекать, источник кровотечения, вероятнее всего, расположен глубже и требуются другие методы остановки.

При продолжающемся кровотечении и установленном источнике взрослым рекомендуется аппликация на источник турунды с сосудосуживающим средством; взрослым и детям возможна аппликация гемостатического средства.

Однократно на турунде применяется #ксилометазолин или #эпинефрин; #оксиметазолин в виде спрея — по 2 впрыскивания в каждую половину носа 3 раза в сутки в течение 3–5 дней (знак # обозначает применение вне инструкции). При артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (ИБС) и ишемии головного мозга сосудосуживающие препараты применяются с осторожностью.

Возможна однократная аппликация на источник кровотечения турунды с #транексамовой кислотой (взрослым: 5 мл на кусочек ваты или марли на 10–30 минут) или этамзилатом (взрослым и детям).

Когда источник продолжающегося кровотечения обнаружить не удаётся, прибегают к передней тампонаде полости носа.

Преимуществом рассасывающихся материалов, например коллагеновой гемостатической губки, является отсутствие необходимости их удаления, поскольку при удалении тампона кровотечение может возобновиться. В связи с этим при высоком риске повторного кровотечения, например при наследственной геморрагической телеангиэктазии или заболеваниях крови, по возможности следует использовать рассасывающиеся материалы. У детей источник кровотечения, как правило, располагается в передних отделах, поэтому, если поведение ребёнка позволяет, предпочтительны бестампонные методы остановки; если ребёнок не готов к манипуляциям, предпочтительна передняя тампонада.

Если кровотечение из задних отделов полости носа не удаётся остановить передней тампонадой, переходят к сочетанной передней и задней тампонаде с установкой тампона в области хоан и носоглотки.

Пациенты с задним тампоном подлежат наблюдению и лечению в стационаре. Нить или фиксатор не должны оказывать избыточного давления на крыло носа во избежание образования пролежня. Ряд авторов указывает на необходимость системной антибактериальной терапии при задней тампонаде.

Продолжающееся кровотечение из установленного источника служит показанием к коагуляции кровоточащего сосуда.

Коагуляция может выполняться химическим методом (нитратом серебра), электрокоагуляцией, лазером или радиоволновым методом. Предварительная аппликация сосудосуживающего средства повышает эффективность коагуляции.

При неэффективности коагуляции и тампонады рассматривается вопрос об эмболизации сосудов или перевязке артерии.

В редких случаях перевязывают наружную сонную артерию на стороне кровотечения. Эффективность эмболизации достигает 87%, однако осложнения при ней развиваются чаще, чем при перевязке; эмболизация может выполняться под седацией и без удаления тампонов.

При рецидивирующих кровотечениях из зоны Киссельбаха рекомендуется отслойка слизистой оболочки перегородки носа.

При субатрофии слизистой оболочки и выраженном искривлении перегородки носа от операции воздерживаются.

4.2 Медикаментозная терапия

Повышенное артериальное давление требует антигипертензивной терапии, которая позволяет уменьшить кровопотерю и риск рецидива.

При недостаточной эффективности первичных мероприятий применяют гемостатические средства: транексамовая кислота (внутривенно с 1 года, в таблетках с 3 лет), аминокапроновая кислота, аминометилбензойная кислота, этамзилат в дозах согласно инструкции. При продолжающемся кровотечении предпочтительно внутривенное введение, таблетированные формы используют для профилактики рецидивов.

Системное применение этамзилата оправдано только при диапедезном кровотечении из мелких сосудов слизистой оболочки.

При травматическом кровотечении или риске тяжёлого кровотечения пациентам старше года показано внутривенное введение транексамовой кислоты в максимально ранние сроки, предпочтительно в первые 3 часа после травмы.

Ведение пациентов с коагулопатиями и переливание крови по возможности осуществляются совместно с гематологом, терапевтом или педиатром.

Детям с геморрагическим синдромом при дефиците витамина K вводится менадиона натрия бисульфит: новорождённым — до 4 мг в сутки, детям от месяца до года — 2–5 мг в сутки. Возможно также профилактическое введение, не дожидаясь подтверждения дефицита.

После кровотечения или его остановки рекомендуются увлажняющие и ранозаживляющие средства для слизистой оболочки полости носа.

Эти средства уменьшают сухость и образование корок, что позволяет пациенту избегать самостоятельного туалета носа; применяют их и при субатрофическом рините.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации

Пациентам разъясняются факторы риска повторного кровотечения, способы его самостоятельной остановки и показания для обращения к врачу.

Детям, родителям и пожилым пациентам следует объяснить недопустимость пальцевой травмы слизистой оболочки носа; пожилым пациентам важно также указать на связь риска кровотечения с приёмом лекарственных препаратов и подъёмом артериального давления. Сухость слизистой оболочки вызывают кислородные канюли и дыхательные аппараты повышенного давления. Пациентам, получающим варфарин, обязателен контроль МНО. При рецидивирующих кровотечениях на фоне применения назальных спреев их дозу уменьшают и обучают пациента правильной технике применения.

Если кровотечение связано с повышением артериального давления, для подбора антигипертензивной терапии пациента направляют к терапевту, педиатру или кардиологу.

5.1 Показания к госпитализации

Решение о необходимости госпитализации после передней тампонады принимается с учётом длительности кровотечения, объёма кровопотери, признаков гиповолемии, сопутствующих заболеваний, типа тампона и доступности амбулаторной помощи. При активном кровотечении или нестабильной гемодинамике обследование и лечение осуществляют в приёмном или оториноларингологическом отделении.

На фоне гипертонической болезни кровотечение останавливает оториноларинголог в приёмном отделении, после чего пациент госпитализируется в терапевтический стационар для нормализации артериального давления.

При незначительном или остановившемся кровотечении обследование пациента возможно в амбулаторных условиях.

Показаниями к госпитализации являются неэффективность первичных мероприятий, значительная кровопотеря или интенсивное кровотечение, признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология, высокий риск рецидива. Госпитализация обязательна во всех случаях переливания крови, задней тампонады, перевязки сосудов и эмболизации, а также после передней тампонады нерассасывающимся материалом, если удаление тампонов в амбулаторных условиях невозможно.

Значительной считается кровопотеря более 10% объёма циркулирующей крови (около 500 мл у взрослого), интенсивным считается кровотечение более 1 мл/кг в минуту. Риск тяжёлого кровотечения повышают госпитализации по поводу кровотечений в анамнезе, особенно с переливанием крови, и более трёх эпизодов за последние 3 месяца.

Пациент выписывается при стойкой остановке кровотечения, отсутствии признаков гиповолемии, стабильной гемодинамике и компенсации сопутствующих заболеваний.

Исход во многом определяется скоростью и объёмом кровопотери: массивная кровопотеря более 40% объёма циркулирующей крови может быть несовместима с жизнью.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Носовое кровотечение»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 08.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	977_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В рекомендации о гемостатической терапии уровень доказательности обозначен как «уровень доказательств – 4» вместо принятой формулировки «уровень достоверности доказательств».
- В оглавлении PDF-версии вместо номеров страниц нескольких разделов указано «Ошибка! Закладка не определена».

Клинические рекомендации

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная **B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная **B34.9** — Вирусная инфекция неуточненная **B97.0** — Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках **B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J01** — Острый синусит **J02** — Острый фарингит **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J04** — Острый ларингит и трахеит **J05** — Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит **J06** — Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации **J20** — Острый бронхит **J21** — Острый бронхиолит **J22** — Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/724_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- При неосложнённой ОРВИ в первые 10–14 дней антибактериальная терапия не назначается, в том числе при наличии ринита, конъюнктивита, затемнения околоносовых пазух на рентгенограмме, ларингита, крупа или бронхита.
- При затруднении носового дыхания более 3–5 дней и подозрении на бактериальный синусит необходимы рентгенография или компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух для своевременного направления пациента к оториноларингологу. Данное осложнение встречается в 0,5–2% случаев, а изменения в пазухах не всегда свидетельствуют о бактериальном воспалении.
- Приём противовирусных препаратов начинают не позднее 48 часов от начала заболевания: в первой линии препараты прямого противовирусного действия, во второй линии иммунотропные препараты.
- При выраженной заложенности носа при рините и риносинусите применяют местные деконгестанты, которые облегчают носовое дыхание и восстанавливают проходимость слуховой трубы.
- Препаратом выбора при бактериальном риносинусите является амоксициллин по 500–1000 мг 3 раза в сутки в течение 7–10 дней.
- Показаниями к срочной госпитализации являются частота дыхания более 24 в минуту, сатурация ниже 95%, очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) представляют собой группу вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём и поражающих преимущественно верхние, реже нижние дыхательные пути.

Грипп А и В и новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) рассматриваются в отдельных клинических рекомендациях и в данном документе не освещаются.

2.2 Этиология

Наиболее частыми возбудителями ОРВИ являются респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) А и В, респираторный энтеровирус, риновирус, аденовирус, метапневмовирус человека, вирусы парагриппа 1–4 типов и сезонные коронавирусы. Большинство из них относится к РНК-содержащим вирусам. Их объединяют общие механизмы и пути передачи, стадии развития заболевания и клинические проявления.

2.3 Возбудители и ведущие клинические синдромы

Возбудитель	Основные синдромы
Вирусы парагриппа	Ларингит, ринофарингит, ложный круп
Респираторно-синцитиальный вирус	Бронхит, бронхиолит
Аденовирусы	Фарингит, тонзиллит, бронхит
Риновирусы	Ринит, фарингит
Коронавирусы человека	Ринофарингит, бронхит

Возбудитель	Основные синдромы
Коронавирус ТОРС (тяжёлого острого респираторного синдрома)	Бронхит, бронхиолит, респираторный дистресс-синдром

2.4 Классификация

По типу течения выделяют типичную (манифестную) и атипичную (бессимптомную, стёртую) формы ОРВИ. По тяжести различают лёгкую, среднюю, тяжёлую и очень тяжёлую степень. По характеру течения выделяют неосложнённую и осложнённую формы (со специфическими осложнениями, с осложнениями, обусловленными вторичной микрофлорой, или с обострением хронических заболеваний). По длительности течения различают острую (5–10 дней), подострую (11–30 дней) и затяжную (более 30 дней) формы.

2.5 Критерии степени тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Температура тела 37–37,5 °С или нормальная, умеренно выраженные катаральные явления, продолжительность заболевания 4–6 дней
Среднетяжёлая	Температура тела 38–39 °С, выраженные катаральные явления; при отсутствии осложнений выздоровление наступает через 6–10 дней
Тяжёлая	Температура тела 39–41 °С; на фоне слабо или резко выраженных катаральных симптомов развиваются угрожающие жизни осложнения

2.6 Клиническая картина

Инкубационный период составляет от 1 до 14 суток, у наиболее распространённых вирусов 1–5 дней. Заболевание, как правило, начинается постепенно с умеренно выраженной интоксикации: повышение температуры тела до субфебрильных или фебрильных значений, слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах. Одновременно развивается катаральный синдром: першение в горле, кашель, насморк, в ряде случаев конъюнктивит. Возможно увеличение лимфатических узлов, реже печени (при аденовирусной инфекции).

2.7 Синдромы поражения дыхательных путей

Синдром	Признаки
Острый ринит	Воспаление слизистой оболочки полости носа: чихание, выделения из носа (ринорея), нарушение носового дыхания. Стекание слизи по задней стенке глотки вызывает кашель.
Фарингит	Воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки: внезапно возникающие першение и сухость в горле, боль при глотании.
Тонзиллит	Изменения нёбных миндалин как вирусной природы, так и при обострении бактериальной (стрептококковой) инфекции. Характерны интоксикация, гиперемия и отёк миндалин, нёбных дужек, язычка и задней стенки глотки, рыхлые налёты в лакунах.
Ларингит	Воспаление гортани с вовлечением голосовых складок и подскладкового пространства. Первыми симптомами являются сухой «лающий» кашель и осиплость голоса.

Синдром	Признаки
Трахеит	Воспаление слизистой оболочки трахеи: саднение и боль за грудиной, сухой надсадный кашель.
Бронхит	Надсадный кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, удлинённый выдох, рассеянные сухие хрипы, в тяжёлых случаях одышка. Кашель сохраняется 2 недели и более (до месяца). На второй неделе мокрота может приобретать желтовато-зеленоватый оттенок вследствие примеси фибрина и присоединения бактериальной флоры.

2.8 Осложнения

Осложнения подразделяются на специфические и обусловленные вторичной микрофлорой. К специфическим осложнениям относятся менингизм, острая дыхательная недостаточность, энцефалопатия, инфекционно-токсический шок, респираторный дистресс-синдром взрослых, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, тромбоэмболия.

Вторичная бактериальная микрофлора является причиной острого синусита, острого отита, острого бронхита, обострения хронических бронхолёгочных заболеваний и пневмонии.

2.9 Жалобы и анамнез

У всех пациентов необходимо уточнить наличие недомогания, повышения температуры тела, утомляемости и слабости, снижения аппетита, головной боли, боли в горле, затруднения носового дыхания, насморка, осиплости, сухого или влажного кашля, увеличения лимфатических узлов, боли в животе, одышки, затруднённого вдоха, рвоты, судорог и потери сознания.

Уточняются длительность заболевания, а также наличие причин, препятствующих незамедлительному началу лечения или требующих его коррекции в связи с сопутствующими заболеваниями.

К таким причинам относятся непереносимость лекарственных препаратов, неадекватное психоэмоциональное состояние, угрожающее жизни острое состояние или обострение хронического заболевания, требующее участия профильного специалиста, а также отказ от лечения.

Необходимо уточнить эпидемиологический анамнез: контакт с больным ОРВИ в пределах инкубационного периода, сезонный подъём заболеваемости, вспышки в организованных коллективах, наличие вакцинации против гриппа.

Выявляются факторы риска тяжёлого и осложнённого течения: хронические заболевания лёгких и сердца, нарушения обмена веществ, хроническая болезнь почек, заболевания печени, неврологические состояния, гемоглобинопатии, иммунодефициты (ВИЧ-инфекция, приём иммуносупрессоров), злокачественные новообразования, возраст старше 65 лет, беременность.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, данных физикального обследования, лабораторных и инструментальных исследований. Целью диагностики является определение нозологической и клинической формы, степени тяжести, наличия осложнений и показаний к лечению.

3.1 Физикальное обследование

Осмотр начинается с оценки кожных покровов и видимых слизистых оболочек: цвет (гиперемия, бледность, цианоз), влажность, отёчность, инъекция сосудов склер, конъюнктивит. Оцениваются носовое дыхание и признаки ринита, проводится осмотр ротоглотки: гиперемия нёбных дужек и задней стенки глотки, состояние миндалин, рыхлость и зернистость задней стенки глотки, слизистый налёт, увеличение лимфоидных фолликулов.

Катаральные симптомы необходимо выявлять уже на первом этапе обследования, однако они встречаются и при некоторых бактериальных инфекциях, в частности при стрептококковом или менингококковом назофарингите.

Всем пациентам необходимы осмотр и пальпация лимфатических узлов головы и шеи с оценкой их размеров и болезненности.

Обследование всех пациентов включает пальпацию, перкуссию и аускультацию лёгких с оценкой частоты дыхания, характера дыхательных шумов, наличия хрипов и крепитации, которая появляется при пневмонии.

Для оценки степени тяжести, выявления тахикардии, шумов, осложнений и сопутствующих заболеваний необходимы измерение частоты пульса и артериального давления, аускультация сердца.

3.2 Лабораторные исследования

Всем пациентам для оценки степени тяжести, своевременного выявления осложнений и исключения бактериальных осложнений показан общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.

Для вирусной инфекции характерны лейкопения или нормальное количество лейкоцитов, лимфоцитоз и моноцитоз.

Всем пациентам выполняют общий анализ мочи для выявления нарушения функции почек, декомпенсации сопутствующих заболеваний, исключения инфекции мочевыводящих путей и нефропатии. При неосложнённой ОРВИ изменения отсутствуют; при выраженной лихорадке возможны преходящее повышение относительной плотности мочи, незначительные лейкоцитурия, протеинурия и цилиндрурия.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении необходимы биохимический анализ крови (активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), амилазы, уровень мочевины) и исследование уровня электролитов.

Для своевременного назначения противовирусной терапии возбудитель определяется экспресс-методами.

Применяется иммунохроматографический тест для выявления антигенов вирусов гриппа A и B, РСВ, аденовируса и SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки у пациентов, обратившихся не позднее 2 суток от начала симптомов.

Для идентификации возбудителя мазки из носоглотки и ротоглотки исследуются методами амплификации нуклеиновых кислот (полимеразная цепная реакция (ПЦР), петлевая изотермическая амплификация (LAMP) и другие) на вирусы ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2.

Данный метод является наиболее эффективным: нуклеиновые кислоты вирусов выявляются в среднем до 7 дней, максимально до 2 недель от начала заболевания при сохранении признаков поражения верхних дыхательных путей. Результат исследования готов через 4–6 часов.

Обследование пациентов с тонзиллитом и пневмонией осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями по данным заболеваниям.

3.3 Инструментальные исследования

Для ранней диагностики дыхательной недостаточности применяют пульсоксиметрию с измерением сатурации крови кислородом (SpO2). Метод является простым и надёжным способом выявления пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной поддержке.

При бронхите продолжительностью более 3–5 дней и при физикальных признаках поражения лёгких для исключения или подтверждения пневмонии показаны рентгенография органов грудной клетки или КТ лёгких.

При затруднении носового дыхания более 3–5 дней и подозрении на синусит вследствие присоединения бактериальной флоры показаны рентгенография или КТ околоносовых пазух для своевременного направления пациента к оториноларингологу.

Данное осложнение встречается в 0,5–2% случаев ОРВИ у взрослых. Изменения в околоносовых пазухах не всегда свидетельствуют об их бактериальном поражении.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно у пациентов пожилого возраста, для оценки функции сердца и выявления нарушений ритма на фоне интоксикации проводится электрокардиография (ЭКГ).

3.4 Консультации специалистов

При подозрении на осложнения показаны консультации смежных специалистов: оториноларинголога при синусите и отите, невролога при энцефалопатии, пульмонолога при признаках пневмонии, гематолога при выраженных изменениях в анализе крови и геморрагическом синдроме, кардиолога при миокардите и острой сердечно-сосудистой недостаточности, акушера-гинеколога при беременности.

При быстро нарастающей острой дыхательной недостаточности (частота дыхания более 25 в минуту, SpO2 ниже 92%) или другой органной недостаточности (2 балла и более по шкале SOFA) показана консультация анестезиолога-реаниматолога для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

3.5 Алгоритм ведения на амбулаторном этапе

При выявлении катаральных явлений необходимы общий анализ крови и обследование лёгких. При отсутствии изменений в лёгких лечение амбулаторное; при сохранении лихорадки на фоне лечения анализ крови повторяется, и при выявлении изменений пациент направляется к инфекционисту. При изменениях в лёгких необходима рентгенография; при отсутствии признаков пневмонии проводят рентгенографию околоносовых пазух, и при выявлении изменений в них пациент направляется к оториноларингологу.

3.6 Дифференциальная диагностика

ОРВИ дифференцируют с острыми респираторными заболеваниями бактериальной природы, в том числе вирусной пневмонии с бактериальной.

3.7 Дифференциально-диагностические признаки основных ОРВИ

Возбудитель	Начало и течение заболевания	Лихорадка и интоксикация	Поражение носа и глотки	Кашель и другие проявления
Парагрипп	Инкубационный период 2–7 дней, чаще 3–4; начало постепенное, течение подострое	37–38 °С, может сохраняться длительно; интоксикация слабо или умеренно выражена, 1–3 дня	Катаральные явления с первого дня, осиплость голоса; заложенность носа; слабая или умеренная гиперемия слизистой оболочки зева, мягкого нёба и задней стенки глотки	Сухой «лающий» кашель, в ряде случаев до 12–21 дня; ведущими синдромами являются ларингит и ложный круп
РС-инфекция	Инкубационный период 3–6 дней; начало постепенное, течение подострое, в ряде случаев затяжное	Субфебрильная, в ряде случаев нормальная; интоксикация умеренная или слабая, 2–7 дней	Катаральные явления нарастают постепенно; заложенность носа, необильные серозные выделения; слабая гиперемия слизистых оболочек	Сухой приступообразный кашель до 3 недель с болью за грудиной; бронхит, бронхиолит, возможен бронхоспазм
Аденовирусная инфекция	Инкубационный период 4–14 дней; начало постепенное, течение затяжное, волнообразное	Фебрильная или субфебрильная; интоксикация умеренная, 8–10 дней	Резко выраженные катаральные явления; обильные слизисто-серозные выделения, резкое затруднение носового дыхания; умеренная гиперемия и гиперплазия фолликулов задней стенки глотки	Влажный кашель; ринофаринго-конъюнктивит, тонзиллит, конъюнктивит, кератит; возможны полиаденит, гепатоспленомегалия, экзантема, диарея

4. Лечение

Целями лечения являются подавление репликации вируса в ранние сроки, предотвращение прогрессирования заболевания, достижение полного выздоровления и профилактика осложнений.

Хирургическое лечение не проводится.

4.1 Базисная терапия

Всем пациентам независимо от степени тяжести необходима базисная терапия: постельный режим, диета и обильное питьё. В рацион включаются легкоусвояемые продукты, богатые витаминами; употребление алкоголя в любом виде исключается.

Всем пациентам без поражения лёгких рекомендуется дезинтоксикационная терапия. При лёгком и среднетяжёлом течении в амбулаторных условиях рекомендуется приём 2–3 литров жидкости в сутки. При среднетяжёлом течении в условиях стационара проводятся пероральная регидратация и (или) инфузия 800–2000 мл растворов, влияющих на водно-электролитный баланс. При осложнённом и тяжёлом течении дезинтоксикационную терапию проводят внутривенно с коррекцией электролитных нарушений.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при поражении лёгких для купирования интоксикации применяют меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно со скоростью 1–4,5 мл/мин, в среднем 10 мл/кг в сутки, курсом до 11 дней.

4.2 Противовирусная терапия

Приём противовирусных препаратов начинают не позднее 48 часов от начала заболевания. Препаратами первой линии являются препараты прямого противовирусного действия, второй линии иммунотропные препараты с опосредованным действием: интерфероны, другие иммуностимуляторы и общетонизирующие средства.

Выбор препарата определяется возбудителем. Раннее назначение противовирусной терапии предупреждает тяжёлое течение и развитие осложнений; целесообразность назначения противовирусного препарата определяется врачом индивидуально для каждого пациента.

Препарат	Доза	УУР, УДД
Риамиловир (первая линия)	Внутрь 250 мг 3 раза в день в течение 5 дней; лечение следует начать не позднее 2-го дня болезни	C, 1
Умифеновир (первая линия)	200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток. Противопоказан в I триместре беременности	C, 2
Энисамия йодид (первая линия)	Внутрь 500 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней. Противопоказан при беременности и грудном вскармливании, тяжёлых поражениях печени и почек, непереносимости лактозы и фруктозы	C, 2
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (вторая линия)	90 мг 1 раз в день в течение 5–7 дней, приём желательно начать в первые 2 суток. Противопоказан при беременности и в период лактации	C, 5
Меглюмина акридонацетат (вторая линия)	По 4 таблетки однократно на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки (всего 20 таблеток). Противопоказан при беременности и в период лактации	B, 1
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (вторая линия)	В первый день 200 мг 3 раза, в последующие 7 дней по 200 мг 1 раз в сутки (на курс 2000 мг)	C, 5

Препарат	Доза	УУР, УДД
Азоксимера бромид (вторая линия)	Таблетки: по 1 таблетке под язык 2 раза в день в течение 7 дней. Раствор: парентерально 6 мг в сутки в течение 3 дней, затем через день, всего 10 инъекций, или интраназально либо сублингвально по 6 мг в сутки в 2–3 приёма. Суппозитории: 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев	C, 5
Тилорон (вторая линия)	125 мг в сутки в первые 2 дня, затем по 125 мг через 48 часов, на курс 750 мг (6 таблеток)	C, 5
Антитела к гамма-интерферону, гистамину и CD4 (Эргоферон)	В 1-й день 8 таблеток: по 1 таблетке каждые 30 минут в течение первых 2 часов, затем ещё 3 раза; со 2-го дня по 1 таблетке 3 раза в день до выздоровления	C, 2
Антитела к гамма-интерферону, CD4 и молекулам MHC (Рафамин)	В 1-й день по той же схеме, затем по 1 таблетке 3 раза в день; общая продолжительность 5 дней, с 18 лет	B, 2

Возможно применение интраназальных интерферонов, которые обладают опосредованным действием и используются в комплексной терапии с первых признаков заболевания. В рекомендации отмечено, что они не входят в перечень препаратов международных клинических рекомендаций.

Интерферон альфа-2b — по 3 капли (дозы) в каждый носовой ход 5–6 раз в день (3000 МЕ на приём, 15 000–18 000 МЕ в сутки) в течение 5 дней.

Интерферон гамма человеческий рекомбинантный — по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носа 5 раз в день в течение 5–7 дней.

Пациентам с неосложнённой ОРВИ, а также с частыми, тяжёлыми или затяжными респираторными инфекциями в анамнезе в комплексное лечение для стимуляции иммунитета включаются лизаты бактерий. Препарат принимается с первых дней заболевания по 1 капсуле утром натощак за 30 минут до еды до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней.

4.3 Жаропонижающая терапия

При температуре тела выше 38 °C и болях в мышцах и суставах назначаются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Препаратами выбора являются парацетамол по 500–1000 мг каждые 4–6 часов при необходимости, не более 4000 мг в сутки, и ибупрофен по 400 мг 3 раза в сутки, не более 1200 мг в сутки. Возможно применение комбинаций ибупрофена с парацетамолом и парацетамола с фенилэфрином и фенирамином.

НПВП применяются только для снижения температуры тела и обезболивания; длительные курсы нецелесообразны, поскольку могут затруднить оценку эффективности лечения.

4.4 Местная терапия ринита и риносинусита

Физиологический раствор натрия хлорида вводится в полость носа 2–3 раза в день; он разжижает секрет, способствует удалению слизи и восстанавливает функцию мерцательного эпителия.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексном лечении ринита и риносинусита применяются местные деконгестанты для уменьшения заложенности носа и восстановления проходимости слуховой трубы.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Ксилометазолин	По 1–2 капли (1 впрыскивание) 3 раза в день
Нафазолин	По 1–3 капли 0,05–0,1% раствора 3–4 раза в сутки

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Ипратропия бромид + ксилометазолин	Фиксированная комбинация, применяется при обильной ринорее; доза в рекомендации не указана
Оксиметазолин	0,05% раствор, по 1–2 капли или 1–2 впрыскивания 2 раза в сутки

При назофарингите и неосложнённом риносинусите с заложенностью носа, ринореей и стеканием слизи по задней стенке глотки с первого дня назначается комбинированный растительный препарат, содержащий корень горечавки, цветки первоцвета, траву щавеля, цветки бузины и траву вербены. Препарат улучшает функцию мукоцилиарного аппарата и отток экссудата, ускоряет выздоровление и способствует профилактике осложнений.

Сухой экстракт — по 160 мг (1 таблетка) 3 раза в день, измельчённое растительное сырьё — по 156 мг (2 таблетки) 3 раза в день, капли — по 50 капель 3 раза в день; курс 7–14 дней.

Беременным при насморке, назофарингите и остром риносинусите препарат может быть назначен после консультации врача в форме таблеток, а при невозможности их приёма в форме капель.

4.5 Местная терапия фарингита и тонзиллита

Для уменьшения воспаления и болевого синдрома и профилактики вторичной инфекции слизистой оболочки ротоглотки назначаются препараты для лечения заболеваний горла и антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций, таблеток и пастилок для рассасывания.

Применяются грамицидин С с цетилпиридинием (в том числе с оксибупрокаином), бензидамин или флурбипрофен с цетилпиридинием, гексэтидин, лизоцим с пиридоксином, хлоргексидин, бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, биклотимол и препараты йода.

При фарингите и тонзиллите (боль в горле в покое и при глотании, гиперемия слизистой оболочки глотки и миндалин, увеличение миндалин) назначается растительный антисептик, содержащий корень алтея, цветки ромашки, траву тысячелистника, кору дуба, листья грецкого ореха, траву хвоща и траву одуванчика. Препарат уменьшает болевой синдром и воспаление и способствует профилактике осложнений и повторных эпизодов ОРВИ.

Таблетки — по 2 таблетки (96 мг) 5–6 раз в день, капли — по 25 капель 5–6 раз в день до купирования боли в горле, затем ещё в течение недели 3 раза в день. Препарат может назначаться беременным и пациентам с соматическими заболеваниями после консультации врача.

4.6 Противокашлевая и мукоактивная терапия

При сухом непродуктивном надсадном кашле, значительно ухудшающем качество жизни (болевой синдром, нарушение сна), назначаются противокашлевые средства: бутамират, леводропропизин, антитела к брадикинину, морфину и гистамину или декстрометорфан в составе комбинированных препаратов.

Бутамират в форме сиропа — по 15 мл 4 раза в сутки. Леводропропизин — по 60 мг 1–3 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов. Антитела к брадикинину, морфину и гистамину — по 1–2 таблетки или 5–10 мл раствора 3 раза в сутки, в первые 3 дня до 4–6 раз.

При остром вирусном бронхите и трахеите с влажным кашлем и бронхообструкцией назначаются муколитические и отхаркивающие средства, но не в комбинации с противокашлевыми. Муколитические препараты, в том числе растительные, применяются только при продуктивном кашле.

Ацетилцистеин — 600 мг в сутки до 5–7 дней; амброксол — 90 мг в сутки, в форме капсул пролонгированного действия 75 мг в сутки, до 14 дней. Растительные комбинации экстрактов тимьяна с плющом или первоцветом применяются в течение 10–14 дней.

Одновременное назначение отхаркивающих и противокашлевых средств не рекомендуется, поскольку подавление кашлевого рефлекса может привести к застою мокроты.

При остром вирусном бронхите с влажным кашлем для облегчения отхождения вязкой мокроты рекомендуются небулайзерные ингаляции гипертонического раствора натрия хлорида (3% или 7%) с гиалуронатом натрия по 5 мл 2 раза в день.

При бронхообструктивном синдроме, обусловленном бронхоспазмом, применяют комбинацию ипратропия бромида с фенотеролом: в форме дозированного аэрозольного ингалятора по 1–2 вдоха до 3–4 раз в сутки или через небулайзер по 1–2 мл до 3–4 раз в сутки.

При продуктивном кашле, особенно с признаками бронхиальной обструкции, взрослым может назначаться амброксол с гвайфенезином и левосальбутамолом по 10 мл 3 раза в день в течение 2 недель.

4.7 Антибактериальная терапия

При неосложнённой ОРВИ в первые 10–14 дней антибактериальная терапия не назначается, в том числе при рините, конъюнктивите, затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме, ларингите, крупе, бронхите и бронхообструктивном синдроме.

К антибактериальной терапии прибегают при вероятной сопутствующей бактериальной инфекции, при неэффективности патогенетической, симптоматической и противовирусной терапии, а также при бактериальных осложнениях среднетяжёлой и тяжёлой ОРВИ (бронхите, пневмонии и других).

4.8 Антибактериальная терапия бактериального риносинусита

Препарат	Доза
Амоксициллин	Внутрь 500–1000 мг 3 раза в сутки в течение 7–10 дней
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутрь 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки в течение 7–10 дней
Азитромицин	Внутрь 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней
Кларитромицин	500 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней (кратность приведена по тексту рекомендации)
Левофлоксацин	Внутрь 500 мг до 5–7 дней; применяется при устойчивой микрофлоре, неэффективности других антибиотиков, экзантеме или лекарственной аллергии на другие антибиотики

> В рекомендации имеется расхождение в сроках. Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а в разделе об организации медицинской помощи сохранение высокой температуры тела более 3 дней названо клиническим признаком вторичной бактериальной инфекции.

Лечение пневмонии в данных рекомендациях не рассматривается и проводится в соответствии с клиническими рекомендациями по внебольничной пневмонии у взрослых.

4.9 Терапия тяжёлого течения

При тяжёлой ОРВИ с инфекционно-токсическим шоком или отёком головного мозга применяют системные глюкокортикоиды; лечение таких пациентов осуществляется в ОРИТ в соответствии с рекомендациями по неотложным состояниям.

При поражении лёгких с дыхательной недостаточностью (SpO2 ниже 92%) необходима оксигенотерапия через носовые канюли, лицевую маску или аппарат высокопоточной оксигенации. Начальная скорость потока составляет 5–7 л/мин, при необходимости она увеличивается до 10 л/мин для поддержания SpO2 выше 90%.

4.10 Дополнительная терапия

Для защиты слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне приёма лекарственных препаратов, в том числе НПВП, назначается омепразол 20 мг 1 раз в день.

Пробиотики рекомендованы пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, функциональными расстройствами пищеварения, заболеваниями кожи, а также при приёме антибиотиков более 7 дней в настоящее время или в предшествующие 1–2 месяца. Пробиотики применяются в ранние сроки заболевания в сочетании с другими препаратами.

4.11 Медицинская реабилитация

Реабилитация начинается в периоде ранней реконвалесценции.

При вирусной и поствирусной астении применяют общетонизирующие препараты, в частности оксиэтиламмония метилфеноксиацетат: в первый день 600 мг, в последующие 7 дней по 200 мг, всего 2000 мг за 8 дней.

Восстановительное лечение проводится комплексно, с участием специалистов разного профиля, последовательно и преемственно на всех этапах, с учётом резервов пациента и при постоянном контроле эффективности. Физическая и умственная нагрузка увеличивается постепенно.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Перед выбором тактики ведения определяется характер течения заболевания (неосложнённое или осложнённое).

Лечение лёгкой и среднетяжёлой ОРВИ амбулаторное. При неэффективности лечения или невозможности его проведения в домашних условиях решается вопрос о госпитализации.

Госпитализации подлежат пациенты с тяжёлым, среднетяжёлым и осложнённым течением, пациенты из групп риска, а также пациенты по эпидемическим показаниям, в том числе с лёгким течением при проживании в общежитии или в неблагоприятных условиях.

> В рекомендации имеется противоречие в отношении среднетяжёлого течения: одна рекомендация раздела 6 предусматривает амбулаторное лечение таких пациентов, следующая предусматривает их госпитализацию.

Показаниями к срочной госпитализации являются частота дыхания более 24 в минуту, SpO2 ниже 95%, очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

Перевод в ОРИТ показан при быстро нарастающей острой дыхательной недостаточности (частота дыхания более 30 в минуту, SpO2 ниже 90%, систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст.) и другой органной недостаточности, например острой почечной недостаточности.

> Пороговые значения для перевода в ОРИТ в разных разделах рекомендации различаются: в разделе 2.5 консультация анестезиолога-реаниматолога показана при частоте дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 перевод в ОРИТ показан при частоте дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.

При прогрессировании заболевания схема ведения пациента подлежит срочному пересмотру. Признаками прогрессирования являются симптомы гипоксии и сердечно-лёгочной недостаточности (одышка, цианоз, кровянистая мокрота, боль в грудной клетке, артериальная гипотензия, снижение сатурации), поражения нервной системы (нарушение сознания, сонливость, судороги, выраженная слабость, параличи), вторичной бактериальной инфекции (в том числе сохранение высокой температуры тела и других симптомов более 3 дней) и тяжёлой дегидратации.

Выписка возможна при стойком улучшении состояния, нормальной температуре тела, после регресса респираторно-катарального синдрома и при нормальных показателях общего анализа крови.

К группам риска тяжёлого течения относятся беременные и родильницы, пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, сердца и сосудов, сахарным диабетом и ожирением 2–3 степени, хронической болезнью почек, заболеваниями печени, некоторыми неврологическими состояниями, гемоглобинопатиями, иммунодефицитами, злокачественными новообразованиями, а также лица в возрасте 65 лет и старше.

5.2 Диспансерное наблюдение

При развитии осложнений наблюдение осуществляет терапевт, после аденовирусной инфекции инфекционист кабинета инфекционных заболеваний поликлиники.

В течение месяца после выписки вакцинация не проводится, за исключением введения анатоксина столбнячного и вакцины против бешенства по показаниям.

После перенесённого заболевания рекомендуется ограничение инсоляции на срок от 2 недель до месяца в зависимости от тяжести течения.

5.3 Профилактика

Вакцины против ОРВИ отсутствуют.

Среди контактных лиц выявляют заболевших. Больной изолируется на дому, при необходимости в отдельном боксе стационара, до клинического выздоровления, в среднем на 1–2 недели, после чего может приступить к работе. Карантин для контактных лиц не вводится.

При работе с больными ОРВИ необходимо использование маски со сменой каждые 3–4 часа.

Необходимы обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей, влажная уборка и проветривание помещений.

После контакта с больным ОРВИ рекомендуется химиопрофилактика. Экстренная профилактика в очаге продолжается 2 дня при прекращении контакта и 5–7 дней при его сохранении. Плановая сезонная профилактика проводится перед эпидемическим подъёмом заболеваемости лицам с высоким риском заражения и неблагоприятного исхода.

Препарат	Доза для профилактики	УУР, УДД
Умифеновир	После контакта — 200 мг в сутки в течение 10–14 дней; сезонная профилактика — 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель	B, 3
Оксодигидроакридинилацетат натрия	250 мг (1 ампула) или 4–6 мг/кг на введение; при длительном применении — с интервалом 3–7 суток	C, 4
Интерферон альфа-2b	По 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в сутки в течение 5–7 дней; при однократном контакте достаточно однократного закапывания	B, 3
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный	По 2–3 капли в каждый носовой ход за 30 минут до завтрака в течение 10 дней	B, 3
Меглюмина акридонацетат	Не позднее 3 дней после контакта — 600 мг (4 таблетки) в сутки на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки	C, 5
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат	200 мг в сутки после еды в течение 14 дней	C, 5

Препарат	Доза для профилактики	УУР, УДД
Азоксимера бромид	По 1 таблетке в день в течение 10 дней, или 6 мг в сутки интраназально или сублингвально, или суппозитории 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев	C, 5
Тилорон	125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель	C, 5
Антитела к гамма-интерферону (Анаферон)	По 1 таблетке в день в течение 1–3 месяцев в период подъёма заболеваемости	B, 2

Лизаты бактерий применяют для профилактики повторных респираторных инфекций и вторичной бактериальной инфекции независимо от сезона лицам, проживающим в неблагоприятных экологических условиях, и пациентам с хроническими заболеваниями дыхательных путей и глотки: хроническим бронхитом, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), бронхиальной астмой, хроническим риносинуситом, хроническим тонзиллитом. Препарат принимается тремя курсами по 10 дней с интервалами по 20 дней.

Взрослым перед эпидемическим сезоном и во время него длительно, от 6 месяцев до года, рекомендуется #колекальциферол: при отсутствии ожирения 2000 МЕ в сутки или 10 000 МЕ в неделю, при ожирении 3000–6000 МЕ в сутки (знак # означает применение вне инструкции по медицинскому применению).

Пациенту разъясняется необходимость срочного обращения к врачу при высокой температуре тела, одышке, стойкой головной боли, повторной рвоте, не приносящей облегчения, и резком снижении артериального давления.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее августа 2028 года
Код в рубрикаторе	724_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российское научное медицинское общество терапевтов; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 6 одна рекомендация предусматривает амбулаторное лечение среднетяжёлой ОРВИ, а следующая предусматривает госпитализацию.
- Пороговые значения для перевода в реанимацию расходятся: в разделе 2.5 частота дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 частота дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.
- Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а сохранение температуры более 3 дней в разделе 6 расценивается как признак вторичной бактериальной инфекции.
- В алгоритме (приложение Б) рентгенография околоносовых пазух предусмотрена только при изменениях в лёгких без признаков пневмонии, тогда как в разделе 2.4 она назначается в

зависимости от длительности затруднения носового дыхания.

- Рекомендации предназначены для взрослых, однако в рекомендации против назначения антибиотиков упоминается «взрослая и детская практика».
- Кларитромицин при риносинусите указан в дозе 500 мг 1 раз в сутки; для оксиметазолина в одной фразе смешаны капли и впрыскивания; доза бромгексина записана неразборчиво («по 8 мг 3 (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки»).
- В разделе 2.2 уровень достоверности доказательств обозначен как «уровень доказательности» и «уровень доказательства»; у рекомендации о пульсоксиметрии уровни указаны после комментария.
- Критерии качества предусматривают коагулограмму, определение маркёров воспаления и антибактериальную терапию при «остром бактериальном тонзиллите», хотя в тексте рекомендаций эти положения отсутствуют.
- В таблице приложения А3.4 для парагриппа в строке ведущего синдрома приведена оборванная фраза «выявляют крайне».

Клинические рекомендации

Острый ларингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J04.0** — Острый ларингит **J04.2** — Острый ларинготрахеит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 01.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/309_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Ларингоскопия показана всем пациентам. С 12 лет гортань осматривают гортанным зеркалом; если у ребёнка младшего возраста такой осмотр невозможен, прибегают к видеофиброринофаринголарингоскопии.
- При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции и длительности симптомов менее 10 дней антибактериальная терапия не назначается.
- При дисфонии показан полный голосовой покой на 1–2 суток с последующим ограничением голосовой нагрузки; из рациона исключаются острая, солёная, горячая и холодная пища, необходим отказ от алкоголя и курения.
- Флегмонозный, абсцедирующий, инфильтративный ларингит и хондроперихондрит гортани являются показанием к срочной госпитализации в стационар, располагающий отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи.
- Ларингит без стеноза гортани на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не требует госпитализации; при дыхательной недостаточности выше I степени необходима экстренная госпитализация.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острый ларингит (ОЛ) представляет собой острое воспаление слизистой оболочки гортани длительностью до 3 недель. При длительности заболевания более 3 недель необходимо исключить его аутоиммунную природу.

Абсцедирующий, или флегмонозный, ларингит является формой острого ларингита с образованием абсцесса, чаще на язычной поверхности надгортанника или на черпалонадгортанных складках. Заболевание проявляется резкой болью при глотании и разговоре с иррадиацией в ухо, повышением температуры тела, плотным инфильтратом в тканях гортани. Острый хондроперихондрит гортани характеризуется острым воспалением хрящей гортани с вовлечением в процесс надхрящницы и окружающих тканей.

Острый подскладочный ларингит (круп) характеризуется воспалением в подголосовом пространстве с отёком слизистой оболочки под голосовыми складками, затруднением дыхания и одышкой. Заболевание встречается у детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет.

2.2 Этиология

Как правило, острый ларингит является проявлением острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ): гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, при которых воспалительный процесс затрагивает также слизистую оболочку полости носа и глотки, а в ряде случаев бронхи и лёгкие. Воспаление гортани может быть также продолжением катарального воспаления полости носа или глотки.

Основными возбудителями бактериального ларингита являются S. pneumoniae (20–43%) и H. influenzae (22–35%); достаточно часто высеваются Moraxella catarrhalis (2–10%), различные стрептококки и стафилококки, значительно реже Neisseria, Corynebacterium и другие микроорганизмы.

Помимо инфекции, причинами ларингита являются наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том числе ингаляционная, инородное тело, аллергия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, повышенная голосовая нагрузка. К предрасполагающим факторам относятся хронические заболевания бронхов и лёгких, полости носа и околоносовых пазух, сахарный диабет, гипотиреоз, заболевания желудочно-кишечного тракта, хроническая почечная недостаточность, нарушение разделительной функции гортани, употребление алкоголя, курение, лучевая терапия в анамнезе.

2.3 Классификация

По форме различают катаральный, отёчный, флегмонозный (инфильтративно-гнойный, в том числе инфильтративный и абсцедирующий) и острый подскладочный ларингит. По этиологии выделяют вирусный, бактериальный, грибковый и специфический ларингит.

2.4 Клиническая картина

Основными симптомами являются нарушение голоса (от лёгкой дисфонии до афонии), острая боль в горле, кашель; возможны затруднение дыхания и ухудшение самочувствия. Заболевание начинается внезапно, на фоне удовлетворительного состояния или небольшого недомогания. При катаральном ларингите температура тела нормальная или субфебрильная; фебрильная лихорадка, как правило, свидетельствует о вовлечении нижних дыхательных путей или о переходе катарального процесса во флегмонозный.

Для инфильтративной и абсцедирующей форм характерны выраженная боль в горле, нарушение глотания, в том числе жидкости, повышенное слюноотделение, вынужденное положение головы, выраженная интоксикация, нарастающие признаки стеноза гортани. Выраженность симптомов соответствует тяжести воспаления; общее состояние становится тяжёлым. При отсутствии адекватного лечения возможно развитие флегмоны шеи, медиастинита, сепсиса, абсцедирующей пневмонии, стеноза гортани.

Клиническая картина острого стеноза гортани не зависит от его причины и определяется степенью сужения: дыхание становится шумным, нарушается его ритм, на вдохе отмечаются западение надключичных ямок и втяжение межрёберных промежутков, пациент запрокидывает голову, гортань опускается на вдохе и поднимается на выдохе.

При неполной обструкции возникает стридор. При преобладании отёка дыхание свистящее, при преобладании гиперсекреции хриплое, клокочущее. В терминальной стадии стеноза дыхание становится всё более тихим вследствие уменьшения дыхательного объёма.

При абсцессе надгортанника на фоне острой боли вначале развивается невозможность глотания, а по мере прогрессирования процесса затруднение дыхания. Голосовая щель может закрыться очень быстро, что требует экстренных мероприятий для спасения жизни пациента.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза, жалоб, данных физикального обследования и ларингоскопии. Как правило, заболевание начинается внезапно на фоне небольшого недомогания; пациенты предъявляют жалобы на изменение голоса, боль при глотании, кашель, повышение температуры тела. При тяжёлых формах отмечаются ухудшение общего состояния, боль при глотании даже жидкости, фебрильная лихорадка, повышенное слюноотделение, нарушение дыхания; шея и гортань болезненны при пальпации, подвижность хрящей гортани нарушена, голова и шея в вынужденном положении.

3.1 Физикальное обследование

Пациента с подозрением на острый ларингит осматривает оториноларинголог, врач общей практики (семейный врач) или педиатр для постановки и уточнения диагноза.

При осмотре необходимо оценить признаки дыхательной недостаточности, основным из которых является одышка. При I степени одышка возникает при физической нагрузке, при II степени при незначительной нагрузке (неспешная ходьба, умывание, одевание), при III степени в покое.

3.2 Стадии стеноза гортани

Стадия	Признаки
Компенсация	Одышка в покое отсутствует, возникает при ходьбе; просвет гортани сужен на треть.
Субкомпенсация	Инспираторная одышка при нагрузке с участием вспомогательной мускулатуры, втяжение межрёберных промежутков, яремной и надключичных ямок, стридор, бледность кожных покровов; артериальное давление нормальное или повышенное; просвет гортани сужен наполовину и более.
Декомпенсация	Дыхание поверхностное, частое, резко выраженный стридор, вынужденное положение сидя, максимальные экскурсии гортани, лицо бледно-синюшное, потливость, акроцианоз, пульс частый, нитевидный, артериальное давление снижено; просвет гортани щелевидный.
Асфиксия	Дыхание прерывистое или отсутствует, голосовая щель резко сужена, сердечная деятельность угнетена, пульс частый, нитевидный, часто не определяется, кожные покровы бледно-серые; потеря сознания, экзофтальм, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца.

При быстром нарастании стеноза состояние пациента тяжелее, поскольку компенсаторные механизмы не успевают развиться. Это учитывается при решении вопроса об экстренном хирургическом вмешательстве.

3.3 Ларингоскопия

Всем пациентам с острым ларингитом выполняют ларингоскопию.

Непрямая ларингоскопия гортанным зеркалом обязательна при осмотре оториноларингологом пациентов 12 лет и старше как в поликлинике, так и в стационаре. У детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях поликлиники её выполнение часто невозможно из-за эмоциональной лабильности и выраженного глоточного рефлекса; в таких случаях проводится видеофиброринофаринголарингоскопия.

При ларингоскопии определяются характер процесса, его локализация, уровень, протяжённость и степень сужения дыхательных путей. Для острого ларингита характерны гиперемия и отёк слизистой оболочки гортани с усилением сосудистого рисунка; голосовые складки розовые или ярко-красные, утолщены, голосовая щель при фонации овальной или линейной формы, со скоплением мокроты. Процесс может распространяться на подскладковый отдел; при подскладковом ларингите определяется валикообразное утолщение слизистой оболочки под голосовыми складками.

При катаральной форме изменения определяются преимущественно на голосовых складках, в межчерпаловидном или подскладковом пространстве: расширенные поверхностные сосуды, слизистый или слизисто-гнойный секрет, усиливающий охриплость. При отёчной форме вся слизистая оболочка гортани гиперемирована и отёчна, смыкание голосовых складок неполное. При ларингите на фоне гриппа или ОРВИ встречаются кровоизлияния в слизистую оболочку, от петехий до небольших гематом (геморрагический ларингит).

Белый или беловато-жёлтый фибринозный налёт свидетельствует о переходе в более тяжёлую, фибринозную форму, налёт серого или бурого цвета может являться признаком дифтерии. Если налёт у взрослого не связан с интубационной травмой, необходима срочная дифференциальная диагностика с системными заболеваниями и туберкулёзом.

При инфильтративном ларингите поражённый отдел гортани значительно инфильтрирован, гиперемирован, увеличен в объёме, малоподвижен, часто покрыт фибринозными налётами, в зоне формирования абсцесса просвечивает гной. При тяжёлой форме и хондроперихондрите гортань болезненна при пальпации, хрящи малоподвижны, кожа над гортанью может быть инфильтрирована и гиперемирована на фоне болевого синдрома и общей гнойной инфекции. Абсцесс надгортанника определяется как шаровидное образование на его язычной поверхности с просвечивающим гноем и сопровождается выраженной болью и нарушением глотания.

3.4 Лабораторные исследования

Развёрнутый общий анализ крови необходим для оценки общего состояния и выявления воспалительной реакции: лейкоцитоза и повышения скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

При флегмонозном ларингите при госпитализации необходимо комплексное клинико-лабораторное обследование всех пациентов.

Гнойное отделяемое направляется на посев на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителя и определением его чувствительности к антибиотикам и другим препаратам для выбора адекватной терапии.

При поступлении в стационар проводится стандартное лабораторное обследование.

3.5 Инструментальные исследования

Детям младшего и дошкольного возраста выполняют пульсоксиметрию для оценки степени дыхательной недостаточности и определения показаний к кислородотерапии.

По показаниям и для дифференциальной диагностики применяют компьютерную томографию (КТ) гортани с внутривенным болюсным контрастированием.

КТ целесообразна в условиях стационара при подозрении на гнойные осложнения или при затруднении дифференциальной диагностики с другими заболеваниями гортани. Если у ребёнка с признаками стеноза выполнение КТ невозможно, в сомнительных случаях проводится рентгенография шеи в прямой и боковой проекциях.

---

4. Лечение

Тактика лечения определяется формой и тяжестью воспалительного процесса.

4.1 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам с острым ларингитом при дисфонии любой степени показаны ограничение голосовой нагрузки (исключение крика и шёпота не менее 2 дней) и лечебно-охранительный режим.

При дисфонии рекомендуется полный голосовой покой на 1–2 суток с последующим ограничением любой голосовой нагрузки. Из рациона исключаются острая, солёная, горячая и холодная пища, спиртные напитки; необходим отказ от курения.

> Сроки голосового покоя в тексте рекомендации расходятся: в самой рекомендации указано исключение крика и шёпота «не менее 2-х дней», в комментарии к ней полный голосовой покой «на 1–2 суток».

При катаральном ларингите на фоне ОРВИ повышенное потребление жидкости не рекомендуется.

Польза обильного питья сомнительна, тогда как повышенная в период заболевания секреция антидиуретического гормона способствует задержке жидкости.

4.2 Симптоматическая терапия

Взрослым и детям с фебрильной лихорадкой рекомендованы противовоспалительные и жаропонижающие препараты.

Детям с температурой тела выше 39–39,5 °C, помимо лекарственных средств, показаны физические методы охлаждения: раскрытие ребёнка и обтирание водой температуры 25–30 °C.

Препарат	Доза
Парацетамол	До 60 мг/кг в сутки. Детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.
Ибупрофен	До 30 мг/кг в сутки. Детям — 7,5 мг/кг каждые 6–8 часов, не более 30 мг/кг в сутки.

Детям с острым ларингитом и ларинготрахеитом рутинное назначение противокашлевых и отхаркивающих препаратов не рекомендуется, за исключением случаев мучительного кашля.

Перед назначением противокашлевых средств необходимо исключить состояния, при которых подавление кашля опасно и которые требуют специфического лечения, например бронхиальную обструкцию, а у детей также острый обструктивный ларингит (круп).

4.3 Местное лечение

Для уменьшения воспаления слизистой оболочки гортани применяют местную противовоспалительную терапию: вливания лекарственных препаратов в гортань и ингаляции.

Для вливаний в гортань чаще всего используются антисептики из группы производных хинолина и четвертичных аммониевых соединений. Раствор подогревается до температуры тела и вливается по каплям, в объёме до 2 мл. Детям вливания в гортань не проводятся в связи с угрозой ларингоспазма.

Применяются небулайзерные ингаляции аэрозолей средней и низкой дисперсности.

Продолжительность ингаляции, как правило, составляет 10 минут, интервал между ингаляциями различных препаратов около 30 минут. При наличии корок в гортани ингаляции начинаются с муколитика.

Препарат	Доза
Ацетилцистеин (раствор для инъекций и ингаляций)	Ингаляционно по 1 ампуле (3 мл) 1–2 раза в сутки, 5–7 дней.
#Будесонид	Ингаляционно 1000 мкг 1–2 раза в сутки, курс 5–8 процедур.

Возможно применение готовых аптечных смесей на основе растительных препаратов с учётом противопоказаний и возраста: масла листьев эвкалипта прутовидного, а также 5–10% отваров цветков ромашки, листьев шалфея, травы тимьяна ползучего (чабреца), цветков календулы, листьев подорожника. Такие ингаляции могут быть тёплыми и холодными; продолжительность первой ингаляции составляет 1–2 минуты, последующих 5–10 минут.

4.4 Антибактериальная терапия

При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции и длительности симптомов менее 10 дней антибактериальная терапия не назначается.

К системной антибактериальной терапии прибегают при сохранении симптомов в течение 10 дней при неосложнённом течении, а также при осложнённом течении заболевания.

Взрослым назначение антибиотика целесообразно при затяжном течении ларингита (10 дней и более), а также при выраженной инфильтрации голосовых складок и экссудации.

Взрослым антибиотик подбирается эмпирически и назначается внутрь: амоксициллин 500–1000 мг 3 раза в сутки 5–10 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой 875/125 мг 2 раза в сутки 5–10 дней; цефиксим 400 мг 1 раз в сутки 5–10 дней; цефдиторен 400 мг 1 раз в сутки 10 дней; кларитромицин 250–500 мг 2 раза в сутки 6 дней; джозамицин 1000 мг 2 раза в сутки 5–10 дней.

4.5 Антибактериальная терапия у взрослых

Препарат	Показание	Доза внутрь
Амоксициллин	Препарат выбора	500 мг 3 раза в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 1000 мг 3 раза в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернативный препарат; при факторах риска продукции бета-лактамаз	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	Альтернатива	400 мг 1 раз в сутки.
Цефдиторен	Альтернатива	400 мг; в таблице кратность зачёркнута, в тексте указано 1 раз в сутки.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	250–500 мг 2 раза в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	1000 мг 2 раза в сутки.

Факторами риска устойчивости пневмококка к бета-лактамам являются приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детские учреждения, проживание в «закрытых» учреждениях. Амоксициллин с клавулановой кислотой предпочтителен при риске инфицирования возбудителем, продуцирующим бета-лактамазы (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis): при бронхиальной астме, сахарном диабете, хроническом бронхите, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет, при неэффективности предшествующего лечения амоксициллином.

> В тексте рекомендации цефдиторен назначается по 400 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней, тогда как в таблице 1 кратность его приёма зачёркнута целиком («2 раза в сутки 1 раз в сутки»). Для джозамицина в тексте указан код АТХ J01FA09, совпадающий с кодом кларитромицина, в таблице указан J01FA07.

4.6 Антибактериальная терапия у детей

В тексте рекомендации детям предлагаются: амоксициллин 40–60 или 80–90 мг/кг в сутки 5–7 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой до 3 месяцев — 30 мг/кг в сутки в 2 приёма, с 3 месяцев — 25 мг/кг в сутки в 2 приёма или 20 мг/кг в сутки в 3 приёма, 5–10 дней; цефиксим в суспензии 8 мг/кг в сутки в 1–2 приёма 5–10 дней; цефтриаксон с 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, при массе тела более 50 кг — дозы для взрослых; кларитромицин 7,5–15 мг/кг в сутки в 2 приёма не более 14 дней; джозамицин 50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма 5–10 дней; тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат внутримышечно 10 дней.

Препарат	Показание	Доза
Амоксициллин	Препарат выбора	Внутрь 40–60 мг/кг в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива	Внутрь, суспензия 4:1 (125 мг + 31,25 мг в 5 мл или 250 мг + 62 мг в 5 мл) в 3 приёма каждые 8 часов; доза «45–60 мг/кг/сутки в 2–3 приёма» в таблице зачёркнута.
Цефиксим	Альтернатива	8 мг/кг в сутки 1 раз в сутки.
Цефтриаксон	Альтернатива	С 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе тела более 50 кг — дозы для взрослых.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	Внутрь 7,5 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки.

Препарат	Показание	Доза
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	При невозможности применения бета-лактамов и макролидов	До 2 лет — по 125 мг 2 раза в сутки; 3–6 лет — по 250 мг 2 раза в сутки; 7–12 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; взрослым — по 500 мг 2–3 раза в сутки; 10 дней.

Детские дозы в тексте и в таблице 2 не совпадают. Для кларитромицина в тексте указана «для детей старше 12 лет разовая доза» 7,5–15 мг/кг/сут, в таблице 7,5 мг/кг/сут в 2 приёма. Для амоксициллина с клавулановой кислотой в тексте приведена доза 20–30 мг/кг/сут, в таблице доза 45–60 мг/кг/сут зачёркнута и указана только суспензия в 3 приёма. Цефиксим в тексте назначается в 1–2 приёма, в таблице 1 раз в сутки. Для тиамфеникола возрастные группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет» не включают детей от 2 до 3 лет.

4.7 Лечение в условиях стационара

В стационаре антибактериальную терапию взрослым и детям начинают эмпирически с учётом региональной резистентности основных возбудителей. После улучшения состояния возможен переход на пероральный приём антибиотика (ступенчатая терапия).

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Амоксициллин + клавулановая кислота	С 3 месяцев внутривенно 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов, 5–10 дней	Внутривенно 1,2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 150 мг/кг в сутки в 4 введения	Внутривенно 2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефтриаксон	С 15 дней до 12 лет внутримышечно или внутривенно 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, 5–10 дней	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки, 7–10 дней
Цефепим	При тяжёлом флегмонозном ларингите и осложнениях в отделении реанимации: при массе тела более 40 кг — 2 г каждые 12 часов, до 40 кг — 50 мг/кг каждые 12 часов, 7–10 дней	—
Меропенем	В тех же условиях: от 3 месяцев до 12 лет — 10–20 мг/кг 3 раза в сутки, при массе тела более 50 кг — доза для взрослых, 5–10 дней	—
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	До 2 лет — 125 мг 2 раза в сутки, 3–6 лет — 250 мг 2 раза, 7–12 лет — 250 мг 3 раза в сутки	500 мг 2–3 раза в сутки, 10 дней

При абсцедирующем и флегмонозном ларингите полость абсцесса промывают растворами антисептиков: 0,01% раствором бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата или гидроксиметилхиноксалиндиоксидом.

Всем пациентам с дисфагией при тяжёлых формах ларингита необходимы дезинтоксикационная терапия, коррекция гиповолемии, глюкокортикостероиды и парентеральное питание.

Для профилактики стеноза гортани применяют консервативную противовоспалительную терапию; в качестве дестенозирующей терапии применяется парентеральное введение глюкокортикоидов.

В комментарии о дестенозирующей терапии фраза оборвана: указана доза «60–120 мг», однако не указано, к какому глюкокортикоиду она относится и предназначена ли она для взрослых или для детей.

4.8 Дополнительная терапия

Эмпирическое назначение противогрибковых препаратов не рекомендуется. Только после подтверждения кандидоза взрослым назначают флуконазол 100 мг в сутки или итраконазол 100 мг 1 раз в сутки в течение 15 дней.

Пациентам с аллергическими заболеваниями (аллергический ринит, крапивница, поллиноз, аллергический конъюнктивит) рекомендованы системные антигистаминные препараты.

Препарат	Доза
Лоратадин, цетиризин	Детям 3–12 лет с массой тела более 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки, менее 30 кг — 5 мг 1 раз в сутки; взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет и взрослым — 5 мг 1 раз в сутки.
Дезлоратадин	От 6 до 12 месяцев — 1 мг, с 1 года до 5 лет — 1,25 мг, 6–11 лет — 2,5 мг, взрослым и детям старше 12 лет — 5 мг; кратность приёма 1 раз в сутки.

> Левоцетиризину и лоратадину в тексте рекомендации присвоен один и тот же код АТХ R06AX13.

4.9 Хирургическое лечение

При неосложнённом остром ларингите хирургическое лечение не требуется.

Детям с декомпенсированным стенозом гортани для обеспечения дыхания выполняют неотложную интубацию трахеи.

При невозможности интубации трахеи выполняется трахеостомия или коникотомия.

При осложнённых формах острого ларингита показано хирургическое лечение.

4.10 Иное лечение

Пациентам с острым ларингитом показана консультация физиотерапевта.

При дисфонии на фоне острого ларингита рекомендацией предусмотрено включение в терапию комплексных гомеопатических препаратов для уменьшения выраженности нарушений голоса. Приведённый в рекомендации препарат зарегистрирован по показанию «ларингиты различной этиологии» и применяется у взрослых и детей старше 6 лет с первых дней заболевания на 6 дней.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациентам голосоречевых профессий после перенесённого острого ларингита показано наблюдение оториноларинголога до полного восстановления голосовой функции.

Сроки нетрудоспособности у таких пациентов продлеваются до полного восстановления голоса. Неосложнённый ларингит разрешается за 7–14 дней, разрешение инфильтративных форм занимает более 14 дней.

Профилактика хронизации воспалительного процесса гортани заключается в своевременном лечении острого ларингита, повышении сопротивляемости организма, лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и инфекций верхних и нижних дыхательных путей, отказе от курения и соблюдении голосового режима.

Пациенту рекомендуется ограничить голосовую нагрузку, исключить горячую, холодную и острую пищу, спиртные напитки, курение и паровые ингаляции, постоянно увлажнять воздух в помещении с помощью увлажнителя; в составе комплексного лечения в рекомендации упоминаются противовирусные препараты.

В разделе 7 и в памятке для пациента паровые ингаляции запрещены, тогда как в разделе 3.1 ингаляции отваров трав допускаются «тёплыми». Там же рекомендованы противовирусные препараты, однако в разделе о лечении такая рекомендация отсутствует.

5.1 Показания к госпитализации

Пациенты с острым ларингитом без стеноза гортани на фоне ОРВИ не нуждаются в госпитализации. Госпитализации подлежат все пациенты с осложнённым течением.

Пациенты с осложнёнными и тяжёлыми формами (флегмонозный, абсцедирующий, инфильтративный ларингит, хондроперихондрит гортани) подлежат обязательной срочной госпитализации в учреждение, располагающее отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи.

Показанием к экстренной госпитализации является острая дыхательная недостаточность выше I степени.

Пациент выписывается при регрессе воспалительных изменений, отсутствии дыхательной недостаточности и осложнений.

При неосложнённом ларингите прогноз благоприятный. При осложнённых формах со стенозом гортани решающее значение для сохранения жизни пациента имеют своевременная специализированная помощь и хирургическое лечение.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый ларингит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 01.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`309_2` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки голосового покоя расходятся: в рекомендации указано «не менее 2-х дней», в комментарии к ней «1–2 суток».
- Для цефдиторена в тексте указано 400 мг 1 раз в сутки, в таблице 1 кратность зачёркнута целиком.
- Джозамицину в тексте присвоен код АТХ J01FA09 (код кларитромицина), в таблице указан J01FA07.
- Детские дозы кларитромицина, амоксициллина с клавулановой кислотой и цефиксима в тексте и в таблице 2 различаются; для кларитромицина «разовая доза» приведена в мг/кг/сут и «для детей старше 12 лет».
- Для тиамфеникола глицината ацетилцистеината не указана доза для детей от 2 до 3 лет: выделены только группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет».
- В комментарии о дестенозирующей терапии не назван глюкокортикоид, к которому относится доза «60–120 мг».
- Левоцетиризину и лоратадину присвоен один и тот же код АТХ R06AX13.
- Раздел 7 запрещает паровые ингаляции и рекомендует противовирусные препараты, тогда как раздел 3.1 допускает тёплые ингаляции и не содержит рекомендации о противовирусных препаратах.

- В комментарии о меропенеме для детей авторы ссылаются на справочник Vidal.

Клинические рекомендации

Острый синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J01** — Острый синусит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/313_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз острого синусита у взрослых:

  Обязательные критерии

  1. острое начало заболевания;
  2. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа и (или) выделения из носа, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки (постназальный синдром);
  3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

  Возможные симптомы

  1. боль или ощущение давления в проекции околоносовых пазух на лице;
  2. снижение или потеря обоняния.
- Диагноз острого синусита у детей:

  Обязательные критерии

  1. острое начало заболевания;
  2. **не менее двух** симптомов из перечисленных ниже;
  3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

  Симптомы

  1. заложенность носа;
  2. выделения из носа, в том числе стекание по задней стенке глотки (постназальный синдром);
  3. кашель.
- Системная антибактериальная терапия взрослым показана:
  1. при среднетяжёлом и тяжёлом течении;
  2. при лёгком течении рецидивирующего синусита с сохранением симптомов **5–7 дней и более**;
  3. при лёгком течении на фоне тяжёлой сопутствующей патологии или иммунодефицита.
- При впервые возникшем синусите стартовым препаратом является незащищённый аминопенициллин (амоксициллин). Если заметного эффекта нет **в течение 3 дней**, препарат заменяют.
- Местная терапия:
  1. промывание полости носа солевыми растворами;
  2. сосудосуживающие капли **не более 5–7 дней**;
  3. интраназальные глюкокортикостероиды пациентам **старше 12 лет**.
- Показания к экстренной госпитализации:
  1. тяжёлое течение;
  2. орбитальные или внутричерепные осложнения;
  3. отсутствие улучшения на фоне системной антибактериальной терапии **в течение 3–5 дней**;
  4. ухудшение состояния в любой момент.

2. Клиническая картина и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый синусит представляет собой острое воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух продолжительностью **менее 12 недель**, проявляющееся не менее чем двумя симптомами (перечислены в критериях диагноза ниже). Часть симптомов может быть заменена данными риноскопии, эндоскопии или компьютерной томографии (КТ).

Синусит считается рецидивирующим при 4 эпизодах и более за последний год, если между эпизодами имеются периоды не менее 8 недель без симптомов и без лечения.

Острый поствирусный синусит диагностируется при сохранении симптомов более 10 дней после острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и отсутствии признаков бактериального синусита. Как правило, он протекает легче и разрешается без антибактериальной терапии.

2.2 Критерии диагноза

У взрослых:

Обязательные критерии

1. острое начало заболевания;
2. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа и (или) выделения из носа, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки (постназальный синдром);
3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

Возможные симптомы

1. боль или ощущение давления в проекции околоносовых пазух на лице;
2. снижение или потеря обоняния.

У детей:

Обязательные критерии

1. острое начало заболевания;
2. **не менее двух** симптомов из перечисленных ниже;
3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

Симптомы

1. заложенность носа;
2. выделения из носа, в том числе стекание по задней стенке глотки (постназальный синдром);
3. кашель.

Болевой синдром может отсутствовать. При верхнечелюстном синусите боль локализуется в проекции пазухи, реже в области переносицы и надбровья, и может иррадиировать в верхние зубы. Для сфеноидита характерна боль в центре головы и в затылочной области (каскообразная боль).

У детей синусит часто сочетается с гипертрофией и хроническим воспалением глоточной миндалины и может проявляться упорным кашлем или выраженным затруднением носового дыхания.

2.3 Степень тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Лихорадка отсутствует. Умеренные симптомы, не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни. Головная боль в проекции околоносовых пазух (ОНП) отсутствует. Осложнений нет
Среднетяжёлая	Выраженные симптомы, умеренно или значительно влияющие на качество жизни. Ощущение тяжести в проекции ОНП при движении или наклоне головы. Осложнение со стороны среднего уха (острый средний отит). Внутричерепные и орбитальные осложнения отсутствуют

Форма	Признаки
Тяжёлая	Выраженные или мучительные симптомы. Болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении, наклоне головы, перкуссии. Внутричерепные или орбитальные осложнения

2.4 Классификация

В 90–98% случаев возбудителями синусита являются вирусы, на долю бактериального синусита приходится лишь 2–10%.

По этиологии выделяют вирусный, бактериальный, травматический, грибковый (в виде острого процесса встречается крайне редко) и смешанный синусит. Изолированный бактериальный синусит встречается редко; как правило, имеет место сочетание вирусов или вирусов и бактерий.

По локализации различают гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит. Поражение всех пазух одной половины носа обозначается как гемисинусит, обеих половин как пансинусит.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР

3.1 Осмотр ЛОР-органов

Показания

1. всем пациентам при обращении к оториноларингологу и при госпитализации в стационар: общий осмотр и стандартный оториноларингологический осмотр.

Диагностические признаки при риноскопии

1. отделяемое в носовых ходах;
2. гиперемия и отёк слизистой оболочки полости носа;
3. отделяемое в среднем носовом ходе (передняя риноскопия) указывает на возможное поражение лобной и верхнечелюстной пазух, передних и средних клеток решётчатого лабиринта;
4. отделяемое в верхнем носовом ходе (задняя риноскопия) указывает на возможное поражение задних клеток решётчатого лабиринта и клиновидной пазухи.

Отсутствие отделяемого не исключает острого синусита: его может не быть при блоке естественных соустий и высокой вязкости секрета.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. оценка состояния полости носа и носоглотки;
2. дифференциальная диагностика.

В большинстве случаев эндоскопия не информативнее передней и средней риноскопии, но помогает отличить сфеноидит от аденоидита и выявить длительно находящееся инородное тело полости носа.

Диагностические признаки

1. гнойное отделяемое и (или) отёк слизистой оболочки в области остиомеатального комплекса; эти данные подтверждают диагноз.

3.3 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания к спиральной КТ

1. подозрение на внутричерепные или орбитальные осложнения;
2. затяжное тяжёлое течение;
3. сложные диагностические случаи.

Диагностические признаки

1. признаки воспаления в околоносовых пазухах и (или) в области остиомеатального комплекса; они подтверждают диагноз.

КТ является наиболее информативным методом: она показывает характер и распространённость изменений, а также анатомические особенности полости носа и пазух, ведущие к рецидивам, и визуализирует структуры, неразличимые на рентгенограмме.

3.4 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение;
2. сложные диагностические случаи при невозможности выполнить КТ.

Диагностические признаки

1. утолщение слизистой оболочки пазухи;
2. горизонтальный уровень жидкости;
3. тотальное снижение пневматизации пазухи.

Интерпретацию затрудняют наложение окружающих костных структур и гипоплазия пазухи.

Данные рентгенографии и КТ совпадают лишь в 34% случаев, для верхнечелюстной пазухи в 77%.

3.5 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на верхнечелюстной или лобный синусит при невозможности выполнить рентгенографию и КТ.

3.6 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение.

Диагностические признаки

1. лейкоцитоз с нейтрофилёзом не является специфическим маркером бактериального синусита, однако его нарастание при повторном исследовании учитывают при решении вопроса о системной антибактериальной терапии.

3.7 Бактериологическое исследование

Посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение у пациентов в стационаре;
2. затяжное течение;
3. неэффективность эмпирической антибактериальной терапии.

Забор материала

1. при верхнечелюстном синусите материал получают при пункции пазухи иглой Куликовского с аспирацией содержимого; если его нет, вводят стерильный 0,9% раствор натрия хлорида и аспирируют;
2. посев из носового хода нецелесообразен из-за попадания в материал посторонней микрофлоры.

Иные диагностические исследования не показаны.

3.8 Дифференциальная диагностика

У взрослых острый синусит дифференцируют с обострением хронического риносинусита, аллергическим и хроническими ринитами, у детей также с аденоидитом и инородным телом полости носа.

Заболевание	Общие с острым синуситом признаки	Отличия от острого синусита
Хронический риносинусит	Манифестация и обострения по клиническим проявлениям идентичны острому синуситу	1. назальные симптомы полностью не разрешаются в течение 12 недель даже на фоне лечения: пациенты отмечают улучшение, но не полное исчезновение симптомов; 2. у детей хронический риносинусит встречается значительно реже острого синусита; 3. в этиологии преобладают неинфекционные факторы: генетические аномалии, аллергия, аномалии строения полости носа.
Аллергический ринит	Сходные назальные симптомы: заложенность носа, выделения из носа, кашель вследствие постназального затекания. Аллергический ринит повышает риск острого синусита	1. симптомы повторяются; 2. значительно чаще беспокоят зуд в носу и (или) чихание; 3. характерны глазные симптомы (зуд в глазах, слезотечение), особенно при поллинозе; 4. в основе патогенеза лежит IgE-ассоциированное воспаление слизистой оболочки; 5. диагноз устанавливают по аллергологическому анамнезу, характеру симптомов и результатам специфического аллергологического обследования.

Заболевание	Общие с острым синуситом признаки	Отличия от острого синусита
Аденоидит	Сходные назальные симптомы: заложенность носа, кашель вследствие постназального затекания, реже выделения из носа. У детей младше 10–12 лет воспаление в полости носа и околоносовых пазухах всегда сопровождается реактивным воспалением глоточной миндалины	1. у детей раннего и дошкольного возраста, не перенёсших аденотомию, при жалобах на «острый насморк» граница между острым синуситом и аденоидитом очень условна; 2. в отдельных случаях помогает эндоскопия полости носа и носоглотки: скопление отделяемого в среднем носовом ходе при небольшом его количестве в носоглотке больше характерно для острого синусита; 3. у дошкольников без признаков внутричерепных и орбитальных осложнений и без критериев острого бактериального синусита основным диагнозом целесообразно указывать аденоидит или острый назофарингит.
Инородное тело полости носа	Родители ребёнка могут жаловаться на остро возникшую заложенность носа и (или) гнойные выделения из носа, особенно при инородном теле органического происхождения	1. трудности возникают, когда ребёнок незаметно для родителей вводит в нос органические вещества: кусочки пищи, семена растений, бумагу, поролон; 2. воспалительные изменения, как правило, односторонние, гнойные выделения появляются на фоне полного здоровья без предшествующего эпизода острого респираторного заболевания; 3. инородное тело выявляют при передней риноскопии после анемизации и аспирационного туалета полости носа, в ряде случаев при эндоскопии полости носа и носоглотки.

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Показания к антибактериальной терапии

Взрослым антибактериальная терапия показана:

1. при среднетяжёлом и тяжёлом синусите;
2. при лёгком течении рецидивирующего синусита с сохранением симптомов **5–7 дней и более**;
3. при лёгком течении на фоне тяжёлой сопутствующей патологии (например, сахарного диабета) или иммунодефицита.

О бактериальном синусите свидетельствуют **три признака и более**:

1. гнойные выделения или выделения только из одной половины носа **в течение 3 дней и более**;
2. головная боль или ощущение давления в проекции верхнечелюстных или лобных пазух;
3. температура тела **38,0 °C и выше**;
4. «вторая волна» заболевания;
5. лейкоцитоз **выше 15×10^9/л**.

На бактериальную этиологию указывают также выраженные с самого начала симптомы, сохраняющиеся 3–4 дня и угрожающие развитием орбитальных или внутричерепных осложнений.

Детям антибактериальная терапия показана при признаках бактериального синусита, среднетяжёлом и тяжёлом течении. При лёгком течении антибиотики необходимы при наличии хотя бы одного из условий:

1. орбитальные или внутричерепные осложнения;
2. три признака бактериального синусита и более;
3. иммунодефицит, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, некомпенсированный сахарный диабет I типа;
4. 4 эпизода синусита и более за последний год.

При впервые возникшем синусите терапия начинается с незащищённых аминопенициллинов.

При высоком риске устойчивости пневмококка доза амоксициллина увеличивается. При сопутствующих заболеваниях, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и при неэффективности ранее назначенного амоксициллина терапия начинается с защищённых аминопенициллинов.

При отсутствии заметного эффекта **в течение 3 дней** препарат заменяют, не дожидаясь окончания курса. У детей эффективность оценивают **через 48–72 часа**.

4.2 Дозы стартовой терапии

Взрослые

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	500 мг × 3 р/сут — без факторов риска[1] 1000 мг × 3 р/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[2]	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут
Цефуроксим	250–500 мг × 2 р/сут
Цефиксим	400 мг × 1 р/сут
Цефдиторен внутрь	200 мг × 2 р/сут
Цефподоксим внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	250–500 мг × 2 р/сут
Левофлоксацин внутрь	500 мг × 1 р/сут
Моксифлоксацин внутрь	400 мг × 1 р/сут
Клиндамицин в/м (в КР со знаком #)	400–900 мг × 3 р/сут, 7–10 дней

[1] Риск устойчивости пневмококка повышают приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детский сад, и проживание в закрытых учреждениях.

[2] Риск продукции бета-лактамаз (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis) повышают бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит, иммуносупрессия, возраст старше 65 лет и неэффективность предшествующей терапии амоксициллином.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7 дней, осложнённого 10–14 дней.

Макролиды являются препаратами резерва и применяются только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов. Фторхинолоны допустимы только у взрослых и только при отсутствии других вариантов; детям и подросткам они противопоказаны.

Дети

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	40–60 мг/кг/сут — без факторов риска[1] 80–90 мг/кг/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь	45–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Цефуроксим	30 мг/кг/сут в 2 приёма, не более 500 мг в сутки
Цефиксим	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен, цефподоксим (старше 12 лет) внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	15 мг/кг/сут в 2 приёма, макс. 1000 мг/сут
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат в/м (стационар, если β-лактамы невозможны)	125–250 мг 2–3 р/сут в зависимости от возраста

Амоксициллин с клавулановой кислотой предпочтителен, если за последние 3 месяца ребёнок получал антибиотики или посещает детский коллектив, а также при неэффективности амоксициллина в течение 48–72 часов. При лёгкой аллергии на пенициллины применяют цефалоспорины III поколения внутрь.

Дозы из расчёта на килограмм массы тела предназначены для детей с массой тела менее 40 кг; при массе 40 кг и более используют дозы для взрослых.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7–10 дней, при орбитальных и внутричерепных осложнениях или рецидивирующем течении 10–14 дней.

> В тексте КР имеется расхождение: в разделе 3.1 стартовая доза амоксициллина для детей составляет 50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, в таблице 5 указано 40–60 мг/кг в сутки (80–90 мг/кг при факторах риска). На сайте приведены данные таблицы.

4.3 Парентеральная терапия при тяжёлом течении

Взрослым при тяжёлом синусите вводятся цефотаксим или цефтриаксон, возможно также внутривенное введение амоксициллина с клавулановой кислотой. При риске анаэробной инфекции применяют клиндамицин в сочетании с цефалоспорином III поколения. При неэффективности стартовой

парентеральной терапии рассматривается назначение цефоперазона с сульбактамом 2–4 г в сутки внутривенно в 2 введения, при резистентных штаммах препаратов резерва с учётом чувствительности.

Детям вводятся ампициллин с сульбактамом 300 мг/кг в сутки в 3–4 введения, цефтриаксон 75 мг/кг в сутки в 2 введения или цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 4 введения. При неэффективности этой терапии переходят на цефоперазон с сульбактамом 75–160 мг/кг в сутки в 2–4 введения (в КР со знаком #, то есть вне инструкции).

4.4 Местная и симптоматическая терапия

Рекомендуется промывание полости носа изотонической стерильной морской водой или солевыми растворами. Слабые гипертонические растворы применяются только в остром периоде и не более 5–7 дней.

Назначение сосудосуживающих капель при остром синусите, согласно рекомендации, абсолютно необходимо, однако срок их применения ограничен **5–7 днями** из-за риска медикаментозного ринита. Нафазолин не применяется.

Детям до 6 лет применяются фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет).

Интраназальные глюкокортикостероиды применяют у пациентов старше 12 лет в монотерапии при затяжном поствирусном синусите или в сочетании с системными антибиотиками. Детям до 12 лет монотерапия глюкокортикостероидами допустима только при сопутствующем аллергическом рините.

Для монотерапии синусита без признаков бактериальной инфекции в России зарегистрирован только спрей мометазона.

Местные антибактериальные препараты используют в сочетании с системными или в монотерапии при лёгком синусите с признаками бактериального воспаления (гнойными выделениями). Эффективность оценивается через 3–4 дня.

Для лечения синусита зарегистрированы фрамицетин (детям с первых лет жизни) и комбинация дексаметазона, неомицина, полимиксина B и фенилэфрина (с 2,5 лет). Введение растворов антибиотиков для инъекций в полость носа и пазухи не допускается.

При лихорадке, головной и лицевой боли применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Детям до 6 лет применяются только парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки), взрослым возможно назначение кетопрофена.

Возможно назначение мукоактивных препаратов, например ацетилцистеина или карбоцистеина. Перед назначением следует свериться с инструкцией, поскольку не все препараты разрешены при заболеваниях ЛОР-органов и в сочетании с антибиотиками.

Применяются растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием: комбинации корня горечавки, цветков первоцвета, шалфея, цветков бузины и вербены, миртол, экстракт пеларгонии сидовидной.

Комбинированные препараты с парацетамолом без психотропных компонентов могут применяться для облегчения симптомов с 12 лет.

Системные антигистаминные препараты оправданы при сопутствующем аллергическом рините и в начальном периоде вирусной инфекции.

При вирусном синусите в комплексное лечение могут включаться противовирусные препараты, в том числе растительного происхождения.

При лёгком течении синусита в амбулаторных условиях возможно применение комплексных гомеопатических препаратов по зарегистрированным показаниям.

Бактериофаги рекомендованы взрослым с острым бактериальным синуситом; местное применение оправдано при устойчивости к антибиотикам или их непереносимости.

4.5 Хирургическое лечение

Пункция верхнечелюстной пазухи показана при рентгенологически подтверждённом наличии содержимого в пазухе и тяжёлом или среднетяжёлом течении без эффекта от системной антибактериальной терапии **в течение 5–7 дней**.

Детям пункция и трепанопункция выполняются только в условиях стационара; во многих случаях вместо них возможно применение синус-катетера.

Дренирование пазух, в том числе с помощью синус-катетера, выполняют при затяжном экссудативном синусите без обструкции соустий. При впервые возникшем неосложнённом синусите дренирование не показано.

При орбитальных или внутричерепных осложнениях показано хирургическое лечение в условиях стационара: вскрытие пазухи и дренирование абсцесса.

Иное лечение (раздел 3.3) и медицинская реабилитация (раздел 4) не требуются.

4.6 Профилактика

Детям из групп риска по респираторным заболеваниям рекомендованы местные и системные лизаты бактерий.

При рецидивирующем синусите и предрасполагающих к нему изменениях перегородки носа или латеральной стенки полости носа показано плановое хирургическое лечение.

4.7 Особые случаи

Сопутствующий аллергический ринит способствует затяжному течению синусита; в этом случае необходимы системные антигистаминные препараты и более высокая доза глюкокортикостероидов.

Лечение одонтогенного синусита хирургическое, с удалением пломбировочного материала и секвестров. Из антибактериальных препаратов предпочтительны респираторные фторхинолоны, поскольку преобладает анаэробная микрофлора.

---

5. Показания к госпитализации. Осложнения

разделы 1.5, 3 и 6 текста КР
Экстренная госпитализация в оториноларингологическое отделение показана:

1. при тяжёлом течении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями;
2. при отсутствии улучшения на фоне системной антибактериальной терапии **в течение 3–5 дней**;
3. при прогрессирующем ухудшении состояния в любой момент.

Орбитальные и внутричерепные осложнения свидетельствуют о тяжёлом течении, острый средний отит о среднетяжёлом.

Пациента выписывают при стабильно удовлетворительном состоянии **в течение не менее 3 дней**.

---

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый синусит»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (карточка рубрикатора на 22.10.2026); год окончания действия не указан
Актуализация	По правилу из самой КР — «не реже чем один раз в три года» (прил. А2): следующая ожидается не позднее октября 2027

Код в рубрикаторе	313_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети
Целевая аудитория	Оториноларингологи, терапевты, педиатры

6.1 Исправления по результатам сверки с PDF

- Удалено предупреждение «пересмотр не позднее 2026»: в PDF и в карточке рубрикатора эта дата отсутствует, она была заимствована из пересказа MedElement.
- Доза амоксициллина у взрослых «500–1000 мг» заменена двумя дозами с условием: 500 мг при отсутствии факторов риска устойчивости пневмококка, 1000 мг при их наличии.
- Добавлены условия назначения амоксициллина с клавулановой кислотой и цефоперазона с сульбактамом, тиамфеникол для детей в стационаре, ограничение дозы цефуроксима «500 мг в сутки».
- Уточнены показания к пункции, ограничение для интраназальных глюкокортикостероидов у детей до 12 лет (монотерапия только при сопутствующем аллергическом рините), признаки степеней тяжести, критерии у детей («бесцветные или светлые выделения»).
- Удалена фраза «КТ рутинно не нужна», поскольку в КР она отсутствует.
- Добавлены разделы 5 «Профилактика» и 7 «Дополнительная информация».

6.2 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина: в тексте раздела 3.1 указано 50–60 мг/кг/сут, в таблице 5 указано 40–60 (80–90) мг/кг/сут.
- В таблице 5 для цефтриаксона указан код АТХ J01FA09, который является кодом кларитромицина; в тексте для цефтриаксона приведён верный код J01DD04.
- Знак # у ряда препаратов в этой КР не расшифрован. ⚠ В российских КР им, как правило, обозначается применение вне инструкции; это следует проверить по инструкции к препарату.

6.3 Шкалы доказательности

Шкала	Интерпретация
УУР А	Сильная рекомендация: все критерии эффективности являются важными, исследования высокого или удовлетворительного качества, выводы согласованы
УУР В	Условная рекомендация: не все критерии эффективности являются важными, не все исследования высокого качества и/или выводы не согласованы
УУР С	Слабая рекомендация: доказательства надлежащего качества отсутствуют
УДД 1–5	Для лечения: от 1 (систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований с метаанализом) … до 5 (только обоснование механизма действия или мнение экспертов). Для диагностики используется отдельная шкала (табл. П1); точная расшифровка открывается при нажатии на бейдж

Клинические рекомендации

Острый тонзиллит и фарингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J02** — Острый фарингит **J02.0** — Стрептококковый фарингит **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J02.9** — Острый фарингит неуточненный **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J03.0** — Стрептококковый тонзиллит **J03.8** — Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями **J03.9** — Острый тонзиллит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Возбудителями тонзиллофарингита в большинстве случаев являются вирусы, и антибактериальная терапия при этом не показана. Из бактериальных возбудителей лечения требует только бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА); выделение из зева стафилококка, пневмококка и других микроорганизмов расценивается как колонизация.
- По клинической картине дифференцировать вирусный и бактериальный тонзиллофарингит невозможно. Пациентам старше 3 лет выполняют экспресс-тест на БГСА; при отрицательном результате у ребёнка его подтверждают бактериологическим исследованием (посевом).
- Антибактериальная терапия назначается только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии. При вирусной инфекции антибиотики неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.
- Препаратом выбора является амоксициллин, курс лечения составляет 10 дней.
- При отсутствии улучшения через 48–72 часа от начала антибактериальной терапии следует пересмотреть диагноз, поскольку заболевание может быть обусловлено острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) или инфекционным мононуклеозом.
- Рутинное определение С-реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина, общий анализ крови в амбулаторных условиях, исследование антистрептолизина О (АСЛ-О) и контрольный мазок после лечения не показаны.

2. Клиническая картина и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый тонзиллофарингит является острым инфекционным воспалением слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки (нёбных миндалин и лимфоидных фолликулов задней стенки глотки). Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, поскольку чаще в воспалительный процесс вовлекаются оба отдела.

По локализации в зависимости от преимущественно поражённого отдела ротоглотки различают тонзиллит, фарингит и тонзиллофарингит. По этиологии выделяют стрептококковый и нестрептококковый (вирусный) тонзиллофарингит. Тактика лечения определяется именно этиологией.

2.2 Клиническая картина

Заболевание начинается остро, как правило, с повышения температуры тела выше 38 °С (реже температура нормальная или субфебрильная) и боли в горле, которая усиливается при глотании и может иррадиировать в ухо. Регионарные лимфатические узлы могут быть увеличены и болезненны, дети младшего возраста отказываются от еды. Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

О стрептококковой этиологии свидетельствуют увеличение подчелюстных или переднешейных лимфатических узлов, высокая температура тела, выраженная боль в горле, «пылающий зев», налёт на миндалинах, отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

На вирусную этиологию указывают насморк, конъюнктивит и кашель. При инфекции, вызванной вирусом Эпштейна — Барр, возможны генерализованная лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки. Петехии на мягком нёбе встречаются как при стрептококковой инфекции, так и при инфекции вирусом Эпштейна — Барр.

При тонзиллофарингите отмечается симметричное увеличение миндалин, что отличает его от паратонзиллярного абсцесса.

2.3 Чувствительность возбудителя и колонизация

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. Устойчивость к макролидам выявляется примерно у каждого пятого штамма, к клиндамицину у 3–4%.

Выделение из зева *S. aureus*, *S. pneumoniae* или других бактерий при клинической картине тонзиллофарингита расценивается как колонизация и не требует назначения антибиотиков.

2.4 Дифференциальная диагностика

Инфекционным мононуклеозом чаще болеют подростки и лица молодого возраста до 30 лет. Характерны слабость, лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в периферической крови. Диагноз подтверждается методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ДНК вируса Эпштейна — Барр и выявлением IgM к капсидному антигену.

Синдромом «рука — нога — рот» болеют дети до 5 лет, как правило в летний период: на слизистой оболочке полости рта появляются везикулы без налётов на миндалинах, на кистях и стопах отмечается сыпь.

При ангине Симановского — Плаута — Венсана на одной миндалине формируется некротическая язва, отмечается гнилостный запах.

При дифтерии зева налёт плотный, снимается с трудом, после снятия остаётся кровоточащая поверхность.

Синдром Маршалла (PFAPA) характеризуется периодической лихорадкой до 39–40 °C в сочетании с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом. Приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей составляет 5 лет; приступ быстро купируется системными кортикостероидами.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз устанавливается на основании жалоб на выраженную боль в горле при глотании, данных осмотра (гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличение регионарных лимфатических узлов) и результатов экспресс-теста на БГСА или бактериологического исследования.

Каждого пациента осматривает оториноларинголог, педиатр, врач общей практики или терапевт.

У каждого пациента необходимо проводить дифференциальную диагностику стрептококкового и вирусного тонзиллофарингита.

Экспресс-тест на БГСА выполняют пациентам старше 3 лет. При положительном результате посев не требуется. При отрицательном результате у взрослых посев также не требуется, у детей и подростков результат подтверждается бактериологическим исследованием.

Детям до 3 лет экспресс-тест рутинно не проводится; исключением является стрептококковый тонзиллит у кого-либо из окружения ребёнка, например у старшего брата или сестры.

Бактериологическое исследование мазка из зева на стрептококк группы А необходимо пациентам старше 3 лет, если экспресс-тест не проводился или его результат отрицательный. Результат готов в течение 72 часов.

Мазок берётся до начала антибактериальной терапии, до утренней гигиены полости рта, натощак или через 2 часа после еды, под контролем орофарингоскопии, без касания зубов и языка, из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

3.1 Исследования, не показанные рутинно

В амбулаторных условиях определение СРБ и прокальцитонина не позволяет дифференцировать вирусное и бактериальное воспаление. СРБ определяется при госпитализации, прокальцитонин у пациентов в тяжёлом состоянии в стационаре.

Общий анализ крови в амбулаторных условиях выполнять рутинно не следует, только по показаниям, например для исключения инфекционного мононуклеоза.

Исследование АСЛ-О применимо только для ретроспективной диагностики, поскольку его уровень повышается лишь на 7–9-й день. Исследование оправдано лишь при подозрении на ревматическую лихорадку, гломерулонефрит или детские аутоиммунные нейропсихиатрические расстройства, ассоциированные со стрептококковой инфекцией (PANDAS).

Контрольный мазок на БГСА после лечения не показан, если пациент не относится к группе высокого риска ревматической лихорадки и симптомы не рецидивируют.

У детей старше 3 лет следует обращать внимание на насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит: при стрептококковой инфекции эти симптомы встречаются не более чем у 10% пациентов и только при сопутствующей вирусной инфекции.

3.2 Шкала Центора в модификации МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Отсутствие катаральных явлений и кашля	1
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Лечебная тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Посев и/или антибактериальная терапия не показаны
2–3	21–38% / 23–37%	Антибактериальная терапия по результатам экспресс-теста и/или посева
4 и более	57% / 55%	Антибактериальная терапия на основании клинической картины

3.3 Шкала FeverPAIN

По одному баллу начисляется за каждый признак: повышение температуры тела за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня в связи с выраженными симптомами, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

Вероятность стрептококковой инфекции групп A, C или G составляет 16% при 0–2 баллах, 43% при 3 баллах, 63% при 4–5 баллах.

Шкалы позволяют выявить пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, однако не дают возможности установить диагноз с абсолютной точностью.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Антибактериальная терапия

При вирусной инфекции системные антибактериальные препараты не применяют: они неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.

Профилактическое назначение антибиотиков при вирусном тонзиллофарингите не рекомендуется.

Антибактериальную терапию назначают только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии.

При стрептококковом тонзиллите препаратом выбора является амоксициллин.

При инфекционном мононуклеозе на фоне приёма амоксициллина возможно появление сыпи, однако она возникает и при приёме других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе следует избегать назначения любых системных антибактериальных препаратов.

Курс пенициллинов, цефалоспоринов, линкозамидов и макролидов, за исключением азитромицина, составляет 10 дней.

При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите препаратами выбора являются амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям старше 3 лет) курсом 10 дней. Необходима консультация оториноларинголога для исключения хронического тонзиллита, у детей также синдрома PFAPA.

Если через 48–72 часа от начала антибактериальной терапии температура тела и боль в горле не уменьшились, следует пересмотреть диагноз: наиболее вероятны ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.

При нетяжёлой аллергии на пенициллины применяют цефалоспорины II–III поколения: цефуроксим, цефиксим, цефдиторен или цефподоксим. Перекрёстная аллергия с пенициллинами встречается менее чем в 2% случаев для цефалоспоринов II поколения и менее чем в 1% для III поколения.

Уровни доказательности для этих препаратов в рекомендации различаются: для цефуроксима УУР C, УДД 5; для цефиксима C и 5 у детей, B и 1 у взрослых; для цефдиторена C и 2; для цефподоксима B и 2. Курс лечения составляет 10 дней.

При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница) используют макролиды или линкозамиды с учётом возможной устойчивости стрептококка к макролидам.

Бензатина бензилпенициллин вводится однократно внутримышечно вместо курса пероральной терапии только при сомнениях в том, что пациент будет принимать препарат. Доза для детей с массой тела до 27 кг составляет 600 тысяч ЕД, более 27 кг 1,2 миллиона ЕД.

4.2 Дозы для приёма внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия, 10 дней		

Препарат	Взрослые	Дети
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1] [3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] При сомнениях в соблюдении пациентом назначений, ревматической лихорадке у пациента или его родственников, неблагоприятных бытовых условиях и вспышках инфекции в коллективе. [3] Доза клавулановой кислоты не должна превышать 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

> Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте 250 мг 2 раза в сутки, в таблице 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 40 мг/кг в сутки, в таблице 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки, в таблице в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор дозы остаётся за врачом; дозы следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

4.3 Парентеральная терапия

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, антибиотик вводится парентерально до стабилизации состояния с последующим переходом на пероральный приём.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (при тяжёлом течении — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

4.4 Симптоматическая терапия

При лихорадке и болевом синдроме применяют ибупрофен, парацетамол или, у пациентов старше 15 лет, ацетилсалициловая кислота; детям применяются только парацетамол и ибупрофен. Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающие препараты назначают при температуре тела выше 39,0 °C при измерении в прямой кишке или выше 38,5 °C в подмышечной впадине.

Ибупрофен: взрослым 200–400 мг, детям 7,5 мг/кг, не более 30 мг/кг в сутки. Парацетамол: взрослым 500–1000 мг, детям 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначаются.

Исключением являются выраженный дискомфорт и угроза асфиксии, например при инфекционном мононуклеозе. В этом случае однократно внутрь назначается #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При выраженном болевом синдроме используют местные анестетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в виде спреев, растворов и таблеток для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение не заменяет системную антибактериальную терапию.

Бензидамин разрешён с 3 лет, бензокаин с хлоргексидином у детей старше 4 лет, флурбипрофен старше 12 лет, кетопрофен с 12 лет. Препараты для лечения заболеваний горла в целом применяются с 3–4 лет из-за риска ларингоспазма. «Смазывание» миндалин и механическое удаление налётов не рекомендуются.

Дополнительно, в том числе курсами в межрецидивный период, возможно применение растительных препаратов: корня алтея, ромашки, тысячелистника, коры дуба, хвоща, листьев грецкого ореха, одуванчика.

Рекомендуется ограничение раздражающей пищи (острой, кислой, солёной, горячей и холодной); пища должна иметь мягкую консистенцию.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения

разделы 5–7 текста КР

После тесного бытового контакта с больным стрептококковой инфекцией антибиотикопрофилактика показана беременным со сроком гестации 37 недель и более, новорождённым и родильницам в первые 28 дней, а также лицам в возрасте 75 лет и старше.

Больные стрептококковым тонзиллофарингитом подлежат изоляции от организованных коллективов, их контакты ограничиваются.

Для профилактики рецидивов тонзиллофарингита применяют лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациент находится под наблюдением в течение месяца: общий анализ крови и мочи повторяют через 7–10 дней и через 3 недели, при жалобах со стороны сердца показана электрокардиография (ЭКГ).

Лечение, как правило, амбулаторное. На фоне антибактериальной терапии улучшение наступает через 12–24 часа. Ребёнок допускается в детский коллектив после полного выздоровления.

Госпитализации в инфекционное отделение подлежат пациенты в тяжёлом состоянии, а также пациенты, которым в связи с отказом от еды и питья необходима инфузионная терапия. При подозрении на гнойное осложнение, атипичной клинической картине или необходимости хирургического вмешательства показаны консультация оториноларинголога и госпитализация в хирургическое отделение.

Стрептококковая инфекция может приводить к гнойным осложнениям (паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцессы, гнойный лимфаденит) и негнойным осложнениям: острой ревматической лихорадке, ревматической болезни сердца, постстрептококковому гломерулонефриту, стрептококковому токсическому шоку, PANDAS.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина с клавулановой кислотой и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются; расхождения приведены в блоке «Текст КР и таблица 1 расходятся» на вкладке «Лечение».

- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» указано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед»; по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.
- Таблицы доз в PDF извлекаются с нарушением порядка строк, поэтому все строки сверены по изображениям страниц 19–21.

Клинические рекомендации

Отит средний острый

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.0** — Острый средний серозный отит **H65.1** — Другие острые негнойные средние отиты **H66.0** — Острый гнойный средний отит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Острый средний отит (ОСО) является воспалительным процессом, охватывающим все три отдела среднего уха: барабанную полость, клетки сосцевидного отростка и слуховую трубу. Заболевание проявляется болью в ухе, повышением температуры тела, снижением слуха, в ряде случаев гноетечением из уха.
- Диагноз устанавливается при одновременном наличии острого начала, воспалительных изменений барабанной перепонки и признаков выпота в барабанной полости: выбухания или снижения подвижности барабанной перепонки при пневмоотоскопии или тимпанометрии. Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.
- У детей до 2 лет клинические признаки ОСО во всех случаях служат основанием для антибактериальной терапии. Независимо от возраста она необходима при гнойной форме, сохранении симптомов более 72 часов, рецидивирующем течении, отягощающей сопутствующей патологии, а также при невозможности повторного осмотра пациента.
- Препаратом первой линии является амоксициллин. При отсутствии эффекта в течение 3 дней он заменяется на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим. Продолжительность курса составляет 7–10 дней.
- Для обезболивания используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол; ушные капли с лидокаином и феназоном допустимы только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.
- Через 3–4 недели пациента повторно осматривают с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы своевременно выявить экссудативный средний отит.

2. Клиническая картина и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определения

Острый средний отит является воспалительным процессом, охватывающим все три отдела среднего уха (барабанную полость, клетки сосцевидного отростка и слуховую трубу) и проявляющимся одним или несколькими симптомами: болью в ухе, повышением температуры тела, снижением слуха, в ряде случаев гноетечением. Поражается только слизистая оболочка.

Рецидивирующим считается отит при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

Затянувшимся считается отит, при котором симптомы воспаления среднего уха сохраняются в течение 3–12 месяцев после одного или двух курсов антибактериальной терапии.

У детей возможны возбуждение, раздражительность, рвота и диарея. Заболевание, как правило, длится не более трёх недель.

2.2 Стадии

1) острый евстахеит; 2) острое катаральное воспаление; 3) доперфоративная стадия острого гнойного воспаления; 4) постперфоративная стадия острого гнойного воспаления; 5) репаративная стадия.

В стадии острого катарального воспаления барабанная перепонка гиперемирована, утолщена, опознавательные знаки определяются с трудом или не определяются.

В стадии острого гнойного воспаления боль в ухе резко усиливается, температура тела достигает фебрильных значений; барабанная перепонка ярко гиперемирована, выбухает, опознавательные знаки

не определяются, возможна перфорация.

В постперфоративной стадии через перфорацию барабанной перепонки в наружный слуховой проход поступает гнойное отделяемое.

В репаративной стадии жалобы практически отсутствуют, цвет и толщина барабанной перепонки восстанавливаются, перфорация в большинстве случаев закрывается рубцом, однако восстановление слизистой оболочки среднего уха ещё не наступило.

2.3 Степень тяжести

Лёгкое течение	Тяжёлое течение
Осложнения отсутствуют	Интратемпоральные или внутричерепные осложнения
Выбухание барабанной перепонки отсутствует	Выраженное выбухание барабанной перепонки
Непродолжительная боль в ухе, хорошо купируется лекарственными средствами	Выраженный болевой синдром (у детей раннего возраста проявляется изменением поведения), плохо купируется или не купируется лекарственными средствами
Общее состояние не изменено: сон, аппетит и активность не нарушены	Общее состояние изменено
Нормальная температура тела или субфебрилитет не более 3 дней	Субфебрилитет более 3 дней или температура тела выше 38,0 °C

2.4 Клиническая картина

У детей старше 2 лет ключевым симптомом является остро возникшая боль в ухе на фоне воспалительных изменений барабанной перепонки (гиперемия, выбухание, снижение подвижности при пневмоотоскопии), в постперфоративной стадии отмечается оторея. У детей раннего возраста большее диагностическое значение имеют выбухание барабанной перепонки и изменения поведения: беспокойство, отказ от еды, ребёнок теребит и трёт ухо.

Взрослые пациенты чаще предъявляют жалобы на заложенность уха, аутофонию и шум в ухе.

Снижение слуха носит кондуктивный характер; сенсоневральный компонент присоединяется редко.

2.5 Возбудитель и выбор антибактериального препарата

Возбудителя в ряде случаев можно предположить по клинической картине. При сочетании отита с конъюнктивитом наиболее вероятным возбудителем является H. influenzae. Стремительное начало с лихорадкой, спонтанной перфорацией и симптомами со стороны дыхательных путей характерно для S. pyogenes, нарастающая боль, лихорадка и спонтанная перфорация характерны для S. pneumoniae.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР

Диагноз устанавливается при одновременном наличии трёх признаков: острого начала заболевания, воспалительных изменений барабанной перепонки (гиперемии, инфильтрации) и выпота в барабанной полости (выбухания, снижения подвижности барабанной перепонки при пневмоотоскопии или тимпанометрии). Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.

Осмотр врачом-оториноларингологом необходим каждому пациенту с ОСО.

При отсутствии реактивных изменений барабанной перепонки её подвижность оценивается при пневматической отоскопии.

Тональную аудиометрию проводят при затяжном течении (более 10 дней), рецидивирующем отите, а также для исключения нейросенсорной тугоухости.

Развёрнутый общий анализ крови выполняют всем пациентам.

Уровень прокальцитонина определяют при подозрении на тяжёлое течение или в сложных случаях, чтобы подтвердить бактериальную природу отита.

3.1 Маркеры бактериального воспаления

Показатель	Катаральный отит	Гнойный отит
Лейкоциты <10 / 10–15 / >15 ×10^9/л	50% / 38% / 12%	12% / 29% / 59%
СРБ <15 / 15–60 / ≥60 мг/л	33% / 50% / 17%	14% / 36% / 50%
ПКТ <0,5 / 0,5–2 / 2–10 нг/мл	58% / 38% / 4%	4% / 32% / 64%

Пороговые значения для гнойного отита: лейкоциты >15×10^9/л (ППР 85%, ПОР 64%), С-реактивный белок (СРБ) >30 мг/л (ППР 79%, ПОР 52%), прокальцитонин (ПКТ) >2 нг/мл (ППР 94%, ПОР 74%). Таблица в PDF представлена изображением; значения перенесены вручную и сверены по изображению страницы 13.

Гнойное отделяемое направляют на микробиологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам при парацентезе или наличии отделяемого из барабанной полости, а также в стационаре при тяжёлом и рецидивирующем течении отита.

Компьютерная томография (КТ) височных костей необходима при затяжном течении (более 10 дней), выраженном ухудшении состояния, а также при подозрении на мастоидит или внутричерепные осложнения.

Если выполнить КТ невозможно, по тем же показаниям прибегают к рентгенографии височных костей в проекциях по Шюллеру и Майеру.

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Обезболивающая и жаропонижающая терапия

При болевом синдроме и лихорадке применяют НПВП или парацетамол. Препараты принимают разово: при боли в ухе или температуре тела выше 38,5 °C, а при фебрильных судорогах в анамнезе уже при 38,0 °C.

Детям до 6 лет допустимо назначение только парацетамола (до 60 мг/кг в сутки, 10–15 мг/кг на приём) или ибупрофена (до 30 мг/кг в сутки, 8–10 мг/кг на приём).

Местное обезболивание обеспечивают ушные капли с лидокаином и феназоном; их применение допустимо только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.

4.2 Показания к антибактериальной терапии

Системная антибактериальная терапия проводится при наличии показаний.

Показание	Показание
Возраст до 2 лет	Во всех случаях при наличии клинических признаков ОСО
Гнойная форма независимо от возраста	Перфорация барабанной перепонки с гнойным отделяемым; при отсутствии перфорации болевой синдром, не купируемый анальгетиками, в сочетании с выраженной гиперемией, отсутствием опознавательных знаков и выбуханием барабанной перепонки
Сохранение симптомов более 72 часов независимо от возраста	Боль, лихорадка или интоксикация при отоскопических признаках ОСО в течение 72 часов и более от начала заболевания
Рецидивирующее течение	3 и более эпизода за 6 месяцев или 4 и более за год
Сопутствующая патология	Сахарный диабет, иммунодефицитные состояния, муковисцидоз, синдромы цилиарной дискинезии, синдром Дауна, врождённые аномалии твёрдого и мягкого нёба
Невозможность повторного осмотра	Отсутствует возможность контрольного осмотра с отоскопией врачом-оториноларингологом или врачом общей практики

4.3 Выбор антибактериального препарата

Препаратом первой линии является амоксициллин при условии, что пациент не принимал его в течение последних 30 дней, а гнойный конъюнктивит и непереносимость аминопенициллинов отсутствуют.

Препаратами второй линии являются защищённые пенициллины и цефалоспорины III поколения. При отсутствии эффекта от амоксициллина в течение 3 дней он заменяется на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим.

При затянувшемся и рецидивирующем отите стартовыми препаратами являются амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим внутрь.

Макролиды у детей относятся к препаратам третьей линии; их применение оправдано только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов, поскольку устойчивость пневмококка к ним превышает 40%.

При лёгкой непереносимости пенициллинов альтернативой служат цефалоспорины III поколения: в амбулаторных условиях цефиксим, в стационаре при необходимости цефтриаксон парентерально.

Продолжительность курса составляет 7–10 дней. Более длительные курсы требуются детям до 2 лет, пациентам с отореей и сопутствующими заболеваниями; при затянувшемся и рецидивирующем отите курс, как правило, составляет не менее 14 дней. Антибактериальную терапию не прекращают до купирования отореи.

Тетрациклины, линкозамиды, аминогликозиды и ко-тримоксазол не рекомендуются в связи с низкой активностью в отношении пневмококка и гемофильной палочки и высокой частотой нежелательных явлений.

В постперфоративной стадии системная антибактериальная терапия продолжается.

4.4 Суточные дозы

Препарат	Взрослые	Дети
Препарат выбора		
Амоксициллин (независимо от приёма пищи)	0,5 г 3 раза в сутки без факторов риска[1]; 1,0 г 3 раза в сутки при факторах риска[2]	50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма[1]
Альтернативные препараты		
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[3] (в начале приёма пищи)	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки	40–45 мг/кг в сутки в 2–3 приёма
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в[4]	3,6 г в сутки в 3 введения	90 мг/кг в сутки в 3 введения (при массе тела 4–40 кг); 60 мг/кг в сутки (при массе тела менее 4 кг)
Ампициллин + сульбактам в/в[3]	1,5–3 г в сутки в 4 введения	150–300 мг/кг в сутки в 3–4 введения
Цефтриаксон[4]	2,0–4,0 г в сутки в 1 введение	50–80 мг/кг в сутки в 1 введение
Аллергия на пенициллины (не анафилактическая)		
Цефуроксим (непосредственно после приёма пищи)	500 мг в сутки в 2 приёма (так в таблице КР)	до 3 лет: 30 мг/кг в сутки в 2 приёма; старше 3 лет: 500 мг в сутки в 2 приёма
Цефиксим	400 мг в сутки в 1 приём	8 мг/кг в сутки в 1 приём
Аллергия на пенициллины и цефалоспорины		
Кларитромицин внутрь (показание «острый средний отит» зарегистрировано только для гранул для приготовления суспензии 125 и 250 мг/5 мл)	1000 мг в сутки в 2 приёма	15 мг/кг в сутки в 2 приёма

[1] [2] Без факторов риска / при факторах риска устойчивости пневмококка: приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца; дети дошкольного возраста в семье, посещающие детские учреждения; проживание в «закрытых» учреждениях. [3] Факторы риска продукции β-лактамаз: сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит), иммуносупрессия, неэффективность терапии амоксициллином. [4] При высоком риске осложнений.

> В тексте рекомендации имеется расхождение. В комментарии к рекомендации об амоксициллине стандартная доза для детей составляет 45–60 мг/кг в сутки, а при высоком риске устойчивости пневмококка 80–90 мг/кг в сутки, тогда как в таблице 4 для детей указано 50–60 мг/кг в сутки.

У детей до 3 лет амоксициллин применяют только в форме суспензии или диспергируемых таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой и цефиксим в таблетках и капсулах разрешены к применению с 12 лет; для детей младше 12 лет с массой тела менее 40 кг предназначены гранулы, порошок для приготовления суспензии или диспергируемые таблетки.

4.5 Местная и вспомогательная терапия

При перфорации барабанной перепонки купирование отореи ускоряют ушные капли на основе фторхинолонов или дексаметазона в комбинации с противомикробными средствами. Капли, содержащие аминогликозиды, и спиртосодержащие капли противопоказаны в связи с ототоксическим действием.

Ушные капли с норфлоксацином разрешены детям старше 1 года, с ципрофлоксацином с 15 лет. Капли с офлоксацином и дексаметазоном в комбинации с противомикробными средствами применяются у детей старше 1 года при остром гнойном отите и установленной тимпаностомической трубке.

Сосудосуживающие капли в нос используют во всех стадиях для восстановления проходимости слуховой трубы на срок не более 5–7 дней. Применение нафазолина не рекомендуется.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет). До года допустимы только капли, после года по возможности переходят на дозированный назальный спрей.

Детям рекомендуется орошение полости носа изотоническим раствором морской воды 1–2 раза в день. У детей дошкольного возраста от промывания полости носа большими объёмами растворов следует воздержаться, поскольку это повышает риск развития отита.

Муколитические препараты применяют у детей старше 2 лет. Перед назначением следует свериться с зарегистрированными показаниями в инструкции, поскольку не каждый муколитик, эффективный при патологии бронхов, пригоден для лечения отита.

4.6 Хирургическое лечение

Парацентез показан при выраженной клинической симптоматике и выбухании барабанной перепонки без перфорации, при болевом синдроме, не купируемом НПВП, а также при отсутствии улучшения через 48–72 часа антибактериальной терапии. Во всех сомнительных случаях решение принимается в пользу парацентеза.

Внутривисочные или внутричерепные осложнения требуют экстренной антромастоидотомии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

разделы 4–6 текста КР
Через 3–4 недели необходим повторный осмотр оториноларингологом с пневмоотоскопией или тимпанометрией для исключения экссудативного среднего отита.

Жалобы на снижение слуха после перенесённого отита служат поводом для консультации сурдолога-оториноларинголога.

В репаративной стадии проводятся продувание слуховых труб и пневмомассаж барабанных перепонок. Восстановление аэрации подтверждается объективными методами, в том числе тимпанометрией.

Консультация физиотерапевта рекомендуется в репаративной стадии.

Всем детям показана вакцинация против пневмококковой инфекции в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.

При рецидивирующем отите в плановом порядке выполняется шунтирование барабанной полости (тимпаностомия).

Показаниями к экстренной госпитализации являются тяжёлое течение, отсутствие положительной динамики при лёгком течении на фоне адекватной терапии в течение 3–5 дней, а также прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.

Пациент выписывается при стабильно удовлетворительном состоянии на протяжении не менее 3 дней.

Более тяжёлое течение и высокий риск осложнений отмечаются у пациентов с иммунодефицитом и сахарным диабетом. Риск развития отита повышен у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), аллергическим ринитом, а также у курильщиков, в том числе пассивных.

---

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Отит средний острый»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	314_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина в комментарии к рекомендации составляет 45–60 мг/кг/сут («стандартная») и 80–90 мг/кг/сут (при высоком риске устойчивости пневмококка), тогда как в таблице 4 указано 50–60 мг/кг/сут.
- Для цефуроксима у взрослых в таблице 4 указано «500 мг/сут в 2 приёма»; дозу следует сверить с инструкцией в ГРЛС.
- Для ушных капель с офлоксацином в одном месте указан код АТХ S01AX13 (код ципрофлоксацина), тогда как выше по тексту для офлоксацина приведён код S01AX11.
- Таблица 2 (маркеры бактериального воспаления) в PDF представлена изображением; её значения перенесены вручную.
- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены детям старше 1 года, в КР «Наружные отиты» (663_2) с 15 лет; возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.

Клинические рекомендации

Отосклероз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H80** — Отосклероз
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/315_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Пациенты предъявляют жалобы на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах; при отомикроскопии барабанная перепонка не изменена.
- Всем пациентам выполняют тональную пороговую аудиометрию; для отосклероза характерно двустороннее повышение порогов воздушной проводимости на низких и средних частотах (0,125–2 кГц), чаще в виде восходящей кривой, с наличием костно-воздушного интервала.
- При акустической импедансометрии для отосклероза характерны тимпанограмма типа А или As и отсутствие акустического рефлекса.
- Стапедопластика показана пациентам старше 15 лет с кондуктивной или смешанной тугоухостью и костно-воздушным интервалом не менее 25–30 дБ при отсутствии признаков активного отосклероза и общих противопоказаний.
- При кохлеарной форме и при наличии активных очагов взрослым пациентам назначают инактивирующую терапию.
- При недостаточном уровне слуха и разборчивости речи, в том числе после операции, при кохлеарной форме, противопоказаниях к операции или отказе от неё подбирают слуховые аппараты.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Отосклероз является первичным метаболическим поражением костной капсулы ушного лабиринта, особой формой остеодистрофии, как правило, двусторонней и очаговой, с локализацией в энхондральном слое капсулы. Вначале происходит резорбция кости с образованием мягких кровенаполненных отоспонгиозных очагов, затем в них откладываются соли кальция и формируется очень плотная склеротическая кость. Фазы размягчения и склерозирования сменяют друг друга волнообразно.

2.2 Этиология

Отосклероз наследуется по аутосомно-доминантному типу; пенетрантность гена составляет 20–40%.

2.3 Аудиометрическая классификация

В России наиболее широко применяется классификация Н. А. Преображенского и О. К. Патякиной (1973), основанная на данных тональной пороговой аудиометрии (ТПА): учитываются средние пороги костной проводимости (КП) на частотах 0,5, 1 и 2 кГц.

Форма	Средний порог КП (0,5–2 кГц)
Тимпанальная	до 20 (единица измерения в КР не указана)
Смешанная I	21–30 дБ
Смешанная II	более 30 дБ
Кохлеарная	более 50 дБ

> Границы форм в КР пересекаются: для смешанной формы II указано «>30 дБ» без верхней границы, для кохлеарной формы «КП >50 дБ». В таблице алгоритма обследования (приложение А3) для смешанной формы указаны пороги КП «до 50 дБ», при этом смешанные формы I и II не разделены.

2.4 Другие классификации

Различают гистологический и клинический отосклероз, а также активную (незрелую, отоспонгиоз) и неактивную (зрелую) стадии. Тактика лечения во многом определяется стадией процесса.

По распространённости очагов по данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) височных костей с мультипланарной реконструкцией выделяются фенестральная форма (очаги в области окна преддверия), ретрофенестральная (очаги вокруг базального и апикального завитков улитки, в области окна улитки, полукружных каналов и дна внутреннего слухового прохода) и смешанная. Очаги могут быть единичными и множественными. Денситометрия позволяет оценить плотность капсулы лабиринта, которая в норме составляет +2000…+2200 единиц Хаунсфилда (HU); плотность ниже 1000 HU свидетельствует об активном процессе (деминерализация, отоспонгиоз), выше 1000 HU о неактивном.

По интраоперационной картине в нише окна преддверия стапедиальный отосклероз подразделяется на ограниченный, умеренный, распространённый и облитерирующий. Наиболее сложными для стапедопластики являются облитерирующие формы, которые подразделяются на три степени. При 1-й степени подножная пластина стремени равномерно утолщена очагами; при 2-й степени очаги сужают нишу окна преддверия по краям при неизменённой пластине; при 3-й степени очаги сужают нишу и захватывают как пластину, так и суперструктуры стремени.

2.5 Клиническая картина

Основными симптомами являются прогрессирующее, чаще двустороннее снижение слуха и шум в одном или обоих ушах: низко- и среднечастотный у половины пациентов, высокочастотный у 10%. Примерно у половины пациентов разборчивость речи в шуме лучше, чем в тишине (paracusis Willisii, паракузия Виллизия). Жалобы на головокружение и нарушение равновесия предъявляют лишь 24% пациентов.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании жалоб на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах, нормальной отомикроскопической картины, данных тональной пороговой аудиометрии (кондуктивная, смешанная или нейросенсорная тугоухость) при 100% разборчивости речи по данным речевой аудиометрии, а также тимпанограммы типа А или As и отсутствия акустических рефлексов при акустической импедансометрии.

Учитываются также латерализация ультразвука и пороги его восприятия, данные компьютерной томографии височных костей с денситометрией: участки пониженной плотности на фоне плотной однородной капсулы лабиринта. При фенестральной форме очаг пониженной плотности определяется в промонториальной стенке барабанной полости кпереди от окна преддверия, при кохлеарной форме очаги повторяют ход завитков улитки и распространяются до стенок внутреннего слухового прохода.

> В критериях диагноза для смешанной формы указано, что ей свойственны признаки, «характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм». По смыслу, вероятно, имелась в виду кохлеарная форма.

3.1 Жалобы и анамнез

У всех пациентов уточняется наличие прогрессирующего снижения слуха на одно или оба уха.

При всех формах слух снижается постепенно, без видимой причины. Тугоухость, как правило, двусторонняя, односторонняя встречается в 15–30% случаев. При раннем начале заболевания очаги чаще облитерирующие и распространённые, тугоухость быстро нарастает; при позднем начале очаги ограниченные, быстрого прогрессирования не наблюдается.

У всех пациентов уточняется наличие шума в одном или обоих ушах.

Шум, как правило, низко- и среднечастотный (у 50%), реже высокочастотный (у 10%). В начале заболевания он ощущается только в тишине, по мере нарастания тугоухости усиливается.

У всех пациентов уточняется, не отмечается ли улучшение слуха в шумной обстановке.

Паракузия Виллизия встречается примерно у половины пациентов, чаще при выраженной фиксации стремени с сохранной костной проводимостью. При переходе тугоухости в смешанную форму этот симптом выявляется реже.

У всех пациентов уточняется наличие головокружения и нарушений равновесия.

Эти жалобы предъявляют около 24% пациентов с отосклерозом. Их связывают с внутрилабиринтной гипертензией, поскольку после операции данные расстройства регрессируют.

3.2 Физикальное обследование

Всем пациентам показана отомикроскопия или отоэндоскопия для оценки состояния наружного слухового прохода и барабанной перепонки.

Барабанная перепонка целостная, опознавательные знаки чёткие. Характерные признаки отосклероза выявляются лишь у 10–21% пациентов.

К ним относятся симптом Лемперта (истончение барабанной перепонки с изменением её цвета вследствие атрофии фиброзного слоя), симптом Хилова (истончение кожи слухового прохода), симптом Тойнби (отсутствие или малое количество серы), симптом Швартца (просвечивание расширенных сосудов мыса через истончённую барабанную перепонку; является признаком активной стадии, встречается у 50%) и симптом Вирховского–Тилло (снижение чувствительности кожи слухового прохода и барабанной перепонки, снижение потоотделения, широкий слуховой проход). Ни один из этих симптомов не является патогномоничным, они оцениваются только в совокупности с другими проявлениями заболевания.

Специфическая лабораторная диагностика отсутствует. Лабораторные исследования необходимы при подготовке к плановому хирургическому вмешательству.

3.3 Аудиологическое исследование

Всем пациентам для скрининговой оценки характера тугоухости проводятся камертональные пробы Ринне, Федеричи и Вебера.

Исследование камертонами С128–С512 позволяет выявить костно-воздушный интервал (пробы Ринне и Федеричи) и хуже слышащее ухо (проба Вебера), что является показанием к тональной аудиометрии. При кохлеарной форме пробы Ринне и Федеричи положительные, звук в пробе Вебера латерализуется в лучше слышащее ухо.

Всем пациентам выполняется тональная пороговая аудиометрия для оценки формы и степени тугоухости.

Оцениваются пороги воздушной (ВП) и костной проводимости и величина костно-воздушного интервала (КВИ, резерв улитки). Характерно двустороннее повышение порогов ВП на низких и средних частотах (0,125–2 кГц), чаще в виде восходящей кривой с небольшим подъёмом. По мере прогрессирования заболевания повышаются и пороги КП вследствие поражения звукопроводящего аппарата и нарушения проведения внутри улитки. Теория Р. Кархарта объясняет механическую природу сенсоневрального компонента нарушением микромеханики и гидродинамики улитки на частотах 0,5–2 кГц. По типу кривой различают тимпанальную, смешанную и кохлеарную формы.

По данным речевой аудиометрии разборчивость речи составляет 100%.

Всем пациентам для оценки характера тугоухости исследуются чувствительность к ультразвуку и его латерализация.

При отосклерозе пороги восприятия ультразвука составляют до 15 дБ, при кохлеарной форме находятся в пределах нормы или незначительно повышены. При кохлеарной форме с односторонней или асимметричной двусторонней тугоухостью ультразвук латерализуется в лучше слышащее ухо. Латерализация в хуже слышащее ухо (60,9% случаев) может свидетельствовать, в частности, о гидропсе лабиринта вследствие нарушения гидродинамики; это характерно для пациентов с длительностью заболевания более 10 лет и подтверждается данными экстратимпанальной электрокохлеографии (ЭКоГ).

Очаги могут вовлекать утрикулярный нерв и сдавливать эндолимфатический проток, а выраженная обструкция его дистального отдела может приводить к расширению саккулюса вплоть до контакта с основанием стремени. Однако ни одна методика не позволяет с полной уверенностью выявить гидропс лабиринта и установить его эндо- или перилимфатический характер, хотя это имеет значение для определения показаний к операции и её результата.

Всем пациентам выполняется акустическая импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия) для исключения патологии среднего уха и оценки давления в среднем ухе, вентиляционной функции слуховой трубы, подвижности барабанной перепонки и состояния цепи слуховых косточек.

Для отосклероза характерны тимпанограмма типа А или As и отсутствие акустического рефлекса.

Акустическая импедансометрия является комплексным методом, включающим тимпанометрию, определение акустического импеданса (сопротивления) и акустического миорефлекса.

3.4 Данные аудиологического исследования при различных формах

Показатель	Тимпанальная	Смешанная	Кохлеарная
Тональная аудиометрия: вид кривой; пороги КП (0,5–2 кГц); КВИ	горизонтальная; до 20 дБ; 30–50 дБ	пологонисходящая; до 50 дБ; 30 дБ	крутонисходящая; выше 50 дБ; менее 10 дБ
Разборчивость речи	100%	100%	100%
Пороги чувствительности к ультразвуку (в КР единица «вт»)	10	10–15	более 15
Феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ)	не выявляется	редко	часто
Тимпанометрия	тип А	тип А	тип А
МСКТ височных костей	фенестральная локализация очагов	фенестральная и улитковая локализация очагов	часто деминерализация улитки

В таблице алгоритма обследования названия форм сдвинуты на одну колонку влево: «тимпанальная» стоит под заголовком «Алгоритм обследования», над последней колонкой название отсутствует. Здесь колонки приведены по смыслу, в соответствии с классификацией: горизонтальная кривая и КП до 20 дБ соответствуют тимпанальной форме. Пороги ультразвука в таблице приведены в ваттах («10 вт», «>15 вт»), в тексте КР в децибелах («до 15 дБ»). В таблице для всех форм указана только тимпанограмма типа А, в тексте указан тип «А» или «As». Текст ссылается на эту таблицу как на приложение Г1, однако в приложении Г1 указано «Отсутствуют», а таблица приведена в приложении А3.

3.5 Компьютерная томография

Всем пациентам выполняется компьютерная томография височных костей для подтверждения диагноза отосклероза, определения локализации и распространённости очагов и оценки их активности.

МСКТ с шагом 0,3–1 мм в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией и денситометрией является единственным объективным неинвазивным методом решения этих задач; чувствительность метода составляет 80–95%, специфичность 99,1%.

До операции МСКТ позволяет выявить особенности строения и заболевания височной кости, имитирующие отосклеротическую тугоухость или снижающие эффективность операции: неотосклеротическую фиксацию цепи слуховых косточек, дегисценцию верхнего полукружного канала, расширение водопровода преддверия, остеодистрофии (синдром Ван-дер-Хуве), облитерирующий отосклероз, оссификацию окна улитки и лабиринта.

Снижение плотности капсулы лабиринта с нормальных +2000…+2200 до +1500…+300 HU свидетельствует о начальной или далеко зашедшей деминерализации.

При фенестральной форме очаги чаще всего определяются в области впередиоконной щели и переднего полюса основания стремени с переходом на его переднюю ножку. Плотность зрелых очагов, как правило, составляет +1000…+1100 HU; плотность +500…+800 HU позволяет предположить активный отосклероз (отоспонгиоз). Тугоухость при фенестральной локализации очагов варьирует от тимпанальной до смешанной формы.

При смешанной форме, помимо фенестральных очагов, определяются участки пониженной плотности капсулы вокруг улитки с переходом на область окна улитки, в ряде случаев до дна внутреннего слухового прохода. На аудиограмме при этом может регистрироваться смешанная тугоухость 1–2 степени.

При кохлеарном отосклерозе в начальной стадии в капсуле вокруг улитки определяются участки плотностью +1500…+1100 HU. В умеренно активной стадии вокруг базального и апикального завитков визуализируются отчётливые участки плотностью +1000…+600 HU, которые часто переходят на область окна улитки и могут распространяться до дна внутреннего слухового прохода и горизонтального полукружного канала.

В стадии высокой активности деминерализация распространяется на капсулу на уровне базального и апикального завитков, может достигать преддверия и полукружных каналов, плотность составляет +300…+600 HU. В этой стадии возможна костная облитерация структур лабиринта, чаще всего базального завитка и горизонтального полукружного канала.

> Плотность активных очагов в КР указана неодинаково: в тексте о фенестральной форме +500…+800 HU, в подписи к рисунку 1 +300…+800 HU. В подписи к рисунку 3 для кохлеарной формы указано +600…+800 HU, тогда как в тексте рядом приведены значения +1000…+600 HU для умеренной и +300…+600 HU для высокой активности.

МСКТ позволяет установить и причину неудачной стапедопластики: оценить положение протеза и глубину его погружения в преддверие, выявить некроз длинной ножки наковальни, перилимфатическую фистулу и гранулему окна преддверия.

4. Лечение

4.1 Инактивирующая терапия

Инактивирующая терапия проводится взрослым пациентам с кохлеарной формой, с тимпанальной и смешанной формами в активной стадии перед операцией, а также при выявлении активного отосклероза во время операции. Целью терапии является инактивация очагов отоспонгиоза.

Терапия снижает активность отосклероза, замедляет нарастание сенсоневрального компонента, повышает плотность капсулы лабиринта, уменьшает вероятность реоссификации после операции, останавливает рост очагов и препятствует облитерации улитки.

Число курсов определяют по плотности очагов отоспонгиоза по данным МСКТ височных костей с денситометрией. Все препараты комплекса в КР отмечены знаком #, что обозначает применение вне инструкции.

4.2 Схема одного курса у взрослых

Препарат	Доза
#Ибандроновая кислота	Внутривенно болюсом за 15–30 секунд 3 мг/3 мл однократно в процедурном кабинете, 1 раз в 3 месяца, или внутрь 150 мг 1 раз в месяц за час до еды, запивая стаканом воды.
#Алендроновая кислота	Вместо ибандроновой кислоты: 70 мг 1 раз в неделю за час до еды, запивая стаканом воды.
#Кальция глюконат	500 мг 3 раза в день после еды.
#Натрия фторид	30–60 мг (0,5 мг/кг) в течение 2 месяцев.
#Альфакальцидол	0,25 мкг 1 раз в день.

Продолжительность курса составляет 3 месяца. В зависимости от плотности очагов назначают 1, 2 или 4 курса с интервалами по 3 месяца до достижения плотности очагов +1000…+1500 HU.

Плотность очагов по МСКТ	Число курсов
ниже +300 HU	4
+300…+600 HU	2
+600…+900 HU	1

> Активными в КР считаются очаги плотностью ниже 1000 HU, однако число курсов указано только для очагов до +900 HU: для очагов +900…+1000 HU схема не приведена.

4.3 Стапедопластика

Показаниями к операции являются жалобы на снижение слуха и шум в ухе, кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ не менее 30 дБ, отсутствие признаков активного отосклероза по данным отомикроскопии и МСКТ с денситометрией, отсутствие перфорации барабанной перепонки и инфекции слухового прохода, отсутствие общих противопоказаний к плановому хирургическому вмешательству.

Стапедопластика выполняется пациентам старше 15 лет при кондуктивной или смешанной тугоухости с КВИ не менее 25–30 дБ при отсутствии признаков активного отосклероза по данным отомикроскопии и компьютерной томографии (КТ) с денситометрией и общих противопоказаний к плановому хирургическому вмешательству.

Операция является паллиативной. В пользу её выполнения свидетельствует то, что в неоперированных ушах нейросенсорный компонент нарастает в большей степени, чем в оперированных.

Операция противопоказана при остром воспалительном процессе и обострении хронического, при декомпенсации сопутствующих заболеваний. Относительными противопоказаниями являются активный отосклероз, единственное слышащее ухо и расширенный водопровод преддверия по данным МСКТ: у пациентов с этим синдромом описаны случаи глухоты после операции.

> Пороговое значение КВИ для операции в КР приведено трижды и неодинаково: в показаниях к хирургическому лечению (раздел 3.2) не менее 30 дБ, в тексте рекомендации 25–30 дБ, в показаниях к госпитализации (раздел 6) не менее 25 дБ.

Основание стремени вскрывают двумя способами: стапедотомия (методика малого окна, поршневая) или стапедэктомия (методика большого окна, частичная или тотальная). Протезы изготавливаются из алло- и аутотканей и биосовместимых материалов (тефлон, керамика, пластипор, сталь, титан, платина); сухожилие стременной мышцы и наковальне-стременное сочленение сохраняются или не сохраняются, окно преддверия изолируется аутотканью (вена, жир, клетчатка, фасция) или не изолируется.

Наибольшее распространение в мире получила поршневая методика J. Shea (1962) ввиду минимальной травматичности для внутреннего уха и простоты выполнения; она обеспечивает КВИ не более 10 дБ у 58–98% пациентов.

Эффективны как стапедотомия, так и частичная стапедэктомия; при стапедэктомии сокращение КВИ в раннем послеоперационном периоде происходит быстрее. Сенсоневральная тугоухость после операции развивается у 3,5–5,9% пациентов, глухота у 0,9–2%.

Методика выбирается на основании данных предоперационного обследования (возраст, жалобы, анамнез, пороги КП и КВИ, строение височной кости по данным МСКТ) и интраоперационных находок: распространённости и активности очагов, строения ниши окна преддверия и канала лицевого нерва, кровоточивости тканей и давления перилимфы.

Поршневая стапедопластика предпочтительна в молодом возрасте (до 40 лет), при активных очагах, узкой нише окна преддверия, распространённых формах с крупными очагами на промонториуме, облитерирующих формах и выраженной кровоточивости тканей. Аутотканевая стапедопластика предпочтительна у пациентов пожилого возраста, особенно при длительном снижении слуха, при смешанных формах и расширенном водопроводе улитки по данным МСКТ. При невозможности аутотканевой стапедопластики устанавливается протез на аутовенозный трансплантат.

4.4 Выбор методики стапедопластики

Критерий	Поршневая	Протез на аутовену	Аутоткани
Молодой возраст (до 40 лет)	+	+	–
Длительность заболевания более 10 лет	–	–	+
Смешанная форма II	–	+	+
Активный отосклероз	+	+	–
Облитерирующий отосклероз	+	–	–

Критерий	Поршневая	Протез на аутовену	Аутоткани
Анатомически узкая ниша окна преддверия	+	+	–
Гидропс лабиринта по данным ЭКоГ	+	+	+
Расширенный водопровод улитки, дегисценция верхнего полукружного канала и гидропс по данным ЭКоГ (перилимфатический гидропс)	–	+	+
Расширенный водопровод преддверия и гидропс по данным ЭКоГ (эндолимфатический гидропс)	–	в КР не заполнено	–

Чем больше диаметр отверстия в основании стремени и протеза при качественном выполнении операции, тем лучше гидродинамика лабиринта: пороги КП снижаются на 10–20 дБ по всей тон-шкале. При поршневой методике такой эффект не наблюдается.

4.5 Доля пациентов с КВИ не более 10 дБ после операции

Методика	10–12 дней	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
Аутотканевая	38%	78%	96%	96%	100%
Поршневая	20%	50%	56%	78%	76%

> Текст ссылается на таблицу критериев выбора методики как на «табл. 1», однако номер у таблицы отсутствует; в строке об эндолимфатическом гидропсе ячейка для протеза на аутовену не заполнена. На рисунке 7 значения для методики с протезом на аутовену не подписаны.

4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование

Взрослым пациентам с отосклерозом рекомендуется кохлеарная имплантация; показания уточнены в комментарии к рекомендации.

Кохлеарная имплантация показана при кохлеарной форме или высоких порогах после стапедопластики с двусторонней тугоухостью 4–5 степени, если разборчивость простых односложных слов по данным речевой аудиометрии с оптимально подобранными слуховыми аппаратами на оба уха составляет менее 30%, по данным МСКТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ) патология улитки отсутствует, а пациент достаточно мотивирован.

Электроакустическая реабилитация (слуховые аппараты) показана всем пациентам с недостаточным уровнем слуха и разборчивости речи, в том числе после операции, при кохлеарной форме, при общих противопоказаниях к операции и при отказе от неё.

Слухопротезирование показано при уровне слуха ниже социального: пороги КП более 30 дБ или ВП более 45 дБ на речевых частотах. Учитываются феномен ускоренного нарастания громкости, который может выявляться как после операции, так и вне связи с ней, а также желание пациента, единственное слышащее ухо, противопоказания к операции и отказ от неё.

5. Медицинская реабилитация. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Медицинская реабилитация заключается в слухопротезировании при уровне слуха ниже социального (пороги КП более 30 дБ или ВП 45 дБ и более на речевых частотах): после операции, в том числе на единственном слышащем ухе, при противопоказаниях к операции или отказе от неё и при кохлеарной форме.

> Пороговое значение воздушной проводимости для слухопротезирования в разделе 3.3 приведено как «более 45 дБ», в разделе 4 как «45 и более дБ».

Методы профилактики отосклероза и диспансерного наблюдения в КР не приведены.

Первичный осмотр пациента выполняют оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

5.1 Показания к госпитализации

Показаниями к плановой госпитализации для хирургического лечения являются жалобы на снижение слуха и шум, кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ не менее 25 дБ при отсутствии признаков активного отосклероза по данным отомикроскопии и МСКТ, перфорации барабанной перепонки, инфекции слухового прохода и общих противопоказаний, а также выполненное обследование в объёме, необходимом для госпитализации в стационар.

Выписка возможна на 7–10-й день после контрольной тональной аудиометрии: пороги КП должны оставаться на дооперационном уровне, а КВИ в зависимости от методики сохраняться прежним или сокращаться за счёт улучшения порогов ВП.

После операции, в зависимости от методики, рекомендуется постельный режим на 1–2 суток с положением на противоположном ухе. В течение месяца необходимо оберегать ухо от попадания воды и громких звуков; авиаперелёты не рекомендуются в течение 3 месяцев.

В информации для пациента указано, что операция даёт положительный результат у девяти из десяти пациентов и неэффективна менее чем у 1%.

> Информация для пациента расходится с основным текстом рекомендации. В ней указано, что лечение и наблюдение пациентов осуществляет сурдолог, тогда как в разделе 6 первичный приём проводят оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог. В ней же сказано, что слуховые аппараты эффективны лишь на поздних стадиях, когда операция не показана, тогда как в разделе 3.3 слухопротезирование рекомендуется и после операции, и при отказе от неё.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Отосклероз»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «Пересмотр не позднее: 2026», следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	315_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Пороговое значение КВИ для стапедопластики указано трижды и неодинаково: 30 дБ (показания, раздел 3.2), 25–30 дБ (рекомендация), 25 дБ (показания к госпитализации, раздел 6).

- В классификации Преображенского–Патякиной границы смешанной формы II («>30 дБ») и кохлеарной формы («>50 дБ») пересекаются, для тимпанальной формы («до 20») не указана единица измерения; в таблице приложения А3 для смешанной формы указано «до 50 дБ».
- В таблице алгоритма обследования (приложение А3) названия форм сдвинуты на одну колонку влево.
- Пороги ультразвука в таблице приложения А3 приведены в ваттах, в тексте раздела 2.4 в децибелах.
- В тексте для отосклероза указана тимпанограмма типа «А» или «As», в таблице приложения А3 только тип А.
- Текст ссылается на приложения Г1 (формы отосклероза) и Г2 (стапедопластика), однако в приложении Г1 указано «Отсутствуют», приложение Г2 отсутствует, а соответствующие таблицы приведены в приложении А3. Приложение Б (алгоритмы) не заполнено.
- В критериях диагноза для смешанной формы указано «признаки характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм», вероятно, вместо «кохлеарной».
- Плотность активных очагов по данным МСКТ в тексте и в подписях к рисункам 1 и 3 не совпадает.
- Число курсов инактивирующей терапии указано только для очагов до +900 HU, хотя активными считаются очаги плотностью ниже 1000 HU.
- Пороговое значение ВП для слухопротезирования: «более 45 дБ» в разделе 3.3 и «45 и более дБ» в разделе 4.
- Таблица критериев выбора методики стапедопластики в тексте названа «табл. 1», но не пронумерована; одна ячейка в ней не заполнена.
- Информация для пациента противоречит разделам 3.3 и 6: согласно ей, лечение проводит сурдолог, а слуховые аппараты эффективны «лишь на поздних стадиях».
- В разделе 3.1 сохранились черновые фрагменты: «источник, где указана дозировка», «Достигаемым техническим результатом является…», «препаратофективен»; тональная аудиометрия сокращается то как ТПА, то как ТАП.

Клинические рекомендации

Паратонзиллярный абсцесс

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J36** — Перитонзиллярный абсцесс **J39.0** — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс **J39.1** — Другой абсцесс глотки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Лечение паратонзиллярного абсцесса осуществляет оториноларинголог в условиях стационара; основным методом лечения является хирургическое вскрытие абсцесса.
- В большинстве случаев (более 70%) абсцесс имеет передневерхнюю локализацию и располагается между капсулой нёбной миндалины и верхней частью передней нёбной дужки.
- Антибактериальные препараты широкого спектра действия, активные в отношении анаэробов, применяются эмпирически, до получения результатов посева; курс терапии, как правило, составляет 10–14 дней.
- При частых ангинах в анамнезе, повторном развитии или затяжном течении абсцесса, неадекватном дренировании и кровотечении после вскрытия нёбные миндалины удаляют одновременно со вскрытием абсцесса (абсцесстонзиллэктомия).
- Если выполнено только вскрытие абсцесса, двустороннюю тонзиллэктомию проводят в плановом порядке через 3 месяца.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Паратонзиллярный абсцесс характеризуется гнойным расплавлением паратонзиллярной клетчатки, расположенной между псевдокапсулой нёбной миндалины и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

2.2 Этиология

В большинстве случаев абсцесс развивается как осложнение ангины, несколько реже на фоне хронического тонзиллита. Возможен также одонтогенный путь инфицирования при кариесе задних зубов нижней челюсти (вторых моляров, зубов мудрости) и периостите альвеолярного отростка, а также инфицирование при попадании в паратонзиллярную клетчатку инородного тела (например, рыбной кости).

Наиболее частыми возбудителями являются бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробные микроорганизмы.

На момент обращения отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная форма выявляется у 15–20% пациентов, абсцедирующая форма у 80–85%. Абсцесс формируется, как правило, через 4–6 дней от начала заболевания, в ряде случаев в течение нескольких часов.

2.3 Локализация

Передневерхний (супратонзиллярный) абсцесс встречается более чем в 70% случаев и располагается между капсулой миндалины и верхней частью передней нёбной дужки. Задний абсцесс (около 15% случаев) располагается между миндалиной и задней нёбной дужкой, нижний (несколько более 5%) между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки, боковой (менее 5%) между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

2.4 Клиническая картина

Абсцесс, как правило, развивается на фоне ангины или через несколько дней после её завершения. Заболевание начинается с боли при глотании, которая становится постоянной, резко усиливается при попытке проглотить слюну и иррадиирует в ухо и зубы. Пациентов беспокоят головная боль, общая разбитость, отмечается повышение температуры тела до фебрильных значений, пациенты отказываются от пищи и питья. В подавляющем большинстве случаев постепенно нарастает тризм жевательной мускулатуры, речь становится невнятной и гнусавой. Вследствие болезненности при поворотах головы пациент держит голову набок и поворачивается всем корпусом.

При передневерхнем абсцессе отмечается резкое выбухание верхнего полюса миндалины вместе с нёбными дужками и мягким нёбом к средней линии, язычок смещён в противоположную сторону, миндалина оттеснена книзу и кзади.

При заднем абсцессе припухлость определяется в области задней нёбной дужки, процесс может распространяться на боковую стенку глотки; миндалина и передняя дужка изменены незначительно, язычок и мягкое нёбо отёчны.

При нижнем абсцессе при фарингоскопии определяются лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки, несмотря на выраженные жалобы. В процесс может вовлекаться корень языка, в ряде случаев развивается отёк язычной поверхности надгортанника; распространение отёка на гортань может привести к её стенозу.

Боковой абсцесс встречается реже остальных форм, однако характеризуется наиболее тяжёлым течением, поскольку условия для самопроизвольного прорыва гноя в полость глотки наименее благоприятны. Выражены отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения, кривошея, тризм; при фарингоскопии определяется лишь умеренное выбухание всей миндалины.

2.5 Жалобы и анамнез

При сборе анамнеза следует уточнить наличие недавно перенесённых ангин, хронического тонзиллита, паратонзиллитов и абсцессов в прошлом и проводившегося лечения, кариеса, возможного попадания инородного тела (например, рыбной кости).

Пациенты предъявляют жалобы на выраженную, как правило одностороннюю боль в горле, усиливающуюся при глотании и иррадиирующую в ухо и зубы, ощущение инородного тела, гнусавость, неприятный запах изо рта, боль в шее при поворотах головы, тризм, слюнотечение. Из общих жалоб отмечаются слабость, разбитость, фебрильная лихорадка, головная боль; эти жалобы неспецифичны и требуют проведения дифференциальной диагностики.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза, физикального обследования с тщательной оценкой подчелюстной области и регионарных лимфатических узлов, данных фарингоскопии и лабораторных исследований.

Каждого пациента с подозрением на паратонзиллярный абсцесс осматривает врач-оториноларинголог.

Местные признаки наиболее выражены при переднем абсцессе: яркая гиперемия, отёк и инфильтрация нёбных дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка, асимметрия мягкого нёба, смещение миндалины, ограничение открывания рта, регионарный лимфаденит.

Фарингоскопию выполняют всем детям и взрослым; её данные имеют решающее значение для постановки диагноза.

При подозрении на распространение воспалительного процесса на гортаноглотку показана непрямая ларингоскопия или фиброларингоскопия.

Компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) шеи применяют в тяжёлых случаях, когда требуется уточнить диагноз и локализацию абсцесса или провести дифференциальную диагностику с воспалением глубоких отделов шеи.

3.1 Лабораторные исследования

Всем пациентам выполняют развёрнутый общий анализ крови, исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) и общий анализ мочи. Выраженный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево и высокий уровень СРБ свидетельствуют о высоком риске осложнений и требуют коррекции лечения, в том числе антибактериальной терапии.

Гнойное отделяемое, полученное после вскрытия абсцесса, направляется на посев на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам; мазок с миндалин исследуется на палочку дифтерии для исключения дифтерии.

Для исследования предпочтительно брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости, поскольку ферменты гноя разрушают микроорганизмы. Материал доставляется в лабораторию в транспортной среде, оптимально в течение 40 минут.

3.2 Дифференциальная диагностика

Паратонзиллярный абсцесс дифференцируют с дифтерией, скарлатиной, абсцессом язычной миндалины, абсцессами подъязычной области, флегмоной дна полости рта, опухолями ротоглотки и перикоронитом.

При дифтерии слизистая оболочка бледная, с цианотичным оттенком, налёты сероватые, распространяются за пределы миндалин, тризм отсутствует.

Для скарлатины характерны сыпь на коже, чёткая граница поражённой слизистой оболочки, «малиновый» язык. При абсцессе язычной миндалины тризм и типичные изменения в ротоглотке отсутствуют. При флегмоне дна полости рта отмечаются боль и отёк в подчелюстной области, язык малоподвижен, нёбные дужки и миндалины не изменены.

Опухоли миндалины характеризуются медленным развитием, отсутствием лихорадки, выраженного болевого синдрома и тризма; регионарные лимфатические узлы плотные, малоболезненные, малоподвижные.

В редких случаях припухлость в глотке обусловлена близким к поверхности расположением сонной артерии или её аневризмой; на это указывает визуально определяемая пульсация.

---

4. Лечение

Лечение осуществляет оториноларинголог в специализированном учреждении; основным методом лечения является хирургическая санация полости абсцесса.

4.1 Хирургическое лечение

При впервые возникшем абсцессе показаны его вскрытие и дренирование.

Независимо от техники вскрытия необходимо убедиться в отсутствии пульсации в месте разреза, глубже 0,5 см продвигаться только тупым путём, разрез выполнять достаточно широким, до 4 см.

Место разреза определяется локализацией абсцесса; операцию выполняют под местной аппликационной анестезией. Передневерхний абсцесс вскрывается через переднюю нёбную дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания, задний абсцесс через заднюю дужку с отступом 0,5 см от её края, нижний абсцесс в нижней части передней дужки. Ткани рассекаются вдоль хода сосудов на глубину 0,5–1 см, далее разводятся корнцангом.

В последующем края разреза регулярно разводятся до начала заживления полости.

При частых ангинах в анамнезе, повторном развитии паратонзиллита или абсцесса, затяжном течении, неадекватном дренировании и кровотечении после вскрытия показано удаление нёбных миндалин одновременно со вскрытием абсцесса, что позволяет устранить и сам очаг инфекции.

Операция выполняется в любом возрасте, от 3–4 до 70 лет и старше. Противопоказаниями являются терминальное или крайне тяжёлое состояние, обусловленное заболеваниями внутренних органов, тромбоз сосудов мозга, разлитой менингит.

После операции осматривают тонзиллярную нишу; выбухание в ней свидетельствует о парафарингеальном абсцессе.

4.2 Антибактериальная терапия

Системную антибактериальную терапию начинают эмпирически, не дожидаясь результатов посева. Поскольку в полости абсцесса, как правило, присутствуют анаэробы, необходимы препараты широкого спектра действия, активные и в отношении анаэробной микрофлоры.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	С 12 лет или при массе тела от 40 кг — 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки. Возможно применение #амоксициллина с сульбактамом по 1 г 2–3 раза в сутки с 12 лет, до 10 дней. Детям до 12 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Цефтриаксон	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки; длительность в таблице рекомендации указана как «в течение 4–14 дней до 10 дней». Новорождённым до 2 недель — 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не более 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки.
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 1 г 2 раза в сутки, до 10 дней. Новорождённым и детям до 12 лет — 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; недоношенным — не более 50 мг/кг в сутки.
Клиндамицин	300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении — до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма. Детям при непереносимости цефалоспоринов III поколения — #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

Курс антибактериальной терапии, как правило, составляет 10–14 дней. Препаратами выбора являются пенициллины, в том числе в сочетании с ингибиторами бета-лактамаз. При затруднённом глотании применяются диспергируемые формы, суспензии или инъекционные формы. При выраженном отёке тканей глотки и шеи, выраженном тризме и высоком риске генерализации инфекции применяют парентеральные цефалоспорины III поколения, а при их непереносимости клиндамицин. Детям предпочтительно назначение ампициллина с сульбактамом и амоксициллина с клавулановой кислотой.

4.3 Дополнительная терапия

При выраженных воспалительных проявлениях используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в стандартных дозах.

Всем пациентам рекомендованы антигистаминные препараты системного действия.

Рекомендацией предусмотрено также применение средств, повышающих естественную резистентность организма (препараты кальция, витамины С и А); при этом следует избегать полипрагмазии.

При выраженной интоксикации необходима инфузионная дезинтоксикационная терапия.

Всем пациентам рекомендованы также местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства (полоскания, инсуффляции, ингаляции, таблетки для рассасывания), однако они не заменяют системную антибактериальную терапию.

После хирургического лечения, не ранее чем через 3 недели после купирования острого воспаления, показана консультация физиотерапевта.

4.4 Послеоперационное ведение

После вскрытия абсцесса двусторонняя тонзиллэктомия выполняется в плановом порядке через 3 месяца.

После тонзиллэктомии в течение месяца рекомендуется ограничение физической нагрузки.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения

При диспансеризации выявляют факторы риска (хронический тонзиллит, рецидивирующие ангины); профилактика включает закаливание и своевременное лечение заболеваний зубов и дёсен.

Лечение осуществляется в хирургическом стационаре. Показанием к госпитализации является необходимость вскрытия абсцесса или удаления нёбных миндалин со вскрытием абсцесса. После вскрытия улучшение состояния отмечается уже через 12–24 часа. При неосложнённом течении после абсцесстонзиллэктомии пациент выписывается на 5–7-е сутки.

При отсутствии лечения или неадекватном лечении высок риск гнойных осложнений: флегмоны шеи, медиастинита, тонзиллогенного сепсиса, инфекционно-токсического шока. Риск возрастает у пациентов с иммунодефицитом (врождённым, на фоне приёма иммуносупрессоров и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции).

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для цефтриаксона в таблице 1 указано «в течение 4-14 дней до 10 дней», что содержит противоречие в сроках; на странице формулировка приведена дословно.
- Знак # у амоксициллина с сульбактамом и у детской дозы клиндамицина обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

Клинические рекомендации

Полипозный риносинусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J33.0** — Полип полости носа **J33.1** — Полипозная дегенерация синуса **J33.8** — Другие полипы синуса **J33.9** — Полип носа неуточненный
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/890_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, данных осмотра и инструментальных исследований: передней риноскопии, эндоскопии полости носа и носоглотки, компьютерной томографии (КТ) околоносовых пазух.
- Препаратом выбора является мометазон в форме назального спрея по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки курсом 3–6 месяцев. При отсутствии уменьшения симптомов в течение 5–6 недель рассматривается вопрос о хирургическом лечении.
- Системная антибактериальная терапия при полипозном риносинусите не рекомендуется.
- При тяжёлом течении, а также при сочетании с бронхиальной астмой рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия (дупилумаб, омализумаб или меполизумаб).
- При неэффективности медикаментозной терапии или распространённом полипозе показано хирургическое лечение; оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия.
- В течение первого года после операции пациента осматривают каждые 3 месяца.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Полипозный риносинусит (ПРС) является фенотипом хронического риносинусита и представляет собой гетерогенное по этиологии и патогенезу хроническое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП) продолжительностью более 12 недель, сопровождающееся ремоделированием слизистой оболочки, образованием и рецидивирующим ростом полипов.

Полипы носа представляют собой доброкачественные новообразования слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

Т2-эндотип ПРС характеризуется воспалением с эозинофилией крови или ткани либо с повышенным уровнем общего иммуноглобулина Е (IgE). К нему относятся эозинофильный хронический риносинусит, аллергический грибковый риносинусит и центральная компартментная атопическая болезнь (CCAD), то есть изолированные полипозные изменения слизистой оболочки верхней и средней носовых раковин и задневерхних отделов перегородки носа у пациентов с установленной аллергией к ингаляционным аллергенам.

2.2 Этиология и патогенез

В развитии ПРС участвуют нарушения врождённого и адаптивного иммунитета, аллергия, генетически обусловленные заболевания (иммунодефициты, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия), изменения внутриносовой анатомии, а также бактериальная, грибковая и вирусная инфекция. В совокупности или по отдельности эти факторы поддерживают хроническое воспаление слизистой оболочки носа, которое приводит к образованию полипов и рецидивам.

Эозинофильный и неэозинофильный эндотипы ПРС различаются клиническими проявлениями, течением и ответом на лечение.

Из анатомических изменений у больных риносинуситом наиболее часто встречаются искривление перегородки носа (36%), concha bullosa (30%), клетки Оноди (12%) и клетки Галлера (6%), реже парадоксальный изгиб средней носовой раковины (3%) и пневматизация крючковидного отростка (2%).

2.3 Классификация

Единая классификация отсутствует. По клиническим и эндоскопическим данным выделяют три стадии: в первой стадии полипы ограничены средним носовым ходом, во второй выходят за его пределы, в третьей обтурируют соответствующую половину носа.

Для эндоскопической оценки применяется шкала Lund–Kennedy: полипы, отёк и отделяемое оцениваются отдельно справа и слева, каждый признак от 0 до 2 баллов.

2.4 Шкала Lund–Kennedy

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Полипы	Полипы отсутствуют	Полипы в пределах среднего носового хода	Полипы распространяются за пределы среднего носового хода
Отёк	Отёк отсутствует	Умеренный отёк	Значительный отёк
Отделяемое	Отделяемое отсутствует	Прозрачное отделяемое	Густое гнойное отделяемое

Данные КТ оцениваются по шкале Lund–Mackay: снижение пневматизации каждой пазухи оценивается отдельно справа и слева в 0 баллов при отсутствии изменений, в 1 балл при частичном затенении и в 2 балла при тотальном затенении. Остиомеатальный комплекс оценивается в 0 баллов, если он интактен, и в 2 балла при его обтурации. Сумма для каждой стороны составляет от 0 до 12 баллов, общая сумма от 0 до 24.

> Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не совпадает с текстом раздела 1.5. Верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны в ней дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют. Остиомеатальный комплекс в таблице оценивается в 0, 1 или 2 балла, в тексте только в 0 или 2 балла. В строке «Общее количество баллов» справа указаны 0, 7 и 14, слева 0, 1 и 2, хотя согласно ключу под таблицей сумма составляет от 0 до 12 на сторону. Расчёт следует проводить по тексту раздела 1.5.

По гистологическому строению различают отёчные полипы с преимущественно эозинофильной инфильтрацией (70–85% клеток), фиброзные полипы с преобладанием нейтрофилов, полипы с гиперплазией серозно-слизистых желёз и полипы с атипией стромы.

2.5 Клиническая картина

Пациентов беспокоят заложенность носа, слизистые или слизисто-гнойные выделения, стекание отделяемого по задней стенке глотки, ощущение тяжести и давления в области носа и в проекции околоносовых пазух, диффузная головная боль, снижение или отсутствие обоняния. В ряде случаев присоединяются жжение и раздражение в горле, кашель, охриплость, недомогание, снижение работоспособности, сонливость. Необходимо оценить выраженность и продолжительность симптомов. При обострении симптомы усиливаются.

2.6 Жалобы и анамнез

Жалобы целесообразно разделять на группы. К назальным относятся затруднённое носовое дыхание, выделения из носа, снижение или отсутствие обоняния. К болевым относятся лицевая боль, ощущение распирания и давления в области лица, головная и зубная боль. К оро- и назофарингеальным относятся неприятный запах изо рта, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель, заложенность или боль в ушах. К системным относятся недомогание, утомляемость, снижение работоспособности. Такое разделение позволяет подтвердить диагноз, оценить степень тяжести и выявить факторы, влияющие на выбор тактики лечения.

При сборе анамнеза уточняются время и причины появления симптомов, последовательность их развития, выраженность и динамика, влияющие на них факторы, ранее проведённые обследования и лечение. Отдельно выясняются связь симптомов с сезонными или круглогодичными аллергенами, наличие непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), симптомов бронхиальной астмы, ПРС у близких родственников, одно- или двусторонний характер симптомов, рецидивирующие носовые кровотечения.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, данных физикального и инструментального обследования: передней риноскопии, эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки, КТ околоносовых пазух.

3.1 Жалобы

У всех пациентов с подозрением на ПРС и с установленным диагнозом для подтверждения диагноза и оценки степени тяжести необходимо уточнить наличие двух или более жалоб, одной из которых является заложенность носа или выделения из носа; учитываются также боль и давление в проекции околоносовых пазух, снижение или отсутствие обоняния.

Степень тяжести заболевания у всех пациентов оценивается по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Пациент оценивает выраженность симптома от 0 (симптом отсутствует) до 10 баллов (максимальная выраженность симптома). Лёгкому течению соответствуют 0–3 балла, умеренному 3–7 баллов, тяжёлому 7–10 баллов. Значимое влияние на качество жизни оказывают симптомы выраженностью 5 баллов и более.
Диагностическая специфичность повышается при сочетании двух или более субъективных симптомов с объективными признаками заболевания (данными эндоскопии носа и лучевых методов исследования).

> В комментарии к рекомендации указано, что оценка жалоб отличается высокой вероятностью ложноположительных заключений, однако приведены специфичность 89% и чувствительность 2%. Высокая специфичность, напротив, свидетельствует о малом числе ложноположительных результатов, поэтому значения, по-видимому, переставлены местами.

> Границы степеней тяжести по ВАШ в рекомендации перекрываются (0–3, 3–7 и 7–10 баллов); к какой степени относятся значения 3 и 7 баллов, не указано.

3.2 Физикальное обследование

Всем пациентам с подозрением на ПРС или с установленным диагнозом для постановки диагноза и оценки особенностей течения необходим осмотр оториноларинголога.

Значение имеют пальпация и перкуссия в проекции околоносовых пазух, признаки назальной обструкции (затруднённое носовое дыхание, гнусавость), вязкое слизистое или слизисто-гнойное отделяемое, наличие полипов. При длительном течении и распространённом процессе полипы могут визуализироваться уже в преддверии носа, в ряде случаев отмечается расширение спинки наружного носа.

Передняя риноскопия, которую выполняют всем пациентам, позволяет оценить распространённость процесса и сопутствующую внутриносовую патологию.

Для определения локализации и распространённости изменений слизистой оболочки всем пациентам проводят эндоскопическую эндоназальную ревизию полости носа и носоглотки.

Эндоскопия позволяет дифференцировать ПРС от заболеваний со сходной симптоматикой: новообразований, гипертрофии глоточной миндалины и задних концов нижних носовых раковин. В сочетании с жалобами и анамнезом метод значительно повышает точность диагностики; специфичность и чувствительность метода составляют 84% и 66% соответственно.

3.3 Инструментальные исследования

КТ околоносовых пазух необходима каждому пациенту для оценки распространённости полипоза, состояния внутриносовых структур и костных стенок пазух.

Для повторных исследований в динамике вместо мультиспиральной КТ может применяться конусно-лучевая томография носа и околоносовых пазух, поскольку она сопровождается меньшей лучевой нагрузкой и не приводит к превышению годовой дозы на одну анатомическую зону.

При подозрении на новообразование полости носа и околоносовых пазух дополнительно к КТ применяют магнитно-резонансную томографию (МРТ) околоносовых пазух.

Рентгенография околоносовых пазух дешевле и доступнее, однако при ПРС она малоинформативна по сравнению с КТ.

3.4 Лабораторные исследования

У всех пациентов операционный материал направляется на патолого-анатомическое исследование для дифференциации субтипов полипозного риносинусита.

Для выявления аллергического воспаления и выбора тактики лечения у всех пациентов выполняют цитологическое исследование отделяемого, отпечатков и мазков со слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

О выраженном аллергическом компоненте свидетельствует содержание эозинофилов более 10% в поле зрения.

3.5 Иные исследования и консультации специалистов

При подозрении на бронхиальную астму или атопию для уточнения диагноза и согласования лечения показана консультация пульмонолога и (или) аллерголога-иммунолога.

При подозрении на первичную цилиарную дискинезию исследуют скорость мукоцилиарного транспорта с помощью сахаринового теста.

---

4. Лечение

Медикаментозное и хирургическое лечение значительно и практически в одинаковой степени улучшают качество жизни при ПРС, что подтверждает приоритетное значение адекватной медикаментозной терапии.

4.1 Кортикостероиды

Кортикостероиды в форме назальных спреев применяют в качестве стартовой терапии при ограниченном полипозе, когда полипы не выходят за пределы среднего носового хода, а также в пред- и послеоперационном периоде.

Предпочтение отдаётся препаратам с высокой топической активностью и низкой биодоступностью, поскольку они безопаснее при длительном применении. Назальные кортикостероиды уменьшают размеры полипов и заложенность носа, улучшают обоняние, предупреждают рецидивы и повышают качество жизни.

При отсутствии уменьшения симптомов в течение 5–6 недель применения мометазона рассматривается вопрос о хирургическом лечении.

Системные кортикостероиды используют при гиперреактивности бронхов, бронхиальной астме, непереносимости нестероидных противовоспалительных препаратов, рефрактерном течении ПРС, выраженной атопии, а также для уменьшения воспаления в пред- и послеоперационном периоде.

Длительный или частый приём системных кортикостероидов может повышать риск нежелательных явлений и осложнений.

4.2 Дополнительная терапия

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов применяют дополнительно к системным кортикостероидам или вместо них при их непереносимости, а также при рефрактерном к кортикостероидам течении ПРС.

Системная антибактериальная терапия при ПРС не рекомендуется, поскольку доказательств её эффективности недостаточно, тогда как риски (развитие резистентности микрофлоры, анафилаксия, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта) реальны.

Применение макролидов обсуждается в связи с их иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, однако оптимальный препарат, доза и длительность терапии не определены, поэтому сделать однозначный вывод об их эффективности при ПРС не представляется возможным.

4.3 Генно-инженерная биологическая терапия

При тяжёлом течении ПРС, а также при сочетании ПРС с бронхиальной астмой для повышения эффективности лечения и снижения риска рецидивов рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия (ГИБТ): дупилумаб, омализумаб или меполизумаб.

Препараты ГИБТ представляют собой рекомбинантные человеческие или гуманизированные моноклональные антитела класса IgG, избирательно связывающие IgE, интерлейкины или субъединицы их рецепторов (ИЛ-5, ИЛ-4/13).

Биологическую терапию назначают при двустороннем полипозе и хирургических вмешательствах в анамнезе при наличии трёх из следующих критериев: признаки Т2-воспаления (эозинофилы в ткани не менее 10 в поле зрения, или в крови не менее 150 клеток/мкл, или общий IgE не менее 100 МЕ/мл); потребность в системных кортикостероидах (2 курса и более за год или приём более 3 месяцев) либо противопоказания к ним; значимое снижение качества жизни (SNOT-22 не менее 40); аносмия по результатам исследования обоняния; бронхиальная астма, требующая регулярного применения ингаляционных кортикостероидов.

Ответ на терапию оценивается по пяти критериям: уменьшение размеров полипов, снижение потребности в системных кортикостероидах, улучшение качества жизни, улучшение обоняния и уменьшение влияния сопутствующих заболеваний. Наличие 4–5 критериев соответствует хорошему ответу, 2–3 критериев умеренному ответу, 0–1 критерия слабому ответу или его отсутствию. Эффективность оценивается через 6 месяцев и через год. При отсутствии ответа диагноз пересматривают, лечение прекращают и при необходимости переходят на другой препарат.

Лечение является длительным, при его прерывании возможен рецидив. Во время беременности препараты применяются только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В период грудного вскармливания решение о прекращении кормления или отмене препарата принимается с учётом пользы того и другого.

Решение о продолжении терапии принимается врачом с учётом тяжести заболевания и степени контроля обострений.

4.4 Режимы дозирования

Препарат	Доза
Мометазон, назальный спрей	По 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс 3–6 месяцев. После достижения эффекта — по 2 впрыскивания в каждую половину носа 1 раз в сутки (200 мкг в сутки).
Преднизолон	Коротким курсом при недостаточном контроле симптомов назальными кортикостероидами: внутрь, в таблетках, 30–60 мг в сутки в течение 14 дней.

Препарат	Доза
Дупилумаб	Подкожно 300 мг (2 мл раствора 150 мг/мл) 1 раз в 2 недели, с 18 лет. При пропуске введения лечение возобновляется как можно скорее; у пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Омализумаб	Подкожно 75–600 мг 1 раз в 2 или 4 недели; доза и кратность введения определяются исходным уровнем IgE и массой тела и корректируются при значительном изменении массы тела.
Меполизумаб	Взрослым с плохо контролируемым тяжёлым ПРС — подкожно 100 мг 1 раз в 4 недели, длительно.

4.5 Хирургическое лечение

К хирургическому лечению для восстановления носового дыхания прибегают при неэффективности медикаментозной терапии, а также при распространённом полипозе полости носа и околоносовых пазух.

Оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ), включающая удаление полипозно изменённой слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, восстановление проходимости естественных соустий и коррекцию анатомических нарушений (как правило, септопластику и (или) резекцию носовых раковин, а также резекцию решётчатой буллы) под видеоэндоскопическим контролем.
В зависимости от выраженности изменений объём вмешательства может быть ограничен минимально инвазивными методиками, обеспечивающими дренирование и аэрацию околоносовых пазух.

Всем пациентам перед операцией рекомендованы кортикостероиды в форме назальных спреев, что позволяет уменьшить кровопотерю, улучшить обзор операционного поля и сократить продолжительность вмешательства.

Результат хирургического лечения во многом определяется предоперационной медикаментозной подготовкой.

4.6 Послеоперационное ведение

После любого хирургического вмешательства необходима комплексная реабилитация, направленная на восстановление носового дыхания и функции слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.

Реабилитация включает охранительный режим продолжительностью 10–14 дней и более, санацию полости носа и околоносовых пазух под эндоскопическим контролем в режиме «ирригация–аспирация» в раннем послеоперационном периоде, бережное удаление плотных продуктов воспаления и фибрина для профилактики образования синехий. При избытке вязкого отделяемого или наличии корок проводится орошение полости носа 0,9% раствором натрия хлорида, что улучшает контакт местных препаратов со слизистой оболочкой.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с ПРС подлежат диспансерному наблюдению у оториноларинголога для своевременного выявления ухудшения на фоне лечения или рецидива после операции и коррекции терапии.

Специфическая профилактика ПРС отсутствует. При применении назальных кортикостероидов в течение 6–12 месяцев в пред- и послеоперационном периоде у большинства пациентов отмечаются уменьшение выраженности воспаления, улучшение качества жизни, снижение частоты рецидивов и увеличение продолжительности ремиссии.

Кратность осмотров определяется индивидуально, однако в течение первого года после операции осматривают каждые 3 месяца. При рецидиве, требующем повторного хирургического вмешательства, и при подозрении на осложнённое течение показана КТ околоносовых пазух.

Пациентам с ПРС необходимо ежедневное применение назальных кортикостероидов, нередко в течение всей жизни с небольшими перерывами.

> Длительность применения назальных кортикостероидов в рекомендации указана по-разному: курс мометазона 3–6 месяцев (раздел 3.1), в пред- и послеоперационном периоде 6–12 месяцев (раздел 5), в разделе 7 ежедневно, нередко в течение всей жизни.

Наблюдение оториноларинголога должно быть систематическим, не реже одного раза в 3 месяца. Результат лечения зависит не только от операции и опыта хирурга, но и от приверженности пациента лечению и выполнения им рекомендаций.

> В разделе 5 указано, что кратность обследований определяется индивидуально, а осмотры каждые 3 месяца необходимы в течение первого года после операции. В разделе 7 и в информации для пациента указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.

Основной задачей является комплексное лечение, обеспечивающее контроль симптомов и улучшение качества жизни. В ряде случаев необходимы повторные щадящие эндоскопические вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах.

При сопутствующей бронхиальной астме показано также наблюдение аллерголога-иммунолога.

5.1 Показания к госпитализации

Обследование и лечение пациентов могут проводиться как амбулаторно, так и в условиях стационара.

Показанием к плановой госпитализации является проведение ФЭРСХ с одномоментной коррекцией внутриносовых структур или без неё при отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению. Плановая госпитализация в дневной или круглосуточный стационар возможна также для подбора и коррекции терапии и для проведения ГИБТ.

Выписка после операции возможна при удовлетворительном общем состоянии и улучшении или восстановлении носового дыхания.

Согласно алгоритму ведения пациента (приложение Б), после диагностики пациент с аллергией или бронхиальной астмой направляется к аллерголог-иммунологу или пульмонологу. При отсутствии показаний к операции наблюдение и лечение осуществляются амбулаторно; при отрицательной динамике, как и при наличии показаний, показана госпитализация в специализированный стационар для ФЭРСХ с последующим продолжением наблюдения и медикаментозного лечения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Полипозный риносинусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	`890_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не соответствует тексту раздела 1.5: верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют, остиомеатальный комплекс оценивается в 0–1–2 балла вместо 0 или 2, а строка «Общее количество баллов» (0–7–14 и 0–1–2) не соответствует сумме от 0 до 12 на сторону.
- В комментарии о жалобах указана высокая вероятность ложноположительных заключений, однако приведены специфичность 89% и чувствительность 2%; по смыслу значения переставлены.

- Границы степеней тяжести по ВАШ перекрываются: 0–3, 3–7 и 7–10 баллов.
- Длительность применения назальных кортикостероидов указана по-разному: 3–6 месяцев (раздел 3.1), 6–12 месяцев (раздел 5), ежедневно, нередко в течение всей жизни (раздел 7).
- Кратность наблюдения в разделе 5 определяется индивидуально, с осмотрами каждые 3 месяца в течение первого года после операции; в разделе 7 указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.
- Назальные кортикостероиды перед операцией рекомендованы дважды с разными уровнями: в разделе 3.1 УУР C, УДД 5, в разделе 3.2 УУР B, УДД 2.
- В оглавлении подраздел «Физикальное обследование» пронумерован как 2.1 вместо 2.2, а приложение А3.1 указано на странице 30, то есть раньше приложения А3 на странице 31.

Клинические рекомендации

Травма носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.3** — Поверхностная травма носа **S01.2** — Открытая рана носа **S02.2** — Перелом костей носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/815_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Для выявления перелома костей носа взрослым и детям с 3 лет выполняют рентгенографию костей лицевого скелета в боковой проекции; чувствительность метода не превышает 70%, поэтому отсутствие изменений на рентгенограмме не исключает перелома.
- При гематоме или абсцессе перегородки носа показаны вскрытие и дренирование с последующей передней тампонадой и ежедневными перевязками до прекращения отделяемого.
- При травматической деформации носа показаны репозиция костей и фиксация отломков. Раннюю операцию выполняют в первые 7 суток; при тяжёлом состоянии или выраженном отёке вмешательство может быть отложено до 15 суток.
- При изолированном переломе, в том числе открытом, рутинное назначение системных антибиотиков не показано. Антибактериальную терапию применяют при загрязнённых и гнойных ранах, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки носа, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.
- При повреждении кожи или слизистой оболочки и загрязнении раны землёй необходима экстренная профилактика столбняка в максимально ранние сроки, но не позднее 20-го дня после травмы.
- Показаниями к госпитализации являются тяжёлое состояние, кровотечение, выраженный отёк или болевой синдром, деформация носа со смещением перегородки, осложнения травмы, тяжёлая сопутствующая патология, приём антикоагулянтов или антиагрегантов, а также необходимость закрытой репозиции.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Травма носа представляет собой повреждение носа в результате прямого или опосредованного воздействия травмирующего фактора снаружи или изнутри, сопровождающееся нарушением целостности тканей и структур наружного носа и полости носа и нарушением функций носа.

Поверхностной называется травма наружного носа без повреждения кожи, костей носа и слизистой оболочки полости носа и без неврологической симптоматики.

Ушиб носа является закрытым повреждением тупым предметом без видимого нарушения целостности кожи и слизистых оболочек, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием. При кровоподтёке кровь пропитывает мягкие ткани наружного носа, тогда как гематома представляет собой скопление крови в ограниченной полости. Ссадиной называется повреждение поверхностного слоя кожи с визуально определяемым местом размозжения кожных сосудов.

Перелом костей носа (ПКН) характеризуется частичным или полным нарушением целостности носовых костей, лобных отростков верхней челюсти, перегородки носа или носовой ости. Перелом считается закрытым при сохранённой целостности кожи носа и открытым, если отломки сообщаются с внешней средой через рану.

Раной носа называется повреждение кожи наружного носа на всю глубину, часто с обнажением хрящей и костей и более глубоких структур полости носа, в ряде случаев с отрывом крыла или кончика носа.

2.2 Механизм травмы

При ударе во фронтальной плоскости возникает перелом носовых костей с западением спинки носа. Боковой удар может приводить к разъединению носовой кости и лобного отростка верхней челюсти с формированием сколиоза наружного носа, однако чаще линия перелома проходит выше шва между ними. Как правило, одновременно возникает перелом перегородки носа, чаще её хрящевого отдела.

У детей младшего возраста кости наружного носа эластичны, поэтому переломы встречаются редко, а гематома и абсцесс перегородки носа чаще.

При переломе нередко происходит разрыв и отслойка надхрящницы или надкостницы перегородки, кровь скапливается между хрящом и надхрящницей, и формируется гематома перегородки носа. При её инфицировании развивается абсцесс, четырёхугольный хрящ расплавляется, что приводит к деформации носа и нарушению его функций.

Травма носа может быть изолированной или сочетаться с повреждением околоносовых пазух, глаза, скуловой области, нижней челюсти, полости рта, ушной раковины, сотрясением или ушибом головного мозга.

2.3 Классификация

Общепринятая классификация переломов отсутствует. Согласно классификации Ю. Н. Волкова (1958), выделяют открытые и закрытые переломы, переломы без деформации и с деформацией наружного носа.

Согласно классификации С. Б. Бесшапочного (1984), переломы подразделяются на переломы без деформации и с деформацией наружного носа; последние могут быть одно- и двусторонними, с боковым смещением отломков, со смещением кзади или с сочетанием обоих видов смещения.

Согласно классификации А. С. Лопатина (2019), выделяют изолированные и сочетанные, открытые и закрытые переломы; переломы со смещением подразделяются по направлению удара на латеральные, фронтальные, фронтолатеральные и базальные.

По распространённости выделяют изолированные переломы (с деформацией наружного носа или без неё), комбинированные (с травмой кожи лица, внутриносовых структур или околоносовых пазух) и сочетанные (с челюстно-лицевой или черепно-мозговой травмой, травмой конечностей, туловища и внутренних органов).

В течении перелома со смещением выделяют три стадии. Острая стадия охватывает первые 14 дней; в этот период кости репонируют по стандартной методике. Застарелый перелом соответствует сроку от двух недель до двух месяцев; репозиция возможна только в сочетании с операцией на перегородке носа. Стойкая деформация констатируется при давности травмы более двух месяцев; сопоставление отломков возможно только после остеотомии.

2.4 Клиническая картина

Поверхностная травма характеризуется слабо выраженными проявлениями: в месте удара отмечаются боль, небольшая припухлость и умеренная гиперемия кожи без нарушения её целостности.

При ушибе пирамида носа увеличена в объёме, контуры её сглажены за счёт отёка; при кровоподтёке и ссадине изменены цвет и целостность кожи; при переломе пирамида носа смещена в сторону или вдавлена; при гематоме перегородка носа утолщена, носовые ходы сужены. Возможны носовое кровотечение, боль и болезненность при пальпации, нарушение дыхания и обоняния. При сочетанной травме отмечаются также отёки, кровоподтёки, гематомы и раны других областей, нарушения зрения и сознания.

Перелом характеризуется отёком, болью, деформацией наружного носа, крепитацией и подвижностью отломков, носовым кровотечением и затруднением носового дыхания.

У детей с переломом деформация носа вследствие выраженного отёка определяется лишь в 57,5% случаев. Кроме того, у 7,4% детей деформация имелась до травмы.

При переломе нередко повреждены кожа носа и слизистая оболочка полости носа, возможны эмфизема мягких тканей носа и лица, экхимозы. Носовое кровотечение встречается часто, однако при неосложнённом изолированном переломе обильное и рецидивирующее кровотечение отмечается редко.

Перелом часто сопровождается кровоизлиянием в веки и мягкие ткани орбиты («симптом очков»), однако этот же симптом наблюдается при переломе переднего основания черепа и травме кавернозного синуса.

Крепитация и подвижность отломков выявляются менее чем в половине случаев, поэтому их отсутствие не исключает перелома. Болевой синдром в области носа также неспецифичен и встречается при ушибах и воспалительных заболеваниях носа.

2.5 Жалобы и анамнез

Необходимо выяснить обстоятельства и механизм травмы, направление удара, наличие потери сознания. Уточняются перенесённые ранее травмы носа с деформацией и операции на носу. При комбинированной травме с повреждением кожи следует уточнить прививочный анамнез в отношении столбняка. При общем осмотре оцениваются артериальное давление, пульс и частота дыхания.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании факта травмы со слов пострадавшего или очевидцев; жалоб на боль, изменение формы носа, затруднение дыхания, кровотечение и нарушение обоняния; данных осмотра: повреждения кожи, деформация, крепитация и подвижность отломков, кровотечение. Перелом подтверждается рентгенографией костей лицевого скелета, при противопоказаниях ультразвуковым исследованием (УЗИ) костей носа. При сочетанной травме для выявления повреждений околоносовых пазух, орбиты, скуловой кости, верхней челюсти и черепа необходимы рентгенография черепа и компьютерная томография (КТ).

3.1 Физикальное обследование

Каждого пациента с травмой носа осматривает оториноларинголог для определения характера и выраженности повреждений.

Всем пациентам показана пальпация челюстно-лицевой области для уточнения характера травмы и выраженности повреждений.

При осмотре фиксируются отёк, гематомы, ссадины и раны, наличие и выраженность деформации. При пальпации выявляются крепитация отломков, подкожная эмфизема и гематома, оцениваются область носового клапана, подвижность крыльев носа и подвижной части перегородки. Для врачебной и судебно-медицинской экспертизы важна фотофиксация повреждений.

3.2 Лабораторные исследования

При травме, сопровождающейся кровотечением, исследуют коагулограмму для оценки системы гемостаза и кровопотери и подготовки к возможному хирургическому вмешательству.

3.3 Инструментальные исследования

Взрослым и детям с 3 лет для выявления костных повреждений выполняется рентгенография костей лицевого скелета.

Рентгенограмма в боковой проекции имеет как диагностическое, так и юридическое значение: в 70,2% случаев она позволяет выявить перелом и характер смещения отломков. Как правило, повреждаются обе носовые кости, однако встречаются одиночные и множественные переломы, поэтому для уточнения стороны перелома боковые снимки выполняют в положении головы на левой и на правой стороне.

Чувствительность рентгенографии при переломе костей носа не превышает 70%, смещение во фронтальной плоскости на боковом снимке не визуализируется. У детей до 3 лет исследование малоинформативно вследствие слабой оссификации и преобладания хрящевой ткани. Поэтому отрицательный результат не исключает перелома.

При подозрении на смещение отломков в переднезаднем направлении и отсутствии изменений на боковом снимке взрослым и детям с 3 лет показана рентгенография околоносовых пазух.

Смещение отломков снаружи внутрь, не определяемое на боковых снимках, выявляется на рентгенограмме околоносовых пазух в носоподбородочной проекции.

При комбинированной и сочетанной травме черепа показана КТ лицевого отдела черепа или челюстно-лицевой области и (или) КТ головного мозга.

Показаниями к КТ являются комбинированные и сочетанные переломы, признаки черепно-мозговой травмы (ЧМТ), неинформативность рентгенографии при клинических признаках перелома, планирование расширенного вмешательства, подозрение на назальную ликворею, тяжёлое состояние, продолжающееся или рецидивирующее носовое кровотечение. Область исследования определяется сопутствующей патологией.

Чувствительность КТ при переломе приближается к 100%. Исследование выполняют в режиме спирального сканирования с толщиной среза 3 мм; оно позволяет оценить положение отломков, состояние перегородки носа, повреждения околоносовых пазух, орбиты, мозгового черепа, мягких тканей и головного мозга. Перед операцией рекомендуется 3D-реконструкция.

При противопоказаниях к лучевым методам выполняется УЗИ костей носа.

УЗИ является простым неинвазивным методом, не сопряжено с лучевой нагрузкой и может выполняться повторно для контроля репозиции и сращения отломков. Исследование выполняют в четырёх проекциях: передней продольной, передней поперечной, правой и левой боковой.

3.4 Консультации специалистов

При подозрении на повреждение органа зрения необходима консультация офтальмолога.

Всем пациентам с травмой носа рекомендуется консультация невролога для своевременного выявления сопутствующей патологии.

При массивном кровотечении и сочетанной травме регистрируют электрокардиограмму (ЭКГ) для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и планирования лечения.

---

4. Лечение

Консервативное лечение направлено на уменьшение болевого синдрома и отёка, профилактику бактериального воспаления в зоне повреждения, ускорение заживления и восстановление функций носа.

4.1 Обезболивание

Всем пациентам при отсутствии противопоказаний назначаются анальгетики.

Выраженный болевой синдром и травматический стресс способствуют развитию или утяжелению травматического шока.

Применяются анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по отдельности или в сочетании; у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде, рекомендуется сочетание НПВП с парацетамолом, а также метамизол натрия. Из НПВП у детей допустимо применение ибупрофена с 3 месяцев и кетопрофена с 15 лет, кетопрофена в гранулах для приготовления раствора с 6 лет. Метамизол натрия детям амбулаторно не назначают, в стационаре применяют только при отсутствии других разрешённых детям анальгетиков в связи с риском серьёзных нежелательных явлений.

4.2 Анальгетики у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г внутривенно, инфузия 15 минут	4 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 мг внутримышечно (в таблице рекомендации указано «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно, внутримышечно	6 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м», то есть единица измерения приведена неверно; с учётом структуры таблицы и максимальной суточной дозы 150 мг речь идёт о 75 мг.

4.3 Анальгетики у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия 15 минут: масса тела менее 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; более 50 кг — 1000 мг	4 ч	Менее 10 кг — до 30 мг/кг; 10–50 кг — до 60 мг/кг, но не более 2 г (для 33–50 кг в той же ячейке указано не более 3 г); более 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 суток
Парацетамол ректально	3–12 месяцев — 50–100 мг; 1–3 года — 100–150 мг; 3–5 лет — 150–200 мг; 5–10 лет — 250–350 мг; 10–14 лет — 350–500 мг	6 ч	до 60 мг/кг	до 5 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Ибупрофен внутрь	3–6 месяцев — 50 мг; 6–12 месяцев — 50 мг; 1–3 года — 100 мг; 4–6 лет — 150 мг; старше 6 лет — 200–400 мг	6–8 ч (в ячейке указано также «8 ч» без пояснения)	3–6 месяцев — 150 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 1–3 года — 300 мг; 4–6 лет — 450 мг; 6–12 лет — 800 мг; 12–17 лет — 1 г	4 суток
Ибупрофен ректально	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	3–9 месяцев — 8 ч; 9–24 месяца — 6 ч	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	не более 3 суток
Метамизол натрия	С 15 лет — 500–1000 мг внутривенно, внутримышечно; 2–14 лет — 50–100 мг/кг внутримышечно, внутривенно; от 3 месяцев до года — 50–100 мг на 10 кг внутримышечно	8–12 ч	с 15 лет — 2 г	1–5 суток; детям младше 15 лет — 3 суток

В таблице 3 имеются несогласованности. Для внутривенного парацетамола весовые диапазоны пересекаются: для массы тела 33–50 кг указана максимальная суточная доза 3 г, для 10–50 кг 2 г. Для метамизола натрия детям 2–14 лет указана доза 50–100 мг/кг, детям до года 50–100 мг на 10 кг, то есть в 10 раз меньше в пересчёте на килограмм массы тела. Дозы следует сверить с инструкцией по медицинскому применению.

4.4 Профилактика столбняка и антибактериальная терапия

При повреждении кожи или слизистой оболочки, если травма получена при ударе о землю или в рану попала почва, показано введение вакцины для профилактики столбняка.

Экстренную профилактику выполняют в максимально ранние сроки, вплоть до 20-го дня после травмы, с учётом инкубационного периода столбняка. Она включает первичную хирургическую обработку раны и одновременное введение столбнячного анатоксина, противостолбнячного иммуноглобулина человека или столбнячного антитоксина в соответствии с инструкцией.

При изолированном переломе костей носа, в том числе открытом, рутинное назначение системных антибиотиков до и после операции не рекомендуется.

Профилактическое применение антибиотиков не снижает риск инфекционных осложнений после репозиции костей носа ни у взрослых, ни у детей.

Системные антибиотики назначаются при загрязнённых и гнойных ранах кожи и слизистой оболочки, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки носа, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.

При явном бактериальном воспалении или высоком риске его развития применяют препараты широкого спектра действия из группы бета-лактамов: цефазолин, цефтриаксон, ампициллин с сульбактамом, амоксициллин с клавулановой кислотой. При аллергии на бета-лактамы применяется клиндамицин.
Ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой обладают более широкой, чем цефазолин, активностью в отношении грамотрицательных и анаэробных бактерий.

Препарат	Доза
Ампициллин и сульбактам	Внутримышечно и внутривенно. Взрослым в зависимости от тяжести инфекции 3–12 г в сутки в 3 введения, детям — 150 мг/кг в сутки в 3 введения (новорождённым — в 2), в течение 5–14 дней.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутривенно. Взрослым и детям старше 12 лет — по 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, детям младше 12 лет — 25 мг/кг 3 раза в сутки, в течение 5–14 дней.

4.5 Противоотёчная, гемостатическая и местная терапия

При выраженном отёке взрослым и детям старше 15 лет назначаются ангиопротекторы, что позволяет выполнить репозицию отломков в более ранние сроки и предупредить осложнения.

Троксерутин (взрослым и детям старше 15 лет) или гель гепарина натрия наносится местно на спинку носа на неповреждённую кожу 2 раза в день до регресса отёка.

При обильном кровотечении, а также для профилактики интра- и послеоперационного кровотечения назначаются гемостатические средства.

Кровотечение возможно из полости носа и из повреждённых мягких тканей при открытых ранах. Механическая остановка кровотечения, как правило, дополняется назначением гемостатиков: этамзилата, транексамовой или аминокапроновой кислоты.

Препарат	Взрослые	Дети
Этамзилат	Для остановки кровотечения — 250–500 мг внутривенно или внутримышечно, затем по 250 мг каждые 4–6 часов. При репозиции — 250–500 мг за час до операции, при необходимости 250–500 мг во время операции и 500–750 мг равномерно в течение суток после неё.	10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней. Во время операции — 8–10 мг/кг внутривенно, затем 10–15 мг/кг в течение суток.
Транексамовая кислота	Внутривенно капельно или медленно струйно со скоростью 1 мл/мин (50 мг/мин), 10–15 мг/кг каждые 6–8 часов до остановки кровотечения.	Старше 1 года — 20 мг/кг в сутки до остановки кровотечения.
Аминокапроновая кислота	Внутривенно капельно: 4–5 г за первый час, при продолжающемся кровотечении — по 1 г в час не более 8 часов; при необходимости инфузии повторяются каждые 4 часа; не более 30 г в сутки. Курс 3–14 дней.	100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг в час; не более 18 г/м² в сутки (до года — 3 г, 2–6 лет — 3–6 г, 7–10 лет — 6–9 г, старше 10 лет — как взрослым). При острой кровопотере: до года — 6 г, 2–4 года — 6–9 г, 5–8 лет — 9–12 г, 9–10 лет — 18 г.

> Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере превышают указанные рядом максимальные суточные дозы: например, до года 6 г при максимуме 3 г, в 9–10 лет 18 г при максимуме 6–9 г.

Всем пациентам для облегчения носового дыхания назначаются деконгестанты и другие назальные препараты.

Сосудосуживающие спреи и капли уменьшают реактивный отёк слизистой оболочки после травмы и облегчают носовое дыхание после операции.

Препарат	Доза
Фенилэфрин 0,125%	Интраназально: до года — 1 капля, 1–6 лет — 1–2 капли, старше 6 лет — 3–4 капли до 3 раз в сутки, до 7 дней.
Оксиметазолин	До года — 0,01%, 1–6 лет — 0,025%, старше 6 лет — 0,05%; по 1–2 капли интраназально 2–3 раза в сутки, до 5 дней.
Ксилометазолин	2–6 лет — 0,05%, старше 6 лет — 0,1%; спрей по 1 дозе 2–3 раза в сутки, до 5 дней.

При повреждении кожи или слизистой оболочки с признаками инфицирования раны или высоким риском инфицирования назначаются местные антисептики.

Применяются бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (в форме спрея не применяется у детей до 3 лет), повидон-йод и хлоргексидин. Кратность обработки раны определяется выраженностью воспаления и количеством экссудата; обработку продолжают до разрешения инфекции или начала заживления.

Всем пациентам показано промывание полости носа для ускорения заживления слизистой оболочки.

Уход за полостью носа после травмы и операции ускоряет заживление и предупреждает осложнения, например синехии. Применяются стерильные изотонические растворы морской воды 2–3 раза в день до эпителизации слизистой оболочки и стихания воспаления.

4.6 Хирургическое лечение

Неотложные мероприятия при травме носа включают остановку кровотечения и первичную хирургическую обработку открытых ран. При переломе хирургическое лечение направлено на восстановление формы наружного носа, устранение смещения внутриносовых структур и восстановление дыхания.

При открытых ранах и открытых переломах выполняется хирургическая обработка раны с иссечением инфицированных тканей и наложением косметического шва.

Перед наложением шва необходимы тщательная ревизия раны, удаление инородных тел и зондирование раневого канала.

При неэффективности гемостатической терапии и тампонады показана хирургическая остановка кровотечения.

Метод определяется источником кровотечения. При кровотечении из передних отделов применяют отслойку участка мукоперихондрия с последующей тампонадой, выскабливание расширенного сосуда, криокоагуляцию или электрокаустику. При обильном кровотечении показаны перевязка наружной сонной артерии, эндоскопическое клипирование сосудов или эндоваскулярная эмболизация. При кровотечении из решётчатых артерий прибегают к этмоидотомии наружным, внутренним или эндоназальным доступом.

При гематоме или абсцессе перегородки носа показаны вскрытие и дренирование.

После вскрытия выполняют переднюю тампонаду, перевязки проводят ежедневно до прекращения отделяемого.

При травматической деформации наружного носа показаны репозиция костей и фиксация отломков для восстановления формы носа и носового дыхания.

Различают раннюю операцию (в первые 7 суток после травмы), отложенную (на 8–15-е сутки) и плановую (через 6 месяцев и позднее).

Ранняя операция показана при минимальном или умеренном отёке, а также при комбинированной травме с повреждением внутриносовых структур или околоносовых пазух и при гематоме перегородки носа. Раннее вмешательство позволяет избежать септических осложнений и синехий.

При тяжёлом состоянии, выраженном отёке, комбинированных переломах костей и перегородки носа и ранениях лица операция может быть отложена до 15 суток.

> Согласно классификации в разделе 1.5, острая стадия, в которой репозиция костей выполняется по стандартной методике, продолжается 14 дней, а по истечении двух недель репозиция возможна только в сочетании с операцией на перегородке носа. В разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.

Плановое хирургическое лечение переломов (риносептопластика) показано при сочетанной травме с переломом основания черепа и назальной ликвореей, а также при тяжёлых функциональных нарушениях.

Кости репонируют наружным (пальцевым), эндоназальным (инструментальным) или экстраназальным (открытым) способом. У детей наружный способ эффективен лишь в 22% случаев, поэтому предпочтительна эндоназальная репозиция элеваторами Манакова или Волкова с последующей передней тампонадой. Открытый способ применяется при одновременном хирургическом вмешательстве по поводу внутричерепной травмы или травмы лобных пазух и верхней челюсти.

При комбинированных назосептальных переломах в остром периоде репозицию костей сочетают с септопластикой. При сочетанной травме репозицию предпочтительно проводить совместно с хирургами других специальностей, если вмешательство выполняется под наркозом.

При подозрении на черепно-мозговую травму репозиция откладывается до осмотра невролога или нейрохирурга и проведения необходимых исследований.

4.7 Анестезия, тампонада и фиксирующая повязка

При операциях по поводу открытых и закрытых переломов и смещения внутриносовых структур проводится анестезия наружного носа и полости носа.

Взрослым при изолированной травме применяют аппликационную анестезию слизистой оболочки полости носа в сочетании с внутримышечным введением анальгетиков или проводниковую анестезию артикаином. Детям рекомендуется сочетанная анестезия.

При переломах костей наружного носа и внутриносовых структур выполняется передняя тампонада для удержания сопоставленных отломков и остановки кровотечения при травме слизистой оболочки.

Тампон вводится на стороне деформации и удаляется на 2–3-и сутки после операции; срок определяется подвижностью отломков. Преимущества длительной тампонады (более 3–5 дней) после репозиции не доказаны.

При переломах, сложных травмах и после операций накладывается пращевидная повязка для профилактики смещения отломков.

Наружная шина после закрытой репозиции рутинно не применяется и показана только при тяжёлых оскольчатых переломах.

При выраженных реактивных воспалительных явлениях показана консультация физиотерапевта.

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области и магнитотерапия уменьшают воспаление и отёк и ускоряют заживление.

На период лечения пациенту рекомендуются ограничение физической активности, исключение действий, способных привести к смещению отломков, в том числе во сне, полноценное витаминизированное легкоусвояемое питание; приём горячей ванны, душа, посещение сауны и бассейна не рекомендуются.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

После операций по поводу деформации наружного носа или перегородки носа пациент в течение года находится под наблюдением оториноларинголога; обязательные осмотры назначают через 1, 3 и 6 месяцев и через год после операции.

Профилактика травм основана на общих социальных мерах предупреждения травматизма.

К ним относятся соблюдение техники безопасности в детских учреждениях, на производстве и в быту, разъяснительная работа с родителями и пропаганда здорового образа жизни.

5.1 Показания к госпитализации

Показаниями к госпитализации являются тяжёлое состояние, выраженный отёк, кровотечение, выраженный болевой синдром; комбинированные переломы костей и перегородки носа с повреждением околоносовых пазух и ранениями лица; травматическая деформация носа со смещением перегородки или нарушением дыхания; тяжёлая сопутствующая патология; приём антикоагулянтов или антиагрегантов; осложнения (гематома и абсцесс перегородки носа, воспаление околоносовых пазух и соседних областей); необходимость закрытой репозиции.

Пациент выписывается при удовлетворительном состоянии и нормальных клинических показателях, улучшении формы носа и носового дыхания и отсутствии осложнений.

Прогноз благоприятный при проведении лечения в соответствии с рекомендациями и выполнении пациентом назначений врача.

Пациенту разъясняется, что при выраженном отёке лица, деформации носа, повреждении мягких тканей, носовом кровотечении или нарушении дыхания необходима экстренная консультация оториноларинголога, поскольку запоздалое лечение может привести к опасным осложнениям.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`815_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 1.4 коды МКБ записаны с лишней точкой («S.00.3», «S.02.2», «S.02.20», «S.02.21»); на титульном листе коды указаны правильно (S00.3, S02.2 и т. д.).
- В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м» вместо миллиграммов.
- В таблице 3 для внутривенного парацетамола пересекаются весовые диапазоны с разными максимальными суточными дозами (33–50 кг: 3 г; 10–50 кг: 2 г); для метамизола натрия доза у детей 2–14 лет (50–100 мг/кг) в 10 раз больше в пересчёте на килограмм, чем у детей до года (50–100 мг на 10 кг). Для ибупрофена внутрь в графе интервала указаны одновременно «6–8 ч» и «8 ч» без пояснения.
- Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере (до года 6 г, в 9–10 лет 18 г) превышают указанные рядом максимальные суточные дозы (3 г и 6–9 г).
- Острая стадия перелома в разделе 1.5 составляет 14 дней, тогда как в разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.
- Критерии качества требуют выполнения рентгенографии или КТ у всех пациентов, тогда как рентгенография рекомендована только с 3 лет.
- В рекомендации о коагулограмме указано «система гомеостаза» вместо «гемостаза»; в оглавлении номера страниц разделов 6, 7 и критериев качества не совпадают с текстом.

Клинические рекомендации

Хронический синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J32.0** — Хронический верхнечелюстной синусит **J32.1** — Хронический фронтальный синусит **J32.2** — Хронический этмоидальный синусит **J32.3** — Хронический сфеноидальный синусит **J32.4** — Хронический пансинусит **J32.8** — Другие хронические синуситы **J32.9** — Хронический синусит неуточненный **J34.1** — Киста или мукоцеле носового синуса
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/955_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз хронического синусита у взрослых устанавливается при наличии двух и более симптомов на протяжении 12 недель и более, одним из которых является заложенность носа или выделения из носа; диагноз подтверждается эндоскопическими признаками или изменениями по данным компьютерной томографии (КТ).
- Основой консервативного лечения являются промывание полости носа солевым раствором, показанное всем пациентам, и интраназальные глюкокортикостероиды с 12 лет; для оценки эффекта глюкокортикостероидов длительность их применения должна составлять не менее 3 месяцев.
- К системной антибактериальной терапии прибегают только при среднетяжёлом и тяжёлом обострении или осложнениях; стартовым препаратом в амбулаторной практике является амоксициллин с клавулановой кислотой.
- Взрослым при неэффективности 1–2 курсов адекватной консервативной терапии показана функциональная риносинус-хирургия.
- При случайном выявлении бессимптомной кисты околоносовой пазухи большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку многие кисты медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.
- Мукоцеле характеризуется медленным ростом, растягивает, а в ряде случаев разрушает стенку пазухи, поэтому его во всех случаях удаляют хирургически.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический синусит (хронический риносинусит, ХРС) характеризуется воспалением слизистой оболочки околоносовых пазух длительностью более 12 недель, сопровождающимся двумя и более симптомами. Одним из них является заложенность носа или выделения из носа (передние или стекающие в носоглотку); к нему могут присоединяться боль или ощущение давления в области лица, снижение или потеря обоняния.

Ретенционные (истинные, секретирующие) кисты околоносовых пазух образуются в результате закупорки выводных протоков желёз слизистой оболочки; их стенки имеют двустороннюю выстилку мерцательным цилиндрическим эпителием. Лимфоэктатические (несекретирующие, ложные, интрамуральные) кисты располагаются в толще слизистой оболочки, не имеют внутренней эпителиальной выстилки и возникают вследствие хронического воспаления в пазухах или баротравмы.

Мукоцеле представляет собой доброкачественное, медленно растущее кистовидное образование околоносовой пазухи. Оно формируется при стойком нарушении дренажной функции естественного соустья пазухи и часто вызывает растяжение, реже разрушение её стенок.

2.2 Этиология

С развитием ХРС ассоциированы аллергический ринит, первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, бронхиальная астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), иммунодефицитные состояния и системные аутоиммунные заболевания.

Важным фактором риска являются анатомические особенности в области остиомеатального комплекса: искривление перегородки носа, буллёзная или парадоксально изогнутая средняя носовая раковина, гиперпневматизация решётчатой буллы, супрабуллярной или инфраорбитальной клетки, аномалии крючковидного отростка, добавочное соустье верхнечелюстной пазухи. Эти особенности нарушают вентиляцию полости носа и отток секрета из полости носа и околоносовых пазух. У детей, значительно реже у взрослых, ХРС может быть связан с гипертрофией аденоидов.

У детей, особенно дошкольного возраста, основной причиной ХРС является муковисцидоз, реже первичная цилиарная дискинезия. По данным отечественных исследований, связь между ХРС и искривлением перегородки носа у детей не выявлена.

Предрасполагающим фактором может являться также аллергический отёк слизистой оболочки в области среднего носового хода; аллергический ринит и хронический синусит часто сочетаются.

Одонтогенный синусит связан с заболеваниями зубов и стоматологическим лечением. Хронический верхнечелюстной синусит может быть осложнением периодонтита или пародонтита; частой причиной является эндодонтическое лечение, при котором инфицированный детрит или пломбировочный материал попадает в пазуху через корневые каналы. Причиной воспаления в пазухе может быть также дентальная имплантация с предшествующим наращиванием костной ткани. При одонтогенном синусите среди возбудителей преобладают анаэробы.

ГЭРБ также может способствовать развитию ХРС: попадание рефлюктата на слизистую оболочку полости носа и носоглотки вызывает воспаление и нарушение мукоцилиарного клиренса, что может привести к блоку остиомеатального комплекса.

Важным фактором риска является курение: табак оказывает токсическое действие на слизистую оболочку полости носа, вызывает её сухость и изменяет свойства слизи.

Связь ретенционных кист с воспалительными заболеваниями полости носа и травмами не доказана. Лимфоэктатические кисты в большинстве случаев обусловлены хроническим, прежде всего аллергическим, воспалением слизистой оболочки; риск их развития повышают гипервентиляция верхнечелюстной пазухи и баротравма. Радикулярная одонтогенная киста развивается из эпителиальной гранулёмы у верхушки корня кариозного зуба; зубная киста может оттеснять дно верхнечелюстной пазухи или прорастать в неё; фолликулярная киста развивается очень медленно из зубного фолликула.

Мукоцеле в подавляющем большинстве случаев является следствием операций на околоносовых пазухах; к другим причинам относятся травма, хроническое воспаление пазух, опухоли и лучевая терапия. Более чем в трети случаев причину установить не удаётся; описаны также врождённые мукоцеле. У детей мукоцеле чаще всего развивается вследствие вторичного хронического синусита при муковисцидозе.

2.3 Классификация

По локализации, с указанием стороны поражения, выделяют верхнечелюстной, этмоидальный, фронтальный и сфеноидальный синусит. Воспаление пазух только одной стороны обозначается как гемисинусит, поражение нескольких пазух как полисинусит.

В клинической практике хронический синусит принято подразделять на полипозный риносинусит и синусит без полипов.

По этиологии выделяют бактериальный, грибковый и бактериально-грибковый синусит.

Тяжесть течения оценивается по суммарной выраженности симптомов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10: выделяют лёгкую (0–3 балла), среднетяжёлую (4–7 баллов) и тяжёлую (8–10 баллов) форму.

> Классификация по тяжести содержит ссылку на приложение Г1, однако в нём описана ВАШ только для оценки интенсивности боли и с другой градацией: значение до 2 см соответствует слабой боли, 2–4 умеренной, 4–6 сильной, 6–8 сильнейшей, до 10 невыносимой. Способ подсчёта суммарной выраженности симптомов в рекомендации не указан.

Классификация EPOS 2020 года основана на эндотипах и фенотипах. Первичный синусит может быть односторонним (локализованным), с воспалением 2-го типа или не 2-го типа (сюда же относят аллергический грибковый синусит и изолированный синусит одной пазухи), и двусторонним (диффузным) с теми же двумя эндотипами, эозинофильным или неэозинофильным. Вторичный односторонний синусит связан с одонтогенным процессом, мицетомой («грибковым шаром») или опухолью. Вторичный двусторонний синусит может быть механическим, воспалительным и иммунным; к его фенотипам относятся первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, гранулематоз с полиангиитом, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом и селективный иммунодефицит.

В России кисты околоносовых пазух, как правило, классифицируются по М. И. Кадымовой: выделяют ретенционные, лимфоэктатические, одонтогенные (радикулярные) кисты верхнечелюстной пазухи и кисты, связанные с пороками развития.

Более 90% кист локализуются в верхнечелюстной пазухе, около 5% в клиновидной пазухе, в лобной пазухе и клетках решётчатого лабиринта кисты встречаются крайне редко. Более чем в 80% случаев киста односторонняя; множественные кисты выявляются лишь у четверти пациентов.

Мукоцеле чаще всего поражает лобные пазухи, реже клетки решётчатого лабиринта, верхнечелюстные и клиновидные пазухи; ряд авторов считает наиболее частой лобно-решётчатую локализацию. Описаны также крайне редкие локализации: нижняя стенка орбиты, крыловидное пространство, средняя и нижняя носовые раковины.

2.4 Клиническая картина

Клиническая картина ХРС неспецифична: заложенность носа, выделения из носа и стекание по задней стенке глотки, головная или лицевая боль, снижение или отсутствие обоняния, ощущение неприятного запаха в носу. Основными симптомами, в наибольшей степени влияющими на самочувствие пациента, являются заложенность носа и выделения. У детей ключевым симптомом может быть также кашель, связанный со стеканием слизи по задней стенке глотки. Хронический синусит отличается от острого сохранением симптомов более 12 недель без полного их разрешения.

Кисты околоносовых пазух часто протекают бессимптомно и выявляются случайно при лучевом исследовании головы. Крупная киста чаще всего вызывает головную или лицевую боль, редко внезапное истечение из носа жидкости янтарного цвета при самопроизвольном разрыве кисты, онемение верхней губы или зубную боль. Заложенность носа, выделения и кашель вследствие стекания слизи у пациента с кистой, вероятнее всего, обусловлены сопутствующим аллергическим ринитом или ХРС.

Клинические проявления мукоцеле зависят от его локализации и размера. Основными симптомами являются головная боль, ощущение давления в области лица, заложенность носа, выделения из носа, боль в периорбитальной области. Небольшое мукоцеле может протекать бессимптомно, однако значительно реже, чем киста.

2.5 Жалобы и анамнез

Взрослые пациенты предъявляют жалобы на стойкую одностороннюю или попеременную заложенность носа, слизистые или слизисто-гнойные выделения, необходимость сморкания или стекание слизи по задней стенке глотки (более выраженное после пробуждения или постоянное в течение дня), неприятный запах в полости носа или носоглотке, снижение обоняния вплоть до аносмии. При хроническом сфеноидите отмечается периодическая боль в теменной и затылочной областях.

Для хронического фронтита характерна выраженная боль в проекции лобной пазухи на стороне поражения при обострении или при перемене атмосферного давления. Возможно ощущение давления за спинкой носа и глазными яблоками, усиливающееся при обострении.

У детей младшего возраста жалобы выясняются у родителей или опекунов: частые затяжные «насморки», заложенность носа, слизистые выделения, кашель, преимущественно ночью или в положении лёжа на спине.

При выявлении кистоподобного образования по данным лучевых исследований в первую очередь уточняется наличие головной или лицевой боли, её постоянный характер, провоцирующие и усиливающие её факторы. Выясняются перенесённые ранее операции на полости носа и околоносовых пазухах и стоматологическое лечение.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

У взрослых диагноз хронического синусита устанавливается при наличии двух и более симптомов на протяжении 12 недель и более, одним из которых является заложенность носа, затруднение носового дыхания или выделения из носа (передние или стекающие по задней стенке глотки); к ним могут присоединяться боль или ощущение распирания в проекции пазух, снижение или потеря обоняния. Диагноз подтверждается эндоскопическими признаками (полипы, слизисто-гнойные выделения или отёк и обструкция слизистой оболочки, преимущественно в среднем носовом ходе) и изменениями слизистой оболочки остиомеатального комплекса или пазух по данным КТ.

У детей для постановки диагноза необходимы два и более из четырёх симптомов на протяжении 12 недель и более: затруднение носового дыхания, боль или ощущение распирания в проекции пазух, выделения из носа или стекание по задней стенке глотки, кашель. Эндоскопические признаки и изменения по данным КТ аналогичны таковым у взрослых.

Диагноз кисты околоносовой пазухи устанавливается по данным КТ или магнитно-резонансной томографии (МРТ): округлое однородное мягкотканное образование на широком основании с чёткими границами, без деструкции кости и выраженной деформации стенок. Дифференцировать ретенционную и лимфоэктатическую кисту возможно только гистологически, по оболочке удалённой кисты.

Диагноз одонтогенной кисты верхнечелюстной пазухи устанавливается по данным КТ (однородное образование на широком основании на нижней стенке пазухи с чёткими границами, оболочкой костной плотности и связью с корнями верхних зубов) с учётом заключения стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга о заболевании соседних зубов.

Диагноз мукоцеле устанавливается по данным КТ: образование в пазухе с округлым ровным контуром и однородным содержимым без кальцинатов и включений; возможны истончение прилежащих костных структур и пролабирование образования в соседние анатомические области.

3.2 Физикальное обследование и консультации специалистов

Всем пациентам с хроническим синуситом, а также с подозрением на кисту или мукоцеле необходим осмотр оториноларинголога с оценкой общего состояния, сбором жалоб и анамнеза, планированием лечения.

При отягощённом аллергологическом анамнезе необходима консультация аллерголога пациентам с хроническим синуситом, а взрослым также при подозрении на кисту или мукоцеле.

При симптомах рефлюкса рекомендуется консультация гастроэнтеролога.

При признаках муковисцидоза или первичной цилиарной дискинезии необходима консультация генетика.

При подозрении на одонтогенный синусит или кисту верхнечелюстной пазухи пациента направляют к стоматологу-хирургу или челюстно-лицевому хирургу для подтверждения или исключения одонтогенной причины.

3.3 Лабораторные исследования

При среднетяжёлом и тяжёлом течении, а также при обострении выполняют бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности для выбора или коррекции антибактериальной терапии.

Оптимальным материалом для исследования является аспират непосредственно из поражённой пазухи, полученный при пункции верхнечелюстной пазухи или интраоперационно.

3.4 Инструментальные исследования

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки выполняют всем пациентам с предполагаемым хроническим синуситом для оценки состояния синоназальных структур и подтверждения диагноза.

Спиральную КТ околоносовых пазух применяют при признаках осложнений во время обострения, перед хирургическим вмешательством и при необходимости дифференциальной диагностики.

КТ является наиболее информативным методом как у взрослых, так и у детей. Метод позволяет выявить изолированное воспаление, блок соустья, инородное тело, диффузный грибковый процесс или мицетому, опухоль, аномалии развития пазух, заподозрить одонтогенную причину. Типичными признаками ХРС являются утолщение слизистой оболочки и снижение пневматизации в области соустий.
Для планирования объёма операции КТ выполняется не ранее чем за 6 месяцев до вмешательства.

Спиральная КТ околоносовых пазух необходима всем пациентам с подозрением на кисту, выявленную другим методом и сопровождающуюся постоянными или периодическими симптомами, а также всем пациентам с подозрением на мукоцеле.

При затруднении дифференциальной диагностики мукоцеле с другими образованиями КТ выполняется с внутривенным болюсным контрастированием: контрастное вещество накапливается в оболочке мукоцеле, но не в его содержимом.

---

4. Лечение

Этиологических факторов ХРС много, и они могут действовать одновременно, поэтому лечение подбирается каждому пациенту индивидуально.

Основой консервативного лечения является медикаментозная терапия; по показаниям она может назначаться и после функциональной риносинус-хирургии.

Доказательства эффективности консервативного лечения кист и мукоцеле околоносовых пазух отсутствуют; уменьшение симптомов возможно лишь при эффективности медикаментозной терапии сопутствующего ХРС или аллергического ринита.

4.1 Базовая терапия

Всем пациентам с ХРС рекомендуется промывание полости носа гипертоническим или изотоническим солевым раствором, что обеспечивает очищение полости носа и уменьшает антигенную нагрузку на слизистую оболочку.

Промывание полости носа имеет важное значение и в составе послеоперационного лечения.

Пациентам старше 12 лет для уменьшения выраженности симптомов применяют интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС).

Единая схема дозирования, кратности и длительности применения отсутствует; допустимо применение как низких, так и высоких доз. Для оценки эффекта лечение продолжается не менее 3 месяцев.

Носовые кровотечения вследствие сухости слизистой оболочки чаще отмечаются при применении высоких доз. Официально зарегистрированное показание при хроническом риносинусите имеется только у назального спрея мометазона: взрослым и детям старше 12 лет по 2 дозы (100 мкг) в каждую половину носа 2 раза в сутки, что составляет 400 мкг в сутки.

4.2 Системная антибактериальная терапия

Системную антибактериальную терапию назначают при среднетяжёлом и тяжёлом обострении, в том числе с периорбитальными и внутричерепными осложнениями, а также при таком обострении у пациентов с заболеваниями, повышающими риск бактериальной инфекции.

Препарат	Показания и режим дозирования
Амоксициллин и клавулановая кислота	Стартовый препарат при обострении в амбулаторной практике у детей и взрослых. Детям от 3 месяцев до 12 лет или с массой тела менее 40 кг — 40 мг/кг в сутки в 3 приёма каждые 8 часов (суспензии 125/31,25 мг и 250/62,5 мг в 5 мл); суспензия 400/57 мг в 5 мл назначается по 45 мг/кг в сутки в 2 приёма. При высоком риске полирезистентного пневмококка — суспензия 600/42,9 мг в 5 мл, 90 мг/кг в сутки по амоксициллину в 2 приёма. Пациентам с массой тела более 40 кг и старше 12 лет — таблетки 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	При лёгкой аллергии на пенициллины. Детям младше 12 лет или с массой тела менее 50 кг — 8 мг/кг в сутки в 1 приём; старше 12 лет — 400 мг 1 раз в сутки.
Цефиксим, цефтриаксон, цефотаксим	При неэффективности амоксициллина с клавулановой кислотой. Старше 12 лет или с массой тела от 50 кг: цефиксим внутрь 400 мг 1 раз в сутки, цефтриаксон внутривенно или внутримышечно 1–2 г 1 раз в сутки, цефотаксим внутривенно или внутримышечно 1 г каждые 12 часов. Детям младше 12 лет или с массой тела менее 50 кг: цефиксим 8 мг/кг в сутки в 1 приём, цефтриаксон 75–80 мг/кг в сутки в 1 введение, цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 2–4 введения.
#Левофлоксацин, #моксифлоксацин	Только взрослым пациентам в амбулаторных условиях при непереносимости всех бета-лактамов или тяжёлой аллергии на пенициллины: #левофлоксацин 500 мг внутрь 1 раз в сутки или #моксифлоксацин 400 мг внутрь 1 раз в сутки, курс 10–14 дней. Знак # обозначает применение вне инструкции.

Лечение детей с обострением, требующим системной антибактериальной терапии, при невозможности назначения пенициллинов предпочтительно проводить в условиях стационара; препарат выбирается с учётом тяжести, локализации и распространённости воспаления и чувствительности выделенного возбудителя.

При неэффективности стартового антибиотика в амбулаторных условиях следует решить вопрос о направлении пациента в оториноларингологическое отделение стационара в неотложном порядке. В стационаре при среднетяжёлом течении предпочтителен пероральный приём препаратов, при его невозможности парентеральное введение; при тяжёлом, в том числе осложнённом, обострении антибиотики вводятся внутривенно.

При неэффективности цефалоспоринов III поколения или выделении устойчивых к ним штаммов переходят на препарат резерва (цефалоспорин IV поколения, карбапенем, оксазолидинон, гликопептид и другие) с учётом чувствительности возбудителя.

Эффект антибактериальной терапии должен проявиться на третьи сутки; при наличии эффекта препарат применяется в течение 10–14 дней.

4.3 Местная антибактериальная терапия

При лёгком обострении у пациентов, ранее перенёсших синусотомию, при появлении гнойных выделений используют местные антибактериальные препараты.

Эффект оценивается через 3–4 дня; при его отсутствии решается вопрос о системной антибактериальной терапии. В России для лечения ХРС зарегистрированы назальный спрей фрамицетина (для детей с первых лет жизни) и комбинированный спрей, содержащий дексаметазон, неомицин, полимиксин B и фенилэфрин (с 2,5 лет). Разовая и суточная дозы должны строго соответствовать инструкции. При обострении фрамицетин применяется не более 7 дней, комбинированный препарат не более 10 дней.
Введение в полость носа и околоносовые пазухи растворов антибиотиков, предназначенных для внутримышечного и внутривенного введения, не допускается: они не адаптированы для этой цели и оказывают повреждающее действие на мерцательный эпителий. Для введения в пазуху может применяться тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат.

4.4 Дополнительная терапия

При обострении и отсутствии противопоказаний для более быстрого регресса симптомов рекомендованы растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием.

Эффективны комбинированные препараты, содержащие экстракты корня горечавки жёлтой, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины чёрной и травы вербены, а также миртол.

При обострении для облегчения оттока секрета из пазух применяют сосудосуживающие капли или спреи в нос.

Нафазолин обладает выраженным токсическим действием, и его применение в оториноларингологической практике не допускается. Предпочтительны оксиметазолин 0,01–0,05% и ксилометазолин 0,05–0,1%. Препараты применяются строго по назначению и под контролем врача, не более 5–7 дней, поскольку более длительное применение приводит к развитию медикаментозного ринита.

Муколитические препараты используют для разжижения отделяемого и облегчения его оттока.

Карбоцистеин назначается коротким курсом, до 2–3 недель, при обострении с густым секретом в полости носа; возможны также курсы продолжительностью около 3 месяцев в сочетании с противовоспалительными средствами. Одновременное назначение карбоцистеина с другими отхаркивающими и муколитическими средствами, в том числе местными, не рекомендуется, поскольку при этом усиливается стекание слизи по задней стенке глотки.

При повышении температуры тела, головной или лицевой боли в период обострения рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол.

Детям до 6 лет допустимо применение только парацетамола (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофена (до 30 мг/кг в сутки).

4.5 Хирургическое лечение

При тяжёлом обострении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, оперируют в неотложном или экстренном порядке. При среднетяжёлом обострении и неэффективности консервативного лечения возможно проведение малоинвазивных манипуляций в неотложном порядке. Остальным пациентам хирургическое лечение выполняют в плановом порядке по показаниям; при отсутствии показаний или наличии противопоказаний ограничиваются консервативным лечением и наблюдением оториноларинголога.

Под функциональной риносинус-хирургией в рекомендации понимаются фронтотомия, этмоидотомия, сфеноидотомия, гайморотомия и вмешательства на структурах полости носа. У взрослых при наличии соответствующего оснащения предпочтительна эндоскопическая техника; у детей при плановом вмешательстве она обязательна.

Кисты и неосложнённые мукоцеле оперируют в плановом порядке, как правило, теми же методами функциональной риносинус-хирургии; при кистах верхнечелюстной пазухи и мукоцеле лобной пазухи в ряде случаев используются микрогайморотомия и фронтотомия через переднюю стенку.

При тяжёлом обострении хронического верхнечелюстного синусита, а при среднетяжёлом в случае неэффективности консервативного лечения показана пункция пазухи для её дренирования.

Через пункционную иглу промывают пазуху раствором антисептика, удаляют секрет и вводят антибиотик.

Пункция допустима только при наличии результатов лучевого исследования, исключающих гипоплазию и ателектаз верхнечелюстной пазухи и подтверждающих скопление в ней секрета.

При тяжёлом обострении пункция часто не заменяет санирующую операцию. Детям пункцию выполняют только в условиях стационара.

Для дренирования возможны установка синус-катетера или зондирование пазух через естественные соустья.

Взрослым при неэффективности 1–2 курсов адекватной консервативной терапии показана функциональная риносинус-хирургия для восстановления аэрации пазух, устранения симптомов и предотвращения осложнений.

> В тексте рекомендации имеется расхождение: в рекомендации о хирургическом лечении взрослых показанием является неэффективность 1–2 курсов консервативной терапии, тогда как в разделе 6 показанием к плановой госпитализации для операции названа неэффективность адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев.

Детям с хроническим синуситом и гипертрофией аденоидов III степени при неэффективности консервативного лечения в течение 3–6 месяцев первым этапом удаляют аденоиды.

Вмешательство планируют при отсутствии противопоказаний, предпочтительно под общим обезболиванием в условиях оториноларингологического отделения или стационара кратковременного пребывания; при наличии соответствующего оснащения вмешательство проводится под эндоскопическим контролем.

Детям со среднетяжёлым и тяжёлым ХРС при неэффективности лечения в течение 3–6 месяцев, если гипертрофия аденоидов исключена или удаление аденоидов выполнено более 6 месяцев назад, показана функциональная эндоскопическая риносинус-хирургия.

Операция плановая. Вмешательство не нарушает рост пазух и лицевого скелета, однако у детей выше риск рубцевания и повторного стенозирования, а малые размеры анатомических структур требуют современного оборудования.

Детям с изолированным поражением пазухи выполняют эндоскопическое дренирование пазухи.

Операцию выполняют независимо от состояния аденоидов при наличии на КТ отграниченного тотального или субтотального затемнения одной пазухи или резкого снижения её пневматизации в сочетании с типичными жалобами. У детей необходима онкологическая настороженность в отношении любого образования, выявленного по данным КТ, за исключением кист с чёткими типичными признаками, не увеличивающихся в размерах.

Киста околоносовой пазухи, сопровождающаяся постоянными или периодическими симптомами, подлежит эндоскопическому удалению с опорожнением кисты и полным или частичным удалением её оболочки.

При случайном выявлении бессимптомной кисты большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку кисты, за исключением одонтогенных, часто медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.

Мукоцеле у всех пациентов дренируют эндоскопически.

При лобной локализации методом выбора считается эндоскопическая марсупиализация с передней этмоидэктомией и фронтотомией по Драфу. При латеральном расположении мукоцеле, дефекте передней стенки лобной пазухи и большом мукоцеле с распространением в полость черепа используется наружный доступ.

4.6 Иное лечение

Пациенты с вторичным ХРС, у которых изменения в полости носа и околоносовых пазухах являются проявлением другого заболевания, находятся под наблюдением и получают лечение у профильного специалиста. Лечение одонтогенных кист верхнечелюстной пазухи осуществляют совместно со стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Послеоперационное ведение

После операции все пациенты находятся под амбулаторным наблюдением оториноларинголога для оценки состояния полости носа и своевременного выявления поздних осложнений.

Первый осмотр проводится через 7–14 дней после выписки, далее повторно несколько раз в течение года для контроля течения заболевания и своевременной коррекции лечения. Осмотры необходимы для контроля состояния полости носа (при неадекватном уходе образуются корки и синехии), выявления и предупреждения осложнений, а также для выполнения манипуляций при необходимости.

В течение месяца после операции пациенту необходимо соблюдать щадящий режим и избегать факторов, повышающих давление и способных спровоцировать кровотечение: интенсивных физических нагрузок, перегревания и переохлаждения. Для профилактики острой респираторной инфекции рекомендуется избегать мест массового скопления людей и по возможности больше времени проводить дома.

5.2 Профилактика

Первичная профилактика направлена на защиту от неблагоприятных факторов внешней среды, вторичная на максимально раннее выявление заболевания. Профилактике хронического синусита способствуют своевременное лечение заболеваний зубов и гастроэзофагеального рефлюкса, отказ от курения и соблюдение техники безопасности при работе с веществами, вредными для дыхательных путей.

Профилактикой мукоцеле является соблюдение принципов функциональной хирургии при операциях на полости носа и околоносовых пазухах, профилактикой лимфоэктатических кист своевременное лечение хронического воспаления в полости носа, радикулярных кист своевременное лечение верхних зубов.

Пациенту разъясняется, что полное излечение хронического синусита затруднительно, однако выраженность симптомов может быть уменьшена; как правило, требуется пожизненный контроль, а тактику лечения определяет оториноларинголог, в ряде случаев совместно с другими специалистами.

Важное значение имеет изменение образа жизни: отказ от курения или по крайней мере уменьшение количества выкуриваемых сигарет, а при аллергии соблюдение гипоаллергенного быта. Необходимы также приверженность лечению, соблюдение режима дозирования, правильная техника введения препаратов и промывания полости носа.

5.3 Показания к госпитализации

Лечение пациентов с хроническим синуситом, кистами и мукоцеле осуществляет прежде всего оториноларинголог, при необходимости совместно с аллергологом-иммунологом, гастроэнтерологом, ревматологом, стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом. Консервативное лечение и лечение лёгких обострений осуществляются в амбулаторных условиях.

Показаниями к экстренной госпитализации в оториноларингологическое отделение являются внутричерепные или внутриглазничные осложнения, тяжёлое обострение, а также среднетяжёлое обострение при неэффективности амбулаторного лечения в течение 5–7 дней или прогрессирующем ухудшении состояния в любые сроки.

Показаниями к плановой госпитализации для хирургического лечения являются подтверждённый хронический синусит, резистентный к адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев; рецидив симптомов после операции; сохранение жалоб и признаков синусита у детей после удаления аденоидов; изолированное воспаление с субтотальным или тотальным снижением пневматизации по данным КТ на протяжении более 2 месяцев; подозрение на новообразование пазухи неясного характера; «синдром молчащего синуса» верхнечелюстной пазухи по данным КТ; киста с постоянными или периодическими симптомами и мукоцеле.

Пациент выписывается после выполнения операции в запланированном объёме при удовлетворительном общем состоянии и отсутствии местного или системного острого инфекционно-воспалительного процесса.

5.4 Прогноз

Эффективность лечения зависит от индивидуальных анатомических особенностей полости носа и околоносовых пазух, наличия хронических системных заболеваний, активного и пассивного курения, профессиональных вредностей, климатических и экологических условий, а также от приверженности пациента лечению.

Одонтогенные кисты не регрессируют самостоятельно, и их лечением совместно занимаются несколько специалистов.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический синусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	955_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки хирургического лечения у взрослых расходятся: в рекомендации о функциональной риносинус-хирургии операция показана после 1–2 неэффективных курсов консервативной терапии, в показаниях к плановой госпитализации (раздел 6) после 6 месяцев неэффективной терапии.
- Классификация по тяжести (0–3, 4–7, 8–10 баллов суммарной выраженности симптомов) ссылается на приложение Г1, в котором описана ВАШ только для оценки боли и с другой градацией.
- В определении указана длительность симптомов «более 12 недель», в критериях диагноза «12 недель и более» (≥12 недель).

- Удаление аденоидов в рекомендации обозначено как «аденоидэктомия», в комментарии к ней как «аденотомия».
- В комментарии об антибактериальной терапии у детей повторяется оборот «в случае невозможности применения при невозможности применения».
- В оглавлении разделы «Хирургическое лечение» и «Иное лечение» пронумерованы как «3.» вместо 3.2 и 3.3.

Клинические рекомендации

Хронический средний отит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.2** — Хронический серозный средний отит **H65.3** — Хронический слизистый средний отит **H65.4** — Другие хронические негнойные средние отиты **H66.1** — Хронический туботимпанальный гнойный средний отит **H66.2** — Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит **H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты **H72.0** — Центральная перфорация барабанной перепонки **H90.0** — Кондуктивная потеря слуха двусторонняя **H90.1** — Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.2** — Кондуктивная потеря слуха неуточненная **H90.6** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя **H90.7** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя, с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.8** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/698_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Основным методом лечения хронического гнойного среднего отита является хирургический, и каждый пациент с этим заболеванием рассматривается как потенциальный кандидат на операцию. Оперируют в период ремиссии, не ранее чем через 3–6 месяцев после последнего обострения.
- При диагностике всем пациентам выполняют тональную пороговую аудиометрию, позволяющую определить степень и вид тугоухости и прогнозировать результат операции. При порогах костной проводимости выше 30 дБ в диапазоне разговорных частот качественного улучшения слуха не следует ожидать даже после безупречно выполненной операции.
- При подозрении на холестеатому или её рецидив показана магнитно-резонансная томография (МРТ) височных костей: в режимах Т1, Т2 и диффузионно-взвешенных изображений метод позволяет отличить холестеатому от секрета, грануляций и холестероловой гранулемы.
- В консервативном лечении основная роль принадлежит местным средствам: антисептикам, ушным каплям с противомикробными препаратами и кортикостероидами. Топические фторхинолоны не обладают ототоксичностью и допустимы при перфорации барабанной перепонки. Местное лечение эффективно только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.
- Неоперированные пациенты осматриваются раз в 6 месяцев, пациенты после тимпанопластики или санирующей операции ежегодно на протяжении не менее 5 лет; это позволяет своевременно выявить рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) характеризуется хроническим воспалением полостей среднего уха со стойкой перфорацией барабанной перепонки, постоянным или периодическим гноетечением из уха и прогрессирующим снижением слуха на протяжении более 3 месяцев.

Мукозитом называется хроническое катаральное воспаление слизистой оболочки среднего уха. Тимпаносклероз является необратимым исходом неспецифического воспаления и сопровождается тугоухостью вследствие фиксации звукопроводящей цепи. Тимпанофиброз представляет собой незавершённый процесс, при котором в барабанной полости фиброзирование преобладает над воспалением. Холестеатома является белесовато-перламутровым эпидермальным образованием с оболочкой (матриксом), покрытой многослойным плоским эпителием; матрикс плотно прилежит к кости и нередко врастает в неё.

2.2 Этиология

У взрослых ХГСО развивается на фоне хронических заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, после перенесённых острых средних отитов, при системной и специфической патологии. Пусковым фактором, как правило, является острый средний отит, после которого сохраняется стойкая перфорация или ретракция с атрофичной неомембраной, а также травматическая или ятрогенная перфорация; после врачебных манипуляций перфорация сохраняется у 1,3–10,8% пациентов.

Хронизации процесса способствуют анатомические особенности среднего уха и слуховой трубы, неадекватная антибактериальная терапия острого отита без дренирования среднего уха, устойчивые штаммы возбудителей, ретракция после острого отита, экссудативный средний отит, снижение местной иммунной защиты, а также заболевания носоглотки и полости носа, нарушающие мукоцилиарный клиренс слуховой трубы.

Ведущим возбудителем среди аэробов является синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), второе место по значимости занимает золотистый стафилококк. Из анаэробов чаще высеваются пептококки и пептострептококки, реже бактероиды; анаэробная флора чаще сопутствует холестеатоме. В 1,4–20% случаев выявляется грибковая флора, как правило Aspergillus и Candida.

2.3 Классификация

Согласно МКБ-10 выделяют две формы ХГСО: мезотимпанит (туботимпанальный отит) и эпитимпанит (эпитимпано-антральный отит). При мезотимпаните поражается преимущественно слизистая оболочка мезо- и гипотимпанума, при эпитимпаните процесс распространяется из эпитимпанума на клетки сосцевидного отростка и вовлекает костные структуры среднего уха.

Согласно клинико-морфологической классификации хронический средний отит подразделяется на неперфоративный и перфоративный. К неперфоративным формам относятся экссудативный и адгезивный (рубцовый) отит, отит с тимпаносклерозом или тимпанофиброзом; к перфоративным формам относятся сухой отит, отит с мукозитом, с тимпаносклерозом или с холестеатомой.

Расположение перфорации отражает лишь преимущественную локализацию воспалительного процесса и не позволяет судить об изменениях в среднем ухе: даже при мезотимпаните разрушение цепи слуховых косточек выявляется у 10–22% пациентов, а холестеатома в барабанной полости у 11,6–42%. Поэтому для планирования операции необходима диагностика этих изменений.

Классификация Европейской академии отологии и нейроотологии и Японского отологического общества (EAONO/JOS) выделяет 4 типа холестеатомы (врождённая холестеатома, холестеатома ненатянутой части, холестеатома натянутой части барабанной перепонки и вторичная холестеатома при перфорации натянутой части) и 4 стадии: 1-я стадия соответствует поражению одного региона, 2-я стадия поражению двух и более регионов, 3-я стадия наличию внечерепного осложнения, 4-я стадия наличию внутричерепного осложнения. Регионы обозначаются по системе STAM: труднодоступные зоны (надтубарный и тимпанальный синусы), барабанная полость, аттик и сосцевидный отросток.

2.4 Клиническая картина

Пациенты предъявляют жалобы на снижение слуха и шум в ухе; при отоскопии определяется перфорация барабанной перепонки с отделяемым или холестеатомой.

Мезотимпанит характеризуется перфорацией в натянутой части барабанной перепонки и встречается у 48–69% больных ХГСО. Эта форма считается относительно благоприятной, поскольку признаки активной остеодеструкции отсутствуют.

Эпитимпанит встречается у 15–19% больных; перфорация располагается в ненатянутой части барабанной перепонки, в среднем ухе протекает кариозный процесс, способный привести к лабиринтным и внутричерепным осложнениям. В 79–97% случаев деструкция кости обусловлена холестеатомой. Ретракционный карман рассматривается как начальная стадия холестеатомы: в 80% случаев она развивается именно из него.

Эпимезотимпанит выявляется у 17–33% пациентов и сочетает признаки обеих форм.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании совокупности жалоб, данных анамнеза, физикального обследования, лабораторных и инструментальных исследований.

3.1 Жалобы и анамнез

Необходимо уточнить наличие снижения слуха на одно или оба уха.

Снижение слуха отмечается у 93–99% пациентов, чаще двустороннее. При длительном течении заболевания с формированием тимпаносклероза, тимпанофиброза и ретракционного кармана тугоухость становится выраженной.

Следует уточнить длительность, частоту и характер выделений из уха.

Оторея является второй по значимости жалобой и встречается у 76–100% пациентов. Около половины пациентов отмечают выделения 1–2 раза в год после переохлаждения, попадания воды в ухо или острого респираторного заболевания (ОРЗ), почти треть указывает на частые или постоянные выделения в последние годы. Характер выделений варьирует от скудных слизистых до гнойных с ихорозным запахом.
Редкие обострения на фоне выраженной тугоухости характерны для тимпаносклероза, тимпанофиброза и холестеатомы, постоянное отделяемое характерно для мукозита, гнойное отделяемое с неприятным запахом характерно для холестеатомы. Опасность эпитимпанита заключается в длительном бессимптомном течении.

Необходимо уточнить наличие шума в одном или обоих ушах.

Шум в ухе беспокоит 19–48% пациентов. Низкочастотный шум, как правило, связан с дефектом барабанной перепонки, высокочастотный шум связан с поражением внутреннего уха. При тимпаносклерозе и тимпанофиброзе шум усиливается.

Следует уточнить наличие заложенности, ощущения жидкости и дискомфорта в ухе.

Подобные жалобы чаще встречаются при сохранённой натянутой части барабанной перепонки.

Необходимо выяснить, отмечались ли эпизоды головокружения в анамнезе.

Системное головокружение или неустойчивость встречаются у 10–27% больных с холестеатомой и возникают при обострении, нагрузке, наклонах и поворотах головы. В половине случаев эти симптомы свидетельствуют о фистуле лабиринта. При деструкции стенки канала лицевого нерва возможен его парез.

Следует уточнить наличие головной боли.

Головная боль различной локализации часто возникает при обострении. Для неосложнённого эпитимпанита боль в ухе и головная боль не характерны; их появление, как правило, свидетельствует о развитии осложнения.

3.2 Физикальное обследование

Всем пациентам показана отоскопия или видеоотоскопия; при ХГСО этот метод наряду с отоэндоскопией является определяющим в диагностике.

Оцениваются состояние барабанной перепонки (тонкая, утолщённая, рубцовая, очаги тимпаносклероза), наличие и глубина ретракционных карманов, размер и локализация перфорации, состояние её краёв, слизистая оболочка барабанной полости (мукозит, тимпаносклероз, полипы, грануляции, эпидермизация), доступные осмотру слуховые косточки (кариес, лизис), латеральная стенка аттика и адитус.

3.3 Степени мукозита по данным отоскопии

Степень	Изменения слизистой оболочки
I	Слизистая оболочка медиальной стенки барабанной полости утолщена, свободное отделяемое отсутствует
II	Подушкообразное утолщение слизистой оболочки медиальной стенки с большим количеством слизистых желёз, скудное слизистое отделяемое
III	Выраженная полиповидная гиперплазия слизистой оболочки мезогипотимпанума, слизистое отделяемое

При отоэндоскопии холестеатома визуализируется в 61% случаев. При эпитимпаните перфорация может быть точечной, определяться только при продувании, прикрываться серной коркой или временно отсутствовать в период стойкой ремиссии; в этих случаях необходим тщательный осмотр латеральной стенки аттика для выявления даже минимальной деструкции. В ряде случаев заболевание протекает под маской рецидивирующего экссудативного отита, и за прозрачным экссудатом определяется холестеатомный мешок при небольшом ретракционном кармане в ненатянутой части. Для осмотра глубоких карманов применяются эндоскопы с углом обзора 0°, 30° и 70°.

Распознать фистулу лабиринта позволяет фистульная проба.

Проходимость слуховой трубы оценивается с помощью пустого глотка, пробы Тойнби, приёма Вальсальвы или продувания баллоном Политцера. Чем более выражен мукозит, тем хуже вентиляционная и дренажная функции слуховой трубы. Дисфункция слуховой трубы может объяснять ретракцию барабанной перепонки до операции и в отдалённом послеоперационном периоде и учитывается при хирургическом лечении и реабилитации. При нормальной функции слуховой трубы у пациента с хроническим серозным отитом следует заподозрить спонтанную отоликворею.

Необходима оценка состояния полости носа, околоносовых пазух и носоглотки: искривление перегородки носа, гипертрофический ринит, хронические заболевания околоносовых пазух и носоглотки нарушают функцию слуховых труб и снижают эффективность лечения.

3.4 Исследование слуха

При подозрении на снижение слуха показано камертональное исследование слуха.

Количественные (камертоны С128–2048) и качественные (С128–512) пробы Ринне, Федериче и Вебера являются скрининговым методом, позволяющим определить вид тугоухости (кондуктивная или сенсоневральная) и хуже слышащее ухо. По их результатам составляется слуховой паспорт; они же служат показанием к тональной пороговой аудиометрии.

При диагностике ХГСО показана тональная пороговая аудиометрия (ТПА).

ТПА позволяет точно определить степень и вид тугоухости (кондуктивная, смешанная или нейросенсорная) и возможности реабилитации, прогнозировать результат операции и контролировать его в отдалённом периоде. При порогах костной проводимости выше 30 дБ в диапазоне разговорных частот качественного улучшения слуха не следует ожидать даже после идеально выполненной операции. Динамику предпочтительно оценивать на одном и том же аудиометре, исследование должен проводить один и тот же специалист.

Для ХГСО характерна кондуктивная и смешанная тугоухость; её степень зависит от величины дефекта барабанной перепонки, целостности и подвижности цепи слуховых косточек и токсического воздействия воспалительного процесса на внутреннее ухо. Глухота при ХГСО часто обусловлена фистулой лабиринта вследствие деструкции кости холестеатомой.

По данным аудиометрии холестеатому распознать невозможно: костно-воздушный интервал не коррелирует с характером разрушения цепи слуховых косточек, а холестеатома и грануляции сами могут проводить звук к внутреннему уху.

3.5 Инструментальные исследования

При ХГСО без холестеатомы для оценки сосцевидного отростка может быть выполнена рентгенография височных костей в укладках по Шюллеру и Майеру.

К нему прибегают только при отсутствии подозрения на холестеатому и осложнённое течение.

Пациентам с ХГСО показана компьютерная томография (КТ) височных костей для оценки их структур.

КТ является методом первичной диагностики. Исследование позволяет оценить распространённость процесса и анатомические особенности (низкое стояние дна средней черепной ямки, высокое стояние луковицы яремной вены, предлежание сигмовидного синуса, дегисценции канала лицевого нерва и лабиринта, перегородка Кёрнера), а также состояние стенок барабанной полости и антромастоидального отдела, цепи слуховых косточек, слизистой оболочки и узких пространств барабанной полости. Исследование выполняют в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией; оптимальная толщина среза составляет 0,5–0,8 мм.

КТ выявляет признаки ХГСО в 99% случаев, деструкцию стенок среднего уха в 55–97% случаев. Дифференцировать холестеатому от фиброза, грануляций, экссудата и гноя по плотности невозможно: плотность всех этих тканей составляет от +30 до +40 HU. Заподозрить холестеатому в 88% случаев позволяют локализация образования, деструкция стенок барабанной полости, слуховых косточек и антромастоидальной области, расширение входа в антрум, разрушение латеральной стенки аттика или адитуса, дефект задней стенки наружного слухового прохода, разрушение канала лицевого нерва и фистула лабиринта, чаще горизонтального полукружного канала.

При ХГСО без холестеатомы на КТ определяются изменения слизистой оболочки, рубцы вокруг цепи слуховых косточек, в ряде случаев её дефект, чаще вследствие лизиса длинной ножки наковальни. Антрум при мезотимпаните в стадии ремиссии, как правило, пневматизирован; сосцевидный отросток в большинстве случаев компактный, склеротический.

Информативность КТ при оценке оперированного уха низкая: рубцы, грануляции и пластический аутоматериал по плотности не отличаются от холестеатомы. Заподозрить холестеатому позволяет только увеличение «подозрительного» образования в динамике.

Для объективной оценки распространённости процесса КТ проводят не ранее чем через 3–6 месяцев после обострения. КТ в период обострения приводит к необоснованному расширению объёма операции и оправдана только при осложнённом течении.

При подозрении на холестеатому или её рецидив показана магнитно-резонансная томография (МРТ) височных костей.

МРТ в режимах T1, T2, EPI DWI и non-EPI DWI позволяет надёжно выявить холестеатому и её рецидив после операции: чувствительность метода составляет 77–100%, специфичность 86–100%. О холестеатоме свидетельствуют низкий сигнал в режиме T1 и высокий или промежуточный сигнал в режимах T2 и non-EPI DWI. На точность исследования влияет размер холестеатомы; для выявления рецидива МРТ имеет преимущества перед ревизионной операцией и служит ей альтернативой.

Ряд авторов для выявления холестеатомы рекомендует сочетать или совмещать КТ и МРТ: чувствительность в этом случае составляет 96%, специфичность 100%.

При ХГСО с холестеатомой, осложнённом фистулой лабиринта, проводится вестибулометрия.

Исследование необходимо при системном головокружении, неустойчивости и признаках фистулы. Выявление фистулы до операции позволяет предупредить послеоперационные кохлеовестибулярные расстройства.

3.6 Лабораторные исследования

Общеклинические лабораторные исследования необходимы при подготовке к плановой операции.

Показан посев отделяемого из уха на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Посев необходим при любой форме ХГСО для подбора этиотропной терапии.

При подозрении на грибковый процесс отделяемое из ушей засевают на дрожжевые и мицелиальные грибы.

Удалённые ткани уха подлежат цитологическому и патоморфологическому исследованию.

Удалённую патологическую ткань во всех случаях направляют на патоморфологическое исследование. При атипичном течении воспаления спектр исследований расширяется для исключения туберкулёза и гранулематоза Вегенера; при отсутствии диагностических данных и неэффективности стандартного лечения исследования повторяются через 3 месяца.

3.7 Консультации специалистов

При сопутствующих заболеваниях и подозрении на осложнение показаны консультации невролога, нейрохирурга и терапевта.

При атипичном течении воспаления и осложнениях может также потребоваться консультация фтизиатра и ревматолога.

---

4. Лечение

Целью лечения является санация среднего уха для достижения стойкой ремиссии и предупреждения осложнений и тугоухости.

4.1 Консервативное лечение

Консервативная терапия проводится при обострении и в рамках подготовки к операции при неосложнённом течении.

Консервативную терапию применяют при обострении для достижения ремиссии перед операцией, а также в раннем периоде после санирующей операции. Она включает бета-лактамные антибиотики, анальгетики, кортикостероиды и процедуры, направленные на улучшение функции слуховой трубы.
При неосложнённом течении лечение амбулаторное, при осложнённом стационарное. В качестве основного метода лечения консервативная терапия носит паллиативный характер и оправдана только у пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией при условии регулярного наблюдения.

При сухом перфоративном среднем отите проведение какого-либо лечения не рекомендуется.

> Расхождение в тексте рекомендации: в разделе 3.1 указано, что при сухом перфоративном отите лечение не проводится, тогда как в разделе 3.2 указано, что при перфорации без возможности улучшения слуха тимпанопластику следует выполнять для предупреждения рецидивов, а наилучшие результаты тимпанопластики достигаются именно при сухих перфорациях. В алгоритме (приложение Б) от сухого перфоративного отита стрелки ведут к лечению. Вероятно, запрет относится только к консервативной терапии.

Антибактериальный препарат выбирается с учётом микрофлоры, её чувствительности и способности препарата проникать через гематоэнцефалический барьер. Препаратами выбора являются бета-лактамы (пенициллины и другие бета-лактамные антибиотики), в ряде случаев респираторные фторхинолоны.

К системным препаратам прибегают, как правило, при выраженном обострении и тяжёлых распространённых деструктивных формах. Периоперационная антибиотикопрофилактика должна соответствовать характеру и объёму операции.

При смешанной микрофлоре рекомендацией предусмотрено сочетание 2–3 препаратов, например цефалоспоринов и фторхинолонов. Допускается сочетание местных противомикробных препаратов с противогрибковыми.

Основная роль в лечении принадлежит местным средствам: антисептикам, ушным противомикробным препаратам, местным противогрибковым средствам и кортикостероидам в комбинации с противомикробными препаратами. Наиболее эффективными и безопасными являются топические фторхинолоны: к ним чувствительны 75,6% возбудителей, они не обладают ототоксичностью и допустимы при перфорации. Местное лечение эффективно только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.

Грануляции в барабанной полости по возможности удаляются или прижигаются соединениями серебра; кроме того, они хорошо регрессируют под действием топических кортикостероидов.

Кортикостероиды в каплях или в составе комбинированных препаратов используют при вялотекущем воспалении слизистой оболочки (мукозите). При неэффективности местного лечения в течение 1–3 месяцев, что характерно для мукозита, показано хирургическое вмешательство с дренированием.

При холестеатоме эффективно местное применение препаратов борной кислоты: помимо антисептического действия, они оказывают подсушивающее действие на ткани и тем самым уменьшают воспаление.

При грибковой флоре противомикробные препараты и кортикостероиды в каплях противопоказаны. Ведение таких пациентов осуществляется строго по алгоритмам применения местных противогрибковых средств; лечение часто длительное и требует участия миколога.

> Расхождение в тексте рекомендации: абзацем выше допускается сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми, тогда как при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны. Кроме того, «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом ATX D01A, который относится к противогрибковым препаратам.

Дисфункцию слуховой трубы устраняют поэтапно. На первом этапе осуществляется лечение заболеваний полости носа и носоглотки, от назначения деконгестантов и назальных кортикостероидов до хирургического вмешательства. Затем восстанавливается проходимость слуховой трубы продуванием по Политцеру или курсом катетеризаций с введением лекарственных препаратов. На заключительном этапе восстанавливается активное открытие и закрытие слуховой трубы с помощью специальной гимнастики или электростимуляции её мышц.

4.2 Хирургическое лечение

Основным методом лечения ХГСО является хирургический: только операция позволяет полностью санировать ухо и улучшить качество жизни, поэтому каждый пациент с ХГСО рассматривается как потенциальный кандидат на хирургическое лечение. Операцию выполняют в период ремиссии, не ранее чем через 3–6 месяцев после последнего обострения; в этом случае объём вмешательства меньше, а операция безопаснее и эффективнее.

Вынужденное вмешательство при обострении или осложнении ограничивается санацией среднего уха открытого типа, при внутричерепных осложнениях расширенной; вследствие кровоточивости тканей такая операция технически сложна и чаще сопровождается ятрогенными осложнениями. Пациентов с осложнениями оперируют в ургентных отделениях, вне обострения в специализированных отделениях и центрах, владеющих реконструктивной хирургией среднего уха. Ранняя операция на «сухом ухе» обеспечивает более полную санацию очага, сохранение слуха и анатомических структур и сокращает сроки реабилитации.

При ХГСО с мукозитом II и III степени выполняются дренирующие операции.

Методика определяется индивидуально с учётом формы ХГСО и распространённости процесса, анатомии височной кости, степени тугоухости, состояния слуховой трубы, наличия осложнений и опыта хирурга.

Для санации среднего уха и улучшения слуха выполняется тимпанопластика.

При мезотимпаните применяют тимпанопластику различных типов и миринготимпластику в зависимости от степени разрушения цепи слуховых косточек; применяются протезы из хряща, наковальни, кортикальной кости, титана, для пластики барабанной перепонки используются аутоматериалы. Вмешательство проводят через наружный слуховой проход, эндауральным или заушным доступом, под местной анестезией или наркозом, под контролем эндоскопа или микроскопа, в один или два этапа.

Результат зависит от срока после последнего обострения, изменений в среднем ухе, локализации и размера перфорации, функции слуховой трубы и состояния слизистой оболочки, способа реконструкции, опыта хирурга и послеоперационного ведения. Обязательным условием успешной тимпанопластики является отсутствие выделений из уха в течение не менее 3–6 месяцев.

Тимпанопластика эффективна в 43–98% случаев, риск глухоты на оперированное ухо составляет 1–2%. Наилучшие результаты (у 93,3% пациентов) достигаются при сухих перфорациях независимо от техники укладки трансплантата.

У пациентов без холестеатомы мастоидотомия при тимпанопластике не улучшает ни анатомический результат, ни аэрацию сосцевидного отростка, но увеличивает объём и риск вмешательства. Обязательной она считается при вялотекущем хроническом перфоративном отите без холестеатомы в случае неэффективности системной и местной антибактериальной терапии.

Применение эндоскопа в дополнение к микроскопу улучшает обзор барабанной полости, однако, по данным систематического обзора, преимущества исключительно эндоскопических операций перед микроскопическими не доказаны.

При тотальных и субтотальных дефектах барабанной перепонки с изменённой слизистой оболочкой большинство хирургов для профилактики реперфорации сочетают аутофасцию, аутохрящ и кожные трансплантаты. Тонкие пластинки аутохряща препятствуют ретракции и не ухудшают акустические свойства.

При мукозите тимпанопластика оправдана: после восстановления функции слуховой трубы и аэрации утолщённая слизистая оболочка нормализуется. Слизистая оболочка удаляется инструментально или с помощью лазера. При выраженном мукозите лучшие результаты достигаются при оставлении дренажной трубки под меатальным лоскутом или при вскрытии антрума с дренированием через него барабанной полости на срок до 2 недель.

Второй этап тимпанопластики проводят через 8–12 месяцев. При наличии перфорации без возможности улучшения слуха тимпанопластика также показана для предупреждения рецидивов ХГСО.

Искусственные протезы и аутопротезы при оссикулопластике не различаются по слуховым результатам, однако искусственный протез без прикрытия аутохрящом смещается в 6 раз чаще.

4.3 Санирующие операции при холестеатоме

При ХГСО с холестеатомой выполняются санирующие операции.

Основным принципом является полное удаление холестеатомы и устранение причин рецидива.

При эпитимпаните и эпимезотимпаните с холестеатомой в зависимости от распространённости процесса выбирают «открытые», «полуоткрытые» или «закрытые» санирующие операции с тимпанопластикой или без неё. С учётом объёма и длительности вмешательства операции выполняют под общей анестезией.

При холестеатоме, ограниченной аттиком или аттиком и адитусом, допустима аттикотомия через наружный слуховой проход при обязательном тщательном удалении патологического процесса из синусов и карманов среднего уха.

«Открытая» техника (с удалением задней стенки наружного слухового прохода) избавляет от повторных операций, но не от регулярного ухода за полостью у оториноларинголога. После «закрытой» операции обязательна ревизия через 8–12 месяцев или МРТ для исключения рецидива. «Закрытые» операции сопряжены с более высоким риском внутричерепных осложнений, поэтому при невозможности постоянного послеоперационного наблюдения предпочтительна «открытая» методика.

«Закрытые» методики (аттикоадитотомия, аттикоантротомия, раздельная антромастоидотомия) предпочтительны при ограниченной холестеатоме; «открытые» методики (модифицированная радикальная, консервативно-радикальная, общеполостная операция, антромастоидотомия с удалением задней стенки, радикальная мастоидэктомия) предпочтительны при распространённой деструкции, активной холестеатоме или вялотекущем обострении.

Современной тенденцией является применение «полуоткрытой» (гибридной) техники: аттикоантро- или мастоидотомии с облитерацией антрума и сосцевидного отростка аутотканями или инертными материалами и тимпанопластикой. При этом анатомия уха остаётся близкой к исходной, болезнь послеоперационной полости не развивается и необходимость в пожизненном наблюдении отсутствует.

> Неточность в тексте рекомендации: частота рецидивов холестеатомы напечатана с ошибками («у 342%» после «закрытой» и «у 712%» после «открытой» техники), по-видимому, в диапазонах пропущено тире. Далее указано, что при «открытой» технике рецидивы возникают реже, однако «эта техника» повышает риск рецидива в 2,9 раза по сравнению с «закрытой» и поэтому рекомендуется только при повторных операциях. По приведённым цифрам чаще рецидивирует «закрытая» техника, поэтому формулировка противоречива.

При выявлении рецидива холестеатомы после «закрытой» операции объём вмешательства расширяется до антромастоидотомии с удалением задней стенки наружного слухового прохода и формированием открытой полости.

После операции наружный слуховой проход тампонируют с противомикробными препаратами: после тимпанопластики на 10–14 дней, после санирующей операции на 14–21 день; дополнительно необходимо медикаментозное и физиотерапевтическое воздействие на слуховую трубу и слизистую оболочку. Важное значение имеет квалифицированное наблюдение в отдалённом периоде.

4.4 Слухопротезирование

При асоциальном слухе (тугоухость выше II степени) и отсутствии возможности его улучшения показана электроакустическая реабилитация.

Слухопротезирование показано при порогах костной проводимости выше 30 дБ на оба уха, в том числе в отдалённом послеоперационном периоде.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты, которым операция противопоказана или отложена, а также отказавшиеся от неё, наблюдаются специалистом поликлиники раз в 6 месяцев; при обострении применяют консервативное лечение.

После тимпанопластики и санирующих операций пациент ежегодно на протяжении не менее 5 лет осматривается врачом поликлиники и отохирургом клиники, в которой выполнялась операция. Цель наблюдения состоит в своевременном выявлении рецидива перфорации, холестеатомы и тугоухости.

Профилактика обострений включает санацию полости носа и носоглотки, разъяснение пациенту характера заболевания, обучение защите уха от попадания воды и предупреждению обострений при ОРЗ, а также своевременному обращению к врачу поликлиники и в клинику, где выполнялась операция.

В послеоперационном периоде в зависимости от методики рекомендуется постельный режим с положением на противоположном ухе. В течение месяца следует избегать физических нагрузок, в течение 3 месяцев авиаперелётов; ухо необходимо защищать от попадания воды до завершения реабилитации.

5.1 Показания к госпитализации и выписке

Первичный осмотр пациента выполняют оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

Показанием к экстренной госпитализации является обострение ХГСО с внечерепными или внутричерепными осложнениями.

Плановая госпитализация для хирургического лечения показана при ХГСО, в том числе с холестеатомой, в стадии вялотекущего воспаления или ремиссии продолжительностью не менее 3–6 месяцев. Показаниями являются снижение слуха с шумом в ухе, снижение слуха со скудным отделяемым, не купирующимся консервативной терапией, или любые клинические проявления ХГСО независимо от вида тугоухости при отсутствии общих противопоказаний и при условии обследования пациента в соответствии с требованиями стационара.

После экстренной госпитализации пациент выписывается при отсутствии угрозы жизни и восстановлении жизнедеятельности, после плановой в зависимости от объёма операции и самочувствия: на 3–5-е сутки после завершения противовоспалительной и симптоматической терапии, с тампонами в наружном слуховом проходе. Тампоны удаляются амбулаторно через 2–3 недели, контроль слуха по данным ТПА осуществляют амбулаторно через 3 и 12 месяцев.

Эффективность лечения оценивается по жалобам на снижение слуха и выделения из уха, по данным отоэндоскопии (закрытие перфорации, отсутствие отореи, эпидермизация полости), ТПА, КТ или МРТ (санация уха, отсутствие деструкции и холестеатомы), а также по данным вестибулометрии при фистуле лабиринта.

ХГСО приводит к прогрессирующей тугоухости и осложнениям: лабиринтиту, периферическому парезу лицевого нерва, менингиту, абсцессу мозга и тромбозу сигмовидного синуса.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический средний отит»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 29.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	698_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- При сухом перфоративном среднем отите раздел 3.1 исключает любое лечение, тогда как раздел 3.2 и алгоритм в приложении Б предусматривают при перфорации тимпанопластику.
- Сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми допускается, однако при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны; «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом противогрибковых препаратов D01A.
- Частота рецидивов холестеатомы напечатана с ошибками («у 342%», «у 712%», «4,28,4%»), а вывод о том, что «открытая» техника повышает риск рецидива в 2,9 раза, противоречит приведённым цифрам.

- Сроки тампонады после операции различаются: в разделе 3.2 указано 10–14 дней после тимпанопластики и 14–21 день после санирующей операции, в разделе 6 указано удаление тампонов через 2–3 недели.
- Название и коды МКБ охватывают и негнойные формы (H65.2–H65.4), однако определение и весь текст рекомендации посвящены только хроническому гнойному среднему отиту.
- В рекомендации о дренирующих операциях мукозит разделён на «стадии», хотя при описании отоскопии приведены его «степени».
- В критериях качества для консервативного лечения указан УДД 4, а в самой рекомендации УДД 5; критерия «хирургическое лечение при неэффективности консервативной терапии» в рекомендациях нет, согласно тексту рекомендации операция является основным методом лечения.
- В оглавлении PDF номера страниц многих разделов искажены («100», «133», «232» и т. п.).

Клинические рекомендации

Хронический тонзиллит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.2** — Хронический фарингит **J35.0** — Хронический тонзиллит **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов **J35.9** — Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании данных фарингоскопии: решающее значение имеют местные признаки хронического воспаления миндалин, наиболее важным из которых является жидкий гной в лакунах. Размер миндалин диагностического значения не имеет.
- В период острого воспаления глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливается, поскольку достоверная оценка его признаков возможна только через 3–4 недели после купирования острого процесса.
- По классификации Солдатова выделяют компенсированную и декомпенсированную формы хронического тонзиллита; форма определяется по данным анамнеза за последние три года.
- Консервативное лечение назначают курсами в межрецидивный период: при компенсированной форме 2 раза в год, весной и осенью, при рецидивирующих ангинах до 4 раз в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Тонзиллэктомия показана при любом виде декомпенсации, а при рецидивирующих ангинах в случае неэффективности противорецидивного лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический тонзиллит является инфекционно-аллергическим заболеванием всего организма с местными проявлениями в виде стойкого воспаления нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

2.2 Местные признаки

Выделяют пять групп местных признаков: гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек; рубцовые спайки между миндалинами и нёбными дужками; разрыхлённые или, напротив, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины; казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах; увеличение регионарных лимфатических узлов.

Признак Гизе характеризуется гиперемией краёв передних нёбных дужек. Признак Зака проявляется отёком в месте соединения передних и задних дужек. Признак Преображенского характеризуется валикообразным утолщением краёв верхних отделов передних и задних дужек.

2.3 Классификация Солдатова

При компенсированной форме определяются местные признаки, а общие симптомы нерезко выражены или отсутствуют. При декомпенсированной форме наряду с местными признаками выявляется хотя бы один вид декомпенсации: рецидивы ангин; паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс; тонзиллогенная интоксикация (длительный субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности при отсутствии другой причины); тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов; заболевания органов, патогенетически связанные с тонзиллитом. Форма определяется по данным анамнеза за последние три года.

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна

Простая форма характеризуется только местными признаками; в подавляющем большинстве случаев в анамнезе имеются ангины.

При токсико-аллергической форме I степени периодически отмечаются субфебрилитет, слабость, быстрая утомляемость, боли в суставах, увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов, непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца, нестойкие отклонения лабораторных показателей.

При токсико-аллергической форме II степени функциональные нарушения сердечной деятельности подтверждаются электрокардиографией (ЭКГ); отмечаются сердцебиение и нарушения ритма, боли в области сердца и в суставах как во время ангины, так и вне её, функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов, а также сопряжённые с тонзиллитом заболевания: паратонзиллярный абсцесс, парафарингит, тонзиллогенный сепсис, ревматизм, артрит, приобретённые пороки сердца, гломерулонефрит.

Описано около 100 заболеваний, патогенетически связанных с хроническим тонзиллитом; наиболее часто поражаются сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В сложных случаях тактика ведения определяется совместно с профильным специалистом.

2.5 Жалобы и анамнез

Пациенты могут предъявлять жалобы на незначительную боль, першение, ощущение инородного тела в горле, периодический сухой кашель, неприятный запах изо рта. Эти жалобы неспецифичны и встречаются также при хроническом фарингите, заболеваниях гортани, полости рта и зубов; у части пациентов жалобы отсутствуют.

При декомпенсированной форме возможны общие жалобы: длительное недомогание, снижение работоспособности, затяжной субфебрилитет. Эти жалобы также неспецифичны и требуют обследования для исключения других причин.

У детей и взрослых, особенно часто и длительно болеющих, уточняются местные и общие жалобы, а также частота ангин. Многие авторы считают ангины в анамнезе наиболее достоверным признаком хронического тонзиллита, однако сведения о них должны быть подтверждены.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза (ангины, длительная утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, сопряжённые с тонзиллитом заболевания), физикального обследования, лабораторных данных и фарингоскопии.

3.1 Физикальное обследование

Фарингоскопию выполняют детям и взрослым для исключения острого тонзиллита и выявления местных признаков хронического тонзиллита.

При наличии острого воспаления глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливается, поскольку достоверная оценка его признаков возможна только через 3–4 недели.

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Решающее значение имеют фарингоскопические признаки, наиболее важным из которых является жидкий гной в лакунах, нередко с неприятным запахом. Увеличение регионарных лимфатических узлов может быть обусловлено и другими воспалительными процессами в области головы и шеи. Размер миндалин диагностического значения не имеет.

Осмотр выполняют при ярком направленном освещении с использованием двух шпателей, при необходимости зонда. За 20–30 минут до осмотра пациенту не рекомендуется принимать пищу, горячие, холодные и газированные напитки, курить и разговаривать на холоде, что позволяет избежать транзиторной гиперемии. Надавливание вторым шпателем на нёбную дужку позволяет выявить содержимое лакун и спайки.

3.2 Лабораторные исследования

Общий анализ крови и мочи, исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) и ревматоидного фактора необходимы для выявления сопряжённых с тонзиллитом заболеваний.

Антистрептолизин-О (АСЛ-О) определяется для дифференциальной диагностики активной стрептококковой инфекции и носительства.

Высокий уровень АСЛ-О при отсутствии стрептококка в посевах свидетельствует о возможной внутриклеточной персистенции и рассматривается как подтверждение декомпенсации. Однако высокий уровень АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не является показанием к лечению.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

Выполняют бактериологическое исследование отделяемого с нёбных миндалин на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитологическое исследование содержимого лакун для постановки диагноза практически не имеют значения. Они необходимы для уточнения формы заболевания, роли микрофлоры, связи с заболеваниями других органов и оценки эффективности лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, ультразвуковое исследование (УЗИ) и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательства их эффективности отсутствуют.

---

4. Лечение

Курсы лечения хронического тонзиллита назначают в межрецидивный период. Тактика при ангине определяется рекомендациями по острому тонзиллофарингиту, при паратонзиллите и абсцессе рекомендациями по этим заболеваниям.

Перед началом любого лечения необходимы осмотр и при необходимости санация зубов, околоносовых пазух и носоглотки.

4.1 Консервативное лечение

При компенсированной и простой формах консервативное лечение назначают курсами 2 раза в год, весной и осенью. При декомпенсации в виде рецидивов ангин и при токсико-аллергической форме I степени назначают до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины. При других видах декомпенсации и токсико-аллергической форме II степени консервативное лечение показано в случае противопоказаний к операции.

Лечение эффективно только при условии дренирования лакун и очищения складок и карманов от экссудата и детрита.

Системную антибактериальную терапию применяют при обострении, выделении стрептококка или появлении признаков осложнений; препаратами выбора являются пенициллины. Вне обострения, при функциональных нарушениях внутренних органов, отрицательных результатах посевов на БГСА и стойко повышенном уровне АСЛ-О предпочтение отдаётся 14-членным макролидам курсом до 2 недель.

Целесообразность антибактериальной терапии в межрецидивный период остаётся дискутабельной, поэтому решение принимается индивидуально на основании объективных данных, динамики симптомов и лабораторных показателей.

При подтверждённой грибковой этиологии используют противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

В межрецидивный период для снижения частоты ангин применяют курсами растительные препараты, содержащие корень алтея, цветки ромашки, траву тысячелистника, кору дуба, траву хвоща и корень одуванчика.

4.2 Местное лечение

В межрецидивный период рекомендуется промывание лакун миндалин курсом из 10 процедур ежедневно или через день. Промывание допустимо не ранее чем через 2–3 недели после острого воспаления.

Для промывания используются стерильный раствор натрия хлорида или растворы антисептиков с соблюдением дозировок и возрастных ограничений и с учётом возможной аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур выполняют отдельно или непосредственно после промывания.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста от промывания и смазывания миндалин следует воздержаться в связи с риском рефлекторного ларингоспазма.

Применяют антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.

Взрослым при обострении рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для местного применения.

Топические бактериальные лизаты в форме таблеток для рассасывания уменьшают частоту и продолжительность обострений.

В период ремиссии показана консультация физиотерапевта; физиотерапии предшествует курс промываний.

4.3 Хирургическое лечение

Двусторонняя тонзиллэктомия выполняется в межрецидивный период для радикального устранения очага инфекции.

По классификации Солдатова операцию выполняют при любом виде декомпенсации, кроме рецидивов ангин, если противорецидивное лечение не проводилось. При рецидивах ангин к тонзиллэктомии прибегают в случае неэффективности консервативного лечения с сохранением ангин или появлением другого вида декомпенсации.

По классификации Преображенского — Пальчуна операция показана при токсико-аллергической форме II степени, а также при простой форме и токсико-аллергической форме I степени в случае неэффективности 2–3 тщательно проведённых курсов консервативного лечения в год.

Детям операцию выполняют при частых стрептококковых ангинах (не менее 7 за последний год, не менее 5 в год за последние 2 года или не менее 3 в год за последние 3 года), при двух и более паратонзиллярных абсцессах (в ряде случаев и после одного), а также по заключению профильных специалистов, если тонзиллэктомия необходима как этап лечения сопутствующего заболевания.

Согласно критериям Paradise, тонзиллэктомия рассматривается при 7 эпизодах боли в горле за год, 5 эпизодах в каждом из двух лет или 3 эпизодах в каждом из трёх лет. Эпизодом считается боль в горле в сочетании хотя бы с одним признаком: температура тела 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, увеличение шейных лимфатических узлов более 2 см с болезненностью, выделение БГСА при посеве или положительный экспресс-тест.

Абсолютными противопоказаниями являются заболевания крови (гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы), аномалии сосудов глотки (пульсация боковой стенки), тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени, выраженная почечная недостаточность, тяжёлый сахарный диабет с кетонурией, тяжёлые заболевания печени, тяжёлые нервно-психические заболевания, злокачественные новообразования, активный туберкулёз.

Относительными противопоказаниями являются острые инфекционные заболевания и период 3–4 недель после них, острые воспалительные заболевания и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов, эпидемии гриппа, менструация, неактивный туберкулёз, преходящая тромбоцитопения, сахарный диабет нетяжёлого течения, кариозные зубы.

Наиболее частым осложнением является кровотечение из тонзиллярной ниши во время операции или в первые 5–7 дней, однако оно возможно и на 8–15-е сутки. В связи с этим первые 5–7 дней пациент находится в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике с освобождением от работы.

4.4 Послеоперационное ведение

В первые сутки соблюдаются постельный и голосовой режим; через несколько часов после операции разрешается сделать несколько глотков воды. В последующие дни режим щадящий, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная. Применяют местные и системные анальгетики, проводят профилактику обострения сопутствующих заболеваний.

Для обезболивания и уменьшения воспаления используют НПВП.

После тонзиллэктомии в течение месяца рекомендуются ограничение физической нагрузки и соблюдение режима сна и отдыха.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

При компенсированной форме курсы лечения повторяют 2 раза в год. Если за 3 года не отмечалось ангин и других признаков декомпенсации, пациент снимается с диспансерного учёта.

При декомпенсации в виде рецидивов ангин курсы лечения повторяют 3–4 раза в год. При неэффективности лечения в течение года, осложнённом течении ангин или появлении другого вида декомпенсации пациент направляется на хирургическое лечение.

После тонзиллэктомии диспансерное наблюдение продолжается в течение 6 месяцев.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск развития хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно дефицит витаминов A, B, E), переутомление, неудовлетворительные гигиенические условия жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, заболевания зубов, полости носа и околоносовых пазух, частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и их нерациональное лечение.

Лечение, как правило, осуществляет оториноларинголог в амбулаторных условиях.

Госпитализация в хирургическое отделение показана при неэффективности лечения, подозрении на гнойное осложнение (паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит) или новообразование, а также при необходимости хирургического лечения. Тонзиллэктомию выполняют в оториноларингологическом отделении в плановом порядке; при неосложнённом послеоперационном периоде пациент выписывается на 5–7-е сутки.

Переход тонзиллита в декомпенсированную форму чаще наблюдается при иммунодефиците (врождённом, на фоне приёма иммунодепрессантов и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции). Аутоиммунные осложнения более вероятны при стрептококковой этиологии тонзиллита и ревматической лихорадке у пациента или ближайших родственников.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», тогда как в карточке рубрикатора приведён J31.2 «Хронический фарингит». На сайте указан код из текста КР.
- Бензидамин в комментарии ошибочно отнесён к «пенициллинам, чувствительным к бета-лактамазам» (код АТХ J01CE); бензидамин является нестероидным противовоспалительным препаратом для местного применения.